INSTRUÇÕES

Aqui temos o banco de questões do medgrupo. Cada pdf tem 500 questões, são 112 pdfs então 56.000 questões.

As questões são divididas da mesma forma que é no medgrupo, então, por exemplo, a pasta "CIR 1" irá conter as questões do modulo CIR 1 do medcurso. No pdf, primeiro há as questões e por final os comentários e gabaritos. Como é uma questão por pagina, sempre por volta da pagina 500 terá o começo do gabarito.

A numeração de cada questão é pelo seu ID, da mesma forma que é no app do medgrupo. Por exemplo, se no modulo CIR 1, uma questão ter o ID 33345 (o ID aparece em cima do enunciado em negrito), no gabarito irá aparecer o mesmo ID como a enumeração da questão.

Além disso, certas questões tem imagens e videos respostas. Dessa maneira se acaso a questão de ID 33345 ter uma imagem, ela estará na pasta Imagens (Cir 1/Imagens/33345.png) com o nome 33345.png e o vídeo estará em (Cir 1/videos/33345.mp4)

***Recomendo, para se localizar no gabarito, utilizar CTRL+F (pesquisar), procure o ID da questão que quer ver a resposta, como o ID 33345.**

***Se houver algum erro, envie mensagem no twitter @livremedicina**

-- Medicina livre, contra os preços abusivos na medicina.

-- Venda proibida

-- @Livremedicina - twitter

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

343775)

Enunciado: A hipoglicemia neonatal ocorre com maior frequência nos pacientes com baixa reserva energética, como nos recém-nascidos prematuros e naqueles com restrição do crescimento intrauterino. Cornblath em 2000 recomendou alguns limiares operacionais para o tratamento da hipoglicemia em neonatos. A respeito desses limiares operacionais, marque a resposta correta abaixo:

A) Recém-nascido a termo saudável com menos de 24h de vida: 30 a 35mg/dL na primeira medição.

B) Recém-nascido com sinais ou sintomas clínicos anormais: 30 a 35mg/dL.

C) Recém-nascido a termo saudável após 24h de vida: 60mg/dL.

D) Recém-nascido com sinais ou sintomas clínicos anormais: 50mg/dL.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

343776)

Enunciado: O teste do reflexo vermelho é o exame de rastreamento para anormalidades oculares, desde a córnea até o seguimento posterior. A respeito desse teste de triagem, qual das afirmativas abaixo é a correta?

A) A rotina de realização do teste do reflexo vermelho deve ocorrer da seguinte forma: antes da alta da maternidade, com 2, 6, 9 e 12 meses de vida e após 1 ano de idade com a frequência de duas vezes ao ano.

B) O teste é considerado normal quando um dos olhos apresentam um reflexo vermelho brilhante.

C) A rotina de realização do teste do reflexo vermelho deve ocorrer da seguinte forma: antes da alta da maternidade, na primeira consulta de puericultura, com 2, 6, 9 e 12 meses de vida e após 1 ano de idade com a frequência de duas vezes ao ano.

D) A rotina de realização do teste do reflexo vermelho deve ocorrer da seguinte forma: antes da alta da maternidade, na primeira consulta de puericultura, mensalmente até os 12 meses de vida e após 1 ano de idade com a frequência de duas vezes ao ano.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

343789)

Enunciado: Recém-nascido de parto fisiológico, nascido com idade gestacional de 36 semanas e 5 dias é encaminhado a Unidade de Terapia Intensiva Neonatal com hipótese diagnóstica de infecção congênita devido história materna suspeita. Ao realizar ultrassonografia transfontanelar, o resultado demonstrou a presença de calcificações cerebrais periventriculares. Qual o provável diagnóstico?

A) Toxoplasmose congênita.

B) Citomegalovírose congênita.

C) Sífilis congênita.

D) Rubéola congênita.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

345492)

Enunciado: Recém-nascido, 36 semanas e 6 dias, apgar 8/9, parto normal, nascido de mãe G1P1A0 que não realizou consultas de pré-natal e apresentou teste rápido para HIV negativo e teste rápido para sífilis positivo no momento do parto. Mãe nega quaisquer tratamentos prévios. Assinale a alternativa que contenha a melhor conduta para o recém-nascido nesse caso:

A) Como a mãe não foi tratada para sífilis na gestação, o recém-nascido não poderá ser tratado com Penicilina Benzatina intramuscular, independente do resultado dos exames.

B) Aguardar o resultado do VDRL, no soro da mãe para decidir sobre a conduta do recém-nascido, e se o VDRL, no soro da mãe for não reagente, é dispensada qualquer conduta especial ao recém-nascido.

C) Nessa situação, a punção lombar do recém-nascido com estudo citobioquímico do líquor está indicada apenas se o VDRL no soro do mesmo for reagente.

D) Se o recém-nascido apresentar VDRL no soro não reagente, os demais exames necessários normais e ausência de sintomas, poderá receber uma dose de Penicilina Benzatina intramuscular e deverá fazer seguimento ambulatorial obrigatória.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

283289)

Enunciado: A doença da membrana hialina é um distúrbio respiratório frequente em recém-nascidos, marque a alternativa CORRETA:

A) O quadro radiológico típico é de áreas de opacidades grosseiras e irregularidades difusas, podendo ser encontrado pneumotórax e pneumomediastino.

B) Afeta recém-nascidos prematuros, sendo sua incidência diretamente proporcional a idade gestacional.

C) A causa principal é a deficiência de surfactante, uma mistura alveolar fosfolipídica que reduz a tensão superficial dos alvéolos, com essa estabilidade comprometida, há formação de áreas difusas de atelectasias.

D) No quadro clínico clássico observa-se gemidos, batimentos de asa de nariz, retrações inter e subcostais, que melhoram com 48 horas de vida.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

283306)

Enunciado: As infecções perinatais afetam 0,5% a 2,5% de todos os nascimentos e constituem um grande problema de saúde pública pela elevada morbimortalidade a elas associadas. Assinale a alternativa CORRETA considerando a toxoplasmose congênita:

A) O risco de transmissão se aproxima de 100% quando a infecção materna ocorre no primeiro trimestre da gestação.

B) Cerca de 70% dos RN com infecção congênita são assintomáticos ao nascimento, sendo que a metade das crianças acometidas têm manifestações graves nos primeiros dias de vida.

C) A toxoplasmose congênita caracteriza-se por hidrocefalia, corioretinite, calcificações intracranianas e elevada proteinorraquia, bioquímico ao exame do líquor.

D) O tratamento é longo, 1 ano, e consiste em sulfadiazina, pirimetamina, acido folínico e prednisona para todos os recém-nascidos.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

283308)

Enunciado: Qual das abaixo NÃO é etiologia das convulsões no período neonatal?

A) Encefalopatia hipóxico-isquêmica.

B) Hipocalcemia.

C) Aminoacidopatias.

D) Enterocolite necrotizante.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

281148)

Enunciado: Recém-nascido (RN) apresenta quadro de desconforto respiratório devido à doença de membrana hialina, com baixa perfusão periférica. Com base nesse caso hipotético, assinale a alternativa que apresenta a conduta terapêutica correta.

A) Fase expansiva com soro glicosado a 10% a 20 mL/Kg, seguida de infusão contínua de dobutamina caso não responda.

B) Fase expansiva com soro fisiológico a 10 mL/Kg, seguida de infusão contínua de dopamina caso não responda.

C) Fase expansiva com soro glicosado a 5% a 29 mL/kg, seguida de adrenalina em infusão contínua caso não responda.

D) Fase expansiva com soro fisiológico a 20 mL/kg, seguida de adrenalina em infusão contínua caso não responda.

E) Fase expansiva com soro glicosado a 10% a 20 mL/Kg, seguida de infusão contínua com dopamina e dobutamina caso não responda.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

283334)

Enunciado: A rubéola congênita NÃO está associada a complicação abaixo:

A) Catarata.

B) Defeitos septais cardíacos.

C) Surdez neurossensorial.

D) Pancreatite.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

251921)

Enunciado: Qual das causas abaixo NÃO causa colestase em crianças?

A) Deficiência de glicose-6-fosfato-desidrogenase (G6PD).

B) Atresia de vias biliares.

C) Hipotireoidismo.

D) Hepatite auto-imune.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

251931)

Enunciado: A hipoglicemia é um distúrbio metabólico frequente na neonatologia, marque a CORRETA, com relação a este distúrbio.

A) São fatores de risco prematuridade, anemia falciforme e hipotireoidismo materno.

B) Deve ser feito corticoide endovenoso, precocemente, na maioria dos casos.

C) O flush de glicose a 10%(2ml/kg), endovenoso é o tratamento de escolha, nos sintomáticos.

D) Nos grupos de risco não devemos realizar triagem por meio de fitas reagentes (dextro).

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

217707)

Enunciado: As doenças respiratórias constituem a causa mais frequente de admissão para cuidados intensivos, tanto do RN a termo quanto pré-termo. Com relação a essas doenças, a assertiva CORRETA é:

A) A taquipneia transitória do RN geralmente ocorre em partos pós-termo e se caracteriza pelo início precoce de taquipneia, por vezes, acompanhada de gemidos expiratórios ou retrações intercostais e ocasionalmente cianose.

B) A síndrome da aspiração de mecônio é o resultado da obstrução das vias aéreas menores pela aspiração de partículas finas de mecônio, caracterizada pelo desconforto respiratório nas primeiras horas de vida com taquipneia, retrações, gemidos e cianose.

C) A hipertensão pulmonar persistente neonatal ocorre em RN pré-termo e tem como alguns fatores predisponentes sepse de início precoce, hipoglicemia, policitemia, doença da membrana hialina e pneumonia por aspiração de mecônio.

D) A doença da membrana hialina tem sua incidência diretamente proporcional à idade gestacional e ao peso de nascimento, caracterizada pela deficiência de surfactante, seja na diminuição da produção ou por alteração na secreção.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

217655)

Enunciado: A toxoplasmose congênita é uma infecção neonatal bastante frequente no Brasil, estima-se que nasçam de 1 a 10 crianças infectadas pelo toxoplasma gondii para cada 10.000 nativivos em todo mundo. Marque a CORRETA com relação à toxoplasmose congênita:

A) O teste de avidez para IgG, quando indica alta avidez (? 60%), reflete uma infecção ocorrida após 12 a 16ª semana de gestação, não sendo útil no início da gestação.

B) A tríade clássica de hidrocefalia, calcificações cerebrais e coriorretinite é sugestiva e bastante frequente.

C) O tratamento é realizado com sulfadiazina, pirimetamina e ácido fólico, sendo associado à prednisolona na presença de coriorretinite e proteinorraquia >1.000 mg/dl no neonato.

D) Quando não diagnosticada precocemente, a mesma pode resultar em coriorretinite ou manifestações neurológicas (convulsões e obstrução liquórica) na infância tardia e adolescência.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

217675)

Enunciado: A icterícia neonatal é uma condição comum, presente em até 85% dos recém-nascidos a termo, sendo utilizadas as Zonas de Kramer para avaliação clínica, sendo necessário investigar outras causas de icterícia em recém-nascidos:

A) Pós-termo, que apresentem icterícia zona II no segundo dia de vida.

B) Que apresentam icterícia nas primeiras 24 horas de vida.

C) Prematuros, que apresentem icterícia entre o 2º e 3º dias de vida, independente da zona de Kramer.

D) Com incompatibilidade Rh, independente da idade gestacional e o tempo de aparecimento da icterícia.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

217686)

Enunciado: Qual padrão de herança é demonstrado no heredograma abaixo? O indivíduo II-4 apresenta qual risco de recorrência para a prole e qual variação genética?

A) Autossômico dominante; 50%; penetrância incompleta.

B) Autossômico recessivo; 25%; expressividade variável.

C) Autossômico dominante; 50%; expressividade variável.

D) Autossômico recessivo; 50%; penetrância incompleta.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

182603)

Enunciado: A triagem neonatal (teste do pezinho) é uma estratégia de prevenção secundária de algumas doenças genéticas ou infecciosas oferecidas gratuitamente pelo SUS. Atualmente, qual das doenças abaixo NÃO é contemplada por esse teste?

A) Hiperplasia suprarrenal congênita.

B) Fenicetonúria.

C) Toxoplasmose.

D) Galactosemia.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

182653)

Enunciado: Recém-nascido (RN) a termo de parto cesáreo, filho de mãe HIV+ e com VDRL de 1/16 na ocasião do parto, apresenta boas condições de vitalidade e, após receber a primeira dose de zidovudina (AZT) é encaminhado ao alojamento conjunto. A conduta adequada em relação ao RN consiste em:

A) Solicitar o VDRL do RN, e se positivo, tratar com Penicilina G cristalina, além de prescrever AZT 4mg/kg/dose, de 12/12hs.

B) Manter o aleitamento materno desde que a carga viral da mãe seja indetectável.

C) Iniciar profilaxia com sulfametoxazoltrimetropim contra pneumocistose a partir de 2 meses de vida, independente da contagem de linfócitos T-CD4+.

D) Adiar a aplicação da BCG até que a infecção do RN seja descartada.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

183175)

Enunciado: São considerados fatores de risco diminuídos para SDR, EXCETO:

A) Retardo crescimento intraútero.

B) Mães que usaram corticosteróide.

C) Masculinos (fator genético).

D) RN com estresse intrauterino.

E) Ruptura prolongada membranas amnióticas.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

183192)

Enunciado: Foi internado, na unidade neonatal, um recém-nascido (RN) de 34 semanas de idade gestacional, nascido de parto cesária, índice de Apgar 8 e 9, respectivamente, no 1º e 5º minuto, peso de nascimento de 2100g. A mãe tinha infecção urinária e, com 6 horas de vida, o RN encontrava-se taquipneico, com tiragem intercostal e pouco gemente, O residente da unidade suspeitou de sepse precoce, solicitou os exames de rastreamento e prescreveu antibiótico e tomou outras condutas, satisfazendo a resolução clínica do paciente. Assinale a alternativa correta do provável esquema antimicrobiano que o residente deva ter prescrito para o paciente empiricamente.

A) Ceftriaxona.

B) Piperacilina/tazobactam e um aminoglicosídeo.

C) Vancomicina e gentamicina.

D) Ampicilina e um aminoglicosídeo.

E) Uma cefalosporina de terceira geração e tobramicina ou gentamicina. Pediatria Página 8

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

183208)

Enunciado: Um recém-nascido de 4 dias de vida, 27 semanas de idade gestacional e 1100 gramas de peso, está na UTI neonatal sob ventilação mecânica e apresenta a seguinte avaliação dos gases sanguíneos: pH = 7.21; paCO2 = 51 mmHg; paO2 = 85 mmHg, BE = -3 e BicNa = 17 mmEq/L. Com esses dados, responder a alternativa correta.

A) O paciente está em hipercapnia e, por isso, sua frequência respiratória deve ser diminuída.

B) Esse paciente está em hiperóxia (paO2 = 85 mmHg).

C) O único problema desse paciente é uma tendência à acidose metabólica.

D) Esse paciente está com hiperóxia e hipercapnia.

E) Os gases sanguíneos desse paciente estão dentro da normalidade levando-se em consideração a idade gestacional de 27 semanas.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

182657)

Enunciado: Qual dos achados encontrados no exame físico de um recém-nascido requer uma investigação mais ampla, pelo risco de associação com má formações?

A) Eritema tóxico.

B) Mancha mongólica.

C) Milium sebáceo.

D) Tufo de pêlos em região sacral.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

183143)

Enunciado: A hiperbilirrubinemia, no período neonatal, decorrente de processo hemolítico, é encontrada nas condições abaixo, EXCETO:

A) Incompatibilidade ABO.

B) Deficiência de Glocose-6-fosfato desidrogenase.

C) Incompatibilidade RH.

D) Síndrome de Gilbert.

E) Esferocitose.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

183156)

Enunciado: As manifestações oculares da síndrome da rubéola congênita são: I. catarata; II. retinopatia pigmentar; III. microftalmia; IV. descolamento da retina. Estão corretas as alternativas

A) I, II, III e IV.

B) I e IV, apenas.

C) II e III, apenas.

D) III e IV, apenas.

E) I, II e III, apenas.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

183173)

Enunciado: A síndrome da rubéola congênita é uma importante complicação da infecção pelo vírus da rubéola durante a gestação, principalmente no primeiro trimestre, podendo comprometer o desenvolvimento do feto e causar aborto, morte fetal e anomalias congênitas. As manifestações clínicas da síndrome da rubéola congênita podem ser transitórias, permanentes ou tardias. É(São) manifestação(ões) que faz(em) parte da síndrome da rubéola congênita I. Surdez; II. Catarata; III. Cardiopatia; IV. Retardo mental. Está (ão) correta(s) a(s) alternativa(s):

A) I, II, III e IV.

B) III, apenas.

C) I e IV, apenas.

D) II e III, apenas.

E) I, II e III, apenas.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

159076)

Enunciado: A aferição da glicemia por fita em avaliação de rotina de recém-nascidos pré-termo assintomático revela um valor de 20 mg/dl. A conduta a ser tomada é:

A) Oferecer soro glicosado por sucção.

B) Aguardar resultado de glicemia venosa.

C) Infundir glicose por via venosa.

D) Oferecer mamadeira com fórmula para prematuros.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

159092)

Enunciado: O índice de APGAR quantifica e resume a resposta de recém-nascido ao ambiente extrauterino. Deve ser avaliado no primeiro e no quinto minuto após o nascimento. Quando necessário, devem-se repetir contagens adicionais a cada cinco minutos, até o 20° minuto. Analise as afirmações a seguir. I. O índice de APGAR é utilizado para determinar a indicação e as ações de reanimação que o recém-nascido irá receber. II. A cada um dos sinais avaliados na composição do índice de APGAR é atribuído um valor que varia entre 0 (pior situação) e 2 (melhor situação). III. Os sinais avaliados para compor o índice de APGAR são: frequência cardíaca, respiração, tônus muscular, irritabilidade reflexa e coloração da pele. IV. Recém-nascido que recebe pontuação do índice de APGAR igual a dez (10) apresenta-se corado, com frequência cardíaca maior que 100 batimentos por minuto, respiração irregular, tônus flácido, espirro ou choro ao ser estimulado. Estão corretas as afirmativas:

A) I, II e III apenas.

B) II,III e IV apenas.

C) I,II e IV apenas.

D) I, III e IV apenas.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

135959)

Enunciado: Assinale a alternativa INCORRETA em relação aos fatores de risco para hiperbilirrubinemia significante:

A) Icterícia precoce;

B) RNPT (recém-nascido pré-termo) tardio;

C) Perda de peso superior a 7%,

D) Descendência negra.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

135964)

Enunciado: Dentre as alternativas a seguir, assinale aquela que NÃO apresenta sinais clínicos usualmente associados à hipoglicemia neonatal.

A) Irritabilidade ou hipotonia;

B) Recusa alimentar ou convulsões;

C) Febre alta ou sudorese excessiva;

D) Letargia ou tremores.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

135989)

Enunciado: Laura está no 7° dia de vida, veio em sua primeira consulta pediátrica, nasceu de parto cesáreo por desproporção céfalo pélvica, à termo, chorou ao nascer, Apgar 9/9, peso de 3.200 gr e 49 cm de comprimento. Mãe informa que a recém-nascida está em aleitamento materno exclusivo, mas que acha o seu leite fraco e que sua bebê dorme muito. Você examina a menor e encontra uma icterícia leve zona II, peso de 2.950gr, comprimento de 50 cm, manchas mongólicas em região glútea, manchas ectásicas em região frontal de cicatriz umbilical de bom aspecto, sem outras alterações no exame físico. Qual a sua conduta?

A) Tranquilizar a mãe, pois as alterações encontradas fazem parte do exame físico normal do recém-nascido;

B) Prescrever fórmula láctea de partida, pois a menor apresentou perda ponderal considerando o peso do nascimento, além de manter o aleitamento materno;

C) Orientar a mãe para acordar o bebê rigorosamente de 3/3 horas para estabelecer uma rotina alimentar e incrementar o ganho ponderal.

D) Solicitar uma dosagem de bilirrubinas total e frações urgente, para avaliar a indicação de fototerapia e suspender o aleitamento materno pela possiblilidade de icterícia relacionada ao aleitamento materno.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

108629)

Enunciado: A conduta em relação à alimentação de um recém-nascido em boas condições de vitalidade, com idade gestacional de 34 semanas e pesando 2.400 g é:

A) Leite artificial por gavagem.

B) Leite artificial no copinho.

C) Amamentação ao seio materno.

D) Leite materno por gavagem.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

108770)

Enunciado: Em relação ao teste de oximetria, conhecido como o teste do coraçãozinho, marque a alternativa que MENOS corresponde ao objetivo da implantação deste teste de triagem, cuja recomendação é que seja realizado em todos os recém-nascidos antes da alta hospitalar.

A) O objetivo do teste do coraçãozinho é o de realizar uma triagem para a identificação de todas as cardiopatias congênitas, especialmente as cardiopatias com sopro cardíaco bem audível no período neonatal.

B) A relevância do diagnóstico das cardiopatias congênitas está na tentativa de se reduzir a mortalidade infantil, pelo Pacto pela Vida, uma vez que as cardiopatias congênitas representam cerca de 10% dos óbitos infantis e cerca de 20% a 40% dos óbitos decorrentes de malformações congênitas.

C) Considerando que cerca de 1 a 2 em cada 1.000 recém-nascidos vivos apresentam cardiopatia congênita crítica e que 30% destes recém-nascidos recebem alta hospitalar sem diagnóstico, evoluindo para óbito precoce, antes mesmo de receber tratamento, o teste do coraçãozinho está sendo implantado.

D) O ecocardiograma deve ser realizado nos casos confirmados pela oximetria de pulso (Saturação SpO2 menor que 95% ou diferença igual ou maior que 3% entre as medidas dos membros).

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

84456)

Enunciado: Na Toxoplasmose congênita, no período neonatal, é característico o encontro de:

A) Proteinorraquia elevada.

B) Hipernatremia.

C) Trombocitose.

D) Hiperglobulinemia.

E) Acolia fecal.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

66941)

Enunciado: Em uma unidade básica de saúde você atende um lactente de seis meses de idade que foi levado à unidade por apresentar uma virose, febre baixa há um dia e coriza nasal. Durante o exame foi constatado que a criança se encontrava em bom estado geral, porém era hipotônica, sustentou a cabeça com cinco meses e ainda não rolava. Apresentava ainda uma fácies, infiltrada, mixedema, pele seca, obstipação e déficit de crescimento que foram notados pela mãe desde os dois meses de vida. As vacinas estavam em dia e a criança não realizou a triagem neonatal. Qual a hipótese diagnóstica mais provável?

A) Desnutrição proteicocalórica.

B) Síndrome Nefrótica.

C) Fenilcetonúria.

D) Hipotireoidismo congênito.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

66985)

Enunciado: Recém-nascido apresentando orifício na parede abdominal de 3 cm de diâmetro, à direita do cordão umbilical, com exteriorização de estômago e alças intestinais, sem membrana recobrindo as alças. Qual o diagnóstico da malformação descrita?

A) Gastrosquise.

B) Onfalocele.

C) Extrofia de cloaca.

D) Anomalia anorretal.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

341080)

Enunciado: Menino recém-nascido pré-termo, limitrofe, apresenta peso adequado para a idade gestacional. No prontuário o Teste do Coraçãozinho foi registrado como ""normal"". Quanto ao Teste da Orelhinha a genitora foi orientada a agendar em um serviço de Fonoaudiologia, após a alta. O teste de Bruckner (Teste do Olhinho), realizado na maternidade imediatamente antes do horário previsto para a alta, apresenta ""reflexo vermelho bilateral"". Considerando o caso, indique a conduta adequada, quanto ao achado no Teste do Olhinho:

A) Relatar teste normal aos familiares.

B) Repetir o teste na maternidade em 24 horas.

C) Solicitar Mapeamento de Retina pelo oftalmologista.

D) Repetir o teste com o oftalmologista em uma semana.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

341081)

Enunciado: Menino recém-nascido pré-termo, limitrofe, apresenta peso adequado para a idade gestacional. No prontuário o Teste do Coraçãozinho foi registrado como ""normal"". Quanto ao Teste da Orelhinha a genitora foi orientada a agendar em um serviço de Fonoaudiologia, após a alta. O teste de Bruckner (Teste do Olhinho), realizado na maternidade imediatamente antes do horário previsto para a alta, apresenta ""reflexo vermelho bilateral"". Indique o parâmetro principal aferido pelo Teste do Olhinho:

A) Integridade da mácula retiniana.

B) Presença de edema na papila óptica.

C) Simetria do reflexo luminoso nas córneas.

D) Integridade dos meios oculares transparentes.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

341082)

Enunciado: Menino recém-nascido pré-termo, limitrofe, apresenta peso adequado para a idade gestacional. No prontuário o Teste do Coraçãozinho foi registrado como ""normal"". Quanto ao Teste da Orelhinha a genitora foi orientada a agendar em um serviço de Fonoaudiologia, após a alta. O teste de Bruckner (Teste do Olhinho), realizado na maternidade imediatamente antes do horário previsto para a alta, apresenta ""reflexo vermelho bilateral"". Indique a idade preconizada para maximizar a eficácia na realização da triagem pelo Teste da Orelhinha, se não for feito na maternidade:

A) 28 dias.

B) 60 dias.

C) 90 dias.

D) 180 dias.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

313442)

Enunciado: Em relação às causas de Calcificações Abdominais no recém-nascido, assinale a alternativa incorreta.

A) Atresia jejunal ou ileal.

B) Imaturidade funcional do cólon.

C) Íleo meconial.

D) Anomalia anorretal com fistula retovesical.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

307063)

Enunciado: Menino nascido a termo há 20 dias, com peso adequado para a idade gestacional, sem intercorrências no parto ou na gestação, é levado à UBS com quadro de icterícia há 4 dias, que tem aumentado de intensidade. Foi observada alteração na coloração das fezes e da urina. O bebê está em aleitamento materno exclusivo. No momento está ativo e afebril; acianótico; descorado +/IV; ictérico +++/IV; auscultas cardíaca e respiratória sem anormalidades; fígado palpável a 1,5cm do rebordo costal direito, com superfície lisa, consistência endurecida; baço palpável a 1,5cm do rebordo costal esquerdo, endurecido. Sem outras alterações ao exame segmentar. Diante do quadro clínico, indique o diagnóstico provável para esse bebê.

A) Icterícia fisiológica.

B) Hepatite neonatal.

C) Colestase neonatal.

D) Icterícia do leite materno.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

307064)

Enunciado: Menino nascido a termo há 20 dias, com peso adequado para a idade gestacional, sem intercorrências no parto ou na gestação, é levado à UBS com quadro de icterícia há 4 dias, que tem aumentado de intensidade. Foi observada alteração na coloração das fezes e da urina. O bebê está em aleitamento materno exclusivo. No momento está ativo e afebril; acianótico; descorado +/IV; ictérico +++/IV; auscultas cardíaca e respiratória sem anormalidades; fígado palpável a 1,5cm do rebordo costal direito, com superfície lisa, consistência endurecida; baço palpável a 1,5cm do rebordo costal esquerdo, endurecido. Sem outras alterações ao exame segmentar. Indique a conduta imediata para esse caso.

A) Orientar banhos de sol.

B) Administrar Interferon alfa.

C) Suspender o leite materno.

D) Encaminhar para especialista.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

307065)

Enunciado: Menino nascido a termo há 20 dias, com peso adequado para a idade gestacional, sem intercorrências no parto ou na gestação, é levado à UBS com quadro de icterícia há 4 dias, que tem aumentado de intensidade. Foi observada alteração na coloração das fezes e da urina. O bebê está em aleitamento materno exclusivo. No momento está ativo e afebril; acianótico; descorado +/IV; ictérico +++/IV; auscultas cardíaca e respiratória sem anormalidades; fígado palpável a 1,5cm do rebordo costal direito, com superfície lisa, consistência endurecida; baço palpável a 1,5cm do rebordo costal esquerdo, endurecido. Sem outras alterações ao exame segmentar. Identifique entre as causas listadas a seguir, aquelas que se apresentam como provocadoras da hiperbilirrubinemia direta no recém-nascido. I) Fisiológica. II) Hiperesplenismo. III) Doença hepática. IV) Doença das vias biliares. A alternativa que apresenta a resposta correta é:

A) I, II e III

B) I, II e IV

C) I, III e IV

D) II, III e IV

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

307080)

Enunciado: Bebê, sexo masculino, é levado, duas semanas após o parto, na maternidade de nascimento, com febre e eritema maculopapular em tronco, palmas e plantas de pés, com secreção nasal serosanguinolenta e hipocromia de mucosas. A mãe não fez pré-natal completo. Um exame da mãe revela VDRL positivo com título de 1:32. Com relação à epidemiologia da sífilis congênita no Brasil, pode se afirmar:

A) A incidência da sífilis congênita aumentou na última década.

B) Houve redução de incidência pediátrica, e aumento da sífilis do adulto.

C) O coeficiente de mortalidade infantil por sífilis reduziu nos últimos dez anos.

D) Houve aumento do diagnóstico em gestantes, com redução da sífilis congênita.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

278621)

Enunciado: Levando em consideração a fisiopatologia da Encefalopatia Hipóxico Isquêmica (EHI), assinale a alternativa correta.

A) A protease hidrolisa, prioritariamente, os fosfolipídios celulares, mas também pode causar a ruptura do esqueleto celular.

B) A fosfolipase hidrolisa os fofolipidios celulares, com liberação de ácido araquidônico e seus metabólitos NMDA e AMPA.

C) NMDA e AMPA são receptores gliais específicos que determinam a entrada de cálcio no compartimento intracelular, com ativação de enzimas como protease e fosfolipase.

D) A despolarização neural provoca a liberação de glutamato, aminoácido neuroinibitório, que se acumula nos espaços intersinápticos e intercelulares.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

278622)

Enunciado: São indicadores de mau prognóstico na encefalopatia hipóxico isquêmica do recém-nascido todos os abaixo, exceto.

A) Asfixia grave e prolongada.

B) Hipertensão intracraniana (>10mmHg).

C) Poliúria persistente.

D) Convulsões de início precoce.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

275993)

Enunciado: Você, acompanhando o serviço de pediatria do hospital de referência da sua cidade, auxilia na avaliação inicial de um recém-nascido. Após avaliar os três parâmetros, você verifica que é um recém- nascido com necessidade de reanimação. Em relação ao tema, analise a sequência a seguir e assinale a alternativa INCORRETA.

A) Os passos iniciais para um recém-nascido com mais de 34 semanas são: prover calor, posicionar a cabeça em leve extensão, aspirar vias aéreas (se necessário) e secar o recém-nascido.

B) Caso a frequência cardíaca seja menos que 100 bpm, haja apneia ou respiração irregular e seja um recém-nascido com menos de 34 semanas, deve- se iniciar ventilação com pressão positiva com balão e máscara facial com uma concentração de O2 de 21%, monitorar SatO2 com oximetria de pulso e monitorização cardíaca.

C) Caso a frequência cardíaca continue menor que 100 bpm, deve-se checar a técnica e considerar intubação.

D) Caso a frequência cardíaca continue a diminuir e fique menor que 60 bpm, indica-se a intubação traqueal, massagem cardíaca, O2 a 100% e considerar cateterismo venoso.

E) Caso a frequência cardíaca continue menor que 60 bpm, indica-se a administração de adrenalina endovenosa, preferencialmente pela veia umbilical.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

279050)

Enunciado: Sobre as causas de calcificações abdominais no neonato, assinale a alternativa incorreta.

A) Íleo meconial.

B) Atresia jejunal ou ileal.

C) Anomalia anorretal com fistula retovesical.

D) Imaturidade funcional do cólon.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

278631)

Enunciado: Assinale a alternativa que apresenta o intervalo de temperatura alvo central da hipotermia terapêutica do recém-nascido.

A) De 29,5 a 30,5 graus celsius.

B) De 30,5 a 31,5 graus celsius.

C) De 32,5 a 33,5 graus celsius.

D) De 33,5 a 34,5 graus celsius.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

279051)

Enunciado: Qual das condições a seguir é causa de enterocolite necrotizante em recém nascidos não prematuros?

A) Cardiopatia congênita cianótica.

B) Estenose hipertrófica do piloro.

C) Atresia do duodeno.

D) Má rotação com bandas de Ladd.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

278636)

Enunciado: Enterocolite necrotizante é a emergência gastrointestinal mais comum no período neonatal. Embora vários fatores contribuintes foram identificados, o fator de risco mais importante para apresentação da doença é:

A) Aleitamento materno.

B) Cateter central.

C) Sexo feminino.

D) Prematuridade.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

278644)

Enunciado: A hérnia diafragmática congênita é uma causa relativamente comum de desconforto respiratório neonatal. A maioria destas hérnias ocorrem no lado esquerdo. Assinale a correta.

A) As hérnias diafragmáticas congênitas posterolaterais são conhecidas como hérnias de Bochdalek.

B) As hérnias diafragmáticas congênitas posterolaterais são conhecidas como hérnias de Morgagni.

C) As hérnias diafragmáticas congênitas anteromediais são conhecidas como hérnias de Stoppa.

D) As hérnias diafragmáticas congênitas anteromediais são conhecidas como hérnias de Bochdalek.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

231344)

Enunciado: Recém-nascido, 40 semanas de idade gestacional, Apgar 9/10, sem fatores de risco, apresenta icterícia em face com 18 horas de vida. História obstétrica sem fatores de risco. Grupo sanguíneo materno: O +, do RN: B +. Exame físico: ativo, mamando bem, já eliminou mecônio e apresentou diurese. Nesse caso, está indicado:

A) aguardar completar 24 horas e colher exames para avaliar exsanguineotransfusão.

B) observar e reavaliar a icterícia antes da alta para decidir sobre a realização de exames.

C) colher exames laboratoriais para avaliar incompatibilidade ABO e decidir sobre fototerapia.

D) suspender o aleitamento materno, pois se trata de icterícia associada ao aleitamento materno.

E) indicar exanguineo transfusão pelo risco de kernicterus

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

231349)

Enunciado: Todas as alternativas representam a indicação de Ventilação com Pressão Positiva na sala de parto. EXCETO:

A) RN com 1apneia

B) RN com respiração irregular

C) RN com Freq Cardíaca menor que 100 bpm

D) RN com Hérnia Diafragmática

E) RN com Gasping

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

231351)

Enunciado: Recém nascido de 39 semanas, parto cesáreo, adequado para a idade gestacional, Apgar 9/10, bolsa rota no ato, líquido amniótico claro, apresenta taquipneia com retrações intercostais logo após o parto. Exame físico: ausculta pulmonar sem crepitantes. RX de tórax: aumento da trama vascular pulmonar. História obstétrica: sem intercorrências. Diante do quadro, o diagnóstico é:

A) pneumonia do recém-nascido.

B) síndrome de aspiração meconial.

C) taquipneia transitória do recém- -nascido.

D) hipertensão pulmonar persistente do recém-nascido.

E) membrana hialina

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

249289)

Enunciado: Qual é o objetivo do acompanhamento ambulatorial do prematuro?

A) Realizar o diagnóstico precoce das alterações de crescimento.

B) Identificar as alterações de peso no recém-nascido.

C) Detectar os possíveis desvios do crescimento normal, principalmente quanto ao peso, ao comprimento e ao perímetro cefálico.

D) Detectar os possíveis desvios do crescimento do perímetro cefálico.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

249205)

Enunciado: Qual é a dose de suplementação de cálcio e fósforo indicada para o recém-nascido pré-termo?

A) 02 ml/kg/dia, duas vezes ao dia.

B) 03 ml/kg/dia, três vezes ao dia.

C) 03 ml/kg/dia, nos intervalos das mamadas.

D) 02 ml/kg/dia, nos intervalos das mamadas.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

249212)

Enunciado: Observe as alternativas abaixo e assinale aquela que não representa uma causa comum de icterícia no período neonatal.

A) Anemia falciforme.

B) Deficiência de G6PD.

C) Icterícia pelo leite materno.

D) Icterícia fisiológica.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

249215)

Enunciado: Observando a figura apresentada abaixo, responda qual alteração morfológica está presente.

A) Polidactilia

B) Geno valgo

C) Sindactilia

D) Pés em garra

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

201775)

Enunciado: Todas as alternativas representam a indicação de ventilação com pressão positiva, EXCETO:

A) RN com apneia.

B) RN com respiração irregular.

C) RN com frequência cardíaca menor que 100 bpm.

D) RN com hérnia diafragmática.

E) RN com Gasping.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

201783)

Enunciado: A equipe MÍNIMA para atender ao RN na sala de parto deveria:

A) Um médico capaz de realizar todos os procedimentos de plantão à distância.

B) Um profissional de saúde que saiba todos os passos iniciais e faça a ventilação com máscara em cada nascimento.

C) Um profissional de saúde que saiba os passos iniciais e chame um médico se for necessário ventilar.

D) Um obstetra capaz de realizar todos os passos.

E) Ter um técnico de saúde que saiba todos os passos inclusive os procedimentos invasivos como intubação e cateterismo umbilical em todos os nascimentos.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

215524)

Enunciado: Todas as patologias citadas a seguir são comuns no período neonatal, EXCETO:

A) Taquipneia transitória.

B) Síndrome de aspiração do mecônio.

C) Pneumonia lobar.

D) Onfalocele.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

219860)

Enunciado: Recém-nascido de 3 dias de vida sob seus cuidados receberá alta da maternidade nesse momento. Sobre as triagens neonatais universais indicadas nessa idade, qual alternativa está CORRETA para orientação aos pais:

A) A triagem neonatal auditiva ou "teste de orelhinha" inclui a realização de avaliação por meio de emissões otoacústicas evocadas.

B) A triagem neonatal biológica ou "teste do pezinho" avalia distúrbios congênitos e hereditários, dentre eles a tirosinemia.

C) A triagem neonatal de cardiopatias congênitas críticas ou "teste do coraçãozinho" deve ser realizada após as primeiras 24 horas de vida.

D) A triagem neonatal ocular ou "teste do olhinho" é realizada através do teste do reflexo vermelho que avalia opacificação da retina.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

212163)

Enunciado: Diante de um recém-nascido assintomático com história materna de toxoplasmose na gestação é correto afirmar:

A) o pediatra deve ficar atento mesmo sem manifestações clínicas no momento do parto, devido à evolução posterior da doença com alterações oculares, como placas de coriorretinite e outras sequelas.

B) deve-se colher sangue para testes sorológicos e, se a IgM for negativa, descartar a possibilidade de transmissão transplacentária.

C) deve-se atentar para as questões oculares e, uma vez que passe no teste da orelhinha, descartar a possibilidade de déficit auditivo.

D) o diagnóstico de Toxoplasmose Congênita é baseado exclusivamente na comparação dos títulos sorológicos.

E) a atenção deve incluir pneumonites, anormalidades ósseas e neurológicas subclínicas.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

187778)

Enunciado: Mãe acompanhada no pré-natal de risco habitual. Realizou sorologias com resultados negativos para sífilis, HIV e hepatite B. Imune a Toxoplasmose. Deu entrada na maternidade em trabalho de parto e história de perda de líquido há 20 horas, com idade gestacional estimada de 34 semanas. Parto por via vaginal, imediatamente após a internação. Com uma hora de vida, dificuldade respiratória, apresentando pontuação de 4 pelo Boletim de Silverman-Anderson. Qual a conduta CORRETA em relação a abordagem de sepse neonatal precoce pelo estreptococo do grupo B?

A) Alta a partir de 24 horas se clinicamente estável

B) Iniciar antibioticoterapia logo após o nascimento

C) Manter o recém-nascido em observação clínica por 48 horas

D) Solicitar exames laboratoriais: hemograma, hemocultura e PCR e aguardar resultado da hemocultura para iniciar antibioticoterapia

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

182736)

Enunciado: Visando a adoção de estratégia protetora, com objetivo de minimizar os efeitos adversos da ventilação mecânica invasiva em prematuros extremos, deve-se:

A) Evitar valores de $PaCO_2$ acima de 45mmHg.

B) Manter a saturação de oxigênio de 85% a 89%.

C) Promover o recrutamento alveolar com uso de PEEP de 8 a 10cmH_2O.

D) Utilizar volume corrente de 4 a 6ml/Kg.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

187789)

Enunciado: Assinale a alternativa CORRETA em relação aos distúrbios metabólicos no período neonatal?

A) A hipocalcemia neonatal precoce apresenta-se, na maioria das vezes, sintomática

B) Asfixia perinatal não é o fator de risco para hipocalcemia

C) Não há sintomas específicos associados a hipoglicemia, podendo os mesmos estarem presentes em outros distúrbios metabólicos

D) Para filhos de mãe diabética está indicado screening mais prolongado, estendendo-se por 48 a 72 horas de vida

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

182751)

Enunciado: Quanto à transmissão do HIV em crianças, pode-se afirmar que:

A) Atualmente predomina-se a transmissão pelo sangue e seus produtos contaminados com HIV.

B) A maioria é infectada pela transmissão materno-infantil, durante a gestação e o parto e por meio do aleitamento.

C) O convívio social com os pais infectados tem sido causa frequente de transmissão aos filhos.

D) A transmissão materno-infantil de mãe soropositiva para o HIV ocorre em mais de 90% das gestações.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

187803)

Enunciado: Lactente, 40 dias de vida, sexo masculino com quadro de icterícia prolongada. Nasceu de parto normal, pesando 3kg. Exames de triagem neonatal normais. Qual achado é o MAIS INDICATIVO de diagnóstico de atresia de vias biliares?

A) Colúria

B) Esplenomegalia

C) Ganho de peso adequado

D) Presença de fezes acólicas

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

182816)

Enunciado: Dentro da definição de caso, existem critérios utilizados para definição de casos de Sífilis Congênita. Abaixo estão listados os do Primeiro Critério, porém um deles está inadequado, assinale-o:

A) Criança cuja mãe apresente, durante o pré-natal ou no momento do parto, teste para sífilis não treponêmico reagente com qualquer titulação e teste treponêmico reagente, que não tenha sido tratada ou tenha recebido tratamento inadequado.

B) Criança cuja mãe não foi diagnosticada com sífilis durante a gestação e, na impossibilidade de a maternidade realizar o teste treponêmico, apresente teste não treponêmico reagente com qualquer titulação no momento do parto.

C) Criança cuja mãe apresente, durante o pré-natal ou no momento do parto, teste para sífilis não treponêmico reagente com qualquer titulação e teste treponêmico reagente, que tenha sido tratada ou tenha recebido tratamento adequado.

D) Criança cuja mãe não foi diagnosticada com sífilis durante a gestação e, na impossibilidade de a maternidade realizar o teste não treponêmico, apresente teste treponêmico reagente no momento do parto.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

152631)

Enunciado: Qual é a conduta de eleição que deve ser estabelecida em um recém-nascido a termo, cuja mãe é portadora de sífilis e a sorologia do RN é positiva?

A) Penicilina cristalina por 14 dias.

B) Eritromicina por 15 dias.

C) Cefalosporina por 7 dias.

D) Cefalosporina de terceira geração por 10 dias.

E) Amoxicilina oral por 8 dias.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

152640)

Enunciado: O primeiro minuto de vida (denominado de ouro), refere ao tempo máximo após o nascimento para iniciar:

A) Ventilação com pressão positiva.

B) Oferta de O2 suplementar

.

C) Intubação orotraqueal.

D) Massagem cardíaca.

E) Adrenalina EV.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

152645)

Enunciado: Indicações de ventilação com pressão positiva por máscara, exceto:

A) Apneia.

B) Respiração Irregular.

C) FC < 100 bpm.

D) Suspeita de Hérnia Diafragmática.

E) Gasping.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

152630)

Enunciado: Recém-Nascido, Pequeno para Idade Gestacional (PIG), apresenta microcefalia, lábio superior fino e fenda palpebral pequena. Qual substancia pode ter sido usada pela mãe?

A) Álcool.

B) Cocaína.

C) Maconha.

D) Benzodiazepínico.

E) Heroína.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

158776)

Enunciado: Em que idade gestacional ocorre risco mais elevado para ocasionar Síndrome da Rubéola Congênita?

A) Nas primeiras 11 semanas.

B) Entre 12 e 13 semanas.

C) Entre 13 e 15 semanas.

D) Entre 15 e 16 semanas.

E) Acima de 17 semanas.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

131340)

Enunciado: Dentre os itens abaixo, aquele que é fator preditivo de risco para icterícia neonatal severa é:

A) Gestação de mais de 40 semanas.

B) História familiar negativa para deficiência de glicose 6 fosfato desidrogenase.

C) Bilirrubina sérica maior que 5mg% nas primeiras 24 horas de vida.

D) Uso de meperidina durante o parto.

E) Parto vaginal.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

131345)

Enunciado: Ao nascer, a maioria dos recém-nascidos com infecção congênita por citomegalovírus é:

A) Asfixiada.

B) Assintomática.

C) Pré-termo.

D) Pequeno para a idade gestacional.

E) Natimorto.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

131350)

Enunciado: A pele do recém-nascido normal pode apresentar as seguintes características,

EXCETO:

A) Milium sebáceo.

B) Hemangioma macular.

C) Eritema tóxico.

D) Máculas brancas.

E) Vérnix.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

140164)

Enunciado: O procedimento mais adequado na prevenção da síndrome da morte súbita do lactente:

A) Dormir com os pais

B) Usar pulsoximetro

C) Usar travesseiro macio e alto

D) Colocar em decúbito lateral para evitar engasgo

E) Cocar em posição supina

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

131380)

Enunciado: Há indicação definitiva de intubação em todos os pacientes abaixo, exceto:

A) RN com Apgar "menor ou igual a" 3 no 1º minuto.

B) RN submetidos à ventilação prolongada com balão e máscara.

C) RN com suspeita ou diagnóstico de hérnia diafragmática que necessitam ventilação com pressão.

D) Positiva.

E) RN com mecônio no líquido aminiótico e que não se apresenta vigoroso ao nascimento.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

131386)

Enunciado: Qual das alternativas abaixo corresponde, na sequência correta ao A, B e C da reanimação neonatal:

A) Iniciar a respiração, manter a circulação e manter a via aérea pérvia.

B) Manter a via aérea pérvia, manter a circulação e iniciar a respiração.

C) Manter a via aérea pérvia, iniciar a respiração, e manter a circulação.

D) Iniciar a respiração, manter a via aérea pérvia e manter a circulação.

E) Nenhuma das anteriores.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

131393)

Enunciado: Quando o recém-nascido é prematuro ou apresenta alterações na respiração, tônus e/ou coloração da pele ou mucosa, quais são os passos iniciais da reanimação que devem ser executados, em sequência? I ? aspirar a boca e as narinas; II ? colocar o RN sob fonte de calor radiante; III ? posicionar a cabeça do RN; IV ? secar o RN e desprezar os campos úmidos.

A) II; III; I; IV.

B) IV; II; III; I.

C) I; IV; II; III.

D) III; I; II; IV.

E) III; II; I; IV.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

131331)

Enunciado: Uma criança acabou de nascer. Ela foi colocada sob calor radiante, posicionada, aspirada e feita a estimulação tátil, porém, permanece em apnéia. Qual a sua conduta?

A) Administrar oxigênio inalatório a 100%.

B) Administrar oxigênio inalatório a 80%.

C) Ventilar através da administração de oxigênio sobre pressão nas narinas.

D) Ventilar com oxigênio através de ambu e máscara.

E) Ventilar com oxigênio através de tubo endotraqueal.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

134844)

Enunciado: Na sala de parto, rotineiramente, aplica-se 1 mg intramuscular, no recém-nascido, de vitamina K. Essa medida visa evitar qual das patologias abaixo?

A) Púrpura trombocitopênica.

B) Eritroblastose fetal.

C) Deficiência nutricional.

D) Doença hemorrágica.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

134851)

Enunciado: É causa de hemorragia retiniana em lactentes, além da síndrome do bebê sacudido:

A) Parto normal.

B) Discrasia sanguínea.

C) Endocardite.

D) Hipertensão grave.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

134064)

Enunciado: A triagem auditiva neonatal deve ser realizada

A) nos recém-nascidos com alterações craniofaciais.

B) nos recém-nascidos que foram internados em UTI neonatal.

C) em todos os recém-nascidos com 24 ? 48h de vida.

D) nos recém-nascidos que apresentam achados clínicos sugestivos de infecção congênita.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

134060)

Enunciado: Recém-nascido a termo, atendido na sala de parto 30 segundos após o nascimento, não apresenta movimentos respiratórios espontâneos e a sua frequência cardíaca é de 90 bpm. Diante de tal caso, indique a conduta CORRETA.

A) Infundir adrenalina EV.

B) Ventilar com pressão positiva.

C) Prover 100% de oxigênio.

D) Realizar massagem cardíaca.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

134067)

Enunciado: A infecção congênita que o Ministério da Saúde considera como evento sentinela é a:

A) Sífilis.

B) Varicela.

C) adenovirose.

D) citomegalovirose.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

134820)

Enunciado: O exame considerado como padrão ouro pela literatura para a pesquisa de maturidade pulmonar fetal é:

A) O teste de Clements.

B) A pesquisa de corpos lamelares.

C) A pesquisa de fosfatidilglicerol.

D) A relação lecitina/esfingomielina.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

110531)

Enunciado: Dentre os itens abaixo, aquele que é fator preditivo de risco para icterícia neonatal severa é:

A) Gestação de mais de 40 semanas;

B) História familiar negativa para deficiência de glicose 6-fosfato desidrogenase;

C) Bilirrubina sérica maior que 5 mg/dL nas primeiras 24 horas de vida;

D) Uso de meperidina durante o parto;

E) Parto vaginal.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

110536)

Enunciado: Ao nascer, a maioria dos recém-nascidos com infecção congênita por citomegalovírus é:

A) asfixiado;

B) assintomática;

C) pré-termo;

D) pequeno para a idade gestacional;

E) natimorto.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

110544)

Enunciado: Um recém-nascido de cinco dias é trazido ao ambulatório. Ele está clinicamente bem e a mãe procura o serviço porque ele está muito "amarelo?. Além de bilirrubina total e frações, os exames a serem solicitados são:

A) transaminases e hemograma;

B) hemograma e contagem de reticulócitos;

C) transaminases e marcadores de hepatite;

D) reticulócitos e tipagemsanguínea (mãe e recém-nascido);

E) tipagemsanguínea (mãe e recém-nascido) e marcadores de hepatite.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

110558)

Enunciado: Uma criança acabou de nascer. Ela foi colocada sob calor radiante, posicionada, aspirada e feita a estimulação tátil, porém, permanece em apneia. Qual a sua conduta?

A) ventilar com oxigênio através de ambu e máscara;

B) administrar oxigênio inalatório a 80%;

C) ventilar através da administração de oxigênio sobre pressão nas narinas;

D) administrar oxigênio inalatório a 100%;

E) ventilar com oxigênio através de tubo endotraqueal.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

109985)

Enunciado: Logo após o nascimento um recém-nascido de termo apresenta-se com taquipneia, retrações com piora progressiva e cianose persistente. O abdome encontra-se escavado. Ventilação com bolsa máscara é iniciada. A auscuta revela sons respiratórios diminuídos à esquerda e bulhas cardíacas que são mais intensas à direita. A explicação MAIS provável para esses achados é:

A) Dextrocardia com situs solitus.

B) Pneumotórax.

C) Hérnia diafragmática.

D) Atresia esofágica com fístula traqueoesofágica.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

109989)

Enunciado: Dos agentes abaixo, qual é o MENOS provável de causar sepse neonatal de início precoce?

A) L. monocytogenes.

B) Estreptococos do grupo B.

C) Streptococcus pneumoniae.

D) E. coli.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

109993)

Enunciado: Qual das afirmações seguintes é VERDADEIRA a respeito de infecção congênita por CMV?

A) Coriorretinite é a manifestação clínica mais comum.

B) Infecção fetal ocorre apenas após infecção materna primária.

C) Recém- nascidos infectados eliminam vírus na urina.

D) Sequelas a longo prazo não ocorrem em neonatos infectados que são sintomáticos.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

109996)

Enunciado: Recém- nascido pequeno para a idade gestacional, que apresenta microcefalia, erupção petequial disseminada, cataratas bilaterais e estenose pulmonar, provavelmente apresenta qual infecção?

A) Rubéola.

B) Citomegalovírus.

C) Toxoplasmose.

D) Sífilis.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

109779)

Enunciado: RN pré-termo tardio, com IG 36 semanas e 5 dias, peso de nascimento 2.580 g, recebe alta com 72 horas de vida, com aleitamento materno exclusivo e pesando 2.300 g, com bons controles de dextro. Qual é a sua orientação na alta?

A) Retorno em 48 horas no consultório para reavaliação.

B) Retorno em 1 semana no consultório para reavaliação.

C) Retorno para reavaliação quando completar 15 dias de vida.

D) Retorno para reavaliação após tomar vacina da hepatite B.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

110024)

Enunciado: Criança com lábio e palato fendidos. Qual é a próxima etapa da avaliação?

A) Ultrassonografia transfontanela.

B) Consulta com cirurgia plástica.

C) Exame físico cuidadoso.

D) Cariótipo.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

86654)

Enunciado: Indique a alternativa errada:

A) Situações como controle de glicemia capilar, fototerapia e uso de antibioticoterapia são suficientes para que o recém-nascido não possa permanecer em alojamento conjunto.

B) Parto operatório, doença mental materna, depressão puerperal e dificuldades de deambulação materna não são contraindicações para o alojamento conjunto.

C) O sistema de alojamento conjunto não isenta a equipe multiprofissional de sua responsabilidade com os cuidados com o neonato.

D) Bebês portadores de toxoplasmose congênita, bem como anomalias congênitas menores podem ser referenciados para o sistema de alojamento conjunto.

E) A alta hospitalar do neonato a termo, saudável, sem intercorrências, deve se dar após 48 horas de vida.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

86679)

Enunciado: Ao reavaliar um recém-nascido a termo durante a assistência em sala de parto, após medidas iniciais de aquecimento, posicionamento e desobstrução de vias aéreas, nota-se padrão respiratório irregular e frequência cardíaca de 70 bpm. A melhor conduta, segundo diretrizes do programa de reanimação neonatal, a ser seguida é:

A) Realizar ventilação com pressão positiva com balão autoinflável sob máscara e O2 a 100% inicialmente, caso não haja dispositivo blender, com reavaliação de frequência cardíaca, cor e padrão respiratório em 30 segundos.

B) Realizar ventilação com pressão positiva com balão autoinflável sob máscara e ar ambiente inicialmente, caso não haja dispositivo blender, com reavaliação de frequência cardíaca e padrão respiratório em 30 segundos.

C) Realizar ventilação com pressão positiva com balão autoinflável sob tubo endotraqueal com O2 a 100% inicialmente, com reavaliação de frequência cardíaca e cor após 30 segundos.

D) Realizar ventilação com pressão positiva com ventilador mecânico manual em tubo T sob máscara com O2 a 50% inicialmente, caso tenha dispositivo blender acoplado.

E) Realizar ventilação com pressão positiva com balão autoinflável sob tubo endotraqueal com ar ambiente, com reavaliação de frequência cardíaca e cor após 30 segundos.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

86684)

Enunciado: Puérpera com 23 anos dá à luz recém-nascido a termo, com boas condições de vitalidade e sem nenhuma anormalidade ao exame físico. Durante coleta de dados do pré-natal, revela que no terceiro trimestre de gestação o VDRL se tornou positivo na diluição 1:32. Afirma que iniciou tratamento 20 dias antes do parto com penicilina benzatina e que seu parceiro não necessitou de medicamento, já que foi não reator. Considerando as normas do Ministério da Saúde, a melhor conduta dentre as descritas será:

A) Não realizar investigação neste momento, já que a mãe foi adequadamente tratada, devendo ser realizado acompanhamento ambulatorial do neonato.

B) Colher novo VDRL materno, além de hemograma, punção lombar, radiografia de ossos longos e VDRL sangue periférico do recém-nascido e, caso qualquer alteração destes ou impossibilidade de seguimento, iniciar tratamento.

C) Colher apenas VDRL materno e de sangue periférico do recém-nascido. Se o do neonato for titulação maior ou igual a da mãe: iniciar tratamento com penicilina procaína por 14 dias.

D) Colher VDRL materno e de sangue periférico do recém-nascido. Caso o do neonato for menor que o da mãe, fazer ainda assim dose de penicilina benzatina, para então liberar alta hospitalar.

E) Colher VDRL do recém-nascido. Se menor que o materno em pelo menos 1 titulação, deverá receber alta, sem maiores investigações.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

86623)

Enunciado: Recém-nascido a termo, 39 semanas, com peso de nascimento: 3450 g, inicia icterícia com 22 horas de vida, sem outras alterações ao exame físico. A tipagem sanguínea materna é O negativo e a do neonato é B positivo. Teste de Coombs direto negativo. A hipótese mais provável é:

A) Icterícia neonatal tardia fisiológica.

B) Icterícia neonatal precoce por incompatibilidade sanguínea ABO.

C) Icterícia neonatal precoce por incompatibilidade sanguínea ABO e RH.

D) Icterícia neonatal precoce por incompatibilidade sanguínea RH.

E) Icterícia neonatal tardia por deficiência da enzima glicose-6-fosfato desidrogenase.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

86629)

Enunciado: Recém-nascido de parto cesárea, na ausência de trabalho de parto, prematuro tardio e peso de nascimento: 2.350 g, evoluiu com desconforto respiratório precoce, necessitando de suporte de oxigenoterapia, sob hood com fiO2: 30%, apresentando à radiografia de tórax: alargamento de espaços intercostais, com retificação de arcos, além de cisurite à direita. O diagnóstico mais provável neste caso é:

A) Síndrome do desconforto respiratório.

B) Síndrome de aspiração meconial.

C) Síndrome de aspiração do líquido amniótico.

D) Pneumonia intrauterina.

E) Taquipneia transitória do recém-nascido.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

86862)

Enunciado: Qual o tempo preconizado, baseado em evidência, recomendado para clampeamento do cordão umbilical em recém nascidos?

A) Clampear quando não sentir a pulsação do cordão umbilical;

B) 3 minutos;

C) 2 minutos;

D) 1 minuto;

E) Nenhuma das anteriores.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

86878)

Enunciado: Lactente de 2 meses é trazido à consulta médica por apresentar choro frequente e obstrução nasal. No exame físico apresenta-se com palidez importante, dor intensa na manipulação de membro superior direito, rinite piosanguinolenta, e hepatoesplenomegalia. O diagnóstico mais provável para o caso é:

A) Sífilis congênita;

B) Septicemia;

C) Leucemia;

D) Maus tratos;

E) Rubéola congênita.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

158413)

Enunciado: Um médico, em um exame de um recém nascido, faz a manobra de Barlow e ela é positiva. Neste caso, a articulação comprometida é a do:

A) Pé.

B) Coluna vertebral.

C) Cotovelo.

D) Ombro.

E) Quadril.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

158418)

Enunciado: Assinale a alternativa que responde CORRETAMENTE à pergunta abaixo. Criança nascida a termo, por cesariana de urgência devido a descolamento prematuro de placenta, apresenta-se em apneia e cianótica após receber passos iniciais de reanimação. Qual o passo a seguir?

A) Entubação traqueal acompanhada de oxigênio inalatório para imediata ventilação.

B) Iniciar ventilação por pressão positiva com ar ambiente com balão e máscara, e instalar oximetria de pulso.

C) Oferecer oxigênio inalatório por 30 segundos e verificar oximetria de pulso.

D) Instalar oximetria de pulso e realizar estímulo tátil.

E) Realizar expansão com soro fisiológico ? 10 ml/kg.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

362430)

Enunciado: A afecção respiratória que acomete mais frequentemente recém-nascidos prematuros com menos de 28 semanas de gestação, do sexo masculino, em filhos de mães diabéticas, e que sofreram asfixia ao nascimento, chama-se:

A) Síndrome do escape de ar.

B) Síndrome da aspiração de mecônio.

C) Síndrome da hipertensão pulmonar persistente neonatal.

D) Síndrome do desconforto respiratório por deficiência de surfactante alveolar.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

362427)

Enunciado: Pedro, RN a termo, adequado para idade gestacional, PN 3400g, filho de mãe comorbidade e com pré-natal adequado, ultrassom morfológico normal. Sorologia de toxoplasmose com 7 semanas de gestação: IgM (método Elisa) positivo, IgG positivo, com alta avidez. Exame clínico normal ao nascimento. A conduta recomendada é:

A) realizar avaliação de fundo de olho, ultrassonografia transfontanela e abdominal, hemograma, punção lombar e sorologias do recém-nascido, antes de indicar o tratamento.

B) coletar sorologia para toxoplasmose do sangue do cordão, realizar fundoscopia e indicar o tratamento dependendo do resultado.

C) realizar cuidados de rotina, não havendo necessidade de investigação diagnóstica ou de tratamento do recém-nascido.

D) iniciar tratamento com sulfadiazina, pirimetamina e ácido folínico por um ano, independentemente do resultado de exames.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

362424)

Enunciado: Gestante em acompanhamento pré-natal fez diagnóstico de HIV com 29 semanas. Iniciou TARV e fez uso regular até o nascimento do bebê. A Carga viral (CV) com 38 semanas era de 1400 cópias. Com relação ao manejo do RN, qual deverá ser a conduta no alojamento conjunto:

A) Coletar CV ao nascimento e iniciar profilaxia com AZT + 3TC + RAL por 28 dias.

B) Coletar CV no primeiro dia de vida e iniciar profilaxia com AZT xarope por 28 dias.

C) Coletar CV no 14° dia de vida e iniciar profilaxia com AZT e NVP por 28 dias.

D) Coletar CV ambulatorialmente e iniciar profilaxia com TDF + 3TC + DTG.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

327286)

Enunciado: Pedro é recém-nascido a termo, com peso de nascimento de 3 Kg, filho de mãe que descobriu HIV na 20ª semana de gestação. Iniciou uso de TARV, assim que teve o diagnóstico. No momento do Parto, não havia registro da Carga Viral, após o início da TARV. Qual a conduta mais adequada com Pedro na maternidade e seguimento:

A) Coletar CV na sala de parto, aguardar resultado para iniciar TARV profilática por via oral e encaminhar para seguimento, com coleta de nova CV com: 14 dias, na 6ª e 12ª semana de vida.

B) Coletar CV na sala de parto, iniciar AZT, 3TC e RAL por via oral e encaminhar para seguimento com coleta de nova CV com: 14 dias, na 6ª e 12ª semana de vida.

C) Coletar CV na sala de parto, iniciar AZT por via oral e encaminhar para seguimento com coleta de nova CV com: 14 dias, na 6ª e 12ª semana de vida.

D) Coletar CV na sala de parto, iniciar AZT, NVP por via oral e encaminhar para seguimento com coleta de nova CV com: 14 dias, na 6ª e 12ª semana de vida.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

298250)

Enunciado: Um recém-nascido a termo, com 25 horas de vida, é submetido ao teste do coraçãozinho (teste de oximetria), obtendo o seguinte resultado: membro superior direito 100% e membro inferior esquerdo 96%. A conduta que deve ser tomada nessa situação é:

A) Dar alta com 48 horas de vida, sem investigação adicional.

B) Realizar ecocardiograma com urgência.

C) Repetir o exame em uma hora e, se permanecer alterado, indicar ecocardiograma.

D) Internar em UTI neonatal, iniciar prostaglandina IV para manter o canal arterial prévio e, somente depois, solicitar ecocardiograma.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

298254)

Enunciado: Gestante de 21 anos, primigesta, teve a primeira consulta de pré-Natal no primeiro trimestre de gestação e apresentou teste rápido para HIV positivo. Foi encaminhada para acompanhamento no SAE e manteve o pré-natal na UBS. Apresentou a primeira carga viral HIV 25.000 cópias, CD4 520 células. Iniciou tratamento com TDF + 3TC + DTG após 20 semanas de gestação. Não tinha outras ISTs ou comorbidades. Com 35 semanas de idade gestacional realizou nova Carga viral que estava em 1000 cópias. O Bebê nasceu com 39 semanas de gestação, parto cesárea, peso de nascimento 3500g Estatura 49cm PC 35 cm, apgar 9/10. Com relação a classificação materna e as medidas a serem tomadas com relação ao recém nascido na maternidade, assinale a alternativa CORRETA:

A) Gestante de alto risco. Coletar Carga viral do RN, iniciar profilaxia com AZT + 3TC + Raltegravir e não amamentar.

B) Gestante de baixo risco. Coletar Carga viral do RN, iniciar profilaxia com AZT e não amamentar.

C) Gestante de alto risco. Coletar Carga viral do RN, iniciar profilaxia com AZT + Nevirapina e não amamentar.

D) Gestante de baixo risco. Coletar Carga viral do RN, iniciar profilaxia com AZT e liberar amamentação.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

298255)

Enunciado: Você é o plantonista da maternidade no interior e recebe uma parturiente que chega em período expulsivo. Ao realizar os testes rápidos, vêm os seguintes resultados: HBsAg negativo, HIV negativo, Sífilis reagente. O bebê nasce ativo, com Idade gestacional de 37 semanas, PN 2800g Est 48 cm PC 34 cm, com exame físico normal. Recebe aleitamento na sala de parto e vai para o alojamento conjunto. Você pede à mãe o cartão do pré-Natal e verifica que no primeiro trimestre ela apresentou FTAbs positivo e VDRL 1:128. Ela nunca teve sífilis, não apresentava sintomas e nem o parceiro. Ambos receberam 3 doses de penicilina benzatina 1.200.000Ui em cada nádega por 3 semanas com intervalo de 7 dias entre elas, todas registradas no cartão. Possuem relacionamento estável e monogâmico. No segundo trimestre o VDRL encontrava-se 1:64 e na maternidade o exame veio 1:16. Você solicita VDRL do RN e vem 1:16 Como você classificaria a mãe e qual sua conduta com relação ao RN?

A) Mãe adequadamente tratada. Trata-se de Bebê exposto a sífilis que deverá realizar VDRL com 1, 3, 6 meses no seguimento ambulatorial.

B) Mãe adequadamente tratada. Trata-se de Bebê com sífilis congênita que deverá receber penicilina cristalina ou procaina, dependendo do resultado do liquor.

C) Mãe inadequadamente tratada. Trata-se de Bebê exposto a sífilis que deverá realizar VDRL com 1, 3, 6 meses no seguimento ambulatorial.

D) Mãe inadequadamente tratada. Trata-se de Bebê com sífilis congênita que deverá receber penicilina cristalina ou procaina, dependendo do resultado do liquor.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

298264)

Enunciado: Recém-nascido a termo nasceu de parto vaginal após uma gestação sem intercorrências. Ao exame inicial, observa-se que a criança apresenta opacificação do cristalino de ambos os olhos, com reflexo vermelho ausente. O pai havia realizado cirurgia em idade precoce. Sem outras alterações no restante do exame físico. O diagnóstico mais provável é:

A) Catarata congênita

B) Glaucoma congênito

C) Atrofia de nervo optico

D) Toxoplasmose congênita

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

286765)

Enunciado: Um recém-nascido a termo, com peso de nascimento de 3000g evoluiu após alguns minutos de vida com taquipnéia e cianose central. Ao exame está hidratado, com murmúrio vesicular audível em ambos os hemitórax e ausência de sopro cardíaco. O oxímetro de pulso na mão direita mostra saturação de 86%. O RN é então colocado no halo de oxigênio e após 20 minutos a saturação atinge o valor de 88%. A hipótese diagnóstica mais provável é:

A) Taquipnéia transitória

B) Cardiopatia congênita cianogênica

C) Pneumonia congênita

D) Síndrome do sequestro pulmonar

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

286770)

Enunciado: São doenças detectadas através do teste do pezinho no SUS:

A) Anemia falciforme, hipotireoidismo, fibrose cística e fenilcetonúria.

B) Anemia de fanconi, hiperparatireoidismo, fibrose cistica e deficiência de biotinidase.

C) Hiperplasia adrenal congênita, deficiência de G6PD, fibrose cistica e deficiência de biotinidase.

D) Anemia falciforme, hiperparatireoidismo, deficiência de G6PD e fenilcetonúria.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

286771)

Enunciado: Um recém-nascido de parto cesárea por DHEG, apgar 7/8, PN 1450g, comprimento 43 cm e perímetro cefálico 31 cm recebeu estimativa de idade gestacional de 33 semanas e 4 dias. Classifique o recém-nascido:

A) Macrossômico ao nascer

B) Baixo peso ao nascer

C) Muito baixo peso ao nascer

D) Extremo baixo peso ao nascer

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

286774)

Enunciado: A sífilis congênita ainda representa um sério problema de saúde pública no Brasil. Sobre esta infecção, é CORRETO afirmar que:

A) O acometimento fetal é mais comum quando a infecção materna ocorre no primeiro trimestre da gestação.

B) A infecção transplacentária pode ocorrer durante toda a gestação e em qualquer estágio de infecção materna.

C) O teste treponêmico de amostra de cordão umbilical apresenta uma boa sensibilidade e especificidade.

D) O VDRL é um bom marcador para diagnóstico no recém-nascido, mas não serve para seguimento.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

252268)

Enunciado: Você é chamado na sala de parto para atender um recém-nascido. O recém-nascido é de termo, sexo masculino, parto vaginal. Nasceu hipotônico, choro ausente. Levado ao berço aquecido, você posiciona o RN, aspira vias aéreas e ao exame ele se encontra em apneia e com frequência cardíaca ausente, qual seu próximo passo?

A) Iniciar massagem cardíaca.

B) Ventilação com pressão positiva com máscara.

C) Intubação traqueal.

D) Adrenalina 1:10 000 em veia umbilical 0,1ml/Kg.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

252274)

Enunciado: Na sala de parto um recém-nascido de termo é seco e estimulado ao nascer, está em apneia, hipotônico e cianótico com frequência cardíaca de 70 bpm. Com um minuto de vida, continua cianótico, hipotônico e tem uma frequência cardíaca de 70 bpm, respirando irregularmente a uma taxa de 15 respirações por minuto e faz algumas caretas durante a estimulação, mas não chora. A equipe segue as diretrizes apropriadamente, faz ventilação com pressão positiva com máscara. Aos 5 minutos, a frequência cardíaca subiu para 90 bpm, o tronco ficou corado (mas as mãos e os pés permanecem cianóticos), está respirando espontaneamente e tem melhora do tônus flexor, mas não se movimenta ativamente. Aos 10 minutos, o lactente está chorando, respirando, se movimentando ativamente, completamente corado e com frequência cardíaca de 120 bpm. Quais notas foram as pontuações do Boletim de Apgar dessa criança?

A) 3, 7 e 9.

B) 3, 6 e 10.

C) 4, 6 e 9.

D) 4, 7 e 10.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

252275)

Enunciado: Recém-nascido masculino, 10 dias de vida, vem à consulta na UBS pela primeira vez. Foi um recém-nascido de termo, parto cesáreo, sem intercorrências, com peso de nascimento de 3.350g, boletim de Apgar 9/10/10. Tipagem sanguínea materna e do RN: B+. A criança recebeu alta no 3º dia de vida, com peso de 3.100g. Na consulta de hoje, a mãe refere que produz bastante leite e que a criança suga bem, mas está cansada porque a criança quer mamar de hora em hora, eventualmente com intervalos de 30 minutos entre as mamadas. Criança evacua três vezes ao dia, com fezes amareladas. Diurese clara, com 4 trocas de fraldas ao dia. Ao exame clínico, apresenta icterícia zona III, sem outras alterações significativas. Peso atual de 3.205g. A conduta indicada é:

A) Encaminhar a mãe para avaliação psicológica e convocar familiares para auxiliarem o cuidado.

B) Reforçar a manutenção do regime de livre demanda e realizar seguimento habitual de puericultura.

C) Iniciar fototerapia, com investigação de infecções, doenças metabólicas e erros inatos do metabolismo.

D) Orientar mamadas mais longas e efetivas, e marcar retorno precoce para reavaliação do peso.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

208303)

Enunciado: Gestante de 39 semanas deu entrada na maternidade em trabalho de parto. Apresentou VDRL do 3º trimestre da gestação reagente com titulação 1:4 e relata ter feito tratamento com eritromicina porque a paciente referia "alergia a penicilina". O recém-nascido nasceu vigoroso e assintomático. Foi realizado VDRL no sangue periférico do recém-nascido cujo resultado mostrou-se "reagente" 1:2. Qual é a alternativa que melhor descreve o estado clínico e a conduta para o recém-nascido?

A) Não haveria necessidade de investigação sorológica no RN, pois a eritromicina é droga de escolha no caso de história de alergia à penicilina.

B) Não é portador de sífilis congênita, pois seu valor do VDRL é menor que o valor do exame da mãe. Alta com orientações.

C) Portador de sífilis congênita. Utilizar ceftriaxona devido à possibilidade de alergia à penicilina no recém-nascido.

D) Portador de sífilis congênita. Utilizar penicilina cristalina.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

208364)

Enunciado: Recém-nascido a termo, filho de mãe com diabetes gestacional, com peso de nascimento de 4350 g. Exame físico com 1 hora de vida: neurológico normal; com capacidade de sucção ativa. Exames laboratoriais: glicemia capilar = 35 mg/dl; hematócrito = 55%. Após coletar sangue para dosagem de glicose, a melhor conduta é:

A) Infusão rápida de glicose intravenosa a 10% e repetir a dosagem de glicose.

B) Colocar o recém-nascido para aleitamento materno e repetir glicemia capilar.

C) Aguardar o resultado para a decisão de como proceder.

D) Administrar fórmula láctea por sonda gástrica e repetir a glicemia capilar

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

176089)

Enunciado: Você é o médico responsável pelo alojamento conjunto de uma maternidade municipal e se depara com um recém-nascido a termo, parto vaginal e com peso de nascimento de 3.450 g, em seu primeiro dia de vida. Paciente apresenta exame clínico sem alterações significativas e encontra-se com boa aceitação do aleitamento materno exclusivo. Ao verificar carteira de pré-natal, você percebe que a mãe apresenta sorologia para toxoplasmose negativa, em coleta realizada no segundo trimestre, e positiva, em coleta realizada no terceiro trimestre de gestação. Diante do descrito, assinale a assertiva que é considerada CORRETA neste momento:

A) Recomenda-se coleta de teste sorológico da criança e, frente a resultado negativo, afasta-se a possibilidade de infecção perinatal.

B) Caso confirmada a infecção perinatal por toxoplasmose, o paciente deverá receber tratamento medicamentoso com sulfadiazina, pirimetamina e ácido folínico por até 6 meses.

C) Caso confirmada a infecção perinatal por toxoplasmose, devemos ficar atentos às possíveis complicações tardias que o recém-nascido pode apresentar, dentre elas a cardiopatia congênita é a mais frequente.

D) Recomenda-se coleta de testes sorológicos da mãe e recém-nascido, além de avaliação adicional inicial com hemograma completo, fundoscopia ocular e ultrassonografia transfontanelar.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

176115)

Enunciado: Recém-nascido de parto normal, a termo, apresenta icterícia com 22 horas de vida. Tipagem Sanguínea (TS) da mãe: O +; TS do RN: A+. Exame físico: discreta icterícia em face e parte superior do tórax. Exames laboratoriais: BT = 12 mg/dl; Coombs direto fracamente positivo, presença de esferócitos na lâmina de sangue periférico e teste da fragilidade osmótica negativo. A hipótese diagnóstica é:

A) Doença hemolítica isoimune ABO.

B) Doença hemolítica isoimune Rh.

C) Esferocitose hereditária.

D) Deficiência congênita de piruvatoquinase.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

151949)

Enunciado: Recém-nascido a termo, adequado para a idade gestacional, apresenta icterícia com 16 horas de vida, sem outras alterações ao exame físico. A mãe tem tipagem sanguínea "O" negativo e, o recém-nascido, "A" positivo; Coombs direto: negativo. A hipótese diagnóstica é:

A) Icterícia fisiológica.

B) Doença hemolítica pelo sistema ABO.

C) Icterícia associada ao aleitamento materno.

D) Deficiência de glicose-6-fosfato desidrogenase.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

151893)

Enunciado: Recém-nascido de termo, com 48h de vida, desenvolve pápulas brancas e pequenas distribuídas pela face, tronco e extremidades. O esfregaço dessas pápulas contém eosinófilo. O diagnóstico provável é:

A) Eritema tóxico.

B) Miliária neonatal.

C) Impretigo neonatal.

D) Melanose pustular.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

151911)

Enunciado: Como trato um recém-nascido com sífilis congênita diagnosticada na primeira semana de vida:

A) Penicilina benzatina 50.000 U\kg\dia dose única IM.

B) Penicilina procaina 100.000 U\kg\dia por 12\12h IM.

C) Penicilina G eristalina 25.000-50.000 U\kg\dia - 6\6h dia EV.

D) Penicilina G cristalina aquosa 100.000-150.000 U\kg\dia - 12\12h EV.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

151927)

Enunciado: Qual a principal ação do surfactante no pulmão do recém-nascido?

A) Regular a produção de lecitina e esfingomielina, que estão diminuídos no final da inspiração.

B) Reduzir a tensão superficial e auxiliar a manter estabilidade alveolar, diminuindo o colapso de espaços aéreos no final da expiração.

C) Induzir o crescimento da árvore alveolar e aumentar a tensão superficial e colapso no final da expiração.

D) Inibir a síntese de proteínas que levam ao acúmulo de líquidos dentro dos sacos alveolares.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

129808)

Enunciado: A avaliação da vitalidade ao nascer tem sido apontada como o principal elemento para a indicação de necessidade de reanimação neonatal. Para isso recomenda-se que se faça uma avaliação rápida da vitalidade do concepto, respondendo a quatro perguntas. Assinale abaixo a alternativa que contenha as perguntas recomendadas.

A) Gestação a termo?; Respiração regular?; Ausência de mecônio?; Irritabilidade reflexa?

B) Gestação pré-termo?; Chorando?; Cianose central?; Tônus muscular em flexão?

C) Gestação a termo?; Frequência Cardíaca > 100 bpm?; Presença de mecônio?; Presença de Cianose?

D) Gestação a termo?; Ausência de mecônio?; Respirando ou chorando?; Tônus muscular bom?

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

129750)

Enunciado: Menino nascido a termo, por via vaginal, de mãe primípara com 22 anos, a gravidez transcorreu sem complicações. Pouco antes do parto, uma bradicardia foi percebida no feto e, no momento do parto, havia presença de mecônio espesso. O recém-nascido apresenta-se com hipotonia e bradicardia. Qual das opções a seguir é o primeiro passo da reanimação?

A) Administração de epinefrina por meio de tubo endotraqueal.

B) Ventilação com dispositivo bolsa-máscara.

C) Intubação endotraqueal com sucção direta.

D) Administração de oxigênio por cânula junto às narinas.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

107851)

Enunciado: Os recém-nascidos (RN) compõem um grupo heterogênio. Quanto ao tamanho ao nascer, responda a assertiva CORRETA.

A) Pequeno para a idade gestacional (PIG), abaixo do percentil 10, dependendo da idade gestacional.

B) Grande para a idade gestacional (GIG), entre percentil 10 e 90, dependendo da idade gestacional.

C) Pequeno para a idade gestacional (PIG), abaixo do percentil 10, independente da idade gestacional.

D) Grande para a idade gestacional (GIG), acima do percentil 90, dependendo da idade gestacional.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

107860)

Enunciado: A icterícia é um dos problemas mais frequentes no período neonatal. Quanto a etiologia da hiperbilirrubinemia indireta no RN. Assinale abaixo qual assertiva correspondente entre a patologia e hiperbilirrubinemia.

A) Atresia de Vias Biliares Extra Hepática - icterícia não colestática.

B) Síndrome da Icterícia por Leite Materno - icterícia não colestática.

C) Síndrome de Gilbert - Icterícia colestática.

D) Clampeamento tardio ou ordenha do cordão - icterícia colestática.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

103786)

Enunciado: A listeriose deve estar incluída no diagnóstico diferencial de infecções por:

A) Bronquiolite

B) Diarreia

C) Sepse neonatal

D) Difteria

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

103811)

Enunciado: Recém-nascido de quatro dias de vida nasceu de parto normal e a termo, está em aleitamento materno exclusivo e apresenta eliminação de secreção sanguinolenta pela vagina, pequenos lábios proeminentes, e glândulas mamárias aumentadas bilateralmente. A conduta indicada nesse caso é:

A) Solicitar pesquisa de 17-cetosteroides.

B) Prescrever creme vaginal inespecífico.

C) Solicitar cromatina sexual e cariótipo.

D) Tranquilizar a mãe e observar a evolução.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

103819)

Enunciado: De acordo com a classificação da Organização Mundial de Saúde, recém nascido a termo é aquele que apresenta idade gestacional de:

A) 36 a 40 semanas e 6 dias

B) 37 a 40 semanas

C) 37 a 41 semanas e 6 dias

D) 38 a 42 semanas

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

87467)

Enunciado: Os Recém-Nascidos (RN) compõem um grupo heterogêneo. Quanto ao peso ao nascer, responda a assertiva CORRETA.

A) RN classificados como RN de Peso Extremamente Baixo ao nascer apresentam peso ao nascimento inferior a 1500 g, independente da idade gestacional;

B) RN classificados como RN de Baixo Peso apresentam peso ao nascimento inferior a 2500 g, independente da idade gestacional;

C) RN classificados como RN de Peso Extremamente Baixo ao nascer apresentam peso ao nascimento inferior a 2000 g, independente da idade gestacional;

D) RN de tamanho excessivamente grande são aqueles cujo peso ao nascimento é igual ou superior a 3500 g, independente da idade gestacional;

E) RN classificados como RN de Baixo Peso apresentam peso ao nascimento inferior a 3000 g.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

87421)

Enunciado: O índice de Apgar é um método objetivo de quantificar a condição do recém-nascido e é útil para se obter informações sobre o estado geral e a reação à reanimação. Qual seria o valor do índice de APGAR, de um recém-nascido que após as medidas de reanimação apresentava respiração irregular, frequência cardíaca maior que 100 bpm, movimento ativo, corpo rosado, extremidades cianóticas e choraminga?

A) APGAR de 4.

B) APGAR de 10.

C) APGAR de 2.

D) APGAR de 3.

E) APGAR de 7.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

87471)

Enunciado: Baseado na estratégia do Ministério da Saúde, OPAS, 2012, para Atenção Integral às Doenças Prevalentes na Infância (AIDPI) Neonatal, classifique o Risco ao Nascer para o recém-nascido, que apresenta: peso ao nascer < 2.000 g, desconforto respiratório, rotura prematura de membranas 18h antes do parto, febre materna, idade gestacional < 35 semanas.

A) Baixo Risco ao Nascer.

B) Médio Risco ao Nascer.

C) Alto Risco ao Nascer.

D) Muito Baixo Risco ao Nascer.

E) Gravidez de Baixo Risco.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

81953)

Enunciado: O conteúdo de vitamina K do leite humano é baixo e pode contribuir para doença hemorrágica do recém nascido. Então, ao nascer, qual dose de vitamina K deve ser administrada ao recém nascido?

A) 0,5 g via oral;

B) 0,5 g via parenteral;

C) 1 mg subcutâneo;

D) 1 mg via parenteral;

E) 2 mg via parenteral.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

81919)

Enunciado: Lactentes cujas manifestações clínicas e biópsia hepática sugerem obstrução biliar, devem realizar:

A) Transplante hepático;

B) Laparotomia exploradora e colangiografia direta para determinar a presença e o local da obstrução;

C) Reposição de vitaminas e lipossolúveis;

D) Ultrassonografia abdominal;

E) Cintilografia hepatobiliar.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

81973)

Enunciado: Recém-nascido com 24h de vida, nascido de parto vaginal, apresentação pélvica, pré natal sem intercorrências, apresenta um "clique" do quadril quando se faz a abdução das coxas a partir de uma flexão do joelho e quadril. Qual a provável patologia do recém-nascido?

A) Doença de legg -Calvé- Perthes;

B) Sinovite transitória do quadril;

C) Displasia do desenvolvimento do quadril;

D) Epifisiólise;

E) Doença de Osgood-Schlatter.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

80965)

Enunciado: A icterícia é um dos problemas mais frequentes no período neonatal. Quanto à etiologia da hiperbilirrubinemia indireta no RN. Assinale abaixo qual assertiva NÃO corresponde à apresentação de icterícia por hiperbilirrubinemia indireta.

A) Atresia de Vias Biliares Extra Hepática.

B) Síndrome da Icterícia por Leite Materno.

C) Síndrome de Gilbert.

D) Céfalo-hematoma.

E) Clampeamento tardio ou ordenha do cordão.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

60853)

Enunciado: Recém-nascido de Termo (RNT), peso ao nascer 3,600g parto normal. Apgar 9' e 10', em aleitamento materno exclusivo, apresentou icterícia, com BT = 10 mg/dl. Os exames laboratoriais afastaram a hipótese diagnóstica: infecção, incompatibilidade sanguínea e deficiência G6PD. Qual a sua conduta?

A) Introduzir fórmula láctea

B) Iniciar hidratação venosa

C) Estimular aleitamento materno

D) Contraindicar aleitamento materno

E) Oferecer solução glicosada 5% por sucção

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

60833)

Enunciado: Em relação aos cuidados a serem tomados com o recém-nascido de Mãe soropositiva para o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV). Marque a alternativa CORRETA:

A) O antirretroviral aprovado para uso na criança é a azitromicina que está disponível como solução oral ou endovenosa e a dose preconizada para um recém-nascido a termo é 2 mg/kg/dose por via oral a cada 6 horas.

B) O recém-nascido deve ser banhado com água e sabão logo após o parto, assim que esteja estável, pois somente após a remoção de secreções maternas pode-se administrar medicações injetáveis.

C) Deve ser amamentado na primeira hora de vida para que adquira anticorpos maternos protetores e não desenvolva a doença.

D) Deve-se imediatamente, após o parto, realizar um teste rápido do recém-nascido para saber se ele está contaminado.

E) A profilaxia com antirretroviral deve ser administrada a criança 12 horas após o nascimento.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

60861)

Enunciado: Gestante diagnosticada com Lues no pré-natal foi tratada com eritromicina por 21 dias por ser alérgica à penicilina. O recém-nato nasce assintomático. Qual a melhor conduta a ser tomada em relação a este bebê?

A) O recém-nascido, mesmo assintomático, deve ser avaliado incluindo VDRL de sangue periférico, radiografia dos ossos longos, liquor cefalorraquidiano (VDRL, celularidade e proteinorraquia), hemograma completo, para então definir o tratamento.

B) A mãe é considerada adequadamente tratada, já que fez eritromicina por 21 anos, e como o recém-nascido é assintomático, não há necessidade de investigação diagnóstica.

C) O teste VDRL negativo no recém-nascido exclui a possibilidade de sífilis congênita.

D) Deve-se acompanhar este recém-nascido por 10 dias e, se ele permanecer assintomático, pode-se dar alta epidemiológica.

E) O recém-nascido deve ser avaliado com VDRL em sangue periférico, hemograma completo e radiografia de ossos longos, mas não há necessidade de avaliação do liquor cefalorraquidiano já que o recém-nascido está assintomático.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

60869)

Enunciado: Em um recém-nascido com 48 horas de vida e diagnóstico de toxoplasmose congênita comprovada, a fundoscopia mostra coriorretinite macular bilateral em atividade. O exame do liquor demonstra uma hiperproteinorraquia. Qual seria o esquema terapêutico mais adequado para iniciar tratamento para esta criança?

A) Espiramicina + corticosteroides.

B) Sulfadiazina + pirimetamina + ácido fólico.

C) Sulfadiazina + pirimetamina + ácido folínico.

D) Sulfadiazina + pirimetamina + ácido folínico + corticosteroides.

E) Espiramicina alternada de duas em duas semanas com sulfadiazina + corticosteroides.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

60887)

Enunciado: Em relação ao tratamento da toxoplasmose congênita, podemos afirmar que:

A) Em criança com toxoplasmose congênita comprovada e em filhos de mulheres com toxoplasmose aguda comprovada ou provável durante a gestação, o recém-nascido deve ser submetido à avaliação clínica cuidadosa e investigação suplementar com hemograma completo, fundoscopia ocular e ultrassom transfontanela e, adicionalmente, deve-se realizar análise do liquor cefalorraquidiano (bioquímica e celularidade), tomografia computadorizada (sem a necessidade de uso de contraste radiológico), avaliação da função hepática e avaliação auditiva.

B) Somente as crianças que apresentam sintomas como hepatoesplenomegalia, icterícia e plaquetopenia devem ser tratadas.

C) Não há necessidade de avaliação de exame de fundo de olho, pois a coriorretinite na toxoplasmose congênita é muito rara.

D) Todas as crianças com toxoplasmose congênita comprovada devem receber tratamento por 6 meses consecutivos, independentemente da presença de sinais e/ou sintomas da doença.

E) Se o recém-nascido for assintomático ao nascimento e com hemograma normal, mesmo que a mãe tenha diagnóstico de toxoplasmose aguda na gestação não precisa ser investigado e deve receber alta hospitalar para acompanhamento em ambulatório de puericultura de baixo risco.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

60917)

Enunciado: A icterícia constitui em um dos problemas mais frequentes no período neonatal e corresponde à expressão clinica da hiperbilirrubinemia. Na prática, 98% dos recém-nascidos apresentam níveis séricos de de bilirrubina indireta acima de 1mg/dl durante a primeira semana de vida, o que na maioria das vezes reflete a adaptação neonatal ao metabolismo da bulirrubina. É a chamada hiperbilirrubinemia fisiológica. Quanto ao diagnóstico da icterícia neonatal podemos afirmar:

A) A icterícia fisiológica geralmente surge nas primeiras 24 horas de vida, em mães primíparas e alcançam niveis séricos maiores que 12 mg/dl.

B) Presença de icterícia antes de 24 horas de vida e valores de bilirrubina total > 12 mg/dl, independentemente da idade pós-natal, alerta para a investigação da causa.

C) Pode-se avaliar clinicamente e afirmar que a icterícia é "fisiológica" se o recém-nascido estiver com a boa sucção ao seio.

D) Apenas a estimativa clínica é suficiente para avaliar os recém-nascidos com a icterícia neonatal, independentemente da idade gestacional.

E) Somente pela história clínica perinatal e familiar podemos averiguar o risco de um recém-nascido desenvolver icterícia neonatal na primeira semana de vida.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

60931)

Enunciado: A história clínica de recém-nascidos com icterícia neonatal permite detectar a presença de fatores epidemiológicos de risco associados ao desenvolvimento de hiperbilirrubinemia significante na primeira semana de vida. Marque a alternativa CORRETA em relação aos fatores de risco para o desenvolvimento de hiperbilirrubinemia significante em recém-nascidos > 35 semanas de idade gestacional:

A) Icterícia após 48 horas de vida em recém-nascido a termo, que está com boa sucção ao seio materno.

B) Idade gestacional de 35 semanas não constitui fator de risco independente para o desenvolvimento de icterícia neonatal.

C) Sexo feminino é um fator de risco para o desenvolvimento de icterícia neonatal, independentemente do tipo sanguíneo do recém-nascido e da mãe.

D) Recém-nascido com tipo sanguíneo O+, sendo a mãe A+, pode ter doença hemolítica por incompatibilidade ABO e desenvolver icterícia grave.

E) Recém-nascido termo, com céfalo-hematoma e equimoses, sexo masculino, grupo Sg A+, sendo a mãe O+, com história de um irmão que necessitou tratamento com fototerapia.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

324671)

Enunciado: Paciente, sexo feminino, nascida há 12 horas, apresentou, durante ultrassonografia morfológica pré-natal, abaulamento em coluna vertebral lombar. Após o nascimento, foi identificada presença de protrusão sacular em região lombar medindo cerca de 10cm, coberta por membrana fina e avermelhada. A paciente também apresentava diminuição da mobilidade dos membros inferiores e retenção urinária. Determine a principal suspeita diagnóstica para o quadro clínico da paciente.

A) Distúrbio de segmentação vertebral.

B) Agenesia segmentar da coluna lombar.

C) Mielomeningocele.

D) Meningioma lombar.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

324672)

Enunciado: Paciente, sexo feminino, nascida há 12 horas, apresentou, durante ultrassonografia morfológica pré-natal, abaulamento em coluna vertebral lombar. Após o nascimento, foi identificada presença de protrusão sacular em região lombar medindo cerca de 10cm, coberta por membrana fina e avermelhada. A paciente também apresentava diminuição da mobilidade dos membros inferiores e retenção urinária. Indique o principal fator de risco para o surgimento da alteração encontrada na paciente.

A) Trissomia cromossomial.

B) Obesidade.

C) Diabetes mellitus.

D) Deficiência de ácido fólico.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

324673)

Enunciado: Paciente, sexo feminino, nascida há 12 horas, apresentou, durante ultrassonografia morfológica pré-natal, abaulamento em coluna vertebral lombar. Após o nascimento, foi identificada presença de protrusão sacular em região lombar medindo cerca de 10cm, coberta por membrana fina e avermelhada. A paciente também apresentava diminuição da mobilidade dos membros inferiores e retenção urinária. Indique a conduta cirúrgica mais adequada para essa paciente, caso não seja possível o fechamento primário do defeito cutâneo.

A) Deixar a área fechar por segunda intenção.

B) Realizar enxerto de pele total.

C) Confeccionar retalho local fasciocutâneo.

D) Realizar colocação de expansor tecidual.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

324825)

Enunciado: Lactante, sexo feminino, no 25º dia de vida, residente em zona rural, é levada à UBS para sua primeira consulta. Nasceu de parto domiciliar e a genitora, multípara, não fez pré-natal regular, tendo registro de apenas uma consulta no segundo mês de gestação. A bebê nasceu a termo, pesando 2.150g, medindo 48cm. Apresentou icterícia no primeiro dia de vida. A genitora relata que percebe que há um círculo esbranquiçado no olho esquerdo. É alimentada exclusivamente com leite materno. Ao exame, ativa, bom estado geral, apresenta microcefalia e opacificação na zona pupilar do olho esquerdo. Sem outros achados anormais. Indique a principal suspeita diagnóstica para o caso descrito.

Resposta descritiva:

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

324826)

Enunciado: Lactante, sexo feminino, no 25º dia de vida, residente em zona rural, é levada à UBS para sua primeira consulta. Nasceu de parto domiciliar e a genitora, multípara, não fez pré-natal regular, tendo registro de apenas uma consulta no segundo mês de gestação. A bebê nasceu a termo, pesando 2.150g, medindo 48cm. Apresentou icterícia no primeiro dia de vida. A genitora relata que percebe que há um círculo esbranquiçado no olho esquerdo. É alimentada exclusivamente com leite materno. Ao exame, ativa, bom estado geral, apresenta microcefalia e opacificação na zona pupilar do olho esquerdo. Sem outros achados anormais. Indique uma outra anomalia que faz parte da síndrome congênita clássica da doença.

Resposta descritiva:

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

324827)

Enunciado: Lactante, sexo feminino, no 25º dia de vida, residente em zona rural, é levada à UBS para sua primeira consulta. Nasceu de parto domiciliar e a genitora, multípara, não fez pré-natal regular, tendo registro de apenas uma consulta no segundo mês de gestação. A bebê nasceu a termo, pesando 2.150g, medindo 48cm. Apresentou icterícia no primeiro dia de vida. A genitora relata que percebe que há um círculo esbranquiçado no olho esquerdo. É alimentada exclusivamente com leite materno. Ao exame, ativa, bom estado geral, apresenta microcefalia e opacificação na zona pupilar do olho esquerdo. Sem outros achados anormais. Indique um critério laboratorial para o diagnóstico da doença na criança.

Resposta descritiva:

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

284619)

Enunciado: Menino, nascido de parto cirúrgico indicado por suspeita de descolamento prematuro da placenta, é assistido na sala de parto. A idade gestacional, aproximada, é de 37 semanas. A criança é entregue ao pediatra, logo após o clampeamento do cordão umbilical. Ao primeiro minuto de vida, o bebê apresenta choro fraco, atitude fletida, movimenta-se sem muito vigor; está rosado e com a frequência cardíaca de 106 bpm. Indique o índice Apgar dessa criança no primeiro minuto de vida.

A) 4

B) 5

C) 6

D) 8

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

284620)

Enunciado: Menino, nascido de parto cirúrgico indicado por suspeita de descolamento prematuro da placenta, é assistido na sala de parto. A idade gestacional, aproximada, é de 37 semanas. A criança é entregue ao pediatra, logo após o clampeamento do cordão umbilical. Ao primeiro minuto de vida, o bebê apresenta choro fraco, atitude fletida, movimenta-se sem muito vigor; está rosado e com a frequência cardíaca de 106 bpm. Identifique a alternativa que informa a ordem correta de execução dos procedimentos que compõem a assistência a essa criança.

A) Posicionar a criança com a cabeça mais baixa do que o corpo; envolvê-la em campos estéreis e secá-la; aspirar secreções de naso e orofaringe.

B) Posicionar a criança com a cabeça mais baixa do que o corpo; aspirar secreções de naso e orofaringe; envolvê-la em campos estéreis e secá-la.

C) Envolver o recém-nascido em campos estéreis e secá-lo; posicioná-lo com a cabeça mais baixa do que o corpo; aspirar secreções de naso e orofaringe.

D) Envolver o recém-nascido em campos estéreis e secá-lo; aspirar secreções de naso e orofaringe; posicioná-lo com a cabeça mais baixa do que o corpo.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

284621)

Enunciado: Menino, nascido de parto cirúrgico indicado por suspeita de descolamento prematuro da placenta, é assistido na sala de parto. A idade gestacional, aproximada, é de 37 semanas. A criança é entregue ao pediatra, logo após o clampeamento do cordão umbilical. Ao primeiro minuto de vida, o bebê apresenta choro fraco, atitude fletida, movimenta-se sem muito vigor; está rosado e com a frequência cardíaca de 106 bpm. Identifique os parâmetros que devem ser considerados para avaliar a vitalidade do recém-nascido.

A) Choro e Frequência respiratória.

B) Choro e movimentos voluntários.

C) Frequência cardíaca e Frequência respiratória.

D) Frequência cardíaca e Movimentos voluntários.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

230172)

Enunciado: Pediatra faz atendimento em sala de parto de recém nascido com idade gestacional de 36 semanas e 5 dias, que nasceu hipoativo. Após secar o bebê, aquecê-lo e colocar touca, aspirá-lo e posicioná-lo, o mesmo mantém-se hipo-responsivo; em uso de oxigênio sob máscara, apresenta frequência cardíaca de 80 bpm, sem responder à estimulação táctil. Diante da situação descrita, indique a conduta essencial para a assistência a esse RN, nesse momento.

Resposta descritiva:

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

230173)

Enunciado: Pediatra faz atendimento em sala de parto de recém nascido com idade gestacional de 36 semanas e 5 dias, que nasceu hipoativo. Após secar o bebê, aquecê-lo e colocar touca, aspirá-lo e posicioná-lo, o mesmo mantém-se hipo-responsivo; em uso de oxigênio sob máscara, apresenta frequência cardíaca de 80 bpm, sem responder à estimulação táctil. Diante da situação descrita, Indique três condições que representam risco de hipóxia neonatal.

Resposta descritiva:

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

230174)

Enunciado: Pediatra faz atendimento em sala de parto de recém-nascido com idade gestacional de 36 semanas e 5 dias, que nasceu hipoativo. Após secar o bebê, aquecê-lo e colocar touca, aspirá-lo e posicioná-lo, o mesmo mantém-se hiporresponsivo; em uso de oxigênio sob máscara, apresenta frequência cardíaca de 80 bpm, sem responder à estimulação táctil. Diante da situação descrita, especifique a faixa de valor normal da saturação de oxigênio que um recém-nascido deve apresentar até o quinto minuto de vida.

A) Resposta:

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

176341)

Enunciado: O Ministério da Saúde recomendou que na rotina de Serviço Neonatal passe a constar a triagem para cardiopatia congênita crítica - "teste do coraçãozinho" - antes da alta hospitalar. Considerando essa informação indique o equipamento essencial para realizar esse exame.

Resposta descritiva:

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

176343)

Enunciado: O Ministério da Saúde recomendou que na rotina de Serviço Neonatal passe a constar a triagem para cardiopatia congênita crítica - "teste do coraçãozinho" - antes da alta hospitalar. Considerando essa informação indique o intervalo de tempo, após o nascimento em que o teste deve ser realizado.

Resposta descritiva:

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

176339)

Enunciado: O Ministério da Saúde recomendou que na rotina de Serviço Neonatal passe a constar a triagem para cardiopatia congênita crítica - " teste do coraçãozinho" - antes da alta hospitalar. Considerando essa informação indique a condição fisiopatológica que define cardiopatia congênita critica no recém-nascido.

Resposta descritiva:

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

152201)

Enunciado: Adolescente, 15 anos de idade, grávida de 37 semanas, com rotura de membranas há, aproximadamente, 19 horas, está em período expulsivo. Apresentou pneumonia durante a gestação. O parto foi vaginal e o RN nasceu flácido e cianótico, com APGAR 4 e 5. Diante desse quadro, identifique os três dados dessa história clínica que, epidemiologicamente, estão associados à necessidade de reanimação neonatal.

Resposta descritiva:

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

152204)

Enunciado: Adolescente, 15 anos de idade, grávida de 37 semanas, com rotura de membranas há, aproximadamente, 19 horas, está em período expulsivo. Apresentou pneumonia durante a gestação. O parto foi vaginal e o RN nasceu flácido e cianótico, com APGAR 4 e 5. Diante desse quadro, indique o valor crítico de frequência cardíaca abaixo do qual é recomendada a ventilação por pressão positiva, para essa criança, segundo critérios estabelecidos pela SBP e pelo Ministério da Saúde.

Resposta descritiva:

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

152206)

Enunciado: Adolescente, 15 anos de idade, grávida de 37 semanas, com rotura de membranas há, aproximadamente, 19 horas, está em período expulsivo. Apresentou pneumonia durante a gestação. O parto foi vaginal e o RN nasceu flácido e cianótico, com APGAR 4 e 5. Diante desse quadro, indique a droga adicional para essa criança, no caso de a mãe ter recebido anestesia com meperidina.

Resposta descritiva:

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

129980)

Enunciado: Bebê, 16 dias de vida, após a gestação de 36 semanas nasceu com 2060g, é levado à USB para iniciar o esquema vacinal. No momento, apresenta peso igual a 1880g. Com base na informação, classifique o bebê ao nascer quanto à idade gestacional e justifique a perda ponderal apresentada.

Resposta descritiva:

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

106525)

Enunciado: Dezoito horas após o nascimento por parto vaginal, a termo, com peso adequado para a idade gestacional, é observado que o recém-nascido apresenta icterícia que atinge a zona III de Kramer. Já eliminou mecônio, está ativo e suga bem o seio materno. RN tem sangue do tipo B positivo, sendo que a mãe tem sangue O positivo. Exames laboratoriais mostram bilirrubina total: 15,2mg/dl, bilirrubina indireta: 13,7mg/dl e bilirrubina direta: 1,5mg/dl. Diante do exposto, identifique o diagnóstico e o mecanismo etiológico da icterícia.

Resposta descritiva:

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

106514)

Enunciado: Dezoito horas após o nascimento por parto vaginal, a termo, com peso adequado para a idade gestacional, é observado que o recém-nascido apresenta ictéria que atinge a zona III de Kramer. Já eliminou mecônio, está ativo e suga bem o seio materno, RN tem sangue do tipo B positivo, sendo que a mãe tem sangue O positivo. Exames laboratoriais mostram bilirrubina total:15,2mg/dl, bilirrubina indireta:13,7mg/dl e bilirrubina direta:1,5mg/dl. Diante do exposto, indique a conduta terapêutica para esse recém-nascido.

Resposta descritiva:

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

106515)

Enunciado: Dezoito horas após o nascimento por parto vaginal, a termo, com peso adequado para a idade gestacional, é observado que o recém-nascido apresenta ictéria que atinge a zona III de Kramer. Já eliminou mecônio, está ativo e suga bem o seio materno, RN tem sangue do tipo B positivo, sendo que a mãe tem sangue O positivo. Exames laboratoriais mostram bilirrubina total:15,2mg/dl, bilirrubina indireta:13,7mg/dl e bilirrubina direta:1,5mg/dl. Diante do exposto,cite três fatores que, quando presentes, aumentam a toxicidade da bilirrubina no recém-nascido.

Resposta descritiva:

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

62894)

Enunciado: RN nascido a termo é encaminhado para o exame e acompanhamento neonatal de rotina. Antes da alta, foi feita pesquisa do reflexo vermelho (teste do reflexo de Bruckner ou teste do olhinho), cujo resultado pode ser visto na figura. (VER IMAGEM) A respeito do possível diagnóstico após o teste, é FALSO afirmar que:

A) A catarata infantil é uma das principais causas de cegueira, passível de prevenção, e de visão subnormal na infância. Essa condição aparece quando o cristalino apresenta uma opacificação que pode ser total ou parcial, uni ou bilateral.

B) O retinoblastoma é um tumor que se origina dos retinoblastos imaturos da retina neural, sendo o tumor maligno intraocular mais frequente encontrado em crianças.

C) A retinopatia da prematuridade é uma doença vascular da retina que acomete recém-nascidos pré-termos, principalmente aqueles que nasceram com menos de 1.500 g e de 32 semanas de idade gestacional.

D) A opacidade do cristalino pode ser decorrente de uma variedade de etiologias, podendo resultar de malformações oculares congênitas, de infecções intrauterinas (rubéola, citomegalovírus, varicela, toxoplasmose).

E) As apresentações clínicas mais frequentes da toxocaríase ocular são endoftalmite crônica, formação de granuloma no polo posterior ou formação de granuloma periférico, ocorrendo bilateral e, frequentemente, na forma congênita.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

62892)

Enunciado: RN nascido de parto cesáreo, pré-termo, baixo peso, pré-natal com duas consultas, a genitora não fez os exames solicitados pelo obstetra e é usuária de álcool. Apresenta, ao nascer, dificuldade de sucção, opistótono, hiperexcitabilidade. Ao exame físico, nota-se fissura palpebral pequena, nariz curto, filtro nasal hipoplásico com lábio superior fino, hipoplasia de maxilar, microcefalia e microftalmia. Das patologias relacionadas a seguir, a mais provável é:

A) Síndrome alcoólica fetal.

B) Síndrome de Turner.

C) Rubéola congênita.

D) SIDA/AIDS.

E) Herpes congênito.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

62888)

Enunciado: RN, nascido pré-termo limítrofe, APGAR de 9 e 10 no primeiro e quinto minuto, respectivamente, apresenta taquipneia com quatro horas de vida. Ao exame, dispneico, com FR de 98 inc/min, retração costal moderada, saturação de 0^2 98%. RX de tórax com imagem de infiltrado linear a partir dos hilos, silhueta cardíaca normal. O diagnóstico mais provável é de:

A) pneumonia aspirativa.

B) taquipneia transitória do RN.

C) enfisema pulmonar congênito.

D) doença de membrana hialina.

E) hipertensão pulmonar persistente.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

281861)

Enunciado: Assinale a alternativa incorreta em relação aos benefícios do CPAP.

A) Diminui o trabalho respiratório e consumo de oxigênio.

B) Não permite uma respiração espontânea.

C) Melhora a função diafragmática.

D) Diminui o edema alveolar.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

281886)

Enunciado: Além do gonococo, dos patógenos listados, o mais provável em diagnóstico de oftalmia em recém-nascido é:

A) Gardnerela.

B) Clamídia.

C) Tricomonas.

D) Estreptococo beta hemolítico do grupo B.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

215592)

Enunciado: Criança apresenta na primeira dentição os chamados ?Dentes de Hutchinson?, que são entalhes semilunares na borda dos mesmos. Provavelmente o caso se refere a:

A) Sífilis congênita.

B) Rubéola congênita.

C) Varicela congênita.

D) Infecção por citomegalovírus na gestação.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

181168)

Enunciado: Assinale a alternativa INCORRETA:

A) Em pacientes com sinais clínicos de hipertensão intracraniana, sinais neurológicos focais, instabilidade hemodinâmica ou ventilatória, imunodeficiência, diminuição do sensório (escala de coma de Glasgow < 13 ou queda no escore > 2), sugere-se a realização de tomografia de crânio antes da punção lombar.

B) Recomenda-se em todos os pacientes com suspeita de encefalite, a pesquisa de PCR no líquor para Herpes Vírus tipo 1 e 2, Varicela Zoster e Enterovírus, o que permitirá a identificação da maioria dos casos conhecidos.

C) A pesquisa de HIV deve ser considerada somente em crianças com fatores de risco para HIV, tais como exposição vertical ao HIV.

D) Quando o agente etiológico é a Varicela Zoster, deve-se administrar aciclovir e considerar o uso de corticóide em casos de vasculopatia.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

157582)

Enunciado: Sobre atresia da via biliar, assinale a alternativa ERRADA.

A) Os principais achados histopatológicos são espaço porta expandido por fibrose e edema, infiltrado inflamatório com predomínio de neutrófilos, neoformação ductal, plugs biliares nos ductos neoformados.

B) Quadro clínico caracterizado por recém-nascidos previamente hígidos, sem hepatoesplenomegalia, com fezes coradas e sem colúria. Após 8 a 12 semanas o fígado já esta aumentado, com sinais de fibrose e/ou cirrose.

C) A mais grave complicação é a colangite, podendo levar à destruição completa das vias biliares. Caracteriza-se por febre, dor à palpação do fígado, aumento das bilirrubinas, para a diminuição do fluxo biliar, elevação das enzimas hepáticas.

D) O tratamento cirúrgico de escolha é a portoenterostomia de Kasai. Piores resultados estão associados à idade menor que 12 semanas, porto hepatis tipo I, área de secção do porta hepatis contendo dúctulos biliares.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

157609)

Enunciado: Qual é a anomalia não associada à polidrâmnio?

A) Atresia duodenal.

B) Atresia de esôfago.

C) Agenesia renal.

D) Diabetes gestacional.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

157614)

Enunciado: Qual deve ser o antibiótico de escolha para paciente com menos de 1 mês na presença de infecção por Estreptococo do grupo B?

A) Vancomicina + cefepime.

B) Ceftriaxone + ampicilina.

C) Ampicilina + vancomicina.

D) Ampicilina + gentamicina.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

157708)

Enunciado: Assinale a alternativa que NÃO representa uma estratégia recomendada para prevenir infecção fúngica em recém-nascidos.

A) Usar fluconazol EV para recém-nascidos com menos de 27 semanas de gestação.

B) Usar bloqueadores de bomba de próton para evitar gastrite.

C) Restringir o uso de antibióticos de largo espectro.

D) Usar dexametasona apenas quando há lesão pulmonar grave.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

139755)

Enunciado: Ao avaliar uma gestante em trabalho de parto a termo, foi observado que, vinte segundos após o início da contração uterina, a frequência cardíaca do feto teve uma queda significativa e persistiu após seu término. Diante disso, podemos concluir que o feto apresenta:

A) hidropisia generalizada.

B) imaturidade cardíaca.

C) asfixia grave.

D) compressão cefálica.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

139794)

Enunciado: No sinal de Galeazzi, observa-se uma diferença de nível dos joelhos com a criança deitada e com os membros fletidos. Aponte a alternativa que representa a patologia em que esse sinal clínico é encontrado.

A) Luxação do quadril.

B) Artrite séptica do joelho.

C) Osteocondrite de calcâneo.

D) Cifose do adolescente.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

111930)

Enunciado: Recém-nascido a termo, com peso ao nascer de 3.500 g, iniciou icterícia com 16 horas de vida, sem apresentar sintomas ou outros achados físicos relevantes. A tipagem sanguínea materna é O negativo e a do RN, A positivo. Coombs direto: negativo. Qual é a hipótese diagnóstica MAIS provável para esse caso?

A) Icterícia fisiológica.

B) Doença hemolítica pelos sistemas RH e ABO.

C) Doença hemolítica pelo sistema ABO.

D) Deficiência de glicose-6-fosfato desidrogenase.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

111935)

Enunciado: RN pré-termo tardio, com IG 36 semanas e 5 dias, peso de nascimento 2.580 g, recebe alta com 72 horas de vida, com aleitamento materno exclusivo e pesando 2.300 g, com bons controles de dextro. Qual é a sua orientação na alta?

A) Retorno em 48 horas no consultório para reavaliação.

B) Retorno em 1 semana no consultório para reavaliação.

C) Retorno para reavaliação quando completar 15 dias de vida.

D) Retorno para reavaliação após tomar vacina da Hepatite B.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

111829)

Enunciado: São vantagens do aleitamento conjunto, EXCETO:

A) Aproximação entre mãe e filho e fortalecimento de laços afetivos entre ambos.

B) Redução do risco de infecção hospitalar, devido à colonização de germes maternos e não hospitalares.

C) Facilitar o relacionamento da mãe e filho em casa, tendo apoio da equipe de saúde, dando mais segurança à mãe.

D) Aprender sozinha ou com outras mães a cuidar dos filhos.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

350850)

Enunciado: RNPT tardio - PIG - nasceu de parto vaginal em boas condições, colocado em contato pele a pele e assegurada amamentação na primeira hora de vida tendo apresentado boa pega e sugado de forma efetiva o seio materno. Atualmente, com 2 horas de vida, ao exame físico, apresenta boa atividade e reatividade, presença de acrocianose e uma temperatura axilar = 36ºC. O nível glicêmico foi aferido por meio das fitas reagentes de glicose cujo resultado foi 28 mg/dl. O RN foi novamente colocado ao seio materno e a mãe foi orientada sobre amamentação. Uma nova aferição de glicemia capilar foi programada para após 1 hora. Como prevenir novos episódios de hipoglicemia para esse RN?

A) Evitar falsa aferição de hipoglicemia higienizando o local de punção com álcool.

B) Prover complementação regular da dieta com fórmula para RNPT a cada 3 horas.

C) Desenvolver estratégias para esse RN corrigir a sua condição de hipotermia.

D) Transferir para unidade neonatal para qualificar o monitoramento da glicemia.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

350823)

Enunciado: Durante a coleta da anamnese materna na sala de parto é identificado que uma mãe teve Sífilis durante a gestação. Parturiente e parceiro foram adequadamente tratados, de acordo com o registrado no cartão pré-natal. O tratamento terminou aproximadamente 40 dias antes do parto. Qual a conduta inicial com o recém-nascido em relação a necessidade de testagem para Sífilis?

A) Coletar teste não treponemico da criança se essa apresentar alterações ao exame físico.

B) Não existe necessidade de testagem da criança caso o teste rápido materno seja negativo.

C) Realizar coleta de teste treponemico da criança por meio de sangue do cordão umbilical.

D) Testagem simultaneamente da mãe e criança com teste não treponemico em sangue periférico.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

350818)

Enunciado: A mãe de um bebê de 5 semanas de vida chega à Puericultura relatando que as fezes do filho estão apresentando cores cada vez mais claras há cerca de 10 dias. Qual a interpretação correta para esse evento?

A) Se as fezes estiverem brancas logo após as mamadas, esse aspecto é normal.

B) Se a criança estiver bem, se não apresentar nenhum outro sintoma, esse aspecto é normal.

C) Se as fezes estão claras, permanecendo quase brancas ou cinzentas, pode significar alguma doença.

D) Se a criança estiver evacuando poucas vezes ao dia com cores claras, pode significar normalidade.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

321317)

Enunciado: Recém-nascido a termo, 36 horas de vida, masculino, em aleitamento materno exclusivo, com diurese e evacuação, apresenta o seguinte achado na fralda visto durante o exame físico sem alterações.Conferir figura correspondente com melhor resolução no anexo (FIGURA 4)Qual a melhor conduta?

A) Achado habitual, seguir rotina do alojamento conjunto.

B) Iniciar antibiótico e solicitar exames séricos e urinários no alojamento conjunto.

C) Suspender o aleitamento materno e prescrever fórmula isenta de proteína de leite de vaca.

D) Prescrever vitamina K e solicitar hemograma e coagulograma, transferindo o bebê para berçário.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

292830)

Enunciado: Diante de um recém-nascido conduzido à mesa de reanimação, deve-se iniciar os passos da estabilização na sequência adequada, com duração de no máximo 30 segundos. Qual das opções abaixo apresenta a sequência correta?

A) Prover calor, fazer estímulo táctil, aspirar boca e narinas (se necessário) e enxugar.

B) Fazer estimulação táctil, posicionar a cabeça em leve extensão, aspirar boca e narinas e secar.

C) Prover calor, posicionar a cabeça em leve extensão, aspirar boca e narinas (se necessário) e secar.

D) Enxugar e aquecer, posicionar a cabeça em extensão, aspirar boca e narinas (se necessário) e estimular.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

259731)

Enunciado: Um recém-nascido a termo, com peso de nascimento de 3100 g e boas condições de vitalidade, encontra-se no alojamento conjunto com sua mãe, que relata que o bebê é tranquilo e pega pouco o seio. Nasceu de parto vaginal, sendo realizada assistência adequada em sala de parto, com clampeamento tardio de cordão. Está com 72 horas de vida, com duas diureses no dia anterior e eliminação de mecônio uma vez. Ao exame, encontra-se ictérico até o umbigo. Ao ser solicitado exame laboratorial, observa-se bilirrubina total de 9 mg/dl, com 72 horas de vida. Mãe 0+/RN 0+. O resultado foi analisado no Nomograma de Bhutani. Qual a melhor conduta para este recém-nascido?

A) Fototerapia no Alojamento Conjunto.

B) Fototerapia na Unidade de Cuidados Intermediários.

C) Exsanguineo transfusão na Unidade de Cuidados Intensivos.

D) Alta hospitalar após orientação sobre amamentação e retorno precoce.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

259732)

Enunciado: O pediatra de plantão, em uma grande maternidade, é comunicado de um parto cesareano de urgência por sofrimento fetal. Após checar no centro cirúrgico, o material de reanimação, local de recepção e a fonte de oxigênio, recebe o recém-nascido. De acordo com o Fluxograma da reanimação neonatal do Programa de Reanimação Neonatal da Sociedade Brasileira de Pediatria, quais perguntas iniciais o pediatra deve fazer para orientar as providências seguintes?

A) Cianose? Reativo? Respirando ou chorando?

B) Chorando forte? Cianose? Saturação de oxigênio acima de 92%?

C) Gestação a termo? Respirando ou chorando? Tônus muscular em flexão?

D) Frequência cardíaca acima de 100 bpm? Saturação de oxigênio acima de 92%? Chorando?

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

234052)

Enunciado: Os recém-nascidos que, ao nascimento, não iniciam movimentos respiratórios regulares e/ou aqueles cujo tônus muscular está flácido precisam ser conduzidos à mesa de reanimação. Nesses casos, quais os passos iniciais indicados em um correto procedimento de reanimação?

A) Posicionar a cabeça em extensão, aspirar boca e narinas, entubar e ventilar. Esses passos devem ser executados em, no máximo, 60 segundos.

B) Posicionar a cabeça em leve extensão, aspirar boca e narinas, e ventilar com ambu e máscara. Esses passos devem ser executados nos primeiros 30 segundos.

C) Prover calor, posicionar a cabeça em leve extensão, aspirar boca e narinas, se necessário, e secar o paciente. Esses passos devem ser executados em, no máximo, 30 segundos.

D) Aspirar boca e narinas, posicionar a cabeça em leve extensão, prover calor e ventilar com ambu e máscara, além de massagem cardíaca. Esses passos devem ser executados nos primeiros 60 segundos.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

234053)

Enunciado: Recém-nascido limítrofe (36 semanas), Apgar 9 e 9, mãe O+, encontra-se no alojamento conjunto com boa pega ao seio. Nasceu de parto vaginal com clampeamento oportuno de cordão umbilical. Está com 22 horas de vida, com boa diurese e ainda com pouca eliminação de mecônio. Ao exame, encontra-se ictérico até zona III de Kramer. Qual o fator de alerta que pode estar associado a hiperbilirrubinemia severa?

A) Clampeamento precoce do cordão.

B) Pouca eliminação de mecônio.

C) Icterícia nas primeiras 24 horas.

D) Icterícia pelo leite materno.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

199720)

Enunciado: No alojamento conjunto, encontra-se um recém-nascido a termo assintomático cuja mãe realizou tratamento adequado para sífilis no 7º mês de gestação. O VDRL em amostra de sangue periférico do bebê é negativo. Segundo o Ministério da Saúde, na impossibilidade de garantir o seguimento clínicolaboratorial, qual a melhor conduta para este RN?

A) Considerar o caso resolvido.

B) Tratar com penicilina G benzatina IM em dose única.

C) Investigar e tratar com penicilina G benzatina IM em dose única.

D) Investigar e tratar com penicilina cristalina ou procaína por 10 dias.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

199667)

Enunciado: Lactente de oito meses de idade com história de sibilância recorrente, que piora nos quadros de infecções de vias aéreas. Mãe refere que criança tem sintomas contínuos desde o período neonatal. Nasceu de parto cesáreo, pré-termo e fez uso de oxigenoterapia. Nega outras alterações, internamentos e alergias na família. Qual o diagnóstico mais provável?

A) Displasia broncopulmonar.

B) Imunodeficiência primária.

C) Fibrose cística.

D) Asma atópica.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

199700)

Enunciado: Recém-nascido com 12 dias de vida encontra-se na UTI desde o nascimento por prematuridade. Apresenta-se com hipotermia, apneia, resíduo gástrico positivo, pele rendilhada e hipoatividade. Realizada punção lombar que evidenciou liquor com baixos níveis de glicose, hiperproteinorraquia e pleocitose com predomínio de neutrófilos. Qual(is) o(s) antibiótico de eleição, dentre os abaixo citados?

A) Cefepime.

B) Ampicilina.

C) Metronidazol.

D) Piperacilina + tazobactam.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

172957)

Enunciado: Um recém-nascido, segundo filho de uma mulher com tipagem sanguínea O negativo com Coombs indireto positivo, apresenta os seguintes resultados de exames no sangue de cordão: tipagem sanguínea O positivo, coombs direto positivo, reticulócitos 8%, bilirrubina indireta de 4,4 mg/dl e hemoglobina de 12,5 g/dl. Qual dos dados indicaria a realização de exsanguineotransfusão para este bebê?

A) Reticulócitos aumentados no sangue de cordão.

B) Hemoglobina do sangue de cordão de 12,5 g/dl.

C) Bilirrubina indireta de sangue de cordão de 4,4 mg/dl.

D) O coombs indireto da mãe e direto do recém-nascido positivos.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

172967)

Enunciado: Uma agente comunitária de saúde apresentou sífilis adequadamente tratada na gestação anterior há 2 anos, quando ela e o parceiro fizeram uso de Penicilina benzatina em 3 doses de 2.400.000, com intervalo semanal. Atualmente, no 9º mês de uma segunda gestação, ela e o esposo apresentam VDRL de 1:1 e o teste rápido da sala de parto foi positivo. Compreendendo que será possível fazer acompanhamento do binômio mãe-bebê de forma adequada e que os exames do RN logo após o nascimento evidenciaram o VDRL sérico de 1:1, com os demais normais, qual a melhor conduta para este RN?

A) Penicilina benzatina - 1 dose de 600.000 UI.

B) Seguimento clínico e laboratorial da criança.

C) Penicilina procaína 50.000 UI/kg/dia por 10 dias.

D) Penicilina cristalina 100.000 UI/kg/dia por 7 dias.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

172977)

Enunciado: Logo após o nascimento, um recém-nascido de 35 semanas de idade gestacional e peso 2.500 g, encontra-se com batimento de asa de nariz, gemente, com retração esternal importante e cianose de extremidades. A frequência respiratória é de 64 irpm e saturação de oxigênio de 94%. Qual é a melhor conduta para o bebê, dentre as abaixo citadas?

A) Aquecer, colocar no capacete (hood) com F1O2 de 60% e reavaliar com 2 horas de vida, na sala de parto.

B) Aquecer em berço de calor radiante em ar ambiente e reavaliar com 2 horas de vida, na sala de parto.

C) Iniciar o CPAP nasal precoce com PEEP de 5 cm H2O já na sala de parto e durante o transporte.

D) Proceder a intubação orotraqueal e iniciar a ventilação com pressão positiva.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

150879)

Enunciado: RN a termo, filho de mãe com sífilis não tratada na gestação, está no alojamento conjunto. Foi afastada neurossífilis e considerando que não está disponível a penicilina cristalina ou procaína, qual a melhor conduta para esse recém-nascido, dentre as abaixo citadas?

A) Cefepima por 7 dias.

B) Cefepima por 10 dias.

C) Ceftriaxona por 7 dias.

D) Ceftriaxona por 10 dias.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

150884)

Enunciado: Recém-nascido a termo, peso de 3.400 g, pré-natal sem intercorrências, boas condições de nascimento, tipagem sanguínea O negativo, em aleitamento materno exclusivo, com boa pega ao seio e eliminações fisiológicas, apresenta icterícia percebida com 60 horas de vida, zona I de Kramer. Qual a melhor conduta para esse recém-nascido?

A) Alta hospitalar com retorno em 72 horas para reavaliação clínica.

B) Permanência hospitalar por mais 12 a 24 horas para observar evolução da icterícia e posterior solicitação de exames, caso evolua.

C) Dosagem sérica de bilirrubina total e frações, Coombs direto, reticulócitos, hemograma completo e iniciar fototerapia no alojamento conjunto.

D) Dosagem sérica de bilirrubina total e frações, Coombs direto, hemograma completo, reticulócitos, protelando a alta hospitalar até checagem dos resultados.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

126952)

Enunciado: Você avalia a vitalidade imediata de um recém-nascido na sala de parto e identifica as seguintes situações: RN de termo, sem mecônio, respirando e chorando adequadamente, com bom tônus muscular. Logo em seguida, quais dos cuidados abaixo devem ser tomados?

A) Prevenção de sangramentos por deficiência de fatores de coagulação.

B) Prevenção da oftalmia gonocócica pelo método de Credé para RN de parto vaginal.

C) Laqueadura do cordão umbilical; verificar a presença de duas artérias e de uma veia umbilical.

D) Realização de exame físico detalhado, incluindo peso, comprimento e os perímetros cefálico, torácico e abdominal.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

126984)

Enunciado: Joana nasceu de parto vaginal a termo com 36 semanas, Apgar 8/9 e peso de 2300g. A mãe é moradora de rua em situação de vulnerabilidade social. Na visita no Alojamento conjunto detectou-se icterícia, hepatoesplenomegalia e dor ao manuseio. Que exames são imprescindíveis para reforçar esclarecimento diagnóstico?

A) VDRL da mãe e do recém-nascido, raio-x de ossos longos, punção lombar e fundo de olho.

B) Hemograma completo, bilirrubinas, teste rápido para HIV e avaliação neurocomportamental.

C) Bilirrubinas séricas, sorologia para citomegalovírus, ultrassonografia abdominal e tomografia computadorizada.

D) Sorologia da mãe e do recém-nascido para toxoplasmose, raio-x de ombro, ultrassonografia transfontanelar e fundo de olho.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

127003)

Enunciado: A icterícia constitui-se em um dos problemas mais frequentes no período neonatal e corresponde à expressão clínica da hiperbilirrubinemia. A hiperbilirrubinemia, na primeira semana de vida, é encontrada tanto no recém-nascido a termo como no prematuro. Diante de um prematuro de 36 semanas de idade gestacional, existem fatores epidemiológicos que orientam o neonatologista para uma investigação clínica e laboratorial. Quais das situações abaixo significam alta probabilidade de a icterícia ter origem patológica?

A) Icterícia com início antes de 24-36 horas de vida, independentemente da idade pós-natal.

B) Icterícia com início após 24 horas de vida, com pico no terceiro dia de vida.

C) Icterícia em recém-nascidos com perda elevada de peso.

D) Icterícia na presença de bossa serossanguínea.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

102169)

Enunciado: Lactente, com 28 dias de vida, é levado ao pediatra com história de icterícia desde o nascimento. Pais informam que seu filho encontra-se em aleitamento materno exclusivo e em bom estado geral. As fezes da criança podem ser vistas na foto abaixo. (VER IMAGEM) Avaliação laboratorial realizada há 3 dias revelou bilirrubina total de 9 mg/dl, com indireta de 5,5 mg/dl. Nascera a termo e com peso adequado para a idade gestacional. A melhor conduta para essa criança, no momento, é:

A) Referenciar com urgência a serviço terciário para investigação de colestase neonatal.

B) Encaminhar para intervenção cirúrgica em vias biliares sob risco de necessidade de transplante hepático.

C) Colher exames de função hepática e sorologias para hepatites, com retorno para reavaliação após 1 mês.

D) Suspender o leite materno, de acordo com as orientações do Ministério da Saúde constantes na caderneta de saúde da criança.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

102176)

Enunciado: Gestante comparece à consulta de pré-natal, com 32 semanas de idade gestacional, tendo o diagnóstico de sífilis confirmado. Inicia tratamento com penicilina benzatina, 2.400.000 UI em três doses (1 dose/semana), juntamente com o parceiro, com comprovação. Com 35 semanas, dá à luz um recém-nascido que se encontra assintomático. São solicitados exames para o bebê. Com esses dados, dentre as abaixo citadas, qual a melhor conduta para este recém-nascido?

A) Penicilina procaína por 10 dias.

B) Penicilina benzatina dose única.

C) Penicilina cristalina por 10 dias.

D) Observação e seguimento ambulatorial.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

102087)

Enunciado: Recém-nascido a termo, por cesárea eletiva devido à malformação congênita, é submetido a procedimento cirúrgico nas primeiras horas de vida. Com 44 horas de idade, evolui com quadro séptico. O pré-natal foi sem intercorrências, a bolsa foi rota no ato e a mãe estava assintomática no momento do parto. Qual a melhor conduta para decidir a antibioticoterapia a ser usada?

A) Considerar infecção neonatal congênita.

B) Considerar infecção neonatal tardia de provável etiologia hospitalar.

C) Considerar infecção neonatal precoce de provável etiologia materna.

D) Considerar infecção neonatal precoce de provável etiologia hospitalar.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

102093)

Enunciado: Recém-nascido de 36 semanas apresenta desconforto respiratório precoce, na primeira hora de vida. O BSA (Boletim de Silverman-Andersen) é igual a 3 e a frequência respiratória é de 64 irpm, com PaO_2 de 58 mmHg e $PaCO_2$ = 44 mmHg. Reavaliado com 6 horas de vida, observa-se BSA = 7 e frequência respiratória de 62 irpm, com necessidade crescente de aumento na fração inspirada de oxigênio, e dados da gasometria mostram PaO_2 = 48 mmHg e $PaCO_2$ = 54 mmHg. Qual a hipótese diagnóstica mais provável diante dessa situação?

A) Síndrome do desconforto respiratório.

B) Síndrome adaptativa do recém-nascido.

C) Taquipneia transitória do recém-nascido.

D) Persistência do padrão fetal de circulação.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

102131)

Enunciado: Recém-nascido, filho de mãe HIV positiva assintomática que fez adequada profilaxia no pré-natal e no parto, nasce de parto cesáreo, eletivo, em boas condições, sendo feitas as medidas preconizadas para diminuição de risco da transmissão vertical do vírus, incluindo a profilaxia com droga antirretroviral. Antes da alta hospitalar, foram solicitados os seguintes exames: hemograma completo, sorologias TORCHS, anti-HIV, HTLV-1/2, glicemia e provas de função hepática. Que exames adicionais devem ser solicitados?

A) Nenhum.

B) CD4/CD8.

C) Carga viral.

D) Citobioquímica do liquor.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

102164)

Enunciado: Recém-nascido a termo com boas condições ao nascer, primeiro filho, peso de nascimento de 3200g, 5º dia de vida, apresenta-se com icterícia (Zona IV), que se iniciou no terceiro dia de vida. O peso atual é de 2920g e está em aleitamento materno exclusivo, com mamadas rápidas e frequentes. Eliminações presentes.Tipagem sanguínea do RN é O positivo, com Coombs direto negativo.Tipagem sanguínea da mãe é A negativo, com Coombs indireto negativo. Qual a hipótese mais provável?

A) Incompatibilidade sanguínea mãe-RN.

B) Síndrome da icterícia pelo leite materno.

C) Deficiência de glicose-6 fosfato desidrogenase.

D) Icterícia por oferta inadequada do leite materno.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

81231)

Enunciado: Durante a avaliação de uma paciente com quadro de miopatia e acidose láctica, o médico obtém a seguinte história familiar: a irmã, o irmão e a mãe são afetados. A paciente não tem outros irmãos. A avó materna e seus dois tios maternos têm a mesma doença, porém suas duas primas maternas são saudáveis. O seu pai e a ascendência genealógica dele não têm a doença. Baseado na clínica e na história familiar dessa paciente, qual o tipo de herança mais provável?

A) Ligada ao X.

B) Mitocondrial.

C) Autossômica recessiva.

D) Autossômica dominante.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

81245)

Enunciado: Criança com 30 dias de vida comparece à consulta e evidencia-se teste do pezinho alterado (positivo) para hipotireoidismo. Qual a CORRETA abordagem clínica para essa criança?

A) Solicitar dosagens séricas de TSH e T4 livre.

B) Repetir o teste do pezinho antes de novos exames.

C) Iniciar tratamento e referenciar para centro especializado.

D) Solicitar dosagem do T4 livre em amostra de papel de filtro.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

81258)

Enunciado: Ao avaliar a alta hospitalar de um recém-nascido de 38 semanas com tipagem sanguínea ?O negativo?, em adequado aleitamento materno exclusivo, eliminações fisiológicas, observa-se icterícia neonatal zona II de Kramer, sendo coletado bilirrubina sérica com 48 horas de vida com o seguinte resultado: BT = 9,0 mg/dl, com BI de 8,3 mg/dl. Procede-se a análise do risco conforme o nomograma de Bhutani. (VER IMAGEM). Não há história de icterícia em irmãos. Com relação à icterícia apresentada pelo recém-nascido, qual a conduta médica?

A) Iniciar fototerapia em alojamento conjunto.

B) Alta hospitalar com retorno em 72 horas para reavaliação.

C) Postergar alta hospitalar, repetir dosagem de bilirrubinas com 72 horas de vida.

D) Postergar alta hospitalar, com observação até o 5° dia de vida quando ocorre o pico de hiperbilirrubinemia.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

81272)

Enunciado: Recém-nascido a termo, peso de 3 kg, filho de mãe com exame de VDRL positivo 1:16 no último trimestre da gravidez. O tratamento foi iniciado no último mês de gestação, quando ela e o parceiro trataram-se com 3 doses de penicilina benzatina 2.400.000 UI. O recém-nascido está assintomático. Qual o melhor critério em que os profissionais de saúde devem se basear para determinar se esse recém-nascido possui risco de ser portador de sífilis congênita?

A) História materna.

B) VDRL positivo no sangue do recém-nascido.

C) Aparecimento de sintomas clínicos no recém-nascido.

D) Testes treponêmicos positivos no sangue do recém-nascido.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

81283)

Enunciado: Recém-nascido a termo, peso de nascimento de 3000 g, Apgar 9 no primeiro e no quinto minutos de vida, encontra-se com 48 horas de vida no alojamento conjunto, em aleitamento materno exclusivo, apresentando temperatura axilar de 37,8°C. A mãe é primípara, está assintomática, fez pré-natal sem nenhuma intercorrência clínica. Parto normal, com tempo de bolsa rota de 1 hora. O peso do recém-nascido, neste momento, é de 2.720 g e o exame físico é normal, exceto por uma discreta irritabilidade do bebê. O exame que melhor confirmaria a principal hipótese diagnóstica para essa distermia é:

A) Hemocultura.

B) Hemograma completo.

C) Dosagem sérica de sódio.

D) Citobioquímica do liquor.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

81230)

Enunciado: RN de 36 semanas apresenta desconforto respiratório precoce, com gemência audível com estetoscópio, com leve batimento de asa de nariz, tiragem intercostal, sendo colocado em CPAP nasal com progressiva necessidade de aumento de fração inspirada de oxigênio. A radiografia de tórax no leito com 6 horas de vida é mostrada a seguir. (VER IMAGEM). Qual a conduta que melhor beneficiaria o recém-nascido, ocasionando menos riscos, dentre as abaixo citadas?

A) Diurético de alça.

B) Corticoide sistêmico.

C) Ventilação mecânica.

D) Surfactante exógeno.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

81277)

Enunciado: Nasce RN a termo, peso de 3 kg, com boa vitalidade, filho de mãe com HIV que fez adequada profilaxia no pré-natal e no parto. Foi adequadamente recepcionado ao nascer, suspensa a amamentação e iniciado AZT nas primeiras 2 horas de vida. Foi notificado para vigilância epidemiológica como criança exposta ao HIV. Qual a melhor conduta a seguir para esse RN antes da alta hospitalar, segundo as diretrizes do Ministério da Saúde?

A) Solicitar hemograma completo, provas de função hepática, sorologias TORCHS e glicemia.

B) Iniciar nevirapina, solicitar hemograma completo, provas de função hepática e sorologias TORCHS.

C) Solicitar hemograma completo, provas de função hepática, sorologias TORCHS, carga viral e CD4/CD8.

D) Iniciar nevirapina, solicitar hemograma completo, provas de função hepática, sorologias, carga viral e CD4/CD8.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

65738)

Enunciado: Considere um recém-nascido assintomático, oriundo de boas condições de parto e de nascimento. A análise da possibilidade de transmissão vertical da sífilis revela que a mãe teve VDRL positivo durante a gravidez, mas foi inadequadamente tratada para sífilis. Os exames revelaram: VDRL negativo, radiologia de ossos longos e exame liquórico normais. Qual a abordagem terapêutica mais adequada ao caso?

A) Não há necessidade de qualquer tratamento com antimicrobianos.

B) Utilizar penicilina procaína; 50.000 UI/kg; intramuscular/dia; 10 dias.

C) Utilizar penicilina benzatina, dose única; 50.000 UI/kg; intramuscular.

D) Utilizar penicilina cristalina; 50.000 UI/kg; endovenosa; 12/12 horas; 10 dias.

E) Utilizar penicilina procaína; 50.000 UI/kg; intramuscular/dia; 14 dias.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

65735)

Enunciado: Recém-nascido prematuro, oriundo de inadequadas condições de parto e de nascimento, apresenta, nas primeiras 48 horas de vida, os seguintes sinais clínicos: instabilidade térmica, dificuldade respiratória, hipotonia, irritabilidade e letargia, manifestações gastrointestinais, icterícia e palidez cutânea. Qual o diagnóstico etiológico mais provável?

A) Sepse por Parvovírus.

B) Sepse por Candida albicans.

C) Sepse por Escherichia coli.

D) Sepse por Staphylococcus aureus.

E) Sepse por Pseudomonas aeruginosa.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

65741)

Enunciado: Médico diarista atende um recém-nascido prematuro (Idade gestacional = 31 semanas; peso = 1430 gramas), sem intercorrências no trabalho de parto vaginal, que apresenta, nas primeiras horas de vida, sinais de aumento do trabalho respiratório. A avaliação é que se trata de Síndrome do Desconforto Respiratório. Que medidas terapêuticas apresentam potencial para modificar tal síndrome?

A) Antibiótico precoce e óxido nítrico inalatório.

B) Assistência ventilatória precoce e surfactante exógeno.

C) Assistência ventilatória precoce, antibiótico precoce e prostaglandina E1.

D) Antibiótico precoce, assistência ventilatória precoce e surfactante exógeno.

E) Corticoide antenatal, assistência ventilatória precoce e surfactante exógeno.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

141622)

Enunciado: A icterícia constitui-se em um dos problemas mais frequentes no período neonatal, motivo pelo qual é necessário saber quando a icterícia é fisiológica ou não fisiológica. Assinale a opção que indica uma situação na qual a icterícia tem grande probabilidade de origem patológica.

A) Icterícia visível nas primeiras 24 horas de vida.

B) Antecedente de irmão que apresentou icterícia.

C) Bilirrubina indireta que aumenta mais do que 2 mg/dl em 24 horas.

D) Icterícia em filho de mãe diabética com qualquer época de aparecimento.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

141621)

Enunciado: Assinale a assertiva que constitui indicação de ventilação com pressão positiva com balão auto-inflável na reanimação de recém-nascidos em sala de parto.

A) Respiração irregular e frequência cardíaca menor que 90 bpm.

B) Apneia, respiração irregular e/ou frequência cardíaca menor do 100 bpm.

C) Apneia, respiração irregular e/ou frequência cardíaca menor que 120 bpm.

D) Apneia, respiração irregular e/ou frequência cardíaca menor que 140 bpm.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

141603)

Enunciado: Para que a criança tenha uma boa linguagem oral é preciso que ela tenha uma boa audição. Com relação a importância da avaliação auditiva, é correto afirmar:

A) A perda auditiva decorrente de otite média recorrente, não é prevalente na infância.

B) O teste da orelhinha permite identificar crianças com perda auditiva moderada, severa ou profunda.

C) Uma criança com atraso na linguagem, que tiver realizado teste da orelhinha no primeiro mês de vida com laudo normal, não precisa realizar nova avaliação auditiva.

D) A triagem auditiva neonatal deve ser indicada apenas para os recém-nascidos com risco para deficiência auditiva.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

141593)

Enunciado: RN com 7 dias de vida, apresentando na cicatriz umbilical, após a queda do coto, pequena tumoração avermelhada, úmida e que ás vezes sangra discretamente. A conduta mais apropriada é:

A) Limpeza local com álcool a 70% e aplicação tópica de pomada antibiótica, pois se trata de onfalite localizada;

B) Limpeza local com álcool a 70% e referir paciente para tratamento antibiótico parenteral, pois se trata de onfalite disseminada;

C) Limpeza local com álcool a 70% e cauterização sucessiva com nitrato de prata a 2% (bastão ou solução), pois se trata de granuloma umbilical;

D) Limpeza local com álcool a 70% e observar evolução da hérnia.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

365580)

Enunciado: No que concerne ao atendimento a crianças expostas à sífilis e àquelas com sífilis congênita, assinale a alternativa correta.

A) Recomenda-se o tratamento com penicilina cristalina ou procaína por 10 dias para todo recém-nascido com evidência de neurossífilis.

B) Caso a mãe tenha sido adequadamente tratada, um teste não treponêmico do recém-nascido com título igual ou inferior ao materno exclui a possibilidade de sífilis congênita.

C) Recomenda-se a realização do teste treponêmico, se estiver disponível na avaliação inicial do recém-nascido, tendo em vista sua maior sensibilidade e especificidade em relação ao teste não treponêmico.

D) Todo recém-nascido de mãe com diagnóstico de sífilis durante a gestação, independentemente do histórico de tratamento materno, deverá realizar teste não treponêmico no sangue periférico.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

365578)

Enunciado: No Brasil, a triagem neonatal começou em 1976, na APAE de São Paulo, por meio de iniciativas isoladas para detecção de fenilcetonúria. O Programa Nacional de Triagem Neonatal (PNTN) foi criado apenas em 2001 e vem sendo ampliado periodicamente. Assinale a alternativa que indica a doença triada e o exame realizado de acordo com o PNTN.

A) Hipotireoidismo congênito - dosagem do T4 livre

B) Fibrose cística - dosagem de cloro

C) Fenilcetonúria - dosagem das concentrações de fenilalanina

D) Anemia falciforme - visualização de hemácias em foice

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

365576)

Enunciado: Com base nas diretrizes da Sociedade Brasileira de Pediatria para atendimento ao recém-nascido (RN) ? 34 semanas na sala de parto, assinale a alternativa correta.

A) A ventilação com pressão positiva, quando indicada, inicialmente deve ser feita com ar ambiente, estando contraindicado o uso de O2 a 100%.

B) O RN com boa vitalidade, nascido com líquido amniótico tinto de mecônio, deve ser levado imediatamente para berço aquecido para aspiração das vias aéreas, com o objetivo de reduzir a aspiração de mecônio.

C) A adrenalina deve ser administrada se FC < 60 bpm nos primeiros 60 segundos de vida.

D) Recomenda-se o clampeamento do cordão umbilical no primeiro minuto após o nascimento, com o objetivo de reduzir a perda de sangue do RN.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

349705)

Enunciado: Entre os anos de 2015 a 2017, houve Emergência em Saúde Pública devido ao aumento na ocorrência de nascidos vivos com microcefalia no Brasil associada à epidemia do vírus Zika, época em que foram registrados 4.595 nascidos vivos com essa malformação congênita. A partir desse episódio, foi possível confirmar a associação entre o vírus Zika e a microcefalia. Assinale a alternativa que define corretamente a microcefalia grave.

A) Recém-nascidos com perímetro cefálico inferior a 3 desvios-padrão, ou seja, mais de 3 desvios-padrão abaixo da média para idade gestacional e sexo.

B) Recém-nascidos com perímetro cefálico inferior a 2 desvios-padrão, ou seja, mais de 2 desvios-padrão abaixo da média para idade gestacional e sexo.

C) Recém-nascidos com perímetro cefálico inferior a 1 desvio-padrão, ou seja, 1 desvio-padrão abaixo da média para idade gestacional e sexo.

D) Recém-nascidos com perímetro cefálico superior a 3 desvios-padrão, ou seja, mais de 3 desvios-padrão acima da média para idade gestacional e sexo.

E) Recém-nascidos com perímetro cefálico superior a 2 desvios-padrão, ou seja, mais de 2 desvios-padrão acima da média para idade gestacional e sexo.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

322172)

Enunciado: Sobre a rubéola congênita, assinale a alternativa correta.

A) Perda auditiva é a manifestação mais comum e usualmente é condutiva bilateral, e a severidade varia de moderada a grave, com progressão ao longo do tempo.

B) Cerca de 50% apresentam algum tipo de defeito cardíaco estrutural, sendo mais comuns os defeitos de septo cardíaco.

C) O risco de transmissão materno-fetal é maior nas primeiras 10 semanas de gestação, e o risco de ocorrer malformações prolonga-se até a 18ª e a 20ª semana.

D) As manifestações tardias de diabete melito e das patologias da tireoide são bastante comuns, afetando mais de 1/3 dos casos até a adolescência.

E) O uso de imunoglobulina para tratamento da rubéola materna garante proteção contra a infecção do feto.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

322181)

Enunciado: A fibrose cística está presente em 99% dos pacientes com diagnóstico de íleo meconial. Na ausência de fibrose cística, qual é um dos grupos de recém-nascidos (RN) mais acometidos?

A) RN com icterícia.

B) RN com asfixia perinatal.

C) RN com doença hemolítica.

D) RN com hipotireoidismo congênito.

E) RN prematuro com peso muito baixo.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

305312)

Enunciado: Em qual das seguintes situações, pode-se proceder ao clampeamento tardio do cordão umbilical?

A) Descolamento prematuro de placenta.

B) Nó verdadeiro de cordão umbilical.

C) Ausência de tônus muscular em flexão.

D) Placenta prévia.

E) Prematuro de 34 semanas.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

305313)

Enunciado: Você está de plantão em um hospital e é chamado para atender um Recém-Nascido (RN) em sala de parto. O parto é por via vaginal, e o RN nasce hipotônico e com movimentos respiratórios irregulares. Você prontamente recebe o RN e inicia o atendimento. A avaliação da Frequência Cardíaca (FC) é o principal determinante da decisão de indicar as diversas manobras de reanimação. Sobre as particularidades de cada método que pode ser utilizado, assinale a alternativa CORRETA.

A) A detecção da atividade elétrica do coração pelo monitor cardíaco não traz benefício na condução da reanimação neonatal, pois atrapalha as demais manobras.

B) A palpação do pulso carotídeo é o melhor método em sala de parto, apesar de subestimar a FC.

C) A ausculta do precórdio com estetoscópio subestima a FC.

D) A palpação do cordão umbilical superestima a FC.

E) A oximetria de pulso detecta de forma contínua a frequência de pulso, é rápida e não subestima nem superestima a FC.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

274384)

Enunciado: Em qual das seguintes situações está autorizado o clampeamento tardio do cordão umbilical, no atendimento em sala de parto?

A) Prematuro de 34 semanas.

B) Descolamento prematuro de placenta.

C) Prolapso de cordão.

D) Nó verdadeiro de cordão.

E) Prematuro de 36 semanas, com tônus fraco.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

261256)

Enunciado: Certo recém-nascido (RN) a termo, de parto vaginal, com peso ao nascimento de 3.200 gramas, é encaminhado à consulta de puericultura aos sete dias de vida, em aleitamento materno exclusivo. A lactante relata dor extrema ao amamentar. O peso atual do paciente é de 2.600 gramas. Com base nesse caso clínico e nos conhecimentos médicos correlatos, julgue o item a seguir. Sonolência excessiva, hipoatividade e convulsões são manifestações de hipoglicemia neonatal.

A) CERTO

B) ERRADO

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

261257)

Enunciado: Certo recém-nascido (RN) a termo, de parto vaginal, com peso ao nascimento de 3.200 gramas, é encaminhado à consulta de puericultura aos sete dias de vida, em aleitamento materno exclusivo. A lactante relata dor extrema ao amamentar. O peso atual do paciente é de 2.600 gramas. Com base nesse caso clínico e nos conhecimentos médicos correlatos, julgue o item a seguir. Na vigência de hipoglicemia neonatal prolongada, deve-se aventar a hipótese de erros inatos do metabolismo.

A) CERTO

B) ERRADO

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

261258)

Enunciado: Determinado recém-nascido (RN) a termo, grande para a idade gestacional, nascido de parto vaginal com período expulsivo prolongado, apresenta-se ao nascimento em apneia, com hipotonia. O líquido amniótico era tinto de mecônio. O paciente, então, é levado ao berço aquecido. Demonstra FC = 80 bpm e SatO? = 80%. A mãe realizou pré-natal adequadamente, sem malformações congênitas detectadas no RN. A respeito desse caso clínico e considerando os conhecimentos médicos correlatos, julgue o item a seguir. Nesse caso, recomenda-se o clampeamento do cordão umbilical após três minutos.

A) CERTO.

B) ERRADO.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

261259)

Enunciado: Determinado recém-nascido (RN) a termo, grande para a idade gestacional, nascido de parto vaginal com período expulsivo prolongado, apresenta-se ao nascimento em apneia, com hipotonia. O líquido amniótico era tinto de mecônio. O paciente, então, é levado ao berço aquecido. Demonstra FC = 80 bpm; e SatO? = 80%. A mãe realizou pré-natal adequadamente, sem malformações congênitas detectadas no RN. A respeito desse caso clínico e considerando os conhecimentos médicos correlatos, julgue o item a seguir. Deve-se proceder imediatamente com massagem cardíaca externa.

A) CERTO

B) ERRADO

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

261260)

Enunciado: Determinado recém-nascido (RN) a termo, grande para a idade gestacional, nascido de parto vaginal com período expulsivo prolongado, apresenta-se ao nascimento em apneia, com hipotonia. O líquido amniótico era tinto de mecônio. O paciente, então, é levado ao berço aquecido. Demonstra FC = 80 bpm; e SatO? = 80%. A mãe realizou pré-natal adequadamente, sem malformações congênitas detectadas no RN. A respeito desse caso clínico e considerando os conhecimentos médicos correlatos, julgue o item a seguir. Indica-se ventilar o paciente utilizando-se de pressão positiva.

A) CERTO

B) ERRADO

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

261261)

Enunciado: Determinado recém-nascido (RN) a termo, grande para a idade gestacional, nascido de parto vaginal com período expulsivo prolongado, apresenta-se ao nascimento em apneia, com hipotonia. O líquido amniótico era tinto de mecônio. O paciente, então, é levado ao berço aquecido. Demonstra FC = 80 bpm; e SatO? = 80%. A mãe realizou pré-natal adequadamente, sem malformações congênitas detectadas no RN. A respeito desse caso clínico e considerando os conhecimentos médicos correlatos, julgue o item a seguir. Para a avaliação do neurodesenvolvimento na infância, indica-se avaliar o Apgar da criança ao nascimento.

A) CERTO

B) ERRADO

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

261262)

Enunciado: Determinado recém-nascido (RN) a termo, grande para a idade gestacional, nascido de parto vaginal com período expulsivo prolongado, apresenta-se ao nascimento em apneia, com hipotonia. O líquido amniótico era tinto de mecônio. O paciente, então, é levado ao berço aquecido. Demonstra FC = 80 bpm; e SatO? = 80%. A mãe realizou pré-natal adequadamente, sem malformações congênitas detectadas no RN. A respeito desse caso clínico e considerando os conhecimentos médicos correlatos, julgue o item a seguir. Icterícia neonatal à custa de hiperbilirrubinemia indireta é uma das complicações do céfalo-hematoma.

A) CERTO

B) ERRADO

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

261263)

Enunciado: Determinado recém-nascido (RN) a termo, grande para a idade gestacional, nascido de parto vaginal com período expulsivo prolongado, apresenta-se ao nascimento em apneia, com hipotonia. O líquido amniótico era tinto de mecônio. O paciente, então, é levado ao berço aquecido. Demonstra FC = 80 bpm; e SatO? = 80%. A mãe realizou pré-natal adequadamente, sem malformações congênitas detectadas no RN. A respeito desse caso clínico e considerando os conhecimentos médicos correlatos, julgue o item a seguir. Crepitações, edema e assimetria claviculares em RN são achados clínicos sugestivos de fratura.

A) CERTO

B) ERRADO

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

284364)

Enunciado: A detecção em indivíduos saudáveis que poderão desenvolver uma doença hereditária no futuro é o objetivo dos testes preditivos (TP). Já a epigenética é uma importante ferramenta para explicar as interações entre gene e ambiente. Acerca desses temas, julgue o item. Os estímulos ambientais que atingem o feto através da placenta ou o recém-nascido por meio da amamentação podem provocar alterações químicas no DNA, que envolvem a sequência dos seus nucleotídeos ou das suas estruturas proteicas, afetando a expressão genética.

A) CERTO

B) ERRADO

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

250103)

Enunciado: Um exame físico completo deve ser realizado na primeira consulta de puericultura. Considerando essa informação, julgue o item a seguir. O teste do reflexo vermelho ou Bruckner test deve ser realizado, em especial, nos prematuros com trinta e duas semanas ou menos e(ou) menores de 1.500 g na 6.ª semana de vida, pois o teste é uma excelente triagem para retinopatia e, caso esteja normal, dispensa o exame oftalmológico especializado.

A) CERTO

B) ERRADO

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

250106)

Enunciado: Um exame físico completo deve ser realizado na primeira consulta de puericultura. Considerando essa informação, julgue o item a seguir. O teste da orelhinha consiste em procedimentos eletrofisiológicos objetivos e a ausência de otoemissões deve-se ao funcionamento coclear alterado, pois a presença de componente obstrutivo condutivo nas várias partes da orelha não são detectados por esse teste.

A) CERTO.

B) ERRADO.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

250112)

Enunciado: Acerca das patologias na infância, julgue o item a seguir. A grande maioria dos recém-nascidos com sífilis congênita apresenta algum sinal ou sintoma ao nascer, principalmente com alterações nos ossos longos detectáveis ao exame radiológico.

A) CERTO

B) ERRADO

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

250113)

Enunciado: Acerca das patologias na infância, julgue o item a seguir. Suponha-se que haja uma mãe primigesta com tipagem sanguínea B positivo e um recém-nascido A positivo que desenvolveu hiperbilirrubinemia. Nesse caso, deve-se considerar como incompatibilidade ABO, mesmo com Coombs direto negativo.

A) CERTO

B) ERRADO

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

239316)

Enunciado: Uma criança de três meses de idade, avaliada em consulta de puericultura, é classificada, pelas curvas de crescimento da Organização Mundial de Saúde, como portadora de muito baixo peso e com perímetro cefálico abaixo do esperado para a idade. É internada para investigação do quadro, sendo solicitada tomografia de crânio que demonstrou calcificações intracranianas periventriculares. Acerca desse caso clínico e considerando os conhecimentos médicos correlatados, julgue o item a seguir. O diagnóstico provável é o de toxoplasmose congênita.

A) CERTO.

B) ERRADO.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

239317)

Enunciado: Uma criança de três meses de idade, avaliada em consulta de puericultura, é classificada, pelas curvas de crescimento da Organização Mundial de Saúde, como portadora de muito baixo peso e com perímetro cefálico abaixo do esperado para a idade. É internada para investigação do quadro, sendo solicitada tomografia de crânio que demonstrou calcificações intracranianas periventriculares. Acerca desse caso clínico e considerando os conhecimentos médicos correlatados, julgue o item a seguir. O tratamento deve ser realizado com sulfadiazina, pirimetamina e ácido folínico.

A) CERTO

B) ERRADO

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

239318)

Enunciado: Uma criança de três meses de idade, avaliada em consulta de puericultura, é classificada, pelas curvas de crescimento da Organização Mundial de Saúde, como portadora de muito baixo peso e com perímetro cefálico abaixo do esperado para a idade. É internada para investigação do quadro, sendo solicitada tomografia de crânio que demonstrou calcificações intracranianas periventriculares. Acerca desse caso clínico e considerando os conhecimentos médicos correlatados, julgue o item a seguir. A avaliação oftalmológica está indicada nesse caso.

A) CERTO

B) ERRADO

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

239319)

Enunciado: Uma criança de três meses de idade, avaliada em consulta de puericultura, é classificada, pelas curvas de crescimento da Organização Mundial de Saúde, como portadora de muito baixo peso e com perímetro cefálico abaixo do esperado para a idade. É internada para investigação do quadro, sendo solicitada tomografia de crânio que demonstrou calcificações intracranianas periventriculares. Acerca desse caso clínico e considerando os conhecimentos médicos correlatados, julgue o item a seguir. O rastreio dessa infecção durante a gestação é preconizado pelas diretrizes do Ministério da Saúde.

A) CERTO

B) ERRADO

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

239320)

Enunciado: Uma criança de três meses de idade, avaliada em consulta de puericultura, é classificada, pelas curvas de crescimento da Organização Mundial de Saúde, como portadora de muito baixo peso e com perímetro cefálico abaixo do esperado para a idade. É internada para investigação do quadro, sendo solicitada tomografia de crânio que demonstrou calcificações intracranianas periventriculares. Acerca desse caso clínico e considerando os conhecimentos médicos correlatados, julgue o item a seguir. A imunoglobulina hiperimune para essa doença pode ser administrada até, no máximo, cinco dias após o contato de comunicantes suscetíveis.

A) CERTO

B) ERRADO

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

239321)

Enunciado: Uma criança de três meses de idade, avaliada em consulta de puericultura, é classificada, pelas curvas de crescimento da Organização Mundial de Saúde, como portadora de muito baixo peso e com perímetro cefálico abaixo do esperado para a idade. É internada para investigação do quadro, sendo solicitada tomografia de crânio que demonstrou calcificações intracranianas periventriculares. Acerca desse caso clínico e considerando os conhecimentos médicos correlatados, julgue o item a seguir. Trombocitopenia é um achado possível nesse caso.

A) CERTO

B) ERRADO

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

214420)

Enunciado: Determinado paciente, atualmente com 24 meses de vida, é levado pela própria mãe, de 18 anos de idade, a consulta com especialista em desenvolvimento. No histórico, observa- se gestação durante a adolêscencia da mãe, complicada por trauma abdominal durante discussão com o pai da criança, às 34 semanas de gestação, causando descolamento prematuro da placenta, com necessidade de parto cesáreo de emergência por sofrimento fetal agudo por ocasião. O RN nasceu com 1.800 g, sendo necessária a realização de manobras de reanimação neonatal. Ele permaneceu internado na unidade de terapia intensiva neonatal por quatro semanas. Apresentou, ao exame físico, FC de 90 bpm, FR de 20 irpm, saturação de oxigênio de 99%, reflexo cutâneo plantar em extensão, reflexo de preensão palmar ausente e capacidade de marchar com apoio (mas não sozinho). Refere ausência de controle esfincteriano no momento. O paciente fala algumas palavras com duas sílabas. Em relação ao caso clínico descrito, julgue o item a seguir. Não há presença de fatores de risco perinatais para distúrbios de desenvolvimento nesse caso.

A) CERTO

B) ERRADO

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

196631)

Enunciado: Recém-nascido de parto vaginal, prematuro tardio, pequeno para a idade gestacional, Apgar 8 ao primeiro minuto e 10 ao quinto minuto, apresenta, em regiões palmoplantares, lesões cutâneas bolhosas, com áreas de descamação subjacentes, além de esplenomegalia. A gestante não realizou pré-natal. Com base, nesse caso clínico e nos conhecimentos médicos correlatos, julgue o item a seguir. Trata-se de uma infecção congênita que representa um evento sentinela, por refletir a eficácia tanto de programas de controle quanto da assistência ao pré-natal.

A) CERTO

B) ERRADO

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

196642)

Enunciado: Recém-nascido de parto vaginal, prematuro tardio, pequeno para a idade gestacional, Apgar 8 ao primeiro minuto e 10 ao quinto minuto, apresenta, em regiões palmoplantares, lesões cutâneas bolhosas, com áreas de descamação subjacentes, além de esplenomegalia. A gestante não realizou pré-natal. Com base, nesse caso clínico e nos conhecimentos médicos correlatos, julgue o item a seguir. Além de esplenomegalia, o recém-nascido também pode apresentar hepatomegalia e icterícia.

A) CERTO.

B) ERRADO.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

196669)

Enunciado: Recém-nascido de parto vaginal, prematuro tardio, pequeno para a idade gestacional, Apgar 8 ao primeiro minuto e 10 ao quinto minuto, apresenta, em regiões palmoplantares, lesões cutâneas bolhosas, com áreas de descamação subjacentes, além de esplenomegalia. A gestante não realizou pré-natal. Com base nesse caso clínico e nos conhecimentos médicos correlatos, julgue o item a seguir. Uma vez que o paciente é portador sintomático, descarta-se a punção lombar para coleta e análise de liquor, pois o tratamento com penicilina benzatina deverá ser prontamente instituído.

A) CERTO.

B) ERRADO.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

196691)

Enunciado: Recém-nascido de parto vaginal, prematuro tardio, pequeno para a idade gestacional, Apgar 8 ao primeiro minuto e 10 ao quinto minuto, apresenta, em regiões palmoplantares, lesões cutâneas bolhosas, com áreas de descamação subjacentes, além de esplenomegalia. A gestante não realizou pré-natal. Com base, nesse caso clínico e nos conhecimentos médicos correlatos, julgue o item a seguir. Não são necessárias medidas preventivas de contato para o paciente, uma vez que essa infecção congênita não se transmite por secreções orgânicas.

A) CERTO

B) ERRADO

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

196701)

Enunciado: Recém-nascido de parto vaginal, prematuro tardio, pequeno para a idade gestacional, Apgar 8 ao primeiro minuto e 10 ao quinto minuto, apresenta, em regiões palmoplantares, lesões cutâneas bolhosas, com áreas de descamação subjacentes, além de esplenomegalia. A gestante não realizou pré-natal. Com base, nesse caso clínico e nos conhecimentos médicos correlatos, julgue o item a seguir. A prematuridade e a restrição de crescimento intrauterino são achados dessa infecção congênita.

A) CERTO

B) ERRADO

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

196703)

Enunciado: Recém-nascido de parto vaginal, prematuro tardio, pequeno para a idade gestacional, Apgar 8 ao primeiro minuto e 10 ao quinto minuto, apresenta, em regiões palmoplantares, lesões cutâneas bolhosas, com áreas de descamação subjacentes, além de esplenomegalia. A gestante não realizou pré-natal. Com base, nesse caso clínico e nos conhecimentos médicos correlatos, julgue o item a seguir. A doença em questão pode cursar com lesões ósseas, com pseudoparalisia dos membros.

A) CERTO.

B) ERRADO.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

214494)

Enunciado: H. C. S., primeiro filho de C. C. S., realizou acompanhamento de puericultura em posto de saúde desde a primeira consulta pós-natal até atualmente, quando tem 8 anos de idade. Ao longo desse acompanhamento, as variações antropométricas foram registradas nas curvas de crescimento (peso para idade, estatura/altura para a idade, IMC para a idade), e o desenvolvimento psiconeuromotor foi avaliado. Na primeira consulta, foi verificada história de parto vaginal laborioso, mas não havia histórico de outras complicações gestacionais ou periparto. Atualmente, nas curvas antropométricas, observam-se z-score de +3,34 no IMC para a idade e z-score de -1,75 na altura para a idade. Considerando as várias consultas realizadas nesse período, os raciocínios diagnósticos e as condutas a serem tomadas frente ao crescimento e desenvolvimento normal e patológico, julgue o item a seguir. Na primeira consulta de puericultura, estaria recomendada a realização dos testes de Ortolani e Barlow para avaliação de fratura de clavícula intraparto e de destacamento do plexo braquial, respectivamente.

A) CERTO

B) ERRADO

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

196640)

Enunciado: Determinada paciente de 16 anos de idade iniciou atendimento pré-natal em posto de saúde da família e foi diagnosticada com HIV nas sorologias de primeiro trimestre, iniciando terapia antirretroviral adequada e com boa adesão imediatamente. Os demais exames de rotina de pré-natal mostraram-se normais. Com base nesse caso clínico e nos conhecimentos médicos correlatos, julgue o item a seguir. Crianças com peso de nascimento inferior a 1.500 g não devem fazer uso do AZT.

A) CERTO

B) ERRADO

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

179206)

Enunciado: Em uma gestante no terceiro trimestre de gestação, foi observada a seguinte sorologia para toxoplasmose: IgG+ e IgM+, com baixo índice de avidez (20%). O Recém-Nascido (RN) não apresentou qualquer sintoma ou alteração no exame físico. Foi realizada punção lombar, que evidenciou proteinorraquia ? 1.000 mg/dl, e exame de fundo do olho normal. Com base nesse caso hipotético, assinale a alternativa que apresenta a conduta terapêutica CORRETA para o RN.

A) Pirimetamina, sulfadiazina, ácido fólico e prednisona até seis meses de vida.

B) Pirimetamina, sulfadiazina, ácido fólico até um ano de idade e prednisona com retirada gradual após estabilização do processo inflamatório.

C) Pirimetamina, sulfadiazina, ácido fólico até dezoito meses de vida.

D) Pirimetamina, sulfadiazina e ácido fólico até um ano de idade.

E) Apenas acompanhamento sorológico.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

179211)

Enunciado: Assinale a alternativa que apresenta o fator de risco para desenvolvimento de hiperbilirrubinemia significante em RN > 35 semanas de idade gestacional.

A) Icterícia nas primeiras 72 horas de vida.

B) Tipagem sanguínea materna A e RN B.

C) Tipagem sanguínea materna A ou B e RN O.

D) Descendência asiática.

E) Fator RH materno positivo e RN negativo.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

179209)

Enunciado: Assinale a alternativa que apresenta fator de risco para sepse neonatal.

A) Gênero masculino.

B) Segundo gemelar.

C) Infecção urinária materna em qualquer fase da gestação.

D) Ruptura prematura de membranas amnióticas superior a seis horas.

E) Colonização inespecífica do trato genital feminino.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

179177)

Enunciado: Embora a grande maioria dos RN sejam assintomáticos ao nascimento, entre 5 e 15% podem ter anormalidades tardias, meses a anos após o nascimento, principalmente surdez neurossensorial, que pode ser bilateral em até 50% dos casos. São os seguintes sinais clínicos mais frequentemente observados na infecção congênita por esse agente: restrição do crescimento intrauterino; petéquias; hepatoesplenomegalia; icterícia associada à colestase; hiperbilirrubinemia direta; microcefalia; calcificações periventriculares; trombocitopenia e aminotransferases séricas aumentadas. Essa infecção congênita corresponde:

A) À sífilis.

B) À toxoplasmose.

C) À Zika.

D) À rubéola.

E) Ao citomegalovírus.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

154320)

Enunciado: O pediatra é chamado por uma enfermeira, responsável pelo plantão da maternidade de um hospital, e questionado acerca de um recém-nascido de 6 horas de vida, que se encontra internado em alojamento conjunto com a mãe. Ela informa que os pais estão ansiosos quanto à possibilidade de uma malformação cardíaca do paciente, uma vez que há casos na família. Após examinar o paciente e não encontrar alterações, orienta os familiares, bem como a equipe de enfermagem, em relação à realização do teste do coraçãozinho, que é conduzida de forma universal como parte da triagem neonatal do Sistema Único de Saúde (SUS). O teste permite identificar precocemente graves malformações cardíacas e, caso apresente resultado alterado, o paciente deve ser submetido a um exame de ecocardiograma para confirmar o diagnóstico. Acerca do caso apresentado, da técnica recomendada pelo Ministério da Saúde e do resultado do teste, assinale a alternativa correta:

A) Aferir a saturação de oxigênio (SpO2) no membro superior direito e em um dos membros inferiores, entre 12 e 24 horas de vida, antes da alta hospitalar. O resultado normal é saturação periférica maior ou igual a 90% em ambas as medidas e diferença menor que 3% entre as medidas. Caso qualquer medida da SpO2 esteja alterada, uma nova aferição deverá ser realizada após 12 horas. Caso o resultado se confirme, um ecocardiograma deverá ser realizado prontamente.

B) Aferir a saturação de oxigênio (SpO2) no membro superior esquerdo e em um dos membros inferiores, entre 24 e 48 horas de vida, antes da alta hospitalar. O resultado normal é saturação periférica maior ou igual a 90% em ambas as medidas e diferença menor que 3% entre as medidas. Caso qualquer medida da SpO2 esteja alterada, uma nova aferição deverá ser realizada após uma hora. Caso o resultado se confirme, um ecocardiograma deverá ser realizado prontamente.

C) Aferir a saturação de oxigênio (SpO2) no membro superior direito e em um dos membros inferiores, entre 36 e 48 horas de vida, antes da alta hospitalar. O resultado normal é saturação periférica maior ou igual a 95% em ambas as medidas e diferença menor que 3% entre as medidas. Caso qualquer medida da SpO2 esteja alterada, uma nova aferição deverá ser realizada após 12 horas. Caso o resultado se confirme, um ecocardiograma deverá ser realizado prontamente.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

D) Aferir a saturação de oxigênio (SpO2) no membro superior direito e em um dos membros inferiores, entre 24 e 48 horas de vida, antes da alta hospitalar. O resultado normal é saturação periférica maior ou igual a 95% em ambas as medidas e diferença menor que 3% entre as medidas. Caso qualquer medida da SpO2 esteja alterada, uma nova aferição deverá ser realizada após uma hora. Caso o resultado se confirme, um ecocardiograma deverá ser realizado prontamente.

E) Aferir a saturação de oxigênio (SpO2) no membro superior esquerdo e em um dos membros inferiores, entre 12 e 24 horas de vida, antes da alta hospitalar. O resultado normal é saturação periférica maior ou igual a 90% em ambas as medidas e diferença menor que 3% entre as medidas. Caso qualquer medida da SpO2 esteja alterada, uma nova aferição deverá ser realizada após 12 horas. Caso o resultado se confirme, um ecocardiograma deverá ser realizado prontamente.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

154329)

Enunciado: Um recém-nascido apresenta exantema maculoso, icterícia, petéquias e algumas vesículas, coriza hemorrágica e lesões ósseas com imagens radiológicas de osteocondrite. Acerca do caso clínico apresentado, assinale a alternativa que corresponde ao diagnóstico mais provável:

A) Sífilis congênita.

B) Infecção pelo herpesvírus.

C) Infecção por pseudomonas.

D) Infecção por Streptococcus beta-hemolítico do grupo B.

E) Doença hemorrágica do recém-nascido.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

152176)

Enunciado: Recém-nascido (RN), no sexto dia de vida, é levado à unidade básica de saúde, pois a mãe vem observando que a criança está mais "amarelada" a cada dia. Notou a aparição com aproximadamente 36 horas de vida. A mãe relata que a criança está em aleitamento materno exclusivo, satisfazendo-se após as mamadas. Ao exame físico, observa-se RN ictérico até zona IV de Kramer, corado, sem visceromegalias, peso 2.720 g (peso do nascimento = 2.950 g). Na avaliação da caderneta de vacinação, identificou-se que a mãe tem grupo sanguíneo O positivo, e o RN tem grupo sanguíneo B positivo. Com base nesse caso hipotético, e considerando os conhecimentos médicos a ele relacionados, julgue o item a seguir. A provável causa da icterícia que a esse RN apresenta é a atresia de vias biliares.

A) CERTO

B) ERRADO

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

152175)

Enunciado: Recém-nascido (RN), no sexto dia de vida, é levado à unidade básica de saúde, pois a mãe vem observando que a criança está mais "amarelada" a cada dia. Notou a aparição com aproximadamente 36 horas de vida. A mãe relata que a criança está em aleitamento materno exclusivo, satisfazendo-se após as mamadas. Ao exame físico, observa-se RN ictérico até zona IV de Kramer, corado, sem visceromegalias, peso 2.720 g (peso do nascimento = 2.950 g). Na avaliação da caderneta de vacinação, identificou-se que a mãe tem grupo sanguíneo O positivo, e o RN tem grupo sanguíneo B positivo. Com base nesse caso hipotético, e considerando os conhecimentos médicos a ele relacionados, julgue o item a seguir. O tratamento da icterícia se baseia em observação clínica, fototerapia e exsanguineotransfusão, devendo-se quantificar a bilirrubina direta e indireta do paciente, em amostra de sangue, para a definição da melhor conduta.

A) CERTO

B) ERRADO

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

152061)

Enunciado: Recém-nascido (RN), no sexto dia de vida, é levado à unidade básica de saúde, pois a mãe vem observando que a criança está mais "amarelada" a cada dia. Notou a aparição com aproximadamente 36 horas de vida. A mãe relata que a criança está em aleitamento materno exclusivo, satisfazendo-se após as mamadas. Ao exame físico, observa-se RN ictérico até zona IV de Kramer, corado, sem visceromegalias, peso 2.720 g (peso do nascimento = 2.950 g). Na avaliação da caderneta de vacinação, identificou-se que a mãe tem grupo sanguíneo O positivo, e o RN tem grupo sanguíneo B positivo. Com base nesse caso hipotético, e considerando os conhecimentos médicos a ele relacionados, julgue o item a seguir. A icterícia pode causar um amplo espectro de disfunções neurológicas, desde a encefalopatia transitória até a instalação do Kernicterus.

A) CERTO

B) ERRADO

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

152064)

Enunciado: Recém-nascido (RN), no sexto dia de vida, é levado à unidade básica de saúde, pois a mãe vem observando que a criança está mais "amarelada" a cada dia. Notou a aparição com aproximadamente 36 horas de vida. A mãe relata que a criança está em aleitamento materno exclusivo, satisfazendo-se após as mamadas. Ao exame físico, observa-se RN ictérico até zona IV de Kramer, corado, sem visceromegalias, peso 2.720 g (peso do nascimento = 2.950 g). Na avaliação da caderneta de vacinação, identificou-se que a mãe tem grupo sanguíneo O positivo, e o RN tem grupo sanguíneo B positivo. Com base nesse caso hipotético, e considerando os conhecimentos médicos a ele relacionados, julgue o item a seguir. A icterícia progride no sentido céfalocaudal.

A) CERTO

B) ERRADO

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

152066)

Enunciado: Recém-nascido (RN), no sexto dia de vida, é levado à unidade básica de saúde, pois a mãe vem observando que a criança está mais "amarelada" a cada dia. Notou a aparição com aproximadamente 36 horas de vida. A mãe relata que a criança está em aleitamento materno exclusivo, satisfazendo-se após as mamadas. Ao exame físico, observa-se RN ictérico até zona IV de Kramer, corado, sem visceromegalias, peso 2.720 g (peso do nascimento = 2.950 g). Na avaliação da caderneta de vacinação, identificou-se que a mãe tem grupo sanguíneo O positivo, e o RN tem grupo sanguíneo B positivo. Com base nesse caso hipotético, e considerando os conhecimentos médicos a ele relacionados, julgue o item a seguir. A icterícia patológica tem aparecimento tardio, após as primeiras 24 horas de vida.

A) CERTO

B) ERRADO

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

152081)

Enunciado: Lactente de um mês de idade é levado à Unidade Básica de Saúde para sua segunda consulta de puericultura. A mãe relata que o paciente está em aleitamento materno exclusivo, peso = 4.125 g (peso de nascimento = 3.620 g), comprimento de 53 cm, e perímetro cefálico de 36 cm. Com base nessa situação, e considerando os conhecimentos médicos a ele relacionados, julgue o item a seguir. O teste do coraçãozinho está registrado na caderneta. Esse é um teste de triagem que alerta para cardiopatias congênitas que o paciente possa apresentar e deve ser realizado, ainda na maternidade, entre 12 e 24 horas de vida.

A) CERTO.

B) ERRADO.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

289520)

Enunciado: Um recém-nascido prematuro, com 36 semanas de idade, pequeno para a idade gestacional, Apgar 5, 7 e 9, apresenta-se com icterícia, hepatoesplenomegalia e plaquetopenia logo nas primeiras 24 horas de vida. A ultrassonografia transfontanelar evidencia dilatação ventricular e calcificações intracranianas difusas. Com base na hipótese clínica apresentada, julgue o item a seguir. Trata-se provavelmente de um quadro sintomático de toxoplasmose congênita; a confirmação diagnóstica dá-se pela presença de IgM ou IgA específicas nos primeiros seis meses de vida, e da persistência de IgG específica no sangue periférico após os 12 primeiros meses de vida.

A) CERTO

B) ERRADO

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

289527)

Enunciado: Um recém-nascido prematuro, com 36 semanas de idade, pequeno para a idade gestacional, Apgar 5, 7 e 9, apresenta-se com icterícia, hepatoesplenomegalia e plaquetopenia logo nas primeiras 24 horas de vida. A ultrassonografia transfontanelar evidencia dilatação ventricular e calcificações intracranianas difusas. Com base na hipótese clínica apresentada, julgue o item a seguir. A infecção congênita apresentada no quadro clínico descrito pode evoluir com surdez neurossensorial, de forma que o paciente deve ser encaminhado futuramente para acompanhamento audiológico.

A) CERTO

B) ERRADO

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

131851)

Enunciado: Considere hipoteticamente que gestante de 30 anos de idade, com idade gestacional de 38 semanas, chega ao hospital do respectivo município em período expulsivo de trabalho de parto. Relata que realizou acompanhamento pré-natal completo e nega doenças crônicas ou intercorrências na gravidez. O bebê nasceu com respiração irregular, frequência cardíaca de 60 batimentos por minuto e líquido amniótico claro. Com base no exposto, assinale a alternativa que apresenta o procedimento inicial mais indicado nessa situação clínica.

A) Intubação orotraqueal com massagem cardíaca externa.

B) Ventilação com pressão positiva com balão autoinflável.

C) Massagem cardíaca externa.

D) Intubação orotraqueal com ventilação positiva com balão autoinflável.

E) Intubação orotraqueal com massagem cardíaca externa associada à infusão de solução cristaloide e uso de adrenalina em infusão venosa.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

105558)

Enunciado: Recém-Nascido (RN) apresenta quadro de desconforto respiratório devido à doença de membrana hialina, com baixa perfusão periférica. Com base nesse caso hipotético, assinale a alternativa que apresenta a conduta terapêutica correta.

A) Fase expansiva com soro glicosado a 10% a 20 mL/Kg, seguida de infusão contínua de dobutamina caso não responda.

B) Fase expansiva com soro fisiológico a 10 mL/Kg, seguida de infusão contínua de dopamina caso não responda.

C) Fase expansiva com soro glicosado a 5% a 29 mL/Kg, seguida de adrenalina em infusão contínua caso não responda.

D) Fase expansiva com soro fisiológico a 20 mL/Kg, seguida de adrenalina em infusão contínua caso não responda.

E) Fase expansiva com soro glicosado a 10% a 20 mL/Kg, seguida de infusão contínua com dopamina e dobutamina caso não responda.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

105554)

Enunciado: A pressão de vias aéreas positivas contínuas (CPAP) nasal é um dos recursos mais antigos e de ampla utilização nas UTI neonatais devido ao seu baixo custo e fácil manuseio. Seu uso tem indicação

A) Profilática, pois previne pneumotórax e apneias, e terapêutica, principalmente nas hérnias diafragmáticas, ao diminuir a pressão toráxica.

B) Profilática, pois leva ao aumento da pressão média das vias aéreas por meio da elevação da PEEP (pressão expiratória), prevenindo o colabamento dos alvéolos distais e melhorando a oxigenação, além de evitar apneia. Terapêutica, pois reabre os alvéolos colabados, estabilizando a respiração do RN.

C) Terapêutica na falência respiratória com gasometria: $PaO_2 < 50$ mmHg e $PaCO_2 > 65$ mmHg, agindo profilaticamente na necessidade de suporte respiratório invasivo e evitando apneia.

D) Profilática, pois leva ao aumento da pressão média das vias aéreas, por meio da elevação da Pressão Inspiratória Máxima (PIM), evitando o colabamento dos alvéolos sem repercussões na apneia, mas, terapeuticamente, só recupera os alvéolos colabados com o uso concomitante de surfactante.

E) Profilática, ao evitar a baixa perfusão periférica aumentando o débito cardíaco e a apneia, e terapêutica, ao aumentar a PO_2 recrutando os alvéolos já colabados.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

105566)

Enunciado: Há risco de icterícia precoce na seguinte situação, considerando a tipagem de sangue da mãe, a tipagem de sangue do RN e o Coombs do RN, respectivamente:

A) A+; B+; Coombs indireto do RN positivo.

B) B+; O+; Coombs direto do RN positivo ou negativo.

C) A+; O+; Coombs direto do RN positivo.

D) O+; B+; Coombs direto do RN positivo ou negativo.

E) O+; A+; Coombs indireto do RN positivo.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

105544)

Enunciado: Os testes neonatais são importantes para a prevenção de agravos relacionados à saúde. Constam, na caderneta de saúde da criança do Ministério da Saúde, os exames de triagem neonatal que devem ser realizados. Considerando essa informação, assinale a alternativa que apresenta a relação entre o tipo de exame e a sua CORRETA finalidade.

A) Manobra de Ortolani para verificar luxação congênita de joelhos.

B) Teste do pezinho para verificar, no mínimo, hipertireoidismo, fenilcetonúria e anemia falciforme.

C) Teste do olho para verificar acuidade visual.

D) Triagem auditiva por meio de emissões otoacústicas evocadas para avaliar o ouvido interno e a cóclea.

E) Teste do coração para verificar se a saturação do CO_2 está > 40%.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

105562)

Enunciado: Estudos epidemiológicos demonstram que a exposição fetal a níveis aumentados de determinados hormônios maternos pode gerar baixo peso ao nascimento. Esses hormônios têm sido apontados como um dos principais fatores de risco para desenvolvimento de doenças crônicas na fase adulta, como diabetes, hipertensão arterial e distúrbios psiquiátricos (depressão e ansiedade). Eles são os hormônios:

A) testosterona.

B) tireoidianos.

C) glicocorticoides.

D) do crescimento.

E) estrógenos.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

108232)

Enunciado: Julgue o item que se segue, relativo as doenças infecciosas na infância e na adolescência. Considere o seguinte caso clínico. O exame de VDRL de uma parturiente no período pós-parto foi positivo. A paciente reportou que havia tido sífilis sete anos atrás, tendo feito tratamento conforme recomendação médica, informou, ainda, que, após doze meses, o resultado do VDRL tinha sido positivo 1/2 e que, na gestação atual, ela não havia feito testagem para sífilis. O teste treponêmico e o TPHA da parturiente feitos após o exame de VDRL pós-parto foram positivos. No recém-nascido, o teste treponêmico e o TPHA foram positivos, e o VDRL positivo 1/1. No caso clínico descrito, o médico deverá concluir que o recém-nascido está infectado, portanto, o profissional procederá à coleta de líquido cefalorraquidiano para exame, incluindo o VDRL, realizada radiografia de ossos longos, e inciará tratamento do bebê com penicilina cristalina na dose de 100.000 UI/kg/dia durante dez dias.

A) CERTO.

B) ERRADO.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

108209)

Enunciado: Um menino de cinco anos de idade, nascido vigoroso de parto vaginal, de termo, foi levado a uma consulta com oftalmologista devido a um desvio do olho esquerdo identificado por sua mãe havia dois meses. Na consulta, o médico constatou estrabismo com esotropia e leucocoria à esquerda. Com base no caso clínico acima apresentado, julgue o item abaixo: O diagnóstico mais provável para a criança em questão é retinopatia da prematuridade.

A) CERTO.

B) ERRADO.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

108229)

Enunciado: No item subsequente, é apresentado um caso clínico referente à resistência ao recém-nascido, seguindo de uma assertiva a ser julgada. Um médico foi chamado para assistir um recém- nascido na sala de parto. Ao consultar a história clínica da parturiente, o médico observou que ela apresentava fator Rh negativo e exame Coombs indireto positivo 1/16. Nesse caso, o médico deve clampear precocemente o cordão umbilical; coletar e solicitar a tipagem sanguínea, o fator Rh e o exame Coombs diretamente do sangue do cordão umbilical; acompanhar o recém-nascido no alojamento conjunto da mesma maternidade com uma visita médica após vinte e quatro horas de vida pós- natal.

A) CERTO.

B) ERRADO.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

108233)

Enunciado: No item subsequente, é apresentado um caso clínico referente à resistência ao recém-nascido, seguindo de uma assertiva a ser julgada. Um médico estava assistindo um recém-nascido de termo, que nasceu em apnei e envolto em líquifo amniótico claro. Inicialmente, ele posicionou o recém-nascido em decúbito dorsal, aspitou suas vias aéreas e lhe aplicou breves piparotes. Enquanto o recém-nascido não iniciou a respiração. Até essa etapa, já tinham se passado trinta segundos. O médico, então, solicitou que seu auxiliar monitorizasse a saturação de O2 em membro superior direito do recém-nascido, que estava em 81% e iniciou o procedimento de ventilação com pressão positiva por meio de um balão de ressuscitação manual. Nesse caso, de acordo com as normas de reanimação neonatal da Sociedade Brasileira de Pediatria, a ventilação com a pressão positiva deve ser administrada com uma mistura de ar que contenha uma fração de oxigênio de 80% a fim de se garantir um aumento da saturação de O2 até 90% no primeiro minuto.

A) CERTO.

B) ERRADO.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

79684)

Enunciado: São causas de desconforto respiratório neonatal, podendo persistir por mais de 48h de vida, exceto:

A) doença da membrana hialina.

B) pneumonia.

C) síndrome da aspiração de mecônio.

D) taquipneia transitória do RN.

E) pneumotórax espontâneo.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

79683)

Enunciado: Com relação à prevenção de transmissão vertical do HIV, assinale a alternativa incorreta.

A) Quando mãe com sorologia positiva, deve-se iniciar tratamento da gestante no pré-natal.

B) O parto deve ser vaginal.

C) Deve-se administrar AZT (azidotimidine) durante o parto.

D) No berçário, colher a sorologia do recém-nascido (RN) e iniciar AZT nas primeiras 8 a 12 horas.

E) O aleitamento materno é contraindicado em mães com sorologia positiva.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

82127)

Enunciado: Um recém-nascido a termo foi diagnosticado com artéria umbilical única. Com vinte e quatro horas de vida, não foi observado o reflexo vermelho dos seus olhos, mas foi constatada a saturação de oxigênio no membro superior direito de 85%. Com quarenta e oito horas de vida, o médico assistente observou icterícia até o nível dos joelhos e maculopápulas de limites imprecisos distribuídos de forma centrípeta. Ainda nesta fase, notou-se, que a criança não havia eliminado mecônio, nem apresentava vômitos. O médico reviu o exame físico, observando que o ânus era tópico e pérvio ao toque retal. Com base nesse caso clínico, julgue o item a seguir: A falta de reflexo vermelho nos olhos do recém-nascido é uma evidência de coriorretinite bilateral.

A) CERTO.

B) ERRADO.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

82123)

Enunciado: Um recém-nascido a termo foi diagnosticado com artéria umbilical única. Com vinte e quatro horas de vida, não foi observado o reflexo vermelho dos seus olhos, mas foi constatada a saturação de oxigênio no membro superior direito de 85%. Com quarenta e oito horas de vida, o médico assistente observou icterícia até o nível dos joelhos e maculopápulas de limites imprecisos distribuídos de forma centrípeta. Ainda nesta fase, notou-se, que a criança não havia eliminado mecônio, nem apresentava vômitos. O médico reviu o exame físico, observando que o ânus era tópico e pérvio ao toque retal. Com base nesse caso clínico, julgue o item a seguir. Se a tipagem sanguínea materna for A+ e a do recém-nascido for O+, a causa mais provável da icterícia do paciente é o retardo da eliminação do mecônio.

A) CERTO.

B) ERRADO.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

82100)

Enunciado: Um recém-nascido a termo foi diagnosticado com artéria umbilical única. Com vinte e quatro horas de vida, não foi observado o reflexo vermelho dos seus olhos, mas foi constatada a saturação de oxigênio no membro superior direito de 85%. Com quarenta e oito horas de vida, o médico assistente observou icterícia até o nível dos joelhos e maculopápulas de limites imprecisos distribuídos de forma centrípeta. Ainda nesta fase, notou-se que, a criança não havia eliminado mecônio, nem apresentava vômitos. O médico reviu o exame físico, observando que o ânus era tópico e pérvio ao toque retal. Com base nesse caso clínico, julgue o item a seguir. Essa criança deve ser investigada com enema opaco, pois o retardo na eliminação de mecônio associado à ausência de vômitos é indicativo de megacólon congênito.

A) Certo.

B) Errado.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

82040)

Enunciado: Um prematuro nasceu após trinta e duas semanas de gestação, de parto vaginal, com peso de 1.500 gramas. O parto teve causa ignorada e bolsa amniótica rota vinte e quatro horas antes do parto. O recém-nascido apresentou boletim de Apgar 7 e 7, no primeiro e quinto minutos de vida. Ainda na sala de parto, apresentou desconforto respiratório, com saturação de oxigênio de 70% no sexto minuto de vida. Com base nesse caso clínico, julgue o item subsequente. O recém-nascido deverá receber CPAP com máscara facial e oxigenoterapia conforme a saturação de oxigênio ainda na sala de parto, com a finalidade de manter pressão positiva nas vias aéreas terminais e manter os alvéolos distendidos.

A) Certo.

B) Errado.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

82044)

Enunciado: Um prematuro nasceu após trinta e duas semanas de gestação, de parto vaginal, com peso de 1.500 gramas. O parto teve causa ignorada e bolsa amniótica rota vinte e quatro horas antes do parto. O recém-nascido apresentou boletim de Apgar 7 e 7, no primeiro e quinto minutos de vida. Ainda na sala de parto, apresentou desconforto respiratório, com saturação de oxigênio de 70% no sexto minuto de vida. Com base nesse caso clínico, julgue o item subsequente. Os diagnósticos mais prováveis para o desconforto respiratório apresentado são: Síndrome do Desconforto Respiratório Idiopático (Doença da Membrana Hialina) e Pneumonia por estreptococo beta-hemolítico do grupo A.

A) CERTO.

B) ERRADO.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

82058)

Enunciado: Um prematuro nasceu após trinta e duas semanas de gestação, de parto vaginal, com peso de 1.500 gramas. O parto teve causa ignorada e bolsa amniótica rota vinte e quatro horas antes do parto. O recém-nascido apresentou boletim de Apgar 7 e 7, no primeiro e quinto minutos de vida. Ainda na sala de parto, apresentou desconforto respiratório, com saturação de oxigênio de 70% no sexto minuto de vida. Com base nesse caso clínico, julgue o item subsequente.

Alimentação por via enteral deverá ser iniciada após vinte e quatro horas de vida, por sonda orogástrica, em volumes de 10 a 20 ml/kg/dia, de preferência com colostro da própria mãe, desde que comprovada a estabilidade cardiovascular e respiratória do recém-nascido e a presença de ruídos hidroaéreos no trato digestório.

A) CERTO.

B) ERRADO.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

82087)

Enunciado: Um prematuro nasceu após trinta e duas semanas de gestação, de parto vaginal, com peso de 1.500 gramas. O parto teve uma causa ignorada e bolsa amniótica rota vinte e quatro horas antes do parto. O recém-nascido apresentou boletim de Apgar 7 e 7, no primeiro e quinto minutos de vida. Ainda na sala de parto, apresentou desconforto respiratório, com saturação de oxigênio de 70% no sexto minuto de vida. Com base nesse caso clínico, julgue o item subsequente. Caso os resultados de hemocultura, citobioquímica e cultura do liquor indiquem infecção, a administração de antibióticos, como ampicilina e aminoglicosídeo, é recomendada.

A) CERTO.

B) ERRADO.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

64322)

Enunciado: Uma mulher de vinte e seis anos de idade, primigesta, procura ambulatório para sua primeira consulta pré-natal com 14 semanas de idade gestacional, pela data da última menstruação. Seus antecedentes patológicos não apresentam nada digno de nota, exceto por ela ser alérgica a penicilina. A paciente refere antecedentes de múltiplos parceiros e está há seis meses em um relacionamento estável. Ao exame clínico, percebe-se na região vulvar lesão ulcerada única de bordos endurecidos, indolor e fundo limpo. Na região inguinal, foi constatada presença de linfadenopatia indolor à palpação. Com base no quadro clínico acima, faça o que se pede a seguir. Apresente duas complicações para o feto decorrentes da principal hipótese diagnóstica.

Resposta descritiva:

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

334885)

Enunciado: Os disrafismos espinhais ocultos são um grupo de afecções dorsais que existem abaixo de uma cobertura intacta de derme e epiderme. Como a pele e o tecido nervoso se originam do ectoderma, anomalias de ambos podem ocorrer simultaneamente. Em relação a esse tema, é correto afirmar que representa um estigma neurocutâneo

A) mancha mongólica.

B) sinus dérmicos.

C) nevo auricular.

D) pelos finos em região anal.

E) ânus imperfurado.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

334888)

Enunciado: Um recém-nascido (RN) a termo, adequado para a idade gestacional, apresenta quadro de icterícia, iniciada com 30 horas de vida. No quinto dia, teve um pico de hiperbilirrubinemia indireta de 15 mg/dL, com redução gradual. Está em aleitamento materno exclusivo, com bom ganho de peso, sem outras alterações ao exame físico. A respeito da icterícia do RN, assinale a alternativa correta.

A) Na icterícia do leite materno, pode ocorrer aumento da bilirrubina indireta, havendo indicação de suspender o leite materno exclusivo.

B) A terapêutica padrão-ouro da hiperbilirrubinemia indireta é a exsanguineotransfusão para qualquer valor sanguíneo.

C) Prematuros com IG < 35 semanas apresentam, comumente, hiperbilirrubinemia direta, em razão de defeito na conjugação da bilirrubina.

D) Deve-se solicitar o grupo sanguíneo da mãe e do RN, pois a incompatibilidade ABO leva á icterícia nas primeiras 24 a 36 horas de vida.

E) Segundo as zonas de Kramer, observa-se o nível mais alto de bilirrubina na zona 3, cabeça e pescoço.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

334889)

Enunciado: O Método Canguru é um modelo de atenção perinatal voltado para a atenção qualificada e humanizada, que reúne estratégias de intervenção biopsicossocial com uma ambiência que favoreça o cuidado ao recém-nascido (RN) e à sua família. O método promove a participação dos pais e da família nos cuidados neonatais. Faz parte do método o contato pele a pele, que começa de forma precoce e crescente desde o toque, evoluindo até a posição canguru. No que se refere a esse método, assinale a alternativa correta.

A) Deve ser aplicado ao RN recebendo nutrição parenteral.

B) Indicado para RN prematuro e (ou) de baixo peso.

C) Pode atrasar o desenvolvimento neuropsicomotor por causa da posição.

D) Impossibilita ao RN manter o seu controle térmico.

E) Deve ser aplicado quando o RN atingir 2.000 gramas.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

343411)

Enunciado: RN com catarata, cegueira, surdez neurossensorial, microcefalia e persistência do canal arterial, apresenta provável diagnóstico de:

A) Sífilis congênita.

B) Infecção congênita por citomegalovírus.

C) Rubéola congênita.

D) Infecção congênita por herpes-simples.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

334891)

Enunciado: Certo recém-nascido (RN) de 30 semanas, nascido de parto cesariana, com peso de nascimento = 1.000 gramas, foi internado em unidade de terapia intensiva neonatal. Com sete dias de vida, iniciou episódios de apneia, com bradicardia e cianose. No que tange à apneia do RN, assinale a alternativa correta.

A) A utilização de sulfato de magnésio na parturiente pode ser causa de apneia em RN prematuros.

B) Os eventos de apneia em RN pré-termo aumentam por volta do final do primeiro mês de vida.

C) As pausas respiratórias periódicas ocorrem com importante queda da saturação e duram maior tempo que a apneia.

D) A utilização do CPAP nasal não está indicada por não conseguir proporcionar adequadas pressões e (ou) volume residual pulmonar.

E) O tratamento medicamentoso de escolha da apneia primária da prematuridade é a teofilina, pois tem menos efeitos colaterais.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

343421)

Enunciado: RN de parto cesariana, idade gestacional de 40 semanas, peso de nascimento 2,800 kg, líquido amniótico claro e bolsa rota no ato. Iniciou com desconforto respiratório logo após o nascimento, necessitando oxigênio inalatório. Radiografia de tórax normal. No final de 72 horas de vida, estava eupneico e sem necessidade de oxigênio. O provável diagnóstico é:

A) Doença de Membrana Hialina.

B) Síndrome de Aspiração de Mecônio.

C) Pneumonia Congênita.

D) Taquipneia Transitória do RN (TTRN).

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

301284)

Enunciado: Considere um recém-nascido (RN) do sexo masculino, com peso = 2.220 g, 46 cm, perímetro cefálico = 31 cm Apgar 8/09 e exame físico normal. A mãe dele realizou pré-natal adequado. No teste de triagem materna, a sorologia mostrou-se negativa para toxoplasmose no primeiro trimestre de gestação. Com 23 semanas, a mãe apresentou quadro de adenomegalia, com IgG e IgM anti-Toxoplasma gondii positivas e avidez de IgG < 20%. Assim sendo, iniciou-se o tratamento com espiramicina e efetuou-se o exame PCR para toxoplasmose no líquido amniótico, cujo o resultado foi positivo. Teve início, então, o tratamento dela com sulfadiazina, pirimetamina e ácido folínico. A ultrassonografia obstétrica apresentou-se normal, o tratamento foi modificado para espiramicina com 37 semanas de gestação e fez-se parto cesariano com 39 semanas. Com base nesse caso clínico, julgue o item a seguir. A infecção aguda materna foi comprovada pela soroconversão associada a uma avidez baixa de IgG. Houve também clínica sugestiva na mãe, facilitando a determinação de que a infecção tenha acontecido no segundo trimestre, com risco de ocorrer transmissão congênita. A infecção fetal foi confirmada pela PCR positiva para toxoplasmose no líquido amniótico e iniciou-se tratamento materno para minimizar o risco de doença clinicamente aparente na criança.

A) CERTO

B) ERRADO

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

301285)

Enunciado: Considere um recém-nascido (RN) do sexo masculino, com peso = 2.220 g, 46 cm, perímetro cefálico = 31 cm Apgar 8/09 e exame físico normal. A mãe dele realizou pré-natal adequado. No teste de triagem materna, a sorologia mostrou-se negativa para toxoplasmose no primeiro trimestre de gestação. Com 23 semanas, a mãe apresentou quadro de adenomegalia, com IgG e IgM anti-Toxoplasma gondii positivas e avidez de IgG < 20%. Assim sendo, iniciou-se o tratamento com espiramicina e efetuou-se o exame PCR para toxoplasmose no líquido amniótico, cujo o resultado foi positivo. Teve início, então, o tratamento dela com sulfadiazina, pirimetamina e ácido folínico. A ultrassonografia obstétrica apresentou-se normal, o tratamento foi modificado para espiramicina com 37 semanas de gestação e fez-se parto cesariano com 39 semanas. Com base nesse caso clínico, julgue o item a seguir. Considera-se a infecção fetal comprovada quando há presença de DNA do Toxoplasma Gondii em líquido amniótico, sangue ou tecido fetal (PCR) e entende-se como feto não infectado quando a mãe é soronegativa, ou por IgM ou IgA positivas na mãe, sem aparecimento de IgG, ou mediante amostra materna positiva antes da concepção.

A) CERTO

B) ERRADO

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

301286)

Enunciado: Considere um recém-nascido (RN) do sexo masculino, com peso = 2.220 g, 46 cm, perímetro cefálico = 31 cm Apgar 8/09 e exame físico normal. A mãe dele realizou pré-natal adequado. No teste de triagem materna, a sorologia mostrou-se negativa para toxoplasmose no primeiro trimestre de gestação. Com 23 semanas, a mãe apresentou quadro de adenomegalia, com IgG e IgM anti-Toxoplasma gondii positivas e avidez de IgG < 20%. Assim sendo, iniciou-se o tratamento com espiramicina e efetuou-se o exame PCR para toxoplasmose no líquido amniótico, cujo o resultado foi positivo. Teve início, então, o tratamento dela com sulfadiazina, pirimetamina e ácido folínico. A ultrassonografia obstétrica apresentou-se normal, o tratamento foi modificado para espiramicina com 37 semanas de gestação e fez-se parto cesariano com 39 semanas. Com base nesse caso clínico, julgue o item a seguir. Infecção congênita é considerada comprovada se há aumento nos títulos de IgG durante os primeiros 12 meses de vida, com a presença de sinais clínicos clássicos de toxoplasmose (hidrocefalia, calcificações intracranianas, corriorretinite) ou persistência de positividade de IgG após os primeiros 12 meses de vida, com sinais clínicos clássicos de toxoplasmose ou IgM positiva nos primeiros seis meses de vida ou IgA positiva nos primeiros seis meses de vida.

A) CERTO

B) ERRADO

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

301287)

Enunciado: Considere um recém-nascido (RN) do sexo masculino, com peso = 2.220 g, 46 cm, perímetro cefálico = 31 cm Apgar 8/09 e exame físico normal. A mãe dele realizou pré-natal adequado. No teste de triagem materna, a sorologia mostrou-se negativa para toxoplasmose no primeiro trimestre de gestação. Com 23 semanas, a mãe apresentou quadro de adenomegalia, com IgG e IgM anti-Toxoplasma gondii positivas e avidez de IgG < 20%. Assim sendo, iniciou-se o tratamento com espiramicina e efetuou-se o exame PCR para toxoplasmose no líquido amniótico, cujo o resultado foi positivo. Teve início, então, o tratamento dela com sulfadiazina, pirimetamina e ácido folínico. A ultrassonografia obstétrica apresentou-se normal, o tratamento foi modificado para espiramicina com 37 semanas de gestação e fez-se parto cesariano com 39 semanas. Com base nesse caso clínico, julgue o item a seguir. Com relação à infecção congênita, a criança é considerada não infectada se há soronegativação durante os primeiros quatro meses de vida, sem ter ocorrido tratamento e confirmado soronegativação com duas sorologias consecutivas, colhidas com dois meses de intervalo, sendo que títulos baixos de IgG podem raramente persistir por mais alguns meses. Também se considera criança não infectada quando ela permanece soronegativa dois meses após o término do tratamento.

A) CERTO

B) ERRADO

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

301288)

Enunciado: Considere um recém-nascido (RN) do sexo masculino, com peso = 2.220 g, 46 cm, perímetro cefálico = 31 cm Apgar 8/09 e exame físico normal. A mãe dele realizou pré-natal adequado. No teste de triagem materna, a sorologia mostrou-se negativa para toxoplasmose no primeiro trimestre de gestação. Com 23 semanas, a mãe apresentou quadro de adenomegalia, com IgG e IgM anti-Toxoplasma gondii positivas e avidez de IgG < 20%. Assim sendo, iniciou-se o tratamento com espiramicina e efetuou-se o exame PCR para toxoplasmose no líquido amniótico, cujo o resultado foi positivo. Teve início, então, o tratamento dela com sulfadiazina, pirimetamina e ácido folínico. A ultrassonografia obstétrica apresentou-se normal, o tratamento foi modificado para espiramicina com 37 semanas de gestação e fez-se parto cesariano com 39 semanas. Com base nesse caso clínico, julgue o item a seguir. Na impossibilidade de se obter o resultado de um teste laboratorial para confirmação da etiologia diante da suspeita clínica de infecção congênita, as manifestações mais sugestivas de toxoplasmose congênita são coriorrenite, calcificações intracranianas e hidrocefalia.

A) CERTO

B) ERRADO

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

301289)

Enunciado: Considere um recém-nascido (RN) do sexo masculino, com peso = 2.220 g, 46 cm, perímetro cefálico = 31 cm Apgar 8/09 e exame físico normal. A mãe dele realizou pré-natal adequado. No teste de triagem materna, a sorologia mostrou-se negativa para toxoplasmose no primeiro trimestre de gestação. Com 23 semanas, a mãe apresentou quadro de adenomegalia, com IgG e IgM anti-Toxoplasma gondii positivas e avidez de IgG < 20%. Assim sendo, iniciou-se o tratamento com espiramicina e efetuou-se o exame PCR para toxoplasmose no líquido amniótico, cujo o resultado foi positivo. Teve início, então, o tratamento dela com sulfadiazina, pirimetamina e ácido folínico. A ultrassonografia obstétrica apresentou-se normal, o tratamento foi modificado para espiramicina com 37 semanas de gestação e fez-se parto cesariano com 39 semanas. Com base nesse caso clínico, julgue o item a seguir. No caso de crianças assintomáticas e com estado de infecção inconclusivo, a definição do diagnóstico representa uma dificuldade muito frequente na prática do acompanhamento de suspeita de toxoplasmose congênita. Assim sendo, o início, a manutenção e a suspensão do tratamento serão definidos caso a caso, de acordo com os resultados dos exames sorológicos e a evolução clínica. Inicia-se o tratamento com sulfadiazina + espiramicina nos RNs filhos de mães com toxoplasmose aguda comprovada durante a gestação.

A) CERTO

B) ERRADO

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

301290)

Enunciado: Um RN com 18 dias de vida foi levado à emergência pela mãe. Ela relata que seu filho, além de apresentar febre, tem mamado menos e está chorando mais que o habitual. Ao exame físico, afere-se temperatura de 38,5 ºC, frequência cardíaca está um pouco aumentada, porém o restante do exame físico encontra-se normal. Com base no caso clínico apresentado, julgue os itens de 47 a 51. Os exames que devem ser solicitados para esse RN são hemograma, hemocultura, análise de urina com cultura, punção lombar e raio X de tórax.

A) CERTO

B) ERRADO

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

301291)

Enunciado: Um RN com 18 dias de vida foi levado à emergência pela mãe. Ela relata que seu filho, além de apresentar febre, tem mamado menos e está chorando mais que o habitual. Ao exame físico, afere-se temperatura de 38,5 ºC, frequência cardíaca está um pouco aumentada, porém o restante do exame físico encontra-se normal. Com base no caso clínico apresentado, julgue os itens de 47 a 51. O RN deve ser hospitalizado e indica-se início de antibioticoterapia após os resultados dos exames e da cultura, sendo, nesse caso, recomendado o antibiótico com base na sensibilidade da cultura.

A) CERTO

B) ERRADO

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

273312)

Enunciado: Recém nascido de 37 semanas de idade gestacional, com 5 dias de vida, permaneceu no alojamento conjunto por dificuldade de amamentação. Pré natal feito de forma irregular, os exames de sorologias maternas são incompletos. No exame físico da criança chama atenção o perímetro cefálico de 30 cm, assim como presença de hepatomegalia e esplenomegalia discretas. Realizada ultrassonografia transfontanelar que evidenciou calcificações no parênquima cerebral, predominantemente periventriculares. Considerando os achados, o diagnóstico mais provável neste caso é:

A) Toxoplasmose congênita.

B) Sífilis congênita.

C) Citomegalovirose congênita.

D) Rubéola congênita.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

268902)

Enunciado: O pediatra de uma maternidade, quando chega ao plantão, é comunicado pelo obstetra que existe a probabilidade de ocorrerem dois partos na próxima hora, com idades gestacionais de 38 semanas e de 35 semanas. Tendo em vista o quadro clínico apresentado e os conhecimentos médicos relacionados a ele, assinale a alternativa correta.

A) Caso os recém-nascidos (RN), logo após a sua extração completa da cavidade uterina, estejam com respiração adequada e tônus muscular em flexão, indica-se o clampeamento tardio do cordão.

B) Em ambos os casos, na idade gestacional de 38 semanas e na de 35 semanas, o contato pele a pele com a mãe nunca deve ser indicado.

C) Quanto maior a oferta de oxigênio suplementar durante a reanimação de RN, maior será a chance de sucesso da reanimação.

D) O RN de 35 semanas somente é considerado prematuro, caso nasça com menos de 2.000 gramas de peso.

E) A normotermia do RN, temperatura corporal mantida entre 36,5ºC e 37,5ºC, tem como único objetivo o sucesso da amamentação

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

274614)

Enunciado: O planejamento e a efetivação das ações e da vigilância na atenção ao neonato são de extrema importância devido à vulnerabilidade da criança quando do nascimento. Considerando as fases do neonatal, classifica-se como período neonatal tardio o:

A) Intervalo de tempo que vai do 2o dia até o momento em que a criança atinge 27 dias, 23 horas e 59 minutos.

B) Intervalo de tempo que vai do 7o dia até o momento em que a criança atinge 27 dias, 23 horas e 59 minutos.

C) Intervalo de tempo que vai do 7o dia até o momento em que a criança atinge 2 anos.

D) Intervalo de tempo do nascimento até o 7o dia de vida da criança.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

274619)

Enunciado: Sépsis é a resposta sistêmica do organismo a um determinado evento. Quanto à sépsis neonatal:

A) É a infecção bacteriana sistêmica que ocorre nos primeiros 28 dias de vida.

B) É a infecção bacteriana sistêmica que ocorre nos primeiros 38 dias de vida.

C) É a infecção fúngica sistêmica que ocorre nos primeiros 23 dias de vida.

D) É a infecção fúngica sistêmica que ocorre nos primeiros minutos até as 42 horas de vida.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

266449)

Enunciado: Com relação aos achados de exames de imagem em paciente pediátrico, julgue o item a seguir. Em se tratando de recém-nascido, a identificação, na tomografia computadorizada do crânio sem contraste, de calcificações periventriculares é mais compatível com o diagnóstico de toxoplasmose congênita do que com o de citomegalovirose congênita.

A) CERTO

B) ERRADO

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

266450)

Enunciado: Com relação aos achados de exames de imagem em paciente pediátrico, julgue o item a seguir. Na radiografia simples do tórax ao final da primeira hora de vida de um recém-nascido prematuro de 28 semanas gestacionais que apresente desconforto respiratório imediatamente após o parto, o achado de infiltrado reticulogranular difuso e broncograma aéreo até a periferia pulmonar bem como o borramento da silhueta cardíaca indicam o diagnóstico de doença da membrana hialina de grau III.

A) CERTO

B) ERRADO

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

266452)

Enunciado: Com relação aos achados de exames de imagem em paciente pediátrico, julgue o item a seguir. Osteocondrite metaepifisária e periostite proximal em radiografia simples do úmero são patognomônicas de sífilis congênita.

A) CERTO

B) ERRADO

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

291516)

Enunciado: Um médico de maternidade pública é chamado para realizar a sala de parto de gestante de 35 semanas com pré-eclâmpsia. Um recém-nascido pesando 2,3 kg apresenta-se banhado em líquido amniótico meconial, hipotônico e respirando de forma irregular. O médico assistente decide levá-lo à mesa de reanimação para realizar aspiração de vias aéreas superiores sob calor. Além disso, posiciona o pescoço em leve extensão, aspira a boca e narinas e seca o paciente. Após 30 segundos, o recém-nascido mostra respiração irregular e frequência cardíaca = 80 bpm. Considerando a situação acima descrita, assinale a alternativa que apresenta a próxima conduta que deve ser tomada pelo médico assistente.

A) Realizar ventilação com pressão positiva com máscara facial.

B) Realizar massagem cardíaca externa.

C) Realizar intubação orotraqueal.

D) Realizar aspiração traqueal sob visualização direta.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

263397)

Enunciado: Um recém-nascido a termo de parto cesáreo, que foi indicado por sofrimento fetal, encontra-se, logo após o nascimento, hipotônico e cianótico, banhado em líquido meconial viscoso. Não houve retardo de crescimento intrauterino e a mãe não apresentou intercorrências durante a gestação. Na mesa de reanimação, foram realizadas as manobras iniciais de secagem, oferta de calor e aspiração de boca e narinas com sonda. Decorridos 15 segundos, o recém-nascido encontra-se hipotônico, com respiração irregular e frequência cardíaca de 75 bpm. A conduta que deve ser realizada até completar o primeiro minuto da reanimação é:

A) Aspirar traqueia sob visualização direta para remover o mecônio.

B) Intubar por via endotraqueal e ventilar com pressão positiva.

C) Intubar por via endotraqueal e aspirar vias aéreas inferiores.

D) Ventilar com pressão positiva através de máscara facial.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

291526)

Enunciado: Um recém-nascido de 15 dias é levado à primeira consulta de puericultura. A gestação correu sem intercorrências. Mãe relata ser asmática e fez uso de prednisona oral durante toda a gestação. Parto vaginal a termo. Peso de nascimento = 3 500 g. Apgar 9/9. Alta com 2 dias. Colheu teste do pezinho no 4.º dia de vida. Ao exame, o recém nascido mostra-se em ótimo estado geral, corado e hidratado. O exame cardiovascular e respiratório sem anormalidades, assim como o exame do abdome. Considerando a história acima, assinale a alternativa que apresenta a doença cujo resultado no teste de triagem neonatal pode ter seu resultado modificado pela condição clínica materna descrita.

A) Deficiência de biotinidase.

B) Anemia falciforme.

C) Hiperplasia adrenal congênita.

D) Fibrose cística.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

263424)

Enunciado: Um recém-nascido a termo, com 24 horas de vida e peso de nascimento de 3.200 g, realiza o teste de triagem neonatal para cardiopatia congênita crítica (teste do coraçãozinho) com os seguintes resultados. Saturação de O? em membro superior direito (MSD) de 97% e em membro inferior direito (MID) de 93%. A conclusão do resultado do teste e a conduta médica indicada em relação ao caso são, respectivamente:

A) Teste normal e a criança deve permanecer por mais 24 horas no alojamento conjunto para observação e, então, poderá ser liberada para casa.

B) Teste limítrofe e deve ser repetido após 12 horas de intervalo e, se persistir com saturação de MID < 95%, deve ser solicitada ecocardiografia.

C) Teste alterado e deve ser solicitado exame radiológico de tórax e avaliação cardiológica com ecocardiografia para esclarecimento.

D) Teste alterado e deve ser repetido após 1 hora de intervalo e, se persistir com alteração, deverá ser solicitada ecocardiografia.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

230564)

Enunciado: Assinale a alternativa INCORRETA sobre as características clínicas habitualmente identificadas nos pacientes com síndrome congênita do Zika Vírus:

A) Manchas maculares pigmentares focais e cicatrizes retinianas.

B) Contraturas congênitas.

C) Hipertonia precoce marcante e sintomas extrapiramidais.

D) Cardiopatias congênitas.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

244484)

Enunciado: Considere um recém-nascido que acaba de nascer por parto cesárea por desproporção cefalopélvica, a termo, idade gestacional de 39 semanas 3/7. Apresenta Apgar 9/10, peso ao nascimento = 4.215 kg, comprimento = 51 cm e perímetro cefálico = 35 cm. A mãe dele, primigesta, teve ganho de peso de 32 kg na gestação e, ao 3º trimestre, foi diagnosticada com diabetes gestacional. Não manifestou outras intercorrências no pré-natal. Considerando essas informações, além do estímulo ao aleitamento materno exclusivo a ser iniciado na sala de parto deve-se estar atento e monitorizar o bebê em razão do risco aumentado de

A) hiperglicemia.

B) hipoglicemia.

C) hipoxemia.

D) hipocalemia.

E) hipercalcemia tardia.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

230574)

Enunciado: Dentre as situações a seguir, qual esta associada à baixa idade gestacional?

A) Encefalopatia hipóxico isquêmica.

B) Infarto cerebral.

C) Hemorragia subaracnóidea.

D) Hemorragia intra-periventricular.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

227415)

Enunciado: Um recém-nascido prematuro tardio com 48 horas de vida encontra-se no alojamento conjunto de uma maternidade, aguardando o momento da alta. O médico assistente realizou os testes de triagem obrigatórios e encontrou os seguintes resultados: TSH = 20 mUI/mL (VR < 10 mUI/mL); saturação de O? pré-ductal e pós-ductal em primeira medida = 95% e 91%, respectivamente; teste do reflexo vermelho do olho = presente bilateralmente; emissões otoacústicas = não passou em um dos ouvidos. A respeito do caso clínico precedente, julgue o item subsecutivo. O chamado teste do coração indicou cardiopatia complexa no recém-nascido, por isso está indicada a realização de ecocardiograma com doppler.

A) CERTO

B) ERRADO

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

227416)

Enunciado: Um recém-nascido prematuro tardio com 48 horas de vida encontra-se no alojamento conjunto de uma maternidade, aguardando o momento da alta. O médico assistente realizou os testes de triagem obrigatórios e encontrou os seguintes resultados: TSH = 20 mUI/mL (VR < 10 mUI/mL); saturação de O? pré-ductal e pós-ductal em primeira medida = 95% e 91%, respectivamente; teste do reflexo vermelho do olho = presente bilateralmente; emissões otoacústicas = não passou em um dos ouvidos. A respeito do caso clínico precedente, julgue o item subsecutivo. Haja vista o resultado do chamado teste do olhinho, é correto afirmar que esse recém-nascido não apresenta opacidade da córnea, catarata congênita, hemorragia vítrea nem tumores da retina (retinoblastoma).

A) CERTO

B) ERRADO

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

227417)

Enunciado: Um recém-nascido prematuro tardio com 48 horas de vida encontra-se no alojamento conjunto de uma maternidade, aguardando o momento da alta. O médico assistente realizou os testes de triagem obrigatórios e encontrou os seguintes resultados: TSH = 20 mUI/mL (VR < 10 mUI/mL); saturação de O? pré-ductal e pós-ductal em primeira medida = 95% e 91%, respectivamente; teste do reflexo vermelho do olho = presente bilateralmente; emissões otoacústicas = não passou em um dos ouvidos. A respeito do caso clínico precedente, julgue o item subsecutivo. Indica-se a realização do teste de potencial evocado auditivo do tronco encefálico (PEATE).

A) CERTO

B) ERRADO

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

206175)

Enunciado: Em relação às vantagens do alojamento conjunto, assinale a alternativa INCORRETA:

A) Melhora o vínculo da mãe com o recém-nascido.

B) Diminui os gastos do hospital com material.

C) Diminui o risco de infecção hospitalar.

D) Melhora o atendimento dos recém-nascidos que realmente precisam do berçário.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

206159)

Enunciado: Recém-nascido pré termo, 28 semanas, masculino, nascido de parto normal, Apgar 3 e 8; presença de fisiometria, intubado em sala de parto, foi encaminhado à UTI Neonatal. Mãe secundigesta, fez pré-natal até 12 semanas, sorologias negativas, urocultura positiva para Streptococcus agalactiae tratada com antibioticoterapia. Refere ter iniciado perda de líquidos há 22 horas. São fatores de risco para sepse neonatal precoce identificados nesse caso, EXCETO:

A) Mãe secundigesta.

B) Trabalho de parto prematuro.

C) Mãe colonizada por Strepto.

D) Bolsa rota > 18 horas.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

206088)

Enunciado: Em relação aos distúrbios da glicemia do recém-nascido assinale a alternativa CORRETA:

A) Hipoglicemia é definida como glicemia plasmática < 40mg/dl e hiperglicemia como glicemia plasmática > 120mg/dl.

B) Tanto a hipoglicemia como a hiperglicemia podem causar repercussões no SNC.

C) O tratamento da hipoglicemia é feito sempre com push de glicose com soro glicosado a 10%.

D) No tratamento da hiperglicemia é importante o tratamento da causa, além do uso de insulina subcutânea.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

206126)

Enunciado: Em áreas endêmicas, casais que desejam a concepção devem ser orientados quanto aos riscos da infecção pelo vírus Zika e a possibilidade de malformações fetais. Sendo INCORRETO que:

A) A transmissão sexual do vírus Zika foi comprovada por inúmeros relatos de casos, sendo a Zika considerada uma IST, cuja transmissão sexual pode ser evitada por meio do uso de preservativo.

B) Para casais que desejam a concepção, recomenda-se aguardar até 2 meses após sinais/sintomas relacionados à infecção pelo vírus Zika quando o homem foi infectado.

C) Deve ser reforçada a importância do uso do preservativo, especialmente após viagens a áreas endêmicas ou suspeita e/ou confirmação do diagnóstico da infecção pela parceria sexual.

D) Isso porque a persistência das partículas virais foi observada em fluidos corporais, como sêmen.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

177244)

Enunciado: Um paciente, recém-nascido a termo, com 48 horas de vida, apresenta opacificação da pupila esquerda no teste do olhinho, realizado na maternidade. Considerando-se o referido caso clínico e os conhecimentos médicos relativos a ele, é correto afirmar que a melhor conduta a ser tomada em relação ao recém-nascido é

A) acompanhar o paciente em ambulatório de puericultura, com avaliações semestrais do oftalmologista, em razão do risco de coriorretinite.

B) encaminhá-lo o mais breve possível para avaliação oftalmológica, com o intuito de investigar retinoblastoma, catarata congênita ou glaucoma congênito.

C) acompanhar o paciente em ambulatório de puericultura, sem que haja necessidade de avaliação por especialista.

D) encaminhar o paciente para seguimento de rotina com solicitações de sorologias para citomegalovírus e toxoplasmose.

E) encaminhar o paciente para puericultura, para confirmação do teste com 6 meses de idade.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

177253)

Enunciado: Neonato com idade gestacional de 35 semanas + 5 dias apresenta, ao exame físico, perímetro cefálico, peso e comprimento abaixo do percentil 10 da curva de crescimento intrauterino de referência. Considerando-se o referido quadro clínico e os conhecimentos médicos relacionados a ele, é correto afirmar que o neonato deve ser classificado como

A) pré-termo tardio, pequeno para a idade gestacional, simétrico.

B) pré-termo moderado, adequado para a idade gestacional,

C) pré-termo tardio, adequado para a idade gestacional.

D) a termo, pequeno para a idade gestacional, simétrico.

E) pré-termo moderado, pequeno para a idade gestacional, assimétrico.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

177263)

Enunciado: Uma paciente recém-nascida, com 39 semanas de idade gestacional e Apgar 8 e 9, peso ao nascer de 3.100 g, com apenas 2 horas de vida, apresenta dificuldade respiratória. No exame físico, ela apresenta FR = 78 irpm, FC = 144 bpm, Tax = 38,2 °C. Além disso, apresenta-se bem corada, hidratada, anictérica e acianótica, com fontanelas normotensas e auscultas cardíaca e respiratória sem alterações, com abdome sem achados patológicos. A mãe apresentou-se com infecção urinária vigente e sem tratamento no momento do parto. Considerando-se o mencionado quadro clínico e os conhecimentos médicos relacionados a ele, é correto afirmar que a conduta mais adequada ao citado caso é

A) verificar a saturação de oxigênio, retirar as roupas da paciente para melhorar a hipertermia e manter rigorosa observação dos sinais vitais da criança.

B) retirar as roupas da paciente para o recuo da temperatura, verificar a saturaçao de oxigênio e solicitar hemograma completo da criança com 24 horas de vida.

C) realizar a intubação orotraqueal para a melhoria do padrão respiratório e, em seguida, realizar a coleta dos exames laboratoriais.

D) iniciar empiricamente a administração de ampicilina e gentamicina e, após 24 horas, coletar exames de controle para sepse.

E) solicitar rastreio para sepse (incluindo punção lombar) e verificar a glicemia capilar e a saturação de oxigênio.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

183870)

Enunciado: O acompanhamento do crescimento e do desenvolvimento da criança é fundamental como medida de medicina preventiva. Considerando esse assunto e os múltiplos aspectos a ele relacionados, julgue o item que se segue. No critério da tabela da OMS, apresenta microcefalia recém-nascido a termo com perímetro cefálico menor ou igual a 31,5 cm, para meninas, e 31,9 cm, para meninos, e equivalente a menor que -2 desvios-padrão para a idade, idade gestacional e sexo.

A) CERTO

B) ERRADO

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

158009)

Enunciado: Recém-nascido de 20 dias de vida apresenta convulsões de difícil controle e microcefalia ao nascimento. A gestação ocorreu sem acompanhamento regular. Foi realizada uma tomografia de crânio, que evidenciou presença de calcificações periventriculares e confirmou microcefalia. No que se refere a esse caso clínico, quanto à infecção congênita mais compatível com o quadro descrito, assinale a alternativa CORRETA:

A) Toxoplasma gondii.

B) Varicela zóster.

C) Herpes-vírus.

D) HIV.

E) Citomegalovirus.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

158022)

Enunciado: Neonato de 18 dias de vida apresenta quadro exantemático, desde a primeira semana de vida, caracterizado por máculas e pápulas que evoluiram para pústulas estéreis sobre uma base eritematosa. Algumas têm resolução espontânea. Nesse caso clínico, o diagnóstico mais provável é:

A) Melanose pustulosa neonatal.

B) Miliária.

C) Pérolas de Epstein.

D) Eritema tôxico neonatal.

E) Crosta láctea.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

158035)

Enunciado: Considere hipoteticamente um lactente em tratamento para toxoplasmose congênita com coriorretinite, em uso de pirimetamina e sulfadiazina. No terceiro mês de tratamento, ao exame de laboratório, apresenta palidez generalizada com pancitopenia. A respeito desse caso clínico, quanto à terapêutica mais apropriada ao quadro, assinale a alternativa CORRETA:

A) Suspender pirimetamina.

B) Aumentar doses de sulfadiazina.

C) Acrescentar ácido folínico ao tratamento.

D) Administrar aciclovir.

E) Prescrever espiramacina.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

154467)

Enunciado: Uma mulher de 32 anos, primigesta, dá a luz por parto normal a um RN com IG de 42 semanas e 2 dias, com peso de nascimento de 3870 g e comprimento de 52 cm. Logo após o nascimento a criança apresenta respiração regular, tônus muscular em flexão cianose central e FC de 118. De acordo com as novas diretrizes do Programa de Reanimação Neonatal da Sociedade Brasileira de Pediatria de 2016 está CORRETO nesse caso:

A) Colocar a criança em contato pele a pele com a mãe e estimular a amamentação na primeira hora.

B) Conduzir o RN a mesa de ressuscitação e após as manobras iniciais ofertar oxigênio com FiO2 de 40% até a melhora da cianose.

C) Proporcionar calor em berço aquecido, posicionar o polo cefálico, com coxim se necessário, aspirar vias aéreas superiores, secar e desprezar campos úmidos.

D) Conduzir RN à mesa de ressuscitação e em caso de excesso de secreção com obstrução de via aérea superior garantir a aspiração de boca, narinas e faringe posterior.

E) Em caso de líquido amniótico meconial e na presença de profissional capacitado, proceder intubação e aspiração traqueal sob visualização direta.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

168529)

Enunciado: Um lactente com 3 meses de vida é atendido em sua terceira consulta em Unidade Básica de Saúde. Segundo o prontuário do paciente, ele nasceu a termo por meio de parto normal, pesando 2.950 g e medindo 49 cm, sem intercorrências, e tendo alta após 24 horas do nascimento. Pré-natal sem alterações. As emissões otoacústicas evocadas, realizadas duas vezes, e o potencial evocado do tronco encefálico, mostram-se alterados (respostas não satisfatórias). Foi realizado um novo potencial evocado do tronco encefálico e o resultado mostra-se normal. O exame físico atual não apresenta alterações, assim como o crescimento e o desenvolvimento da criança. Na situação descrita, a conduta adequada é o acompanhamento audiológico do paciente na unidade

A) básica, em conjunto com a especializada.

B) especializada, com realização de audiometria.

C) básica, com observação do seu desenvolvimento.

D) especializada, para tratamento específico de otite crônica.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

129001)

Enunciado: O mecanismo de ação da fototerapia é a transformação da bilirrubina nas áreas expostas à luz, que modificam sua estrutura molecular. A respeito dessa importante terapêutica no período neonatal, assinale a alternativa CORRETA:

A) A molécula de bilirrubina torna-se menos hidrossolúvel, permitindo que ela seja eliminada pelos rins e pelo fígado.

B) Recém-nascidos afrodescendentes respondem menos ao tratamento, pois a pigmentação da pele limita a penetração da luz na epiderme.

C) Uma das principais complicações da fototerapia é a hipertermia.

D) Nas icterícias associadas ao aleitamento materno, deve-se suspender temporariamente a amamentação para evitar a fototerapia e suas complicações.

E) A fototerapia só tem eficácia quando se utiliza acima de 15 mg% de bilirrubina indireta no soro, o que contraindica seu uso nas icterícias fisiológicas.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

129007)

Enunciado: A sepse neonatal precoce geralmente é causada por germes do trato geniturinário materno. Desse modo, o agente mais comum e o esquema de antibiótico a ser usado são respectivamente

A) Escherichia coli e antibiótico de amplo espectro para gram-negativo.

B) Enterobacter e antibióticos de amplo espectro para gram-positivo.

C) Clamídia e antifúngico.

D) Gonococo e antibióticos de amplo espectro para gram-negativo.

E) Streptococcus do grupo A e antibióticos de amplo espectro para gram-positivo.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

104780)

Enunciado: Assinale a alternativa que apresenta importante exame laboratorial que caracteriza diagnóstico de infecção bacteriana no período neonatal.

A) Níveis elevados de proteína C-reativa.

B) Níveis baixos de relação entre neutrófilos imaturos e o total de neutrófilos.

C) Creatinina elevada.

D) Níveis elevados de antiestreptolisina O.

E) Níveis elevados de mucoproteína.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

104772)

Enunciado: Assinale a alternativa que apresenta a conduta correta em caso de RN manifestar conjuntivite gonocócica.

A) Tratar o RN com antibiótico sistêmico e os pais com colírio de antibiótico.

B) Tratar apenas o RN com colírio de antibiótico.

C) Tratar o RN com colírio de antibiótico e os pais com antibiótico sistêmico.

D) Tratar tanto o RN quanto os pais com colírio de antibiótico e com antibiótico sistêmico.

E) Tratar o RN apenas com antibiótico sistêmico, não necessitando tratar os pais.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

111280)

Enunciado: Durante exame físico de um recém-nascido eutrófico você observa pequenas vesículas císticas esbranquiçadas na rafe mediana do palato medindo cerca de dois mm e restante da mucosa oral sem alterações. A conduta correta neste caso é:

A) Iniciar tratamento tópico com nistatina para evitar progressão da doença.

B) Iniciar tratamento com antibiótico oral devido a faixa etária.

C) Encaminhar o recém-nascidoa um odontopediatra para possível intervenção.

D) Solicitar perfil lipídico, pois tais vesículas apresentam conteúdo rico em gordura.

E) Não é necessária nenhuma conduta, pois se trata de pérolas de Epstein.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

97845)

Enunciado: Em uma maternidade de referência, o médico é chamado ao Centro Obstétrico para recepcionar um recém-nascido prematuro. A mãe é uma primigesta de 26 anos de idade, com 28 semanas de idade gestacional pela data da última menstruação confirmada pela ultrassonografia. Ela não realizou pré-natal, só procurando o Serviço de Emergência em estado febril e em início de trabalho de parto. Referia ainda perda de líquido vaginal há dois dias. Foi indicada cesariana, com o nascimento de um recém-nascido pesando 950 gramas e em apneia. Imediatamente após o nascimento, iniciou-se ventilação com pressão positiva e oxigênio a 100%, com boa resposta nos primeiros 30 segundos de ventilação. Em seguida, o recém-nascido evoluiu com quadro de gemência acompanhado de retrações subcostais e intercostais moderadas. Para o quadro clínico apresentado pelo recém-nascido, indique: duas hipóteses diagnósticas.

A) Resposta:

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

97846)

Enunciado: Em uma maternidade de referência, o médico é chamado ao Centro Obstétrico para recepcionar um recém-nascido prematuro. A mãe é uma primigesta de 26 anos de idade, com 28 semanas de idade gestacional pela data da última menstruação confirmada pela ultrassonografia. Ela não realizou pré-natal, só procurando o Serviço de Emergência em estado febril e em início de trabalho de parto. Referia ainda perda de líquido vaginal há dois dias. Foi indicada cesariana, com o nascimento de um recém-nascido pesando 950 gramas e em apneia. Imediatamente após o nascimento, iniciou-se ventilação com pressão positiva e oxigênio a 100%, com boa resposta nos primeiros 30 segundos de ventilação. Em seguida, o recém-nascido evoluiu com quadro de gemência acompanhado de retrações subcostais e intercostais moderadas. Para o quadro clínico apresentado pelo recém-nascido, indique: três fatores que predispõem o recém-nascido a desenvolver o quadro respiratório descrito.

A) Resposta:

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

97847)

Enunciado: Em uma maternidade de referência, o médico é chamado ao Centro Obstétrico para recepcionar um recém-nascido prematuro. A mãe é uma primigesta de 26 anos de idade, com 28 semanas de idade gestacional pela data da última menstruação confirmada pela ultrassonografia. Ela não realizou pré-natal, só procurando o Serviço de Emergência em estado febril e em início de trabalho de parto. Referia ainda perda de líquido vaginal há dois dias. Foi indicada cesariana, com o nascimento de um recém-nascido pesando 950 gramas e em apneia. Imediatamente após o nascimento, iniciou-se ventilação com pressão positiva e oxigênio a 100%, com boa resposta nos primeiros 30 segundos de ventilação. Em seguida, o recém-nascido evoluiu com quadro de gemência acompanhado de retrações subcostais e intercostais moderadas. Para o quadro clínico apresentado pelo recém-nascido, indique: quatro medidas recomendadas para a estabilização desse recém-nascido na primeira hora de vida.

A) Resposta:

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

97848)

Enunciado: Em uma maternidade de referência, o médico é chamado ao Centro Obstétrico para recepcionar um recém-nascido prematuro. A mãe é uma primigesta de 26 anos de idade, com 28 semanas de idade gestacional pela data da última menstruação confirmada pela ultrassonografia. Ela não realizou pré-natal, só procurando o Serviço de Emergência em estado febril e em início de trabalho de parto. Referia ainda perda de líquido vaginal há dois dias. Foi indicada cesariana, com o nascimento de um recém-nascido pesando 950 gramas e em apneia. Imediatamente após o nascimento, iniciou-se ventilação com pressão positiva e oxigênio a 100%, com boa resposta nos primeiros 30 segundos de ventilação. Em seguida, o recém-nascido evoluiu com quadro de gemência acompanhado de retrações subcostais e intercostais moderadas. Para o quadro clínico apresentado pelo recém-nascido, indique: quatro exames complementares que devem ser solicitados dentro das primeiras 24 horas de vida.

A) Resposta:

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

97753)

Enunciado: Um paciente com dois meses de idade foi atendido no Hospital apresentando há um mês coriza mucossanguinolenta e choro à mobilização do braço esquerdo. Nasceu a termo, com peso de 2 kg, comprimento de 47 cm e perímetro cefálico de 34 cm. Ao exame físico, a criança mostrava-se ativa e hidratada, chorava à manipulação do braço esquerdo e apresentava edema em porção proximal de úmero. Na ausculta cardiopulmonar, o murmúrio vesicular estava bem distribuído e as bulhas cardíacas eram rítmicas. No abdome palpava-se o fígado a 4 cm do rebordo costal direito e 4 cm do apêndice xifoide e o baço a 4 cm do rebordo costal esquerdo. Resultados de exames: Hemoglobina = 9.5 g/dl (Valor de referência: 11,5 - 13,5 g/dl); Hematócrito = 28% (Valor de referência: 34% - 40%); Leucócitos = 8.000/ mm^3 (Valor de referência. 5.500 - 14.500/mm^3); Segmentados = 43 %; Linfócitos = 55%; Monócitos = 2%; Plaquetas = 155.000/mm^3 (Valor de referência: 150.000 - 350.000/mm^3); Bilirrubina total = 1.5 mg/dl (Valor de referência. 0,3-1.2 mg/dl); AST (TGO) = 11 U/L (Valor de referência: < 35 U/L) e ALT (TGP) = 58 U/L (Valor de referência: < 31 U/L). É solicitado internamento para investigação. A conduta adequada após a admissão é:

A) pesquisa de treponemas no sangue, estudo do liquor, radiografia de ossos longos; iniciar penicilina cristalina endovenosa.

B) ultrassonografia de abdome total, radiografia de úmero, fundoscopia; iniciar ganciclovir endovenoso.

C) radiografia de crânio e úmero; iniciar sulfadiazina e pirimetamina por via oral.

D) avaliação de função hepática e radiografia de ossos longos; iniciar aciclovir endovenoso.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

80739)

Enunciado: A Caderneta de Saúde da Criança traz importantes informações, com dados desde o pré-natal. Em relação às sorologias maternas que estão consignadas na caderneta sob a forma de Código Internacional de Doenças, aquelas de grande relevância e que, de algum modo, podem ser prevenidas ou tratadas no período neonatal são:

A) HIV, sífilis, toxoplasmose e rubéola.

B) HIV, hepatite C, sífilis e toxoplasmose.

C) HIV, sífilis, toxoplasmose e hepatite B.

D) Doença de Chagas, toxoplasmose, sífilis e hepatite C.

E) Rubéola, sífilis, hepatite B e HTLV.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

97742)

Enunciado: Um lactente com seis meses de idade é trazido a consulta médica em Unidade Básica de Saúde para avaliação de atraso do desenvolvimento. A mãe relata que compareceu a somente duas consultas de pré-natal e que a criança nasceu de parto vaginal e a termo, pesando 3.240 g, com Apgar 9/10. A alta se deu em dois dias. O sorriso social surgiu com um mês e sustentou o pescoço com dois meses. Entretanto, hoje não segura objetos, nem rola. Não consegue sentar com apoio. História familiar não revela casos semelhantes. Ao exame o lactente mostra-se em regular estado geral, interagindo pouco com o observador; corado, hidratado, anictérico e acianótico; ausência de estigmas cutâneos. Auscultas cardíaca e respiratória sem anormalidades. Exame neurológico evidencia perímetro cefálico acima do percentil 90 para a idade, aumento de tônus e de reflexos profundos nos quatro membros, associado com redução da força proximal. Coordenação preservada. Exame dos pares cranianos demonstra dificuldade em acompanhar os objetos apresentados. Fundo de olho evidencia cicatriz de coriorretinite bilateralmente. Tomografia computadorizada do crânio evidencia múltiplas calcificações difusamente distribuídas no parênquima, associadas a aumento do volume dos ventrículos laterais, terceiro e quarto ventrículos. O agente etiológico mais provável para o quadro clínico descrito é:

A) vírus da rubéola.

B) Toxoplasma gondii.

C) Treponema pallidum.

D) vírus do herpes simples.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

138704)

Enunciado: Primigesta com 27 anos de idade, teve parto vaginal, a termo, com recém-nascido de peso adequado para a idade gestacional, sem intercorrências. Está com o filho em alojamento conjunto. Vinte horas após o parto, ao examinar o recém-nascido (RN), o médico observou que ele está sugando bem, já eliminou mecônio e está apresentando icterícia até a cicatriz umbilical. Exames realizados indicam tipagem sanguínea da mãe (O positivo) e RN (A positivo), bilirrubinas total e frações para o RN: bilirrubina total = 12,4 mg/dL (valores de referência para RN com menos de 24 horas: até 6,0 mg/dL); bilirrubina indireta = 11,4mg/dL e bilirrubina direta = 1,0 mg/dL. Com base no relato acima, responda: Qual a conduta inicial para o recém-nascido?

Resposta descritiva:

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

75465)

Enunciado: Recém-nascido com 36 semanas de idade gestacional, parto cesariano, Apgar 6 e 8, peso de nascimento = 2.100 g, evoluiu com sintomas precoces e graves nas primeiras 24 horas de vida (icterícia, hepatoesplenomegalia, elevação das enzimas hepáticas, anemia, trombocitopenia e hemorragia), associados ao quadro de microcefalia com calcificações cerebrais periventriculares, microftalmia, coriorretinite e surdez. A principal hipótese diagnóstica para esta infecção congênita e o tratamento de escolha são, respectivamente:

A) herpes simples e aciclovir.

B) citomegalovírus e ganciclovir.

C) rubéola e tratamento de suporte.

D) sífilis congênita e penicilina cristalina.

E) toxoplasmose e piremetamina/sulfadiazina.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

304871)

Enunciado: Neonato, sexo feminino, de 10 dias de vida, comparece à primeira consulta de puericultura em aleitamento materno exclusivo. Mãe refere como queixa que as fezes são "quase brancas". História gestacional sem alterações. Nascimento sem intercorrências, 39 semanas, antropometria normal para a idade gestacional. Mãe A+, filho A+. Ao exame clínico, apresenta excelente estado geral, ganho de peso satisfatório, icterícia leve em pele e mucosas, abdome globoso, com fígado a 3 cm do rebordo costal direito, liso, borda fina. Durante a palpação abdominal, a neonata evacuou e ficou confirmado que as fezes são hipocólicas. Com base nestas informações, marque a alternativa CORRETA:

A) Importante fazer o teste de retirada do leite materno por 72h para exclusão da icterícia do leite materno e retorno à pigmentação das fezes.

B) Retirar o leite de vaca da mãe, pois pode ser uma das raras manifestações de alergia alimentar à proteína do leite de vaca com repercussão hepática e intestinal.

C) Avaliar a possibilidade de doença hepática obstrutiva tais como Atresia de Vias Biliares Extra-Hepáticas (AVBEH) ou cisto de colédoco, já que a correção cirúrgica imediata é imprescindível.

D) Avaliar o diagnóstico precoce de hepatite neonatal idiopática que cursa com hiperbilirrubinemia intensa, com aumento importante da bilirrubina indireta.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

351627)

Enunciado: Considere o caso a seguir: Ao ser informado sobre a admissão de uma parturiente de 39 semanas e 2 dias de idade gestacional, o pediatra encarregado pela sala de parto prontamente requisitou o cartão de pré-natal desta mãe, inteirando-se de que se tratava de gravidez de risco habitual, com nove consultas realizadas em unidade básica de saúde, com sorologias para HIV, sífilis, toxoplasmose, rubéola e hepatite B não reagentes. A gestante apresentou níveis tensionais adequados em todas as consultas, níveis glicêmicos controlados e não houve episódios de infecção. Ao realizar anamnese materna, orientou a gestante acerca do papel do pediatra na sala de parto. Após isso realizou briefing com a equipe assistencial e novamente conferiu a presença de matérias e equipamentos necessários a reanimação neonatal. Cerca de uma hora mais tarde, com a evolução do parto por via vaginal, ao nascimento observou-se que o recém-nascido estava hipotônico. O pediatra procedeu ao clamp imediato, levou o neonato ao berço aquecido, secou o paciente e estendeu levemente seu pescoço para abertura de via aérea. Ao constatar que a frequência cardíaca era de vinte batimentos por minuto, iniciou imediatamente ventilação com pressão positiva sem oxigênio suplementar. Solicitou a seu auxiliar que monitorizasse o paciente. Trinta segundos depois, notou que, apesar de a técnica de ventilação estar correta, a frequência cardíaca era de zero batimentos por minuto. Diante disso, iniciou imediatamente massagem cardíaca sincronizada em três compressões para uma ventilação. Assegurou-se que a técnica de compressão e ventilação com máscara facial estavam corretas. Como não houve melhora, procedeu à infusão de adrenalina - via cateter umbilical - de três em três minutos, e finalmente ao uso de expansão com soro fisiológico. Ainda assim, o paciente não apresentou melhora com as medidas instituídas, evoluindo para óbito. Nesse caso, ao avaliarmos a abordagem do pediatra, é CORRETO afirmar que:

A) A sequência de reanimação foi realizada de forma correta e adequada, não havendo impacto possível no desfecho do caso.

B) A infusão de adrenalina por cateter umbilical na reanimação neonatal não tem indicação, sendo o acesso intraósseo o mais adequado nessas situações.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

C) A massagem cardíaca na reanimação em sala de parto só deve ser iniciada a perviedade da via aérea estar garantida por intubação orotraqueal.

D) A anamnese materna é de responsabilidade do médico obstetra, tendo o pediatra dispendido tempo precioso nessa coleta de informações, as quais poderiam ser obtidas em conversa com o colega obstetra.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

351628)

Enunciado: Acerca da triagem neonatal de cardiopatias congênitas críticas, o ?teste do coraçãozinho?, assinale a alternativa CORRETA.

A) O teste do coraçãozinho é importante ferramenta para descartar a ocorrência de cardiopatia congênita dependente de canal arterial, sendo que o achado de teste sem alteração exclui a ocorrência de cardiopatias de qualquer natureza.

B) O teste do coraçãozinho deve ser realizado entre vinte e quatro e quarenta e oito horas de nascimento, e, quando alterado, motiva a solicitação de ecodopplercardiograma.

C) A realização do teste baseia-se no achado de saturação com mais de 4% de diferença entre membros superiores e inferiores, podendo ser usado qualquer membro superior e qualquer membro inferior para sua aferição.

D) O achado de sopro precoce demanda necessariamente a realização de ecocardiograma, não havendo utilidade para o teste do coraçãozinho, quando há presença de tal sinal.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

354079)

Enunciado: Ao nascimento, após as primeiras respirações, o clampeamento tardio do cordão facilita a transição hemodinâmica para o ambiente extrauterino ao permitir:

A) A redução do retorno venoso ao coração direito, enquanto a resistência vascular sistêmica está diminuindo.

B) O aumento do retorno venoso ao coração direito, enquanto a resistência vascular sistêmica está diminuindo.

C) A redução do retorno venoso ao coração esquerdo, enquanto a resistência vascular pulmonar está aumentando.

D) A redução do retorno venoso ao coração direito, enquanto a resistência vascular pulmonar está aumentando.

E) A manutenção do retorno venoso ao coração esquerdo, enquanto a resistência vascular pulmonar está diminuindo.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

368170)

Enunciado: Recém-nascido a termo nasce hipotônico e com respiração irregular. Após serem realizados os passos iniciais de reanimação neonatal, manteve respiração irregular e FC = 80 bpm. O próximo passo a ser realizado é:

A) estímulo tátil vigoroso em plantas dos pés e dorso.

B) ventilação com pressão positiva por cânula endotraqueal.

C) ventilação com pressão positiva por máscara, em ar ambiente.

D) ventilação com pressão positiva por máscara com oxigênio a 30%.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

336262)

Enunciado: RN prematuro, masculino, idade gestacional de 27 semanas e 3 dias, nascido por Sindrome Help materna, estando a mesma na UTI desde seu nascimento. Mantido em ventilação mecânica, cateter umbilical venoso e arterial, sem antibiótico, uso de nutrição parenteral e fórmula enteral própria para prematuro iniciada com 48h de vida. No 7° dia de internação evoluiu com palidez, vômito bilioso, instabilidade hemodinâmica com déficit perfusional, sangramento nas fezes, distensão abdominal e dor difusa a palpação. Realizado RX abdome (abaixo). Qual a melhor conduta neste caso?

A) Antibioticoterapia de largo espectro e reavaliação radiológica em 24h

B) Ultrassonografia de abdome total

C) Laparotomia exploradora de urgência

D) RX abdome seriado a cada 6 horas

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

345713)

Enunciado: Quanto à melhor técnica para monitorar a frequência cardíaca do recém-nascido na sala de parto, assinale a alternativa correta.

A) Ausculta com estetoscópio

B) Oximetria de pulso

C) Eletrocardiografia

D) Palpação do cordão umbilical

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

345714)

Enunciado: Com relação à definição de hipotensão para um recém-nascido, assinale a alternativa correta.

A) A hipotensão no recém-nascido pode ser definida como PAM menor que 30 mmHg.

B) Nos recém-nascidos, a hipotensão é a PAM menor que a idade gestacional menos 3.

C) A hipotensão nos recém-nascidos pode ser definida como a PAM menor que p3 de acordo com o gráfico de Zubrow.

D) Não há um consenso sobre a definição de hipotensão em recém-nascidos.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

337633)

Enunciado: No Brasil, o número de mortes por prematuridade, asfixia e infecção é muito acima do esperado e, em grande parte, relacionado às causas sensíveis à atenção de qualidade no pré-natal e no nascimento. Nesse contexto, sobre o Recém-Nascido (RN) de baixo peso, é CORRETO afirmar que:

A) O peso ao nascer deve ser inferior a 2.000g para que o recém-nascido possa ser classificado como RN de baixo peso, independentemente da idade gestacional.

B) O RN de baixo peso, pode se subdividir em dois grupos, sendo RN de peso extremamente baixo ao nascer < 1.500g e baixo peso ao nascer entre 1.500g e 2.499g.

C) O RN pré-termo, ou prematuro, é aquele que possui idade gestacional menor que 37 semanas, podendo ainda ser dividido em dois subgrupos: imaturidade extrema, com idade gestacional inferior a 28 semanas de gestação e RN pré-termo, de 28 a 36 semanas de gestação.

D) A variação de peso considerada normal para cada período da gestação está entre os percentis de 20 e 80 e RN pode ser classificado como Pequeno para Idade Gestacional (PIG), se estiver abaixo de 20.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

320439)

Enunciado: Durante uma sala de parto, pediatra dá suporte à um recém-nascido, filho de gestante que teve acompanhamento pré-natal irregular. O recém-nascido apresenta uma tumefação dorsal mediana na altura da coluna lombar, de cor avermelhada, coberta por uma fina membrana com extravasamento lento de líquido claro através de uma fenda na membrana. A equipe do hospital informa que o neurocirurgião só estará? disponível dentro de dois dias. A conduta neste caso:

A) Transferir para unidade com neurocirurgião e realizar cirurgia imediata.

B) Internar na UTI neonatal e solicitar parecer do neurologista.

C) Internar em alojamento conjunto e aguardar parecer do neurocirurgião.

D) Internar na UTI neonatal e solicitar ressonância magnética da coluna lombar.

E) Internar na UTI neonatal e solicitar ultrassonografia da coluna lombar.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

320441)

Enunciado: Recém-nascido, sexo masculino, é levado ao setor de emergência com 16 horas de vida. O paciente nasceu na residência da família, e o pai informa que o bebê ?evacuou sangue?. Exame físico: peso 3.500g, comprimento 50 cm, FC 150 bpm, FR 50 irpm, pulsos periféricos facilmente palpáveis, exsudação sanguinolenta no coto umbilical. Exames laboratoriais: plaquetas: 300.000/mm, TAP e PTT prolongados, BT: 5mg/dl, função hepática normal. A medida terapêutica mais importante é a administração de:

A) antibiótico.

B) vitamina K.

C) fatores de coagulação.

D) plasma fresco congelado.

E) acetato de desmopressina.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

337641)

Enunciado: Uma das mais difíceis e complexas mudanças relacionadas ao nascimento é a transição abrupta para o feto de uma dependência total de suprimento da glicose materna para uma total independência desta, após a ligadura do cordão umbilical. Sobre os distúrbios metabólicos do recém-nascido, é CORRETO afirmar que:

A) Os sinais e sintomas de hipoglicemia em neonatos são inespecíficos, e incluem abalos, letargia, fome excessiva, sucção vigorosa, apneia, crises de cianose, dificuldade respiratória, convulsões mioclônicas ou multifocais, e, muito raramente, coma.

B) A antecipação e a prevenção são fundamentais para o manejo do RN sob risco de hipoglicemia. Em recém-nascidos pré-termo ou recém-nascidos pequenos para idade gestacional, o controle da glicemia deve ser feito em 3, 6, 12 e 24 horas, e após isso, em intervalos de 8 a 12 horas conforme protocolos das unidades.

C) A diabetes gestacional ou pré-gestacional materna, administração de drogas à gestante e hipertensão e pré-eclâmpsia são fatores de risco para desenvolvimento de hiperglicemia transitória neonatal.

D) O limiar costuma ser considerado para diagnóstico de hiperglicemia nos neonatos como sendo 126mg/dL no sangue, sendo necessária intervenção terapêutica independente da presença de glicosúria com diurese osmótica.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

336288)

Enunciado: Gestante, 30 semanas de idade gestacional, DHEG grave, internada há 4 dias inibindo trabalho de parto prematuro, sem outras alterações no pré natal. Evoluiu com piora clínica sendo necessária cesariana de urgência. RN nasceu bem, transferido a UTIN em CPAP nasal, realizou RX de tórax abaixo. Sobre o diagnóstico mais provável e a indicação de corticoide ante natal assinale a alternativa correta:

A) Síndrome do desconforto respiratório, corticóide ante natal era indicada para mãe.

B) Taquipneia transitória do recém-nascido, conticóide ante natal não era indicada para mãe.

C) RX normal para o prematuro, corticóide ante natal era indicada para mãe.

D) Pneumonia, corticóide ante natal não era indicada para mãe.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

335111)

Enunciado: Recém-nascido a termo nasce hipotônico e com respiração irregular. Após serem realizados os passos iniciais de reanimação neonatal, manteve respiração irregular e FC = 80 bpm. O próximo passo a ser realizado é:

A) Realizar estímulo tátil vigoroso em plantas dos pés e dorso.

B) Aplicar ventilação com pressão positiva por cânula endotraqueal.

C) Aplicar ventilação com pressão positiva por máscara em ar ambiente.

D) Aplicar ventilação com pressão positiva por máscara com oxigênio a 30%.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

334762)

Enunciado: As infecções adquiridas intra-útero ou durante o trabalho de parto são causas de significativa morbidade e mortalidade neonatal. Correlacione a coluna com os nomes de algumas infecções adquiridas intra-útero ou durante o trabalho com a coluna dos sinais e sintomas e a seguir assinale a alternativa com a ordem correta. (1) Sífilis. (2) Rubéola. (3) Toxoplasmose. (4) Citomegalovírus. ( ) Calcificações intracranianas difusas, hidrocefalia, coriorretinite, líquor com inexplicável pleiocitose ou proteína elevada e hepatoesplenomegalia. ( ) Rash maculopapular (palmas das mãos e plantas dos pés), rinite persistente, osteocondrite e periostite e pseudoparalisia de Parrot. ( ) Catarata, cardiopatia congênita (persistência do canal arterial ou estenose pulmonar), perda auditiva e retardo de crescimento intrauterino. ( ) Calcificações periventriculares, microcefalia, trombocitopenia, hepatoesplenomegalia e petéquias.

A) 1, 2, 3, 4.

B) 2, 3, 1, 4.

C) 3, 1, 2, 4.

D) 2, 4, 1, 3.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

306701)

Enunciado: Gestante de 37 semanas e 5 dias, após diagnóstico de pré eclampsia é encaminhada para cesariana. O recém-nascido (RN) nasce hipotônico e em apneia. O pediatra em sala de parto solicita clampeamento imediato de cordão umbilical, leva RN ao berço aquecido e faz os passos iniciais. Após, avalia o RN que apresenta FC: 90 bpm e mantém apneia. A próxima conduta a ser realizada deve ser:

A) CPAP em sala de parto.

B) Intubação orotraqueal.

C) Ventilação com pressão positiva.

D) Massagem cardíaca.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

305006)

Enunciado: A respeito da investigação laboratorial da atresia de vias biliares, é correto afirmar:

A) Os testes de síntese hepática (albumina) e coagulação são anormais.

B) Na atresia de vias biliares, ocorre hiperbilirrubinemia, com preponderância da fração conjugada (indireta), porém, o predomínio da fração não conjugada (direta) não exclui o diagnóstico.

C) Em geral, as transaminases são normais ou discretamente diminuídas.

D) Em geral, os valores da bilirrubina total estão entre 6 mg/dL e 12 mg/dL, com 50% a 60% de bilirrubina direta.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

291628)

Enunciado: A alternativa que descreve as complicações mais frequentes nos recém-nascidos de mães diabéticas é:

A) Hipocalcemia, policitemia e hemorragia intracraniana.

B) Hipoglicemia, Cardiopatia congênita e policitemia.

C) Anemia, hipoglicemia e déficit sucção.

D) Anemia, hipocalcemia e síndrome de aspiração meconial.

E) Anemia, hipoglicemia e hiponatremia.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

291629)

Enunciado: Recém-nascido pré-termo de 34 semanas de idade gestacional, pequeno para idade gestacional, peso de nascimento de 1.500 gramas, mãe hipertensa grave. Apresenta com uma hora de vida dosagem capilar de glicose pela glicofita de 12mg/dL. A conduta terapêutica imediata é realizar:

A) Hidratação venosa com glicose a 50% e alimentação por sucção com duas horas de vida.

B) Infusão rápida de glicose 10%, alimentação com duas horas de vida por gavagem e controle de glicemia capilar em seis horas.

C) Infusão rápida de glicose 10%, mais hidratação venosa com glicose a 10% e controle de glicemia capilar em 30 minutos.

D) Hidratação venosa com SF 0;9%, alimentação com uma hora de vida por sucção e controle de glicemia capilar em duas horas.

E) Estimular aleitamento materno e reavaliar criança em 1 hora.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

291630)

Enunciado: Gestante com 39 semanas de idade gestacional admitida em trabalho de parto. Oito consultas de prénatal, segunda gestação, histórico de sífilis na gestação anterior. Com 11 semanas de idade gestacional apresentou VDRL de 1:128, recebendo três doses de Penicilina Benzatina, 2.400.000UI, com intervalo de uma semana entre cada dose. Parceiro se recusou a pesquisar e tratar sífilis. Teve queda titulação VDRL 1:16. Com 28 semanas de idade gestacional, apresentou aumento de título de VDRL de 1:64. Parto vaginal, recém-nascido vigoroso, assintomático ao exame físico, sendo encaminhado ao alojamento conjunto. Nesse caso, é correto afirmar que:

A) Mãe inadequadamente tratada para sífilis gestacional, devemos realizar apenas o VDRL de sangue periférico do recém-nascido. Se o VDRL do recém-nascido for reator, independente do título, devemos tratar com Penicilina Cristalina por dez dias, mesmo que haja possibilidade de seguimento ambulatorial.

B) Mãe adequadamente tratada para sífilis gestacional, devemos realizar o VDRL de sangue periférico do recém-nascido, avaliação liquórica, hemograma completo e radiografia de ossos longos. Só iniciar o tratamento se houver alteração em qualquer dos exames de triagem. Acompanhar ambulatorialmente, minimamente por dois anos.

C) Mãe inadequadamente tratada para sífilis gestacional, devemos realizar o VDRL de sangue periférico, punção lombar, hemograma, radiografia de ossos longos do bebê. Se o VDRL do recém-nascido for reator e houver alteração no líquor, devemos tratar com Penicilina Cristalina por dez dias e acompanhar ambulatorialmente, por pelo menos 2 anos.

D) Mãe adequadamente tratada para sífilis gestacional, devemos realizar o VDRL de sangue periférico do recém-nascido. Se o VDRL do recém-nascido for não reator, devemos tratar com Penicilina Benzatina em dose única, independente da possibilidade de seguimento ambulatorial.

E) Mãe inadequadamente tratada para sífilis gestacional, devemos realizar VDRL e hemograma do de sangue periférico do recém-nascido. Se o VDRL do recém-nascido for não reator, devemos dar alta hospitalar para seguimento ambulatorial.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

313306)

Enunciado: Considere a alternativa que descreve, corretamente, o teste do coraçãozinho:

A) Aferição da oximetria de pulso no membro superior direito (MSD) e em um dos membros inferiores (MI). RN entre 24 e 48 horas de vida, antes da alta hospitalar.

B) Aferição da oximetria de pulso no membro superior esquerdo (MSD) e em um dos membros inferiores (MI). RN entre 24 e 48 horas de vida, antes da alta hospitalar.

C) Aferição da oximetria de pulso no membro superior direito (MSD) e no membro superior esquerdo (MSE). RN entre 24 e 48 horas de vida, antes da alta hospitalar.

D) Aferição da oximetria de pulso no membro superior direito (MSD) e em um dos membros inferiores (MI). RN entre 6 a 12 horas de vida, antes da alta hospitalar.

E) Aferição da oximetria de pulso no membro superior esquerdo (MSD) e em um dos membros inferiores (MI). RN entre 6 a 12 horas de vida, antes da alta hospitalar.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

313307)

Enunciado: MHR é RN, nascida de parto cesárea, de primípara de 20 anos. Nasceu com 48 cm, 2,950 Kg, Apgar 9, sem alterações congênitas. Ao exame clínico, o pediatra verifica hemorragia abaixo da aponeurose epicraniana que conecta os componentes frontal e occipital dos músculos fronto-occipitais. O diagnóstico desse achado é:

A) Hematoma Subgaleal.

B) Céfalo-hematoma.

C) Bossa sanguinolenta.

D) Borra serossanguínea.

E) Caput succedaneum.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

313308)

Enunciado: A atresia biliar é a principal causa de transplante hepático em crianças e, se não tratada, é fatal em 100% dos casos. A única alternativa para evitar o transplante hepático, tendo melhores resultados se realizada, precocemente, é a cirurgia de:

A) Nissen (portoenterostomia).

B) Kasai (portoenterostomia).

C) Bohr (portoenterostomia).

D) Whipple (portoenterostomia).

E) Hartmann (portoenterostomia).

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

313310)

Enunciado: Sobre as medicações de reanimação neonatal, a adrenalina endotraqueal é indicada na dosagem de:

A) 0,1 ? 0,3 mL/Kg.

B) 0,25 ? 0,5 mL/Kg.

C) 0,5 ? 1,0 mL/Kg.

D) 0,8 ? 1,5 mL/Kg.

E) 1,0 ? 2,0 mL/Kg.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

313311)

Enunciado: Com relação ao diagnóstico diferencial das infecções congênitas. Não há edema generalizado em casos de:

A) Sífilis.

B) Citomegalovirose.

C) Doença de Chagas.

D) Vírus Herpes Simples.

E) Toxoplasmose generalizada.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

313312)

Enunciado: De acordo com o Ministério da Saúde, os seguintes princípios devem ser adotados para melhorar os efeitos da terapia com o surfactante: I- Estimular o uso de corticoide antenatal em gestantes de risco para parto prematuro; II- Implementar recursos suficientes de pessoal, equipamentos e laboratório para o cuidado de RN com insuficiência de múltiplos órgãos. Além disso, manter vigilância constante da qualidade do atendimento a esses pacientes; III- Preferir os preparados contendo surfactante endógeno de animais, exceto nas situações em que a lesão inflamatória é extensa, como na síndrome do desconforto respiratório - SDR grave, pneumonias, síndrome de aspiração meconial - SAM e na síndrome do desconforto respiratório agudo ? SDRA; IV- Iniciar com dose de 10 mg/kg de fosfolípides. Caso o paciente apresente melhora da função pulmonar, manter essa dose se houver necessidade de novo tratamento. Nas situações em que há lesão inflamatória extensa (SDR grave, pneumonias, SAM e SDRA), considerar o uso de doses maiores, próximas a 15 mg/kg de fosfolípides. A necessidade de doses adicionais deve ser individualizada. Dos itens acima:

A) Apenas os itens III e IV estão corretos.

B) Apenas os itens I e II estão corretos.

C) Apenas os itens I e III estão corretos.

D) Apenas os itens II e III estão corretos.

E) Apenas os itens II e IV estão corretos.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

313313)

Enunciado: A cianose, coloração azulada decorrente da presença de pelo menos 5 g de hemoglobina não saturada, é intercorrência, relativamente comum, no RN, que, frequentemente, possui níveis de hemoglobina:

A) Abaixo de 9 g/dL.

B) Abaixo de 11 g/dL.

C) Acima de 13 g/dL.

D) Acima de 15 g/dL.

E) Acima de 18 g/dL.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

313314)

Enunciado: O milium sebáceo está presente em 40% dos RNs. É correto afirmar que o milium sebáceo manifesta-se por:

A) Pelos finos que costumam recobrir a região do ombro e da escápula.

B) Material gorduroso e esbranquiçado na cabeça e nas extremidades.

C) Manchas azul-acinzentadas localizadas, preferencialmente, no dorso e nas regiões glútea e lombossacra.

D) Pequenos pontos brancos (menor que 1mm), localizados na base do nariz, queixo e fronte.

E) Lesões eritematosas multiformes (pápulas, máculas e até algumas vesículas), esparsas ou confluentes.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

313315)

Enunciado: RN pré-termo (32 semanas), com presença de taquipneia, retração subcostal e tiragem intercostal importantes, gemidos expiratório e crises de cianose. Achados radiológicos pouca expansão pulmonar, infiltrado micronodular difuso (vidro fosco?) e aerobroncogramas. Sobre o caso clínico, temos que: I- O uso do CPAP ? pressão de distensão contínua de vias aéreas ? deve ser precoce. II- Possivelmente é um caso de doença de membrana hialina (DMH). III- O uso de surfactante, nesses casos, leva à piora drástica da condição respiratória, sendo contraindicado.

A) Nenhum dos itens está correto.

B) Apenas os itens I e II estão corretos.

C) Apenas os itens I e III estão corretos.

D) Apenas os itens II e III estão corretos.

E) Todos os itens estão corretos.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

305036)

Enunciado: Considere um recém-nascido a termo nasce hipotônico e com respiração irregular.

Após serem realizados os passos iniciais de reanimação neonatal, manteve respiração irregular e

FC = 80 bpm. Nesse caso, o próximo passo é:

A) Realizar estímulo tátil vigoroso em plantas dos pés e dorso.

B) Aplicar ventilação com pressão positiva por cânula endotraqueal.

C) Aplicar ventilação com pressão positiva por máscara, em ar ambiente.

D) Aplicar ventilação com pressão positiva por máscara com oxigênio a 30%.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

260687)

Enunciado: Recém nascido a termo, parto normal, com 18 horas de vida, em bom estado geral, grupo sanguíneo A positivo, em aleitamento materno exclusivo, apresenta-se ictérico até a região do tronco. No prontuário materno há registro de Gesta: 1 Para: 1, Aborto: 0, três consultas de pré-natal; tipagem sanguínea materna: O positivo; sorologias do último trimestre de gestação: negativas. A conduta adequada é realizar:

A) Hemograma, bilirrubinas, Coombs direto e suspender aleitamento materno.

B) Hemograma, bilirrubinas, ultrassonografia de abdome e suspender aleitamento materno.

C) Hemograma, reticulócitos, bilirrubinas, ultrassonografia de abdome e manter aleitamento materno.

D) Hemograma, reticulócitos, bilirrubinas, Coombs indireto e manter aleitamento materno.

E) Hemograma, reticulócitos, bilirrubinas, Coombs direto e manter aleitamento materno.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

260688)

Enunciado: Ao prestar assistência a um parto vaginal, você observa que ao romper a bolsa o líquido amniótico encontra-se meconial. Logo após a extração o recém-nascido se encontra com tônus preservado, mas com movimentos respiratórios irregulares. A conduta apropriada neste caso após o clampeamento do cordão umbilical é:

A) Secar o corpo e a cabeça do recém-nascido e promover o contato pele-a-pele com a mãe, sempre friccionando a sua pele para que ele respire normalmente.

B) Secar o corpo e a cabeça do recém-nascido, promover o contato pele-a-pele com a mãe e aspirar o nariz do recém-nascido nesta posição para facilitar sua respiração.

C) Levar o recém-nascido para unidade de calor radiante, posicionar a cabeça, aspirar a traqueia e realizar intubação orotraqueal.

D) Levar o recém-nascido para unidade de calor radiante, posicionar a cabeça, aspirar boca e nariz, secar, desprezar campos e avaliar.

E) Clampeamento tardio do cordão umbilical e após promover o contato pele-a-pele com a mãe e aspirar o nariz do recém-nascido nesta posição para facilitar sua respiração.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

287351)

Enunciado: São doenças que acometem o indivíduo na infância que podem ser diagnosticada no ?teste do pezinho?, EXCETO?

A) Fibrose cística.

B) Hipotireoidismo.

C) Fenilcetonúria.

D) Deficiência da 21- hidroxilase.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

287906)

Enunciado: Sobre as doenças de pele no recém-nascido, analisar os itens abaixo: I. A miliária, problema cutâneo comum no período neonatal, pode se manifestar em dois tipos: cristalina e rubra. II. A infecção secundária por Candida é um evento muito frequente nas dermatites da região das fraldas. III. O impetigo é causado exclusivamente pelo Streptococcus pyogenes. Está(ão) CORRETO(S).

A) Somente o item I.

B) Semente o item II.

C) Somente os itens I e II.

D) Somente os itens I e III.

E) Todos os itens.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

287911)

Enunciado: Considerando-se a icterícia neonatal, analisar os itens abaixo: I. A icterícia fisiológica reflete uma adaptação neonatal ao metabolismo da bilirrubina indireta e tem início precoce, em geral nas primeiras 24 horas de vida. II. A icterícia que tem início tardio, com mais de 24 horas de vida, decorre de processo patológico, com possibilidade de elevação anormal da concentração sérica de bilirrubina indireta e com possível dano cerebral. III. A icterícia associada ao leite materno em neonatos saudáveis e em aleitamento materno exclusivo pode perdurar até o segundo ou terceiro mês de vida. Está(ão) CORRETO(S):

A) Somente o item I.

B) Somente o item III.

C) Somente os itens I e II.

D) Somente os itens II e III.

E) Nenhum dos itens.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

255622)

Enunciado: A icterícia neonatal ocorre em 85% dos neonatos nascidos a termo e a maioria dos casos é fisiológica. Sobre os fatores de maior risco para hiperbilirrubinemia indireta, MARQUE A CORRETA:

A) Mãe de tipagem AB.

B) Mãe hipertensa.

C) Baixo aporte de leite materno na primeira semana de vida.

D) Recém-nascido termo.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

255623)

Enunciado: O diagnóstico precoce das infecções congênitas e adquiridas no período perinatal é de fundamental importância para o início da terapia adequada e determinação do prognóstico. Em relação à sífilis congênita. MARQUE A CORRETA:

A) Pode ser classificada como sífilis congênita precoce ou tardia.

B) Os testes não treponêmicos, como o VDRL, são pouco sensíveis e muito específicos.

C) Os casos notificados se estabilizaram nos últimos anos.

D) Nos recém-nascidos de mães com sífilis inadequadamente tratada, sem alterações clínicas, radiológicas, hematológicas ou liquóricas e VDRL negativo, não é necessário o tratamento.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

234416)

Enunciado: Em relação à rubéola na gravidez, assinale a alternativa INCORRETA:

A) A rubéola é uma doença infecciosa aguda virótica causada pelo vírus da família ?Fogaviridae?, sendo que a infecção ocorre de forma horizontal ou vertical.

B) Os sintomas são inespecíficos no período prodrômico da rubéola, e o exantema quando surge é do tipo maculopapilar fino.

C) A principal forma de transmissão dessa doença é a vertical e os mecanismos de danos ao feto ocorrem por lesões intensas e bem localizadas.

D) O diagnóstico clínico de rubéola é muito difícil por algumas razões. Dentre elas os vários tipos de exantema que são atribuídos à rubéola e vice-versa.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

232126)

Enunciado: Aleitamento materno é fundamental para o crescimento e desenvolvimento adequados da criança. No período neonatal, mesmo o recém-nascido saudável poderá apresentar icterícia precoce em razão de aleitamento materno insuficiente, cuja etiologia é hiperbilirrubinemia

A) direta por esteatose hepática.

B) direta por céfalo-hematoma.

C) indireta por deficiência da enzima lactoferrina.

D) indireta por deficiência de alfa-1-antitripsina.

E) indireta por aumento da circulação êntero-hepática da bilirrubina.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

232128)

Enunciado: Todo recém-nascido é avaliado ao nascimento pelo escore de Apgar, no primeiro e no quinto minuto de vida. Qual dos itens não faz parte dessa avaliação?

A) Tônus muscular.

B) Reatividade à aspiração.

C) Frequência respiratória.

D) Frequência cardíaca.

E) Coloração.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

227099)

Enunciado: Colestase é a incapacidade de secretar bilirrubina, o que resulta em hiperbilirrubinemia conjugada e icterícia. Sobre a colestase, é INCORRETO afirmar que:

A) A doença extra-hepática mais comum é a atresia biliar.

B) A incompatilibade de Rh, seria a principal causa de colestase.

C) As causas tóxicas ocorrem principalmente devido ao uso de nutrição parental.

D) A colestase é tipicamente observada nas primeiras 2 semanas de vida.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

232130)

Enunciado: Recém-nascido de 40 semanas, parto cesáreo, adequado para a idade gestacional, Apgar 9/10, bolsa rota no ato, líquido amniótico claro, apresenta taquipneia com retrações intercostais logo após o parto. Exame físico: ausculta pulmonar sem crepitantes. RX de tórax: aumento da trama vascular pulmonar. História obstétrica: sem intercorrências. Diante do quadro, o diagnóstico é

A) síndrome de aspiração meconial.

B) pneumonia do recém-nascido.

C) hipertensão pulmonar persistente do recém-nascido.

D) taquipneia transitória do recém-nascido.

E) sepse neonatal provável origem materna.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

232131)

Enunciado: Recém-nascido, 39 semanas de idade gestacional, Apgar 9/10, sem fatores de risco, apresenta icterícia em face com 18 horas de vida. História obstétrica sem fatores de risco. Grupo sanguíneo materno: O +, do RN: B +. Exame físico: ativo, mamando bem, já eliminou mecônio e apresentou diurese. Nesse caso, está indicado

A) observar e reavaliar a icterícia antes da alta para decidir sobre a realização de exames.

B) colher exames laboratoriais para avaliar incompatibilidade ABO e decidir sobre fototerapia.

C) aguardar completar 24 horas e colher exames para avaliar exsanguineotransfusão.

D) suspender o aleitamento materno, pois se trata de icterícia associada ao aleitamento materno.

E) alta hospitalar com reavaliação em 24 horas.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

227101)

Enunciado: Sífilis congênita é uma infecção de múltiplos sistemas, causada pelo Treponema pallidum e transmitida ao feto pela placenta. Em relação a sífilis congênita, assinale a alternativa INCORRETA:

A) A sífilis congênita precoce manifesta-se com erupções vesiculobolhosas características ou erupção macular com coloração cúprica nas palmas das mãos e nas solas dos pés.

B) A sífilis congênita tardia geralmente se manifesta após o segundo mês de vida e causa úlcera gomosa.

C) A suspeita diagnóstica de sífilis congênita precoce baseia-se usualmente na sorologia materna, realizada de rotina no início da gestação, com frequência no terceiro trimestre e no parto.

D) A sífilis pode causar muitas anormalidades diferentes nas radiografias dos ossos longos.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

227316)

Enunciado: A capacidade de manter constante a temperatura corporal é limitada no Recém-Nascido e depende da idade gestacional e pós natal, do peso de nascimento e das condições clínicas do Recém-Nascido. Assinale a repercussão clínica que não ocorre na hipotermia.

A) Edema ou escleredema.

B) Diminuição do débito cardíaco.

C) Diminuição da produção de surfactante.

D) Diminuição do consumo de oxigênio.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

246796)

Enunciado: Lactente de 45 dias apresenta colestase desde a segunda semana de vida. Qual dos achados clínicos afasta temporariamente o diagnóstico de atresia das vias biliares?

A) Ganho de peso adequado.

B) Fígado palpável.

C) Baço palpável.

D) Icterícia às custas de aumento da bilirrubina direta.

E) Fezes coradas.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

199498)

Enunciado: A icterícia neonatal é, provavelmente, o diagnóstico mais frequentemente realizado nos recém-nascidos. Em relação a icterícia neonatal, assinale a alternativa INCORRETA:

A) A produção diária de bilirrubina no recém- nascido é pelo menos duas vezes mais do que na criança maior.

B) O aleitamento materno está claramente associado a aumento na incidência da icterícia neonatal.

C) A icterícia que se inicia antes de 24h de vida, frequentemente se deve à doença hemolítica.

D) A metabolização e a reciclagem de sangue sequestrados em hematomas, equimoses ou hemorragias são uma causa frequente de hiperbilirrubinemia direta.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

202730)

Enunciado: Segundo o Programa de Reanimação Neonatal, quando existe a necessidade do uso de adrenalina no momento da reanimação, a diluição e a dose a ser administrada por via Intravenosa, respectivamente, são:

A) 1/5.000 / 0,05-0,1ml/kg.

B) 1/2.000 / 0,3-0,5ml/kg.

C) 1/1.000 / 0,1-0,5ml/kg.

D) 1/10.000 / 0,1-0,3ml/kg.

E) 1/5.000 / 0,1 -0,3 ml/kg.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

202751)

Enunciado: Qual dos achados abaixo determina a escolha do tratamento para um recém nascido com sífilis congênita?

A) Radiografia de ossos longos com sinais de periostite.

B) Pênfigo palmo plantar.

C) Proteína no líquor > 160 mg/dl.

D) Hemograma com score rodwell > 3.

E) Vdrl no sangue do recém nascido 1/128.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

202756)

Enunciado: Dos diagnósticos citados abaixo, qual o mais provável para o recém-nascido, cuja a mãe não fez pré-natal e apresenta baixo peso, anemia, icterícia, hepatoesplenomegalia, hidrocefalia e coriorretinite?

A) Sífilis congênita.

B) Toxoplasmose congênita.

C) Doença de Chagas congênita.

D) Infecção pelo citomegalovírus congênita.

E) Rubéola Congênita.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

202774)

Enunciado: Adolescente de 17 anos, internada em período expulsivo, dá à luz recém-nascido a termo, vigoroso e sem nenhuma anormalidade aparente ao exame clínico. A análise do cartão do pré-natal da adolescente revela que, apesar de negativo no primeiro trimestre, o VDRL colhido no último trimestre de gestação foi positivo na diluição de 1/8. A adolescente informa que iniciou tratamento penicilínico na semana que antecedeu o parto e que seu parceiro não foi submetido a tratamento, pois seu VDRL foi não-reator. De acordo com as normas do Ministério da Saúde, além de colher VDRL da mãe, está indicado, nessa situação, considerar o tratamento da mãe:

A) Inadequado e iniciar tratamento penicilínico do recém-nascido sem necessidade de realizar qualquer exame complementar.

B) Adequado e iniciar tratamento penicilínico do recém-nascido apenas se o VDRL for positivo em diluição maior ou igual à da mãe.

C) Inadequado, realizar hemograma, punção lombar, radiografia de ossos longos e VDRL do recém- nascido e iniciar tratamento penicilínico.

D) Adequado e iniciar tratamento penicilínico do recém-nascido apenas se o VDRL da mãe, colhido nesse momento, for positivo em diluição >1/8.

E) Inadequado realizar hemograma e VDRL. Se estiverem normais, fazer 1 dose de penicilina G benzatina e dar alta ao paciente.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

199597)

Enunciado: A gestante chegou em período expulsivo e o obstetra o chama pra assistir ao Recém-Nascido (RN). Ao nascer deve-se avaliar a vitalidade do RN por meio das seguintes perguntas segundo as Diretrizes da Reanimação Neonatal 2015:

A) RN a termo?; RN com bom tônus muscular?; RN chorando ou respirando?

B) RN pré-termo?; Líquido amniótico meconial?; RN chorando ou respirando?

C) RN com gasping ou apneia?; Líquido amniótico meconial?; Frequência cardíaca > 100 bpm?

D) RN respirando?; RN com bom tônus muscular?; Líquido amniótico meconial?

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

199616)

Enunciado: Neonato a termo, peso adequado para a idade gestacional, gestação sem intercorrências, parto vaginal, APGAR 8/9. Em aleitamento materno exclusivo e mãe com boa quantidade de colostro. Após 48 horas de vida, exame físico normal, está para ter alta da maternidade. Foi submetido à triagem neonatal para cardiopatia congênita complexa sendo a saturação da oxi-hemoglobina de 92%. Diante do relato, qual o próximo passo a ser seguido segundo as orientações da Sociedade Brasileira de Pediatria e de Cardiologia?

A) Realizar outra oximetria de pulso em 24 horas e se valor igual ou menor (diferença de "maior ou igual que" 3%), solicitar ecocardiograma antes da alta hospitalar.

B) Refazer o exame físico e se dentro da normalidade, dar alta para seguimento em ambulatório sendo o retorno marcado para 48 horas depois.

C) Realizar outra oximetria de pulso em 1 hora e se valor igual ou menor (diferença de "maior ou igual que" 3%), solicitar o ecocardiograma antes da alta hospitalar.

D) Realizar outra oximetria de pulso em 6 horas e se valor igual ou maior (diferença de "maior ou igual que" 3%), dar alta para seguimento em ambulatório, retorno em 48 horas.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

196757)

Enunciado: Recém-nascido de mãe com 7 consultas pré natais, sem história de infecção urinária, hipertensão arterial ou diabetes durante a gestação, sorologias de prá natal: HIV não reagente no primeiro e no terceiro trimestre, Toxoplasmose IgM negativo e IgG positivo no primeiro trimestre, Rubéola IgM negativo e IgG positivo no primeiro trimestre, Citomegalovírus IgM negativo e IgG positivo no primeiro trimestre, VDRL 1:64 no primeiro trimestre e 1:32 no último trimestre, com história de tratamento com 3 doses de penicilina benzatina no primeiro trimestre de gestação. Qual a conduta em relação ao recém nascido?

A) Rx de ossos longos, hemograma, punção lombar e avaliar tratamento conforme resultado dos exames

B) Penicilina benzatina dose única e internação hospitalar

C) Penicilina procaína dose única e avaliação ambulatorial

D) Penicilina benzatina dose única e alta hospitalar, sem necessidade de reavaliação

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

196767)

Enunciado: O treinamento e padronização da assistência ao recém nascido na sala de parto é de suma importância para garantir a redução de danos caso haja algum desvio da normalidade esperada para o parto via vaginal. Ao imediato nascimento do bebê o Pediatra que presta assistência na sala de parto responde a três perguntas pré programadas e então inicia ou não sua intervenção. Caso a uma das três perguntas a resposta seja não, qual o próximo passo?

A) prover calor, posicionar a cabeça em leve extensão e ventilar com balão valva máscara com ar comprimido

B) prover calor, posicionar a cabeça em leve extensão, aspirar boca e narinas, se necessário, e secar

C) prover calor, posicionar a cabeça em leve extensão, aspirar boca e narinas, ventilar com balão valva máscara com ar comprimido e secar

D) prover calor, posicionar a cabeça em leve extensão, aspirar boca e narinas, secar e ventilar com balão valva máscara com ar comprimido

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

196814)

Enunciado: Gertraude está grávida de 14 semanas e teve diagnóstico de varicela. Qual das alterações fetais abaixo estaria relacionada a varicela? Marque a CORRETA:

A) Catarata

B) Microcefalia

C) Agenesia de bexiga

D) Artrogripose

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

215148)

Enunciado: Gestante, CTP, de 40 anos, encontra-se na 30ª semana de gestação e devido a uma infecção do trato urinário entra em trabalho de parto. O Prematuro de 30 semanas é encaminhado a UTI neonatal, onde é estabilizado clinicamente. O pediatra deverá iniciar a nutrição desse recém-nascido. Nesse caso, é CORRETO afirmar que:

A) O prematuro deverá receber preferencialmente fórmula nutritiva.

B) O prematuro deverá receber somente hidratação e reposição de eletrólitos.

C) O alimento mais apropriado é o leite humano pasteurizado proveniente de um conjunto de mães de prematuros de idades pós-natal diversas, via enteral.

D) O alimento mais apropriado é o leite da própria mãe de forma oral.

E) O alimento mais apropriado é o leite da própria mãe, associado a reposições hidroeletrólicas e proteicas.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

187504)

Enunciado: Recém-nascido com 12 horas de vida, suga bem seio materno, mãe com pouco colostro. Nasceu a termo, AIG, com peso de 3000 gramas, com APGAR de 9/9, e está em bom estado geral, com exame físico normal. Mãe relata pré-natal de 9 consultas, sem intercorrencias, e com glicemias de jejum e teste oral de tolerância à glicose normais. Qual a conduta mais adequada?

A) Prescrever fórmula láctea como complemento ao aleitamento materno.

B) Incentivar o aleitamento materno, verificar glicemia capilar periférica do recém nascido, e prescrever fórmula láctea como complemento ao aleitamento caso glicemia menor que 60 mg/dl.

C) Incentivar o aleitamento materno, verificar glicemia capilar periférica do recém nascido, e prescrever fórmula láctea como complemento ao aleitamento caso glicemia menor que 55 mg/dl.

D) Incentivar o aleitamento materno, verificar glicemia capilar periférica do recém nascido, e prescrever fórmula láctea como complemento ao aleitamento caso glicemia menor que 50 mg/dl.

E) Incentivar o aleitamento materno exclusivo e não verificar glicemia capilar periférica do recém-nascido.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

174362)

Enunciado: Recém-nascido prematuro, com 33 semanas de idade gestacional, pesando 1.600 g, é atendido pelo pediatra em sala de parto. Quais os primeiros passos a serem adotados?

A) Assegurar a temperatura na sala de parto entre 23-26ºc, após clampeamento do cordão umbilical, recém-nascido é levado a fonte de calor radiante, posiciona-se a cabeça do recém-nascido em leve extensão, aspiração das narinas e boca se presença de secreção, secar o paciente e retirar compôs úmidos. Avaliação da FC, respiração e Tônus muscular. Todo procedimento deve ser realizado em 60 segundos.

B) Assegurar a temperatura na sala de parto entre 23-26ºc, após clampeamento do cordão umbilical, recém-nascido é levado a fonte de calor radiante, posiciona-se a cabeça recém-nascido em leve extensão, aspiração das narinas e boca se presença de secreção, secar o paciente e retirar compôs úmidos. Avaliação da FC, respiração e Tônus muscular. Todo procedimento deve ser realizado em 30 segundos.

C) Assegurar a temperatura na sala de parto entre 23-26ºc, após clampeamento do cordão umbilical, recém-nascido é levado a fonte de calor radiante, envolto em saco plástico transparente, touca dupla, posiciona-se a cabeça do recém-nascido em leve extensão, aspiração das narinas e boca se secreção, e avaliação da FC, respiração e Tônus muscular. Todo procedimento deve ser realizado em 30 segundos.

D) Assegurar a temperatura na sala de parto entre 23-26ºc, após clampeamento do cordão umbilical, recém-nascido é levado a fonte de calor radiante, posiciona-se a cabeça do recém-nascido em leve extensão, inicia CPAP nasal com ventilador manual em T, e encaminhar a UTI neonatal para receber cuidados intensivos.

E) Assegurar a temperatura na sala de parto entre 23-26ºc, após clampeamento do cordão umbilical, recém-nascido é levado a fonte de calor radiante, posiciona-se a cabeça do recém-nascido em leve extensão, realizar intubação orotraqueal e realizar uma dose de surfactante, monitorização continua e encaminhamento à UTI neonatal acoplado ao ventilador Manuel em T.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

174370)

Enunciado: Recém nascido, 36 semanas de idade gestacional, pesando 2000 g, é atendido pelo pediatra em sala de parto, apresentando FC >100bpm, respiração rítmica, retração esternal, batimento de asa de nariz e gemido expiratório. A Conduta a ser adotada, neste caso, é:

A) Aplicar CPAP com ventilador manual em T e máscara facial.

B) Iniciar ventilação com pressão positiva, com balão autoinflável e máscara.

C) Iniciar ventilação com pressão positiva com ventilador mecânico manual em T e tubo traqueal.

D) Obsetvar por 10 minutos e, se não melhorar, oferecer oxigênio.

E) Aplicar CPAP com balão autoinflável e tubo traqueal.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

187509)

Enunciado: Os neonatos prematuros têm maior risco de hemorragia craniana peri-intraventricular.

Qual o método de escolha para o diagnóstico dessa patologia?

A) Raio X de crânio.

B) Ultrassonografia craniana Transfontanelar.

C) Tomografia computadorizada de Crânio.

D) Cintilografia de Crânio.

E) Punção ventricular.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

187511)

Enunciado: Segundo as diretrizes do Programa de Reanimação Neonatal, qual método de determinar a frequência cardíaca parece ser o mais indicado para a condução da reanimação em sala de parto?

A) A palpação do cordão umbilical.

B) A ausculta do precórdio com o estetoscópio.

C) A detecção do sinal de pulso pela oximetria.

D) A detecção da atividade elétrica do coração pelo monitor cardíaco.

E) A palpação do pulso radial.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

174356)

Enunciado: Recém-nascido a termo, 40 semanas de idade gestacional, mãe primípara, sem intercorrências no pré-natal. Nasceu de parto vaginal em boas condições de vitalidade, pesando 3500 g, sendo encaminhado ao alojamento conjunto. No primeiro dia de vida apresentou dificuldade para amamentar e icterícia com 15 horas de vida. Ao exame físico, apresenta icterícia +/4+ em face e parte superior do tronco, restante do exame normal. Baseado no quadro clínico descrito, o diagnóstico mais provável e a conduta correta são:

A) Icterícia fisiológica; suplementação com fórmula láctea de partida e fototerapia.

B) Icterícia fisiológica; tipagem sanguínea e bilirrubina total e frações e fototerapia.

C) Icterícia hemolítica; Coombs do recém-nascido, dosar substância redutora na urina e fototerapia.

D) Icterícia hemolítica; Coombs da mãe, suplementação com leite humano de banco de leite e fototerapia.

E) Icterícia hemolítica; tipagem sanguínea, Coombs da mãe e do recém-nascido, bilirrubina total e frações e fototerapia.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

174361)

Enunciado: Para efeito de vigilância epidemiológica, toda mãe com VDRL positivo na gravidez, e que não tenha recebido tratamento adequado, terá seu recém-nascido com diagnóstico como portador de sífilis congênita:

A) Se ele apresentar VDRL positivo e radigráfia de ossos longos alterada e ou alterações clínico-laboratoriais.

B) Se ele apresentar VDRL com titulação maior que a da mãe.

C) Independente de sua condição clínica e de seu VDRL.

D) Se ele apresentar VDRL positivo com qualquer titulação.

E) Se ele apresentar VDRL positivo > 1:4 e tiver alteração clínica ou laboratorial compatível com a doença.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

188028)

Enunciado: Gestante portadora de cardiopatia deu entrada no pronto socorro obstétrico com relato de redução de movimentos fetais há 24 horas. Após avaliação obstétrica foi realizado parto cesariana de urgência sob anestesia geral de recém-nascido a termo, 40,3 semanas, bolsa rota no ato com líquido amniótico meconial ++/4+, apresentação pélvica. Após recepcionar o recém-nascido e efetuar os passos iniciais de reanimação, você percebe que o paciente se encontra pálido, em apneia, com frequência cardíaca de 50 bpm e hipotonia generalizada. Qual é a conduta a ser tomada no recém-nascido?

A) Administrar o antagonista dos opióides - naloxone.

B) Realizar aspiração traqueal sob visualização direta.

C) Iniciar ventilação com pressão positiva.

D) Intubar e administrar adrenalina endotraqueal.

E) Iniciar massagem cardíaca externa.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

172813)

Enunciado: Lactente de 2 meses é atendido no ambulatório de pediatria com história de choro persistente principalmente ao manuseio, ganho de peso inadequado, adenomegalia generalizada, hepatoesplenomegalia e palidez cutâneo-mucosa. A acompanhante desconhece a história gestacional. O diagnóstico mais provável é:

A) Toxoplasmose congênita.

B) Sífilis congênita.

C) Citomegalovírus.

D) Doença metabólica óssea.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

172750)

Enunciado: Recém-nascido de 36 semanas de idade gestacional, necessitou de ventilação com pressão positiva a 21% na sala de parto. No quinto minuto de vida, apresentou queda de satuação até 60%. Qual a conduta mais adequada?

A) Aquecer e reavaliar após 10 minutos.

B) Iniciar oxigenioterapia no CPAP nasal a 40%.

C) Manter a saturação de O? em torno de 98% na sala de parto.

D) Certificar se a ventilação com pressão positiva está sendo realizada com técnica correta.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

172556)

Enunciado: RN nascido de cesáreo, devido pré eclampsia, 37 semanas. No primeiro minuto: Chorou forte, movimentos ativos, FC 115 bpm, cianose central. Foi aquecido, examinado, sem anormalidades, no quinto minuto permanece apenas cianose em extremidades. O APGAR desse RN:

A) 8/9

B) 8/10

C) 7/10

D) 6/9

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

149130)

Enunciado: Recentemente no Brasil em virtude das Olimpíadas no Rio de Janeiro e pelo surgimento e disseminação de uma série de casos de infecção pelo Zika virus, um pânico generalizado no país e mundo foi propagado. Muitas coisas foram ditas sobre o assunto e nas questões abaixo, identifique a alternativa que aponta uma afirmação INCORRETA sobre o assunto:

A) Isolado pela primeira vez em 1947, o Zika permaneceu em relativa obscuridade por cerca de 70 anos, e num espaço de cerca de 1 ano, foi introduzido no Brasil, disseminando-se intensa e rapidamente no país e pelas Américas.

B) O Zika vírus se tornou a doença infecciosa com maior ligação à anormalidades no desenvolvimento fetal decoberta em mais de meio século, criando um alarme na Organização Mundial de Saúde.

C) Com os dados disponíveis até o momento é precipitado afirmar haver uma relação causal entre o Zika vírus e a microcefalia, permanecendo ainda apenas como uma forte suspeita.

D) O primeiro grande surto de Zika foi detectado em Salvador / Bahia no ano de 2015. Nesse mesmo ano foram relatados mais de 4000 casos de microcefalia no Brasil e uma possível relação causal com o Zika vírus foi estabelecida inicialmente.

E) Apesar da taxa de infecção do Zika vírus na Bahia não poder ser precisamente estimada com os dados disponíveis, é seguramente possível afirmar que há uma forte correlação entre a infecção pelo Zika vírus no primeiro trimeste de gestação e o risco de microcefalia.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

155444)

Enunciado: Recém-nascido a termo com peso ao nascer de 3400 g inicia icterícia com 20 horas de vida, sem apresentar outras alterações ao exame físico. A tipagem sanguínea materna é O negativo e a do recém-nascido, A positivo. Coombs-direto: negativo. A hipótese diagnóstica é:

A) Icterícia fisiológica.

B) Doença hemolítica pelo sistema ABO.

C) Doença hemolítica pelo sistema Rh.

D) Doença hemolítica pelos sistemas Rh e ABO.

E) Deficiência de glicose-6-fosfato desidrogenase.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

148577)

Enunciado: O escore de Apgar é muito utilizado para avaliar o recém-nascido após o parto. Qual a indicação do Apgar?

A) O escore de Apgar auxilia na identificação de pacientes com paralisia cerebral.

B) A nota do Apgar no primeiro minuto prediz a evolução neurológica da criança.

C) O escore de Apgar avalia de modo sistemático o recém-nascido após o parto. No primeiro minuto pode assinalar a necessidade de ressuscitação.

D) O escore de Apgar nos auxilia na identificação da idade gestacional do recém-nascido.

E) O escore de Apgar nos auxilia na identificação de icterícia neonatal.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

148587)

Enunciado: São considerados recém-nascidos de alto risco:

A) Crianças com peso inferior a 2.500 g são considerados recém-nascidos de alto risco. Pesos superiores são considerados fator de proteção.

B) Nascimentos antes de 37 semanas são considerados de alto risco. Nascimentos após 37 semanas são considerados fator de proteção.

C) Pacientes Pequenos para a Idade Gestacional (PIG) são considerados recém-nascidos de alto risco. Os pacientes Adequados para a Idade Gestacional (AIG) e Grande para a Idade Gestacional (GIG) são considerados fator de proteção.

D) Crianças com peso inferior a 2.500 g ou superior a 4.000 g são considerados recém-nascidos de alto risco.

E) Nascimentos antes de 32 semanas e acima de 40 semanas são considerados de alto risco.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

149131)

Enunciado: Recém-nascido a termo com 16 dias de vida, em aleitamento materno exclusivo, é levado a consulta devido a quadro de icterícia. Exame físico: corado, ictérico até zona III de Kramer, fígado palpável a 1cm do RCD, Traube livre. Exames laboratoriais (colhidos em regime de urgência): BT: 15,1mg/dl, BI: 14,8mg/dl, Ht: 47%. As hipóteses diagnósticas que devem ser consideradas incluem?:

A) atresia de vias biliares e hipotireoidismo

B) Icterícia do leite materno e hipotireoidismo

C) icterícia fisiológica e icterícia do leite materno

D) icterícia fisiológica e incompatibilidade materno-fetal

E) incompatibilidade materno-fetal e atresia de vias biliares

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

148551)

Enunciado: A Doença das Membranas Hialinas ou Síndrome de Desconforto Respiratório é uma doença frequente e fundamentalmente relacionada à deficiência primária de surfactante. Observe as afirmativas abaixo e marque a sentença correta a respeito da Doença das Membranas Hialina no recém-nascido.

A) A Doença das Membranas Hialinas ocorre principalmente em recém-nascido pós-termo.

B) A Doença das Membranas Hialinas tem incidência maior em mães com hipertensão crônica ou hipertensão associada à gestação.

C) A gestação múltipla é um fator de proteção para a Doença das Membranas Hialinas.

D) O uso antenatal de corticoide aumenta o risco de Doença das Membranas Hialinas.

E) 60-80% de todos os recém-nascidos com idade gestacional menor que 28 semanas apresentam Doença das Membranas Hialina.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

148584)

Enunciado: Observe as frases sobre icterícia na infância e assinale a alternativa que contém a resposta correta: I- Sepse neonatal é possível causa de icterícia com hiperbilirrubinemia indireta (não conjugada). II- Colecistite em crianças pode causar icterícia. III- O aleitamento materno pode causar icterícia.

A) As alternativas I e II estão corretas.

B) As alternativas II e III estão corretas.

C) Todas as alternativas estão corretas.

D) Somente a alternativa II está correta.

E) Todas as alternativas estão erradas.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

148592)

Enunciado: Os sucessos na prevenção da transmissão vertical, principal mecanismo de aquisição do HIV em pediatria, levaram a uma significativa redução dos casos novos, porém, com estabilização nos últimos anos. Observe as afirmativas abaixo e marque a sentença incorreta a respeito de infecção por HIV na infância.

A) Em todos os recém-nascidos de mulheres infectadas pelo HIV recomenda-se a não amamentação e a substituição do leite materno por fórmula infantil após aconselhamento.

B) Todos os recém-nascidos de mulheres infectadas pelo HIV devem receber profilaxia com antirretroviral.

C) No diagnóstico de crianças menores de 18 meses de idade, resultados detectáveis de carga viral abaixo de 5.000 cópias/mL devem ser cuidadosamente analisados e repetidos por causa da possibilidade de um resultado falso-positivo.

D) Uma criança menor de 18 meses de idade com duas cargas virais indetectáveis, sendo a segunda após quatro meses de idade, é considerada não infectada pelo HIV.

E) O parto vaginal e o tratamento da mãe HIV positiva com antirretrovirais reduz o risco de transmissão do vírus para o bebê.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

162536)

Enunciado: A retinopatia da prematuridade é uma das principais causas de cegueira e baixa visão infantil. São considerados fatores que podem contribuir para o desenvolvimento da retinopatia da prematuridade, EXCETO:

A) Oxigenoterapia.

B) Transfusão sanguínea.

C) Hiperbilirrubinemia.

D) Prematuridade.

E) Baixo peso ao nascer.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

162543)

Enunciado: Recém-nascido com 25 dias de vida é levado ao pediatra para consulta de puericultura. Ao exame físico, está afebril, em bom estado geral, e tem icterícia colestática, hepatomegalia, e fezes acólicas. A mãe tem exames do pré-natal negativos para HIV, toxoplasmose, rubéola, citomegalovírus, hepatite B, herpes e sífilis. Nasceu a termo, sem intercorrências. Qual o diagnóstico mais provável?

A) Galactosemia.

B) Atresia de vias biliares.

C) Tirosinemia.

D) Sepse.

E) Cisto de colédoco.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

155423)

Enunciado: Em relação à avaliação genético-clínica do recém-nascido, podemos afirmar, EXCETO:

A) São suportes para o diagnóstico final e tomada de condutas: anamnese e história familiar.

B) A presença de pelo menos 3 malformações maiores, associadas ou não a defeitos menores, caracterizam as síndromes malformativas.

C) Prega palmar transversal única bilateral pode ser encontrada num recém-nascido saudável, de cariótipo normal.

D) A presença de três anomalias menores indica a pesquisa de anomalias maiores.

E) O cariótipo é essencial para conclusão diagnóstica da maioria dos quadros dismórficos.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

155424)

Enunciado: Qual a orientação correta, na alta hospitalar a ser dada à mãe de um recém-nascido com teste de emissão otoacústica (EOA) alterado, sendo ele um bebê sem indicadores de risco para perda auditiva?

A) Reteste com 6 meses de vida.

B) Reteste no período de 30 dias.

C) Reteste com 1 ano de vida.

D) Reteste com 9 meses de vida.

E) Encaminhar imediatamente para um otorrinolaringologista.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

162515)

Enunciado: Sobre a citomegalovirose na gestação, podemos afirmar, EXCETO:

A) De forma geral a realização rotineira de testes sorológicos para detecção de anticorpos anti-citomegalovirus durante o pré-natal não está indicada para a população brasileira.

B) A grande maioria das gestantes é assintomática durante a primo-infecção pelo citomegalovírus.

C) Praticamente todas as gestantes são assintomáticas durante a recorrência pelo citomegalovírus.

D) A transmissão vertical pode ocorrer durante a vida fetal, no momento do parto ou durante o aleitamento materno.

E) Em casos de soro positividade materna para o citomegalovírus, o aleitamento materno não é contraindicado, devendo apenas ser suspenso temporariamente na infecção aguda.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

155341)

Enunciado: Em relação às infecções congênitas no recém-nascido, é CORRETO afirmar que:

A) A infecção por citomegalovírus pode ser transmitida ao concepto em qualquer período da gravidez.

B) A infecção por citomegalovírus não apresenta quadros graves no período neonatal.

C) A sífilis pode ser transmitida ao concepto somente no último trimestre da gestação.

D) A presença de rubéola congênita no recém-nascido não requer isolamento do mesmo.

E) A infecção fetal pelo vírus da rubéola ocorre principalmente no último trimestre da gestação.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

155351)

Enunciado: A sífilis congênita é, ainda, um importante problema de saúde pública, podendo ser prevenida. O tratamento da gestante é considerado eficaz ao seu recém-nascido se concluído até quantos dias antes de ocorrer o parto?

A) 15.

B) 30.

C) 40.

D) 45.

E) 60.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

137808)

Enunciado: Um recém-nascido na sala de parto, a termo, liquido amniótico claro, nasce em apneia e hipotônico. Ordene os procedimentos que definem corretamente a sequência de atendimento inicial: (1) Aspirar vias aéreas se necessário; (2) Secar e remover os campos úmidos; (3) Avaliar respiração e frequência cardíaca; (4) Prover calor; (5) Posicionar a cabeça. A ordem CORRETA dos números de cima para baixo é:

A) 1-2-3-4-5

B) 2-1-4-3-5

C) 4-5-1-2-3

D) 1-5-2-4-3

E) 4-5-2-1-3

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

137823)

Enunciado: Com relação à icterícia neonatal, assinale as associações corretas: 1- Hipotireoidismo ; 2- Icterícia fisiológica ; 3- Atresia de vias biliares; 4- Incompatibilidade sanguínea; 5- Leite humano; A- Icterícia com colúria; B- Icterícia precoce; C- Icterícia prolongada; D- Icterícia Tardia materno fetal; E- Icterícia sem colúria.

A) 1A; 2B; 3C.

B) 1C;2E;4B.

C) 1B; 3E; 4A.

D) 3D; 4C; 5C.

E) 1D; 2A; 5C.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

137815)

Enunciado: Em um RN com 36 horas de vida e diagnóstico de toxoplasmose congênita comprovada, a fundoscopia mostra coriorretinite macular bilateral em atividade. O hemograma apresenta 850 neutrófilos/mm³ e bilirrubina total de 9,0 mg/dl, com bilirrubina direta de 0,7 mg/dl. Qual seria o esquema terapêutico mais adequado para esta criança?

A) Sulfadiazina, pirimetamina, ácido folínico.

B) Espiramicina e corticosteroides.

C) Sulfadiazina, pirimetamina, ácido folínico e corticosteroide.

D) Espiramicina alternada com sulfadiazina + pirimetamina + ácido folínico.

E) Cirurgia refrativa e sulfadiazina.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

137840)

Enunciado: Recém-nascido a termo, de parto vaginal, Apgar 1º min: 8, 5ºmin: 9, realizado oximetria de pulso (?teste do coraçãozinho?) com 30 horas de vida, sendo repetido após uma hora. SatO2 em membro superior direito: 98% e em membro inferior direito: 93%. A conduta indicada é:

A) Ecocardiograma.

B) Indometacina IV.

C) Oferta de oxigênio em hood (60%).

D) Teste terapêutico com óxido nítrico.

E) Alta hospitalar e consulta ambulatorial com cardiopediatra.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

126894)

Enunciado: O rastreamento de doenças no período neonatal é mundialmente aceito como prática relevante de saúde pública. Quanto à triagem neonatal, assinale a alternativa INCORRETA.

A) O exame deve ser colhido entre 30 e 40 dias de vida.

B) A suspeita de hipotireoidismo congênito é pesquisada através da dosagem de TSH.

C) A dosagem de tripsina permite o diagnóstico de fibrose cística.

D) A dosagem do hormônio 17-hidroxiprogesterona permite o diagnóstico de hiperplasia adrenal congênita.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

126918)

Enunciado: RN de T.G.C., sexo masculino, 39 semanas, nasceu de parto vaginal, apgar 9/10. Atualmente está com 36 horas de vida. Ao exame: Acianótico, FC=132bpm, FR=43irpm, PA=80/60 mmHg. Peso ao nascer = 2870g. Estatura ao nascer = 49cm. Perímetro cefálico ao nascer = 34 cm. Ausculta cardíaca normal, ausculta respiratória normal. Abdômen flácido, sem visceromegalias. Avaliação do sistema nervoso central normal. Sobre à classificação do Recém-Nascido (RN) quanto à idade gestacional, peso, estatura e perímetro cefálico, assinale a alternativa CORRETA.

A) RN a termo, PIG, estatura normal.

B) RN pré-termo porque tem menos de 40 semanas.

C) RN pequeno para a idade gestacional, pré-termo.

D) RN AIG, estatura normal, perímetro cefálico normal.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

131652)

Enunciado: Assinale a opção errada, com relação à reanimação neonatal:

A) Recém-nascido a termo, que nasce chorando, com respiração rítmica e regular, com tônus muscular em flexão, e sem líquido amniótico meconial, não necessita de nenhuma manobra de reanimação.

B) Recomenda-se que o RN a termo, saudável e com boa vitalidade ao nascer seja posicionado no nível da placenta por 1 a 3 minutos, antes de clampear o cordão umbilical.

C) Após o clampeamento do cordão, o recém-nascido que nasce com peso inferior a 1500 gramas é recepcionado em campos aquecidos, colocado sob calor radiante, e logo a seguir é envolvido em filme plástico transparente de polietileno

D) Todo RN com líquido amniótico meconial espesso logo após o nascimento deve ser submetido à aspiração traqueal.

E) A avaliação da coloração da pele e mucosas do recém-nascido não é mais utilizada para decidir procedimentos na sala de parto.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

131654)

Enunciado: Recém-nascido a termo, que nasceu de parto normal, sem intercorrências. Com 12 horas de vida, iniciou febre, hipoatividade, taquipneia e desconforto respiratório. Teve piora clínica rápida, evoluindo com insuficiência respiratória. Tratando-se de quadro infeccioso, o agente etiológico mais provável é:

A) Candida albicans.

B) Staphylococcus aureus.

C) Pseudomonas aeruginosa.

D) Enterobacter.

E) Streptococcus agalactiae.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

131656)

Enunciado: Com relação ao teste do reflexo vermelho, assinale a alternativa errada.

A) É uma ferramenta de rastreamento de alterações que possam comprometer a transparência dos meios oculares.

B) Deve ser realizado utilizando um oftalmoscópio direito, em sala escurecida, não havendo necessidade de colírios.

C) Em caso de reflexo alterado ou suspeito, a criança deve ser encaminhada ao oftalmologista.

D) Devem ser submetidos ao teste do reflexo vermelho somente os recém-nascidos com peso menor que 2000 gramas ao nascer.

E) Dentre as doenças que o teste do reflexo vermelho pode detectar, estão a Catarata, o Glaucoma, a Toxoplasmose e o Retinoblastoma.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

126927)

Enunciado: RN de S.O.N., primeira filha, sexo feminino, nascida a termo. A mãe tem 24 anos, escolaridade primária, e fez pré-natal com 5 consultas. Exames realizados no pré-natal: Anti-HIV negativo; HBsAg negativo, VDRL não reator. Toxoplasmose: exame do primeiro trimestre gestação: IgG negativo, IgM negativo; terceiro trimestre gestação: IgG positivo; IgM positivo. Considerando o caso descrito, assinale a alternativa CORRETA.

A) A mãe teve uma viragem sorológica para toxoplasmose entre o primeiro e o terceiro trimestres de gestação, significando reativação da doença.

B) A mãe teve uma viragem sorológica para toxoplasmose entre o primeiro e o terceiro trimestres de gestação, significando contaminação pelo toxoplasma.

C) O teste de avidez para IgG, deve ser feito, para confirmar a infecção por toxoplasmose na mãe.

D) O recém-nascido não tem risco de toxoplasmose, porque a doença ocorreu no final da gestação.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

131659)

Enunciado: Com relação à convulsão febril simples, assinale a alternativa errada.

A) Pode ser focal ou generalizada.

B) Dura no máximo 15 minutos.

C) Vem acompanhada de febre de 38 graus Celsius ou maior.

D) Não recorre num período de 24 horas.

E) Não causa na criança efeitos adversos a longo prazo.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

131660)

Enunciado: São sinais clínicos frequentes da meningite bacteriana no período neonatal, exceto:

A) Respiração irregular.

B) Hipotonia, hiporreflexia.

C) Rigidez de nuca.

D) Tremores, convulsões.

E) Irritabilidade, letargia.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

127162)

Enunciado: A reanimação neonatal deve ser realizada de forma ativa e seguindo recomendações médicas baseadas na melhor evidência científica. Qual alternativa abaixo apresenta a sequência CORRETA referente aos passos iniciais da reanimação?

A) Secar e remover os campos úmidos, colocar o recém-nascido sob fonte radiante, posicionar a cabeça, aspirar narinas e boca (se excesso de secreções).

B) Aspirar narinas e boca (se excesso de secreções), secar e remover os campos úmidos, colocar o recém-nascido sob fonte radiante e posicionar a cabeça.

C) Colocar o recém-nascido sob fonte radiante, posicionar a cabeça, aspirar narinas e boca (se excesso de secreções), secar e remover os campos úmidos.

D) Colocar o recém-nascido sob fonte radiante, secar e remover os campos úmidos, posicionar a cabeça, aspirar narinas e boca (se excesso de secreções).

E) A ordem das manobras de reanimação deverá levar em conta a vitalidade do recém-nascido.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

127168)

Enunciado: Correlacione a primeira coluna, dos agentes etiológicos, com a segunda, que se refere às manifestações clínicas mais significativas da infecção congênita, e escolha a resposta CORRETA: I- Rubéola; II- Citomegalovírus; III- Toxoplasmose; IV- Vírus herpes simples; V- Sífilis. ( ) Vesículas e conjuntivite; ( ) Microcefalia e calcificação intracraniana; ( ) Catarata e cardiopatia congênita; ( ) Hidrocefalia e coriorretinite; ( ) Exantema maculopapular e lesão óssea.

A) III ? II ? IV ? I ? V.

B) V ? III ? I ? II ? IV.

C) IV ? II ? I ? III ? V.

D) V ? III ? I ? IV ? II.

E) IV ? II ? III ? V ? I.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

100961)

Enunciado: Neonato apresentando torcicolo congênito pode ter associação de outras deformidades como a alteração da coluna cervical. Além dessa associação deve-se pesquisar também:

A) Rim único.

B) Artrogripose.

C) Cardiopatia congênita.

D) Osteogênese imperfecta.

E) Displasia congênita do quadril.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

100953)

Enunciado: Recém-nascido com 44 horas de vida, a termo, em alojamento conjunto, parto normal, raça negra, aleitamento materno exclusivo, adequado para idade gestacional, encontra-se ictérico até zona II de Kramer. Mãe O positivo e recém-nascido A positivo. Qual a melhor conduta?

A) Iniciar fototerapia imediatamente.

B) Liberar o recém-nascido e tranquilizar a família.

C) Dosar a bilirrubina e dar alta com acompanhamento já marcado.

D) Liberar o recém-nascido para marcar consulta em sua unidade de saúde.

E) Iniciar água nos intervalos das mamadas.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

101009)

Enunciado: Durante a atenção, na sala de parto normal de uma gestante de risco habitual, foi observado um líquido amniótico com grumos, um recém-nascido que chorou logo, frequência cardíaca, respiratória e tônus normais. A conduta conforme o Programa de Reanimação Neonatal é:

A) Aquecer, posicionar vias aéreas, secar e estimular o recém-nascido nesta ordem.

B) Deixar com a mãe provendo seu aquecimento, mantendo suas vias aéreas pérvias, secando e permitindo o contato ao seio materno.

C) Banhar imediatamente e deixar com a mãe já vestido.

D) Deixar em contato pele a pele com a mãe na sala climatizada a 20°C.

E) Secar, aquecer, estimular e posicionar vias aéreas nesta ordem.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

106374)

Enunciado: Um recém-nascido com hidrocefalia, coriorretinite e calcificações cerebrais difusas provavelmente é portador de:

A) citomegalovírus.

B) rubéola congênita.

C) toxoplasmose.

D) sífilis congênita.

E) listeriose.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

106380)

Enunciado: Recém-nascido a termo, no quarto dia de vida, em aleitamento materno exclusivo, apresenta bilirrubina total de 10 mg/dl. O grupo sanguíneo materno é ?A? RH positivo, e o RN é ?0? RH positivo. Sua conduta diante desse caso é:

A) dar alta hospitalar ao RN e manter em aleitamento materno exclusivo.

B) dar alta hospitalar ao RN e substituir o aleitamento materno por fórmula láctea.

C) manter o RN no hospital e repetir dosagem sérica de bilirrubina no dia seguinte.

D) manter o RN no hospital e iniciar fototerapia única.

E) manter o RN no hospital e iniciar fototerapia dupla.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

111658)

Enunciado: O exame de triagem oftalmológico, onde em ambiente escuro, a luz do oftalmoscópio é direcionada às pupilas do recém-nascido, permite o diagnóstico precoce de:

A) proptose e epífora.

B) glaucoma e alterações arteriovenosas

C) catarata e alterações arteriovenosas.

D) coloboma e glaucoma.

E) catarata e retinoblastoma.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

77337)

Enunciado: Recém nascido a termo, gravidez sem intercorrências, nascido de parto Cesário por rotura prematura de membranas, iniciou cianose, taquipneia e gemidos respiratórios após nascimento. A principal hipótese diagnóstica e conduta são:

A) Obstrução nasal por aspiração nasal vigorosa ao nascer - fazer nebulização com oximetazolina.

B) Pneumonia bacteriana - fazer raio X de tórax e iniciar antibióticos.

C) Taquipneia transitória do recém nascido - prover oxigênio.

D) Hipertensão pulmonar persistente neonatal - ventilação mecânica e alcalinização.

E) Cardiopatia congênita - iniciar infusão de prostaglandina.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

59375)

Enunciado: Com relação à doença de Hirschsprung, marque a alternativa INCORRETA:

A) Na doença de Hirschsprung observa-se na histologia ausência dos plexos de Meissner e Auerbach e feixes nervosos hipertrofiados com altas concentrações de acetilcolinesterase entre as camadas musculares e na submucosa.

B) O toque retal revela tônus anal normal e é usualmente seguido por eliminação explosiva de fezes fétidas ou gases.

C) Uma vez que o diagnóstico esteja estabelecido, o tratamento definitivo é a intervenção cirúrgica.

D) A doença de Hirschsprung deve ser suspeitada em qualquer RN, principalmente em prematuros (mais acometidos) com atraso na eliminação de fezes.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

59393)

Enunciado: RN com 5 dias de vida, foi levado pela mãe à maternidade em que nasceu devido bolhas tensas de conteúdo purulento com halo eritematoso e bolhas rotas com descamação em colarete, duas em prega do pescoço e cinco em região axilar direita, não dolorosas à palpação. Mantendo bom estado geral, em Aleitamento Materno Exclusivo. Mãe refere parto cesáreo, bolsa rota no ato e nega infecção (corrimento vaginal ou infecção urinária). Pode-se afirmar:

A) Trata-se de um caso de piodermite, essas lesões são conhecidas como periporites. São decorrentes de contaminação dos orifícios e dos ductos de glândulas.

B) O diagnóstico é, em geral, clínico, mas exames bacteriológicos podem ser realizados, principalmente para detectar a sensibilidade da cepa estafilocócica aos antibióticos.

C) O tratamento é desnecessário, a afecção é autolimitada e desaparece espontaneamente sem deixar sequelas.

D) O quadro cutâneo pode ser acompanhado de eosinofilia sanguínea em 7 a 15% dos casos. Nos casos duvidosos pode ser realizado exame citológico das vesículas que revela presença de eosinófilos.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

59107)

Enunciado: Neonato de 30 semanas de idade gestacional, com quadro de insuficiência respiratória precoce após parto cesáreo por descolamento prematuro de placenta. Qual a etiologia provável da insuficiência respiratória?

A) Taquipneia transitória do recém-nascido.

B) Síndrome do desconforto respiratório.

C) Pneumonia.

D) Síndrome de aspiração meconial.

E) Hipertensão pulmonar persistente.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

59110)

Enunciado: Você é o pediatra de plantão e chega à Maternidade uma gestante HIV positivo. Indicada a cesariana que transcorreu sem intercorrências. O recém-nascido apresentou Apgar 8 no primeiro minuto e 9 no quinto minuto, é adequado para idade gestacional e a termo. Marque a melhor conduta:

A) Estimular o vínculo mãe-filho em regime de alojamento conjunto e estimulando a amamentação.

B) Oferecer AZT oral ao recém-nascido após testes sorológicos específicos, com permanência em alojamento conjunto.

C) Oferecer AZT oral ao recém-nascido nas primeiras horas de vida e contraindicar a amamentação.

D) Contraindicar o regime de alojamento conjunto e a amamentação, e oferecer ao recém-nascido suspensão oral de AZT.

E) Oferecer à mãe e ao recém-nascido AZT endovenoso durante a internação hospitalar.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

59415)

Enunciado: RN nascido de parto normal, 37 semanas e 3 dias. No primeiro minuto apresentou: bradicardia (FC < 100 bpm), flácido, sem movimentos respiratórios, azul pálido e reagindo pouco. Foi aquecido, estimulado e feito O2 inalatório, respondeu com choro forte, FC > 100 bpm, movimento ativo, cianose apenas de extremidades. O APGAR desse RN:

A) 2/9

B) 1/7

C) 2/7

D) 3/8

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

59081)

Enunciado: Relacione corretamente os dados maternos com as manifestações clínicas no recém-nascido e assinale a alternativa CORRETA: Doença Materna: A - Coxsackie vírus; B - Lúpus eritematoso sistêmico; C - Rubéola; D - Diabetes mellitus. Doença Neonatal: I - Miocardiopatia hipertrófica; II - Bloqueio atrioventricular total; III - Miocardite congênita; IV - Persistência do canal arterial.

A) A II, B II, C III, D IV

B) A III, B IV, C I, D II

C) A III, B II, C IV, D I

D) A IV, B II, C III, D I

E) A II, B I , C IV, D III

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

59084)

Enunciado: Mãe de recém-nascido de parto cesáreo, a termo, 72 horas de vida, reflexo de sucção normal, encontra-se com dificuldade de amamentar por fissura mamária à direita. Produção de leite adequada. Qual a melhor conduta?

A) Translactação com fórmula infantil na mama direita.

B) Suspender totalmente a amamentação na mama direita.

C) Ordenhar a mama direita pré-sucção e acertar a "pega".

D) Manter o mamilo bem seco com protetores de algodão.

E) Administrar metoclopramida para mãe.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

366980)

Enunciado: Um recém-nascido prematuro está na Unidade de Cuidado Intensivo Neonatal e desenvolve súbito desconforto respiratório, com cianose e queda da saturação de oxigênio. Qual é a suspeita clínica mais provável?

A) Pneumotórax.

B) Asma bronquial.

C) Cardiopatia congênita.

D) Bronquiolite.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

363932)

Enunciado: Quais características são indicativas de icterícia neonatal grave com necessidade de atenção médica imediata?

A) Olhos amarelados, letargia e recusa alimentar.

B) Choro noturno e pele amarelada no rosto.

C) Pele amarelada que desaparece quando pressionada.

D) Icterícia persistente por mais de um mês.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

363931)

Enunciado: O contato pele a pele do recém-nascido (RN) com sua mãe, imediatamente após o parto,

A) aumenta a incidência de hipoglicemia neonatal.

B) contribui com o aumento de casos de hemorragia materna no pós-parto.

C) é indicado a todos os recém-nascidos (RNs) com boas condições de nascimento.

D) provoca um maior número de casos de hipotermia neonatal.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

331989)

Enunciado: Sobre as crianças expostas ao HIV, é correto afirmar que:

A) Nos primeiros seis meses de vida, não devem receber as vacinas oferecidas pelo PNI, mas sim imunológicos especiais no centro de referência.

B) O Ministério de Saúde do Brasil recomenda que a coleta da primeira carga viral seja feita na segunda semana de vida do recém-nascido.

C) Deve-se iniciar a profilaxia para pneumonia por Pneumocystis jiroveci com o uso de sulfametoxazol + trimetoprim três vezes por semana se a contagem de linfocitos CD4 estiver abaixo de 15%.

D) As não infectadas tendem a apresentar mais infecções bacterianas e quadros mais graves se comparadas a crianças não expostas ao HIV.

E) Para o diagnóstico de infecção pelo HIV, a recomendação é que o teste anti-HIV seja feito entre o sexto e o 12° mês de vida.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

330090)

Enunciado: Há uma infecção congênita que ocorre, geralmente, por infecção genital materna. É mais comum sua transmissão durante o trabalho de parto ou pós-natal e chega a 50% no parto vaginal. Mulheres com primo-infecção geralmente são assintomáticas, enquanto aquelas com infecção recidivante têm a transmissão intraparto diminuída para uma taxa de 3% a 5% pela presença de anticorpos preexistentes. A alternativa correspondente à infecção é:

A) Infecção congênita por herpes simples.

B) Sífilis congênita precoce.

C) Infecção congênita por citomegalovírus.

D) Rubéola congênita.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

331990)

Enunciado: A toxoplasmose congênita é uma doença evitável se os cuidados com a gestante, a interpretação dos exames durante o pré-natal e a indicação do tratamento forem corretos. Nesse contexto, é um erro afirmar que:

A) A transmissão vertical em gestante com infecção crônica é improvável, exceto se ela for imunodeprimida.

B) A espiramicina é medicação para a profilaxia da toxoplasmose congênita.

C) Se a IgG e a IgM forem positivas para toxoplasmose e o resultado de teste de avidez for baixo durante a gravidez, isto significa que a gestante tem infecção recente e o tratamento para toxoplasmose deve ser iniciado imediatamente.

D) Havendo soroconversão durante a gravidez, é indicada a pesquisa de DNA do toxoplasma pela técnica de PCR em líquido amniótico para investigar infecção fetal.

E) Se a IgG e a IgM forem negativas para toxoplasmose no primeiro trimestre de gestação, o feto não será infectado e não está indicado o tratamento da gestante.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

346440)

Enunciado: Qual dos seguintes fatores de risco não está associado com a Doença da Membrana Hialina?

A) Diabetes Materno;

B) Cesárea eletiva na ausência de trabalho de parto;

C) Prematuridade;

D) Doença hipertensiva específica da gravidez.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

346441)

Enunciado: Qual das seguintes características está associada com Icterícia Neonatal Fisiológica?

A) Icterícia desde o primeiro dia de vida;

B) Atinge o pico de bilirrubina total dentro de 07 dias;

C) Icterícia associada com anemia;

D) Icterícia associada com perda de peso.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

346444)

Enunciado: Criança de 08 anos, com quadro de encefalopatia hipóxico isquêmica, traqueostomizada e gastrostomizada, apresenta disfagia, sialorreia importante e pneumonias de repetição. Qual a conduta inicial mais adequada?

A) Antibioticoterapia profilática;

B) Desconexão laringotraqueal;

C) Colírio de Atropina por via oral;

D) Observação clínica.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

342639)

Enunciado: Catarata congênita, retinopatia, persistência do canal arterial e baixo peso ao nascer são manifestações clínicas comumente encontradas em que patologia?

A) síndrome da rubéola congênita

B) hipotireoidismo congênito

C) toxoplasmose congênita

D) sífilis congênita

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

321586)

Enunciado: Quando deve ser clampeado o cordão umbilical de um recém-nascido (RN) a termo com boa vitalidade?

A) Imediatamente após o nascimento.

B) Até 60 segundos após o nascimento.

C) Entre 1 e 3 minutos de vida do RN.

D) Após 3 minutos de vida do RN

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

334816)

Enunciado: Atualmente, qual é o exame considerado padrão ouro para o diagnóstico de atresia biliar?

A) Ultrassonografia abdominal com visualização do sinal do cordão triangular.

B) Cintilografia hepatobiliar sem evidência de excreção intestinal do contraste.

C) Colangiografia transoperatória.

D) Histologia (proliferação ductal, plungs biliares, edema e arquitetura biliar preservada).

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

321591)

Enunciado: Qual é a classe de antibióticos com propriedades farmacológicas semelhantes (ação antimicrobiana e anti-inflamatória) que são utilizados com eficácia em crianças com infecções graves de vias aéreas inferiores?

A) Aminoglicosídeos.

B) Cefalosporinas.

C) Glicopeptídeos.

D) Macrolídeos.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

334819)

Enunciado: Os recém-nascidos prematuros que não possuem quantidades adequadas de surfactante podem desenvolver insuficiência respiratória grave. Nesse cenário, o que acontece com a tensão superficial alveolar e a complacência pulmonar, respectivamente?

A) Reduzida; reduzida.

B) Aumentada; aumentada.

C) Aumentada; reduzida.

D) Reduzida; aumentada.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

321593)

Enunciado: Qual exame auditivo deve ser realizado em crianças que permaneceram internadas em UTI-Neonatal por mais de 5 dias?

A) Emissões otoacústicas evocadas.

B) Potencial evocado auditivo de tronco encefálico.

C) Audiometria de campo livre.

D) Impedanciometria.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

334823)

Enunciado: Sobre a triagem neonatal realizado por meio do teste do pezinho sabe-se que:

A) qualquer alteração do exame só será valorizada se o paciente apresentar clínica compatível com a doença testada.

B) as doenças obrigatórias testadas são: fenilcetonúria, hipotireoidismo congênito, doença falciforme, fibrose cística, hiperplasia adrenal congênita e deficiência de biotinidase.

C) a coleta deverá ocorrer ao nascimento, antes da alta da maternidade.

D) prematuridade e hemotransfusões não interferem no resultado do teste.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

339823)

Enunciado: Recém-nascida com 56 horas de vida apresenta icterícia que se iniciou com 14 horas de vida. Encontra-se em aleitamento materno exclusivo e pesando 2925 gramas. Genitora GIPIA0 fez pré-natal sem intercorrência, classificação sanguínea da mãe. O negativo. A recém-nascida nasceu bem, o cordão umbilical foi clampeado 60 segundos após o nascimento, com o seguinte peso: 2900 gramas. Exame físico: icterícia em face, tronco e membros e palidez cutâneo-mucosa. Classificação sanguínea do recém-nascido A positivo com Coombs direto negativo. Restante do exame físico normal. A provável causa dessa icterícia deve ser

A) incompatibilidade materno-fetal Rh.

B) incompatibilidade materno-fetal ABO.

C) icterícia do leite materno.

D) clampeamento tardio do cordão umbilical.

E) deficiência de G6PD.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

339826)

Enunciado: Quando deve ser clampeado o cordão umbilical de um recém-nascido (RN) a termo com boa vitalidade?

A) Imediatamente após o nascimento.

B) Até 60 segundos após o nascimento.

C) Entre 1 e 3 minutos de vida do RN.

D) Após 3 minutos de vida do RN.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

300814)

Enunciado: A anemia é definida como a concentração de hemoglobina abaixo do segundo desvio-padrão da média da distribuição da hemoglobina para população de mesma idade e sexo, vivendo na mesma altitude. Quanto à anemia fisiológica em prematuros, é CORRETO afirmar:

A) É mais pronunciada, ocorrendo mais cedo e com um nadir mais alto em comparação com crianças nascidas a termo. Essa condição também é chamada de ?anemia da prematuridade?.

B) Possui um mecanismo semelhante àquele que provoca anemia em crianças nascidas a termo e causa anemia em prematuros nas primeiras 4 a 12 semanas.

C) A eritropoetina mais alta, a vida-média mais curta das hemácias (35 a 50 dias), o crescimento rápido e as flebotomias mais frequentes contribuem para o menor nadir de Hb em prematuros.

D) A anemia da prematuridade afeta mais comumente crianças < 36 semanas de gestação.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

315790)

Enunciado: Sobre o tratamento da Retinopatia da Prematuridade (ROP), assinale a alternativa correta.

A) A terapia antiangiogênica é uma opção nos casos de falha do tratamento com laser ou quando sabidamente os resultados tendem a ser ruins com o tratamento isolado com laserterapia.

B) O paciente está definitivamente curado quando a doença regride após o tratamento com a injeção de antiangiogênico.

C) A injeção de antiangiogênico é a terapia de escolha.

D) O uso de antiangiogênico em prematuros tem poucos efeitos deletérios.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

300823)

Enunciado: A palavra ?neonatologia? deriva de ?natos? que, em latim, significa ?nascer?, e ?logos?, que quer dizer ?tratado? ou ?estudo?. Em resumo, é o ?conhecimento do recém-nascido humano?. É uma das especialidades pediátricas com atenção voltada ao Recém-Nascido (RN) sadio ou com problemas de saúde. Considerando o contexto do controle de temperatura de RNs, é CORRETO afirmar:

A) Oferecer e manter ambiente com temperatura estável permite ao prematuro consumo mínimo de energia e, consequentemente, menor consumo de oxigênio. A umidade do ar estável também contribui para a manutenção da temperatura corpórea.

B) A hipertermia pode ocorrer devido à perda de calor para o ambiente que está fora das condições ideais, procedimentos demorados que expõem o RN ao frio, quadros de hipóxia, choque, hipoglicemia, infecção grave, lesão cerebral, hipotireoidismo ou uso de benzodiazepínicos.

C) A maior perda de calor de um RN ocorre nas primeiras 24 horas de vida. Sem medidas de controle térmico, o bebê pode perder de 2 a 4°C de sua temperatura corpórea. Por isso, nesse período, deve-se evitar o transporte na incubadora de transporte de dupla parede, utilizando outros métodos de controle de temperatura.

D) No transporte de prematuros, a utilização do gorro é indiferente para prevenir perda de calor por meio das fontanelas, que representam grande área de troca de calor no RN, devendo ser utilizado saco plástico, que confere proteção adequada contra perda de calor corpóreo, além de possibilitar a visualização completa do neonato, permitindo avaliação clínica apropriada.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

314122)

Enunciado: Recém-nascido, cuja mãe tem tipagem sanguínea "A" Rh positivo, nasceu com 36 semanas de idade gestacional, por parto normal e apresentou icterícia (zona III) com 30 horas de vida. Neste momento, qual é a conduta as ser tomada imediatamente, além de colocar o RN sob fototerapia?

A) Manter sob observação clínica.

B) Realizar exsanguineotransfusão.

C) Administrar imunoglobulina endovenosa.

D) Solicitar exames laboratoriais.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

302861)

Enunciado: Qual a idade ideal para a realização da triagem neonatal para hipotireoidismo congênito em recém-nascidos a termo?

A) Até 24 horas de vida.

B) Do 3° ao 5o dia de vida.

C) Após o 10° dia de vida.

D) Após o 7o dia de vida.

E) Do 1° ao 7o dia de vida.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

300827)

Enunciado: Paciente, sexo feminino, 1 ano e 1 mês, com percentil 25 para peso, percentil 10 para comprimento e percentil abaixo de 5 para perímetro cefálico. O nascimento ocorreu a termo, sendo revelado na inspeção pequeno tamanho de crânio. Apresenta retardo de desenvolvimento e, ao nascimento, teve icterícia neonatal prolongada. Atualmente, apresenta crises de convulsões. Considerando as descrições do enunciado, a melhor explicação para o pequeno tamanho da criança é:

A) Síndrome de Down.

B) Hipotireoidismo congênito.

C) Craniofaringioma.

D) Infecção congênita por citomegalovírus.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

313217)

Enunciado: Um recém-nascido com 37 semanas de vida apresentou, ao nascimento, respiração adequada, choro forte, bom tônus em flexão o e líquido amniótico meconial. Com base nesse cálculo assinale a alternativa correta:

A) o recém-nascido deverá ser aquecido, e sua vitalidade, avaliada enquanto se encontrar junto à mãe.

B) o cordão umbilical deverá ser clampeado imediatamente após a extração completa do recém-nascido da cavidade uterina

C) o recém-nascido deverá ser examinado na mesa de reanimação da sala de parto antes de ser colocado junto à mãe

D) as vias aéreas superiores deverão ser aspiradas assim que o polo cefálico se desprender

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

313218)

Enunciado: Acerca do clampeamento tardio do cordão umbilical na sala de parto, assinale a alternativa correta:

A) em recém-nascido que não tenha iniciado a respiração ao nascer, a necessidade de intubação orotraqueal será menor

B) em recém-nascido pré-termo, diminui a incidência de hemorragia intracraniana

C) aumenta o risco de enterocolite necrosante

D) é contraindicado a recém-nascido pré-termo com menos de 34 semanas de idade gestacional

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

315805)

Enunciado: Recém-nascido prematuro, de 26 semanas, pesando 900g, masculino, internado em leito de terapia intensiva neonatal desde o nascimento para suporte à vida. No momento encontra fórmula hidrolisada em sonda enteral associada à nutrição parenteral em cateter central de inserção periférica. Hoje, com 15 dias de vida, apresentou letargia, alguns episódios de apneia, aumento do resíduo gástrico e distensão abdominal. Os exames séricos evidenciaram leucocitose e plaquetopenia com aumento de provas inflamatórias inespecíficas. Mantém-se hemodinamicamente com abdome distendido, doloroso difusamente, mas sem sinais de irritação peritoneal. Ausência de flogoses e parede abdominal. Foram realizadas as radiografias abaixo. A principal hipótese diagnóstica é:

A) Íleo meconial.

B) Volvo de sigmoide.

C) Enterocolite necrosante.

D) Invaginação intestinal.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

315806)

Enunciado: Recém-nascido prematuro, de 26 semanas, pesando 900g, masculino, internado em leito de terapia intensiva neonatal desde o nascimento para suporte à vida. No momento encontra fórmula hidrolisada em sonda enteral associada à nutrição parenteral em cateter central de inserção periférica. Hoje, com 15 dias de vida, apresentou letargia, alguns episódios de apneia, aumento do resíduo gástrico e distensão abdominal. Os exames séricos evidenciaram leucocitose e plaquetopenia com aumento de provas inflamatórias inespecíficas. Mantém-se hemodinamicamente com abdome distendido, doloroso difusamente, mas sem sinais de irritação peritoneal. Ausência de flogoses e parede abdominal. Foram realizadas as radiografias abaixo. A melhor conduta no momento é:

A) Piloromiotomia.

B) Antibioticoterapia sistêmica, dieta zero e suporte clínico.

C) Colonoscopia descompressiva.

D) Biopsias retais e abaixamento de cólon.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

308275)

Enunciado: Ao longo século, a evolução das pesquisas em biologia molecular possibilitou muitas aplicações a beira leito com considerável impacto clinico no tratamento em oncologia. Neste contexto, conhecimento sobre a genética do câncer demonstrou que a base fisiopatológica tem forte associação com consecutivas alterações somáticas no DNA resultando em proliferações celulares irrestritas. Este conceito hoje muito claro, foi uma das bases ou ponto de partida das pesquisas que resultaram nos desfechos clínicos atuais. Entretanto, ainda há muito o que descobrir e avançar no tratamento do câncer. Considerando a temática da genética oncológica e sua importância na prática clínica em oncologia, resposta as questões abaixo. Sobre a epigenética e os mecanismos de manifestação de doenças podemos afirmar que:

A) Uma modificação epigenética se refere a uma mudança no genoma, herdada pela progênie celular, que não envolve mudança na sequência de DNA.

B) Uma modificação epigenética se refere a uma mudança no genoma, herdada pela progênie celular, que envolve mudança na sequência de DNA.

C) Uma modificação epigenética se refere a uma mudança no genoma, herdada pela progênie celular, que geralmente envolve mudança na sequência de DNA.

D) Uma modificação epigenética se refere a uma mudança no genoma, herdada pela progênie celular, que geralmente não envolve mudança na sequência de DNA.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

316370)

Enunciado: O recém-nascido deve passar por vários rastreios. Dentre eles, temos o teste do pezinho e o teste do reflexo vermelho. Qual a data correta para realizar esses exames, respectivamente:

A) Após 7º dia de vida / a cada 3 meses até os 2 anos de idade.

B) 3º ao 5º dia de vida / 1 consulta, 4 meses, 6 meses, 12 meses e 2 anos.

C) 1º ao 10º dia de vida / a cada 3 meses até os 2 anos de idade.

D) Ambos do 3º ao 5º dia de vida.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

308288)

Enunciado: O nosso país atualmente apresenta quedas nas taxas de transmissão vertical do HIV. Este fato é decorrente de medidas profiláticas, envolvendo cuidados com o binômio mãe-recém-nascido. Medidas como o aumento do número de diagnósticos realizados durante o pré-natal, utilização da terapia antirretroviral e medidas profiláticas para o recém-nascido contribuíram para esse cenário (Pascom et al.,2020). Gestante, portadora do vírus HIV há cerca de 3 anos, não faz uso de terapia antirretroviral, deu entrada no Hospital e Maternidade Dona Íris, em trabalho de parto. Recém nascido com peso ao nascimento de 3150 gramas, Capurro de 39 semanas e 2 dias. Qual (is) antirretroviral (is) este recém-nascido deverá receber?

A) AZT (zidovudina) por 42 dias.

B) AZT (zidovudina) por 28 dias e NVP (nevirapina) por 3 dias.

C) AZT (zidovudina) , NVP (nevirapina) e 3TC (lamivudina) por 28 dias.

D) AZT (zidovudina) , 3TC (lamivudina) e RAL (raltegravir) por 28 dias.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

308289)

Enunciado: Recém- nascido a termo de 39 semanas e 5 dias, parto normal, com 18 horas de vida, em bom estado geral, grupo sanguíneo A positivo, em aleitamento materno exclusivo, apresenta-se ictérico até a região do tronco. Tipagem sanguínea materna: O positivo. Realizado bilirrubina transcutânea deste recém-nascido, com valor de 9,5. A conduta mais adequada neste caso é:

A) Solicitar hematócrito, hemoglobina, bilirrubinas, coombs direto e reticulócitos, iniciar fototerapia e suspender aleitamento materno.

B) Solicitar hematócrito, hemoglobina, bilirrubinas, coombs direto e reticulócitos, aguardar resultados de exames e iniciar complementação com fórmula.

C) Solicitar hematócrito, hemoglobina, bilirrubinas, coombs direto e reticulócitos, iniciar fototerapia e manter aleitamento materno.

D) Iniciar imediatamente fototerapia e suspender aleitamento materno.

Gabarito

343775.

Comentário: A hipoglicemia neonatal representa um dos principais distúrbios metabólicos do período neonatal. Ela ocorre com maior frequência nos pacientes com baixas reservas de glicogênio, como nos recém-nascidos (RN) pré termo e naqueles com restrição de crescimento intrauterino. Pode ocorrer também quando aumentam as demandas energéticas, como na sepse, na hipotermia e na asfixia perinatal. Apesar de muitas discordâncias, a definição de hipoglicemia neonatal ainda permanece controversa. Entretanto, segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, o manejo diagnóstico e terapêutico da hipoglicemia não deve basear-se apenas no valor da glicemia, mas considerar o contexto clínico, contemplando a existência ou não de sintomas, fatores de risco e idade pós-natal. A recomendação é ter como alvo o nível de glicose 45 mg dL em sangue total (medida com glicosímetro), que equivale a aproximadamente um valor plasmático de 50 mg dL (medida em laboratório). Ainda que a letra A questione a conduta frente a um RN a termo e saudável, não temos informações a respeito de fatores de risco, ficando inviável considerá-la como resposta correta. As demais alternativas, estão claramente incorretas. As letras B e D estão

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

incorretas, pois o valor de corte para RN com sinais ou sintomas clínicos anormais é de 45 mg dL. E por fim, a letra C também está incorreta, pois o valor de corte para RN a termo saudável após 24h de vida é de 45 a 50 mg dL (lembrando que esses valores não são consenso). Por não apresentar resposta correta, a questão foi anulada.

343776.

Comentário: O reflexo vermelho (ou teste do olhinho) é o exame de rastreamento (screening) para anormalidades oculares, desde a córnea até o segmento posterior. Nesse exame, pode ser detectado as opacidades dos meios transparentes do globo ocular. Várias doenças podem ser detectáveis catarata congênita retinopatia da prematuridade retinoblastoma glaucoma congênito descolamento de retina hemorragia vítrea. Segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, o teste deve ser realizado com a seguinte rotina antes da alta da maternidade na primeira consulta de puericultura 2 meses de vida (período ideal para a cirurgia de catarata) com 6, 9 e 12 meses de vida e após 1º ano duas vezes por ano. Resposta letra C.

343789.

Comentário: Um recém-nascido pré-termo tardio que apresenta calcificações intracranianas localizadas em região periventricular tem como principal hipótese diagnóstica citomegalovirose congênita. A maioria dos RN com citomegalovirose congênita é assintomática ao nascimento 10% apresentam manifestações clínicas, dentre as quais se destacam microcefalia, calcificações intracranianas tipicamente periventriculares e coriorretinite. Na toxoplasmose congênita as calcificações intracranianas são difusas. Além disso, encontramos hidrocefalia ou microcefalia, retardo psicomotor e retinocoroidite. Em relação à sífilis congênita, as principais manifestações são as lesões cutâneas, como exantema e pênfigo palmoplantar rinite serossanguinolenta anemia hemolítica com Coombs direto negativo acometimento ósseo (periostite e osteocondrite) e de sistema nervoso central (neurossífilis) lesões condilomatosas e lesões oculares. E, por fim, a rubéola é caracterizada principalmente por alterações cardíacas, oculares e surdez. Resposta letra B.

345492.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

Comentário: Um recém-nascido, filho de mãe com diagnóstico de sífilis no momento do parto, deve receber toda a investigação para a doença. Além do exame físico completo, estão indicados hemograma, VDRL, radiografia de ossos longos e punção lombar. Caso todos os exames sejam negativos, o bebê poderá receber uma dose única de penicilina benzatina intramuscular e continuar acompanhamento regular ambulatorial. Caso qualquer exame venha alterado, o recém-nascido deverá ser tratado por dez dias, com penicilina procaína ou cristalina, a depender do resultado da análise do líquor. Resposta letra D.

283289.

Comentário: A doença da membrana hialina, atualmente chamada de síndrome do desconforto respiratório, é a principal causa de desconforto respiratório precoce em recém-nascidos prematuros, sendo esse o principal fator de risco para a doença a incidência tem relação inversa com a idade gestacional, ou seja, quanto mais prematuro, maior o risco de desenvolvimento (alternativa B incorreta). A doença ocorre pela deficiência de surfactante no interior dos alvéolos, que leva à instabilidade e colapso dos mesmos, com consequente desenvolvimento de atelectasias generalizadas, alterações na relação ventilaçã-perfusão e desenvolvimento de hipoxemia (alternativa C correta). As principais manifestações clínicas são taquipneia, gemência, desconforto respiratório (retração sub e intercostal, retração de fúrcula, batimento de asa nasal), com piora progressiva nas primeiras 48 a 72 horas (alternativa D incorreta). A radiografia de tórax evidencia um padrão reticulogranular difuso, com presença de broncogramas aéreos e redução do volume pulmonar (alternativa A incorreta). O tratamento inclui o suporte respiratório e a administração de surfactante exógeno. Resposta letra C.

283306.

Comentário: Vamos avaliar as alternativas A letra A está errada o risco de transmissão da toxoplasmose quando ocorre no primeiro trimestre de gestação é cerca de 15%, mas as repercussões da doença no feto são graves. O risco se aproxima de 100% se a infecção da genitora ocorre no ÚLTIMO mês da gestação. A letra B está errada aproximadamente 70% das crianças com toxoplasmose são assintomáticas ao nascimento aproximadamente 10% têm

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

manifestação grave nos primeiros dias de vida. Podem apresentar doença multisistêmica ou isoladamente com doença em sistema nervoso e ou forma ocular. A letra C está correta e é o gabarito o quadro pode caracterizar-se por corioretinite, convulsão, micro ou hidrocefalia, calcificações cranianas, icterícia, anemia, hiperproteinaquia, febre, hipotermia, hepatoesplenomegalia, icterícia, vômitos, diarréia, linfoadenomegalia, pneumonite, apneia, taquipneia, diátese hemorrágica, rash, catarata, glaucoma, microftalmia. Menos freqüentemente podem apresentar miocardite, hidropsia fetal, retardo mental. A letra D está errada o tratamento do bebê acometido consiste em sulfadiazina, pirimetamina e ácido folínico e a duração é de 1 ano de tratamento. Associamos o corticosteroide quando há comprometimento do SNC. Resposta Letra C.

283308.

Comentário: São diversas as causas de convulsões no período neonatal distúrbios neurológicos (ex encefalopatia hipóxico-isquêmica), distúrbios metabólicos (ex hipoglicemia e hipocalcemia), infecções congênitas ou do SNC, hemorragias intracranianas, erros inatos do metabolismo (como as aminoacidopatias). Dessas, a causa mais comum é a encefalopatia hipóxico-isquêmica. A enterocolite necrotizante é um quadro de emergência intestinal grave que pode ocorrer no período neonatal, mas não cursa com convulsões. Resposta Letra D.

281148.

Comentário: A banca não liberou o gabarito oficial, portanto o comentário se refere à opinião da equipe MEDGRUPO. Diante de um paciente com sinais de má perfusão periférica, a primeira conduta envolve a administração de expansão volêmica, que nunca deve ser realizada com soro glicosado, mas sim com soro fisiológico (com isso, já descartamos as alternativas A, C e E). E agora, expandir com 10 ou 20 ml kg No período neonatal, a recomendação é de utilizarmos volumes menores, especialmente em um RN com sinais de desconforto respiratório. O desconforto está sendo causado pela DMH, mas ofertas excessivas de volume podem agravar esse quadro. Portanto, nossa tendência já seria considerar a alternativa D incorreta e B correta. Para corroborar, a droga vasoativa citada na alternativa B é uma opção muito mais utilizada no período neonatal, pelo maior número de estudos com essa droga e melhor perfil de efeitos colaterais nesta faixa

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

etária. A adrenalina fica reservada para uso em pacientes refratários a volume, dopamina e dobutamina. Gabarito MEDGRUPO letra B.

283334.

Comentário: A síndrome da rubéola congênita é uma doença disseminada decorre da teratogênese do vírus da rubéola. Pode apresentar anomalias congênitas que incluem alterações cardíacas (ducto arterioso persistente, defeitos do septo interatrial ou interventricular, estenose da artéria pulmonar), restrição de crescimento intrauterino, microcefalia, hipoacusia neurossensorial, catarata congênita, microftalmia e retinopatia. A pancreatite não é uma complicação associada. Resposta letra D.

251921.

Comentário: A questão apresenta três doenças que claramente cursam com colestase atresia das vias biliares (a mais clássica), hipotireoidismo (também bastante cobrada em provas) e hepatite auto-imune (mais rara). A deficiência de glicose-6-fosfato desidrogenase (G6PD) é um defeito enzimático das hemácias que a tornam vulneráveis ao estresse oxidativo desencadeado por desidratação, medicamentos, toxinas e infecção e acarreta sua lise, com consequente anemia e icterícia, ou seja, não causa colestase. No período neonatal, a principal manifestação clínica da condição é a icterícia por hiperbilirrubinemia indireta e hemólise. Resposta letra A.

251931.

Comentário: A hipoglicemia no período neonatal é tema bastante relevante na prática pediátrica e também nos concursos de Residência. Nos grupos de risco, já deve ser realizada triagem por meio de Dextro, a fim de identificar hipoglicemias assintomáticas e corrigi-las precocemente, evitando deterioração clínica (letra D errada). O fatores de risco são prematuridade, diabetes materno, RN com peso inadequado para idade gestacional (grande ou pequeno). Anemia falciforme e hipotireoidismo materno não tem relação com maior risco de hipoglicemia neonatal (letra A errada). Um vez que o paciente é identificado como de risco, devem ser ralizadas medidas de Dextro seriadas e observação clínica dos bebês. O tratamento recomendado é correção da glicemia, que pode ser realizada via oral, preferencialmente via leite materno, se criança está assintomática.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

Caso criança apresente sintomas ou Dextro extremamente baixo (valores não são consensuais) a correção deve ser via parenteral (letra C correta). Não está indicado uso de corticoide para correção da hipoglicemia neonatal na maioria dos casos (letra B errada). Gabarito letra C

217707.

Comentário: Analisando as opções A - errada. A Taquipneia transitória do recém-nascido ocorre em geral em partos a termo ou pré-termo limítrofes, cursando com desconforto respiratório leve, que costuma melhorar com baixas concentrações de oxigênio. B - correta. A Síndrome de aspiração meconial é considerado o mais grave distúrbio respiratório no período neonatal, cursando exatamente com o que se diz na assertiva. C - errada. A Doença da membrana hialina não é um fator predisponente para a Hipertensão pulmonar persistente. D - errada. A relação é inversamente proporcional, e não diretamente proporcional. Resposta letra B.

217655.

Comentário: Vejamos as alternativas A) Incorreta. O teste de avidez da IgG é útil também no início da gestação, pois nos auxilia a reconhecer se a infeção é aguda ou de longa data. Um teste de baixa avidez fala a favor de infecção aguda. B) Incorreta. A tríade clássica é essa descrita, porém, não aparece com muita frequência. Lembre-se de que cerca de 50% dos recém-nascidos afetados são assintomáticos. C) Incorreta. O tratamento deve ser feito com sulfadiazina, pirimetamina e ácido folínico (cuidado para não confundir com acido folíco). A prednisona tem sido utilizada em complemento ao tratamento da toxoplasmose quando há coriorretinite, ou quando a proteína do líquor é 1000 mg dL no nascimento. D) Correta. Se não diagnosticada precocemente, a infecção pode causar danos graves ao feto, assim como manifestações neurológicas na infância tardia e adolescência. Resposta letra D

217675.

Comentário: Sabemos que a icterícia neonatal na grande maioria dos casos pode ser fisiológica. As situações em que devemos pensar que a icterícia seja patológica são as seguintes - Icterícia nas primeiras 24 horas de vida - Nível de bilirrubina subindo a uma taxa superior a 5 mg dL nas 24 horas - Nível de bilirrubina maior do que 12 mg dL em RN a termo ou 10-14 mg dL em prematuros -

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

Icterícia persistente (mais de 8 dias nos RN a termo e mais de 14 dias nos prematuros) - Aumento na bilirrubina direta (acima de 2 mg dL) ou sinais de colestase, como acolia e colúria - Associação com alterações clínicas diversas (hepatoesplenomegalia, palidez, etc). Uma das principais características que devemos pensar que a icterícia seja patológica é o surgimento do quadro nas primeiras 24 horas de vida, devendo investigar as causas de hemólise, prioritariamente. Quadros clínicos brandos (zona I ou II de Kramer) ou que surgem no segundo terceiro dia de vida em RN a termo ou no terceiro quarto dia de vida em prematuros, mesmo na presença de fatores de risco, possivelmente tratam-se de quadros de icterícia fisiológica, não configurando indicação clínica formal de investigação. Resposta letra B.

217686.

Comentário: A polidactilia em humanos é uma característica dominante com penetrância incompleta. Isso quer dizer que nem todos os portadores do alelo para polidactilia terão o fenótipo. O heredograma acima mostra a distribuição do alelo da polidactilia em uma família. O indivíduo II-4 tem fenótipo normal, mas genótipo (heterozigoto) para a condição polidáctilo. Resposta letra A.

182603.

Comentário: O Programa Nacional de Triagem Neonatal, atualmente, prevê o rastreamento de seis doenças fenilcetonúria, hipotireoidismo congênito, doença falciforme e outras hemoglobinopatias, fibrose cística, hiperplasia adrenal congênita e deficiência de biotinidase, sendo que as duas últimas forma incluídas na última etapa do programa (IV fase). De fato, a galactosemia não faz parte das doenças triadas pelo teste, ao mesmo tempo que a toxoplasmose também não. Pela impossibilidade de apresentar duas respostas corretas, a banca optou pela anulação da questão.

182653.

Comentário: Temos um recém-nascido (RN) a termo com exposição vertical ao HIV e sífilis. Com relação a primeira, devemos instituir a zidovudina (AZT) até as primeiras quatro horas de vida, independente do tratamento materno prévio. Para RN acima de 35 semanas, será administrado de 4 mg kg dose de 12 12 horas do AZT que deverá ser mantido até as primeiras quatro semanas de vida ou até a definição diagnóstica. Vale lembrar que a nevirapina também será indicada para filhos

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

de mães que não fizeram uso da terapia antirretroviral durante a gestação, porém o enunciado não informou nenhum tratamento materno prévio. O mesmo ocorreu com relação a sífilis, mas a ausência de informação sobre o tratamento da mãe é um dos critérios para considerá-lo como inadequado. Logo, o RN deverá ser investigado com VDRL no sangue periférico, hemograma, radiografia de ossos longos e avaliação liquórica. Se VDRL positivo, o RN deverá ser tratado com penicilina G cristalina ou procaína por 10 dias. Em caso de alteração liquórica, a penicilina G cristalina é a única opção terapêutica considerável. Apesar do pobre caso clínico e as alternativas com condutas incompletas, a única que apresenta uma conduta adequada para este RN é a letra A. O aleitamento materno é contraindicação absoluta em caso de infecção materna pelo HIV, a profilaxia primária para pneumocistose será iniciada após quatro a seis semanas de vida e a aplicação da BCG não deve ser adiada na vigência de qualquer uma das patologias. Resposta letra A.

183175.

Comentário: Os fatores de risco diminuídos, ou seja, de proteção para a síndrome do desconforto respiratório ou doença da membrana hialina são doença hipertensiva materna, uso materno de heroína, ruptura prolongada das membranas e administração antenatal de corticoide para a mãe. Existem alternativas que não constam nesta lista mas que estão associados a tais fatores, como retardo do crescimento intraútero (que pode estar associado ao uso materno de heroína) e estresse intrauterino (relacionado a doença hipertensiva materna). No entanto, o sexo masculino é o único que representa um fator de risco maior, sendo este a exceção das alternativas listadas. Resposta letra C.

183192.

Comentário: A questão apresenta um quadro típico de sepse neonatal, que trata-se de uma infecção precoce do recém-nascido, manifestada nas primeiras 48 horas de vida, que ocorre por via ascendente ou durante a passagem pelo canal de parto, associado aos agentes mais típicos nesta topografia, como Streptococcus agalactiae , E. coli e outras enterobactérias. Perceba que a mãe apresentou infecção urinária na ocasião do parto, que é um fator de risco associado à infecção.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

Após a suspeita e coleta dos exames, a antibioticoterapia empírica deverá ser instituída, cujo esquema de escolha é ampicilina associada a um aminoglicosídeo, normalmente a gentamicina. Resposta letra D.

183208.

Comentário: Em neonatologia, considera-se como HIPERCAPNIA a presença de uma pCO2 60 mmHg (A e D erradas). A meta de oxigenação dos RN prematuros que apresentam síndrome do desconforto respiratório é manter a pO2 entre 50 e 70 mmHg. Uma oxigenação acima disso é considerada hiperóxia, sendo potencialmente prejudicial, já que o excesso de O2 inalatório pode favorecer o surgimento de displasia broncopulmonar (B correta, C e E erradas). Resposta certa B.

182657.

Comentário: O eritema tóxicos (pápulas eritematosas evanescentes sob a pele), milium sebaceo (micropontos amarelos sob a base do nariz) e mancha mongólica (mancha azul-cinza de contornos bem definidos em região sacral em crianças de origem afro-asiática) são alterações BENIGNAS e sem significado clínico no período neonatal. Entretanto, depressões, tumores ou tufo de cabelo na região sacral podem esconder defeitos de fechamento de medula nervosa. Resposta letra D.

183143.

Comentário: As doenças hemolíticas são a principal causa de ictéricia não-fisiológica no recém-nascido, principalmente quando iniciada nas primeiras 24 horas de vida. A hiperbilirrubinemia ocorre por passagem transplacentária de anticorpos maternos que sensibilizam as hemácias fetais, levando a sua destruição. As etiologias mais comuns são as incompatibilidades ABO e Rh, mas outras doenças hemolíticas também podem ocasionar quadro de icterícia, como as doenças hemolíticas enzimáticas (ex deficiência de G6PD, que é mais comum após 48 a 72 horas de vida) e defeitos na membrana eritrocitária (esferocitose hereditária). Dentre as alternativas, a única que não corresponde a uma causa hemolítica de hiperbilirrubinemia é a síndrome de Gilbert, que se caracteriza por icterícia intermitente na ausência de hemólise ou hepatopatia subjacente. A hiperbilirrubinemia é leve e pode ser desencadeada por fatores externos, como desidratação, jejum, períodos menstruais ou de stress elevado, como uma atividade física rigoroso. O tratamento é de

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

suporte, pois a maioria dos episódios de icterícia tem resolução espontânea. Resposta letra D.

183156.

Comentário: A síndrome da Rubéola Congênita ocorre mais frequentemente quando a grávida adquire a infecção primária ainda no primeiro trimestre de gestação. A maioria dos recém-nascidos infectados são assintomáticos, sendo as principais manifestações clínicas surdez neurossensorial, retardo do crescimento intrauterino e baixo peso, cardiopatias congênitas (persistência do canal arterial e estenose pulmonar), malformações oculares (catarata, glaucoma, retinopatia pigmentar - sal e pimenta e microftalmia), microcefalia, retardo no desenvolvimento, hepatoesplenomegalia, icterícia, púrpura trombocitopênica, lesões ósseas e pneumonite intersticial. Resposta correta letra E.

183173.

Comentário: A Síndrome da Rubéola congênita é caracterizada por uma vasculite disseminada, com acometimento de vários órgãos e sistemas 1) cardiovascular ducto arterioso patente, estenose de artéria pulmonar 2) SNC microcefalia, meningoencefalite crônica e calcificações - consequentemente o paciente pode evoluir com retardo mental) 3) olhos retinite em sal e pimenta, catarata , microftalmia 4) ouvido surdez sensorioneural 5) outros órgãos como fígado, rins e ossos também podem estar comprometidos. Resposta correta letra A.

159076.

Comentário: Apesar do manejo da hipoglicemia neonatal ser um tema bastante controverso na literatura, não deixa dúvidas que este recém-nascido deve ser tratado com infusão de glicose endovenosa. A hipoglicemia neonatal é definida quando o nível glicêmico estiver abaixo de 40 mg dL. Algumas referências permitem que, quando a glicemia estiver entre 25-34 mg dL,o tratamento inicial possa ser realizado somente com alimentação (leite materno), com posterior aferição de glicose em 30-60 minutos. No entanto, em casos sintomáticos ou com valor muito abaixo, o tratamento imediado com bolus de glicose deve ser instituído. Resposta letra C.

159092.

Comentário: O boletim de Apgar é uma medida da vitalidade neonatal, com base em parâmetros

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

clínicos como respiração, frequência cardíaca (FC), tônus muscular, cor e responsividade (irritabilidade reflexa). Cada um desses parâmetros recebe uma pontuação de 0 a 2, o que permite uma nota variável de 0 a 10. O cálculo deve ser realizado obrigatoriamente no primeiro e quinto minutos de vida. Se no 5 minuto o Apgar for menor ou igual a 6, novas pontuações serão calculadas a cada 5º minutos (10º, 15º, 20º, ...), até que se obtenha uma nota maior que 6. Lembrar que este índice não é um bom preditor de prognóstico de sequelas neurológicas, como também não deve ser usado para definir necessidade de reanimação, devendo estar ser indicada somente pela avaliação da FC e respiração. Após a análise das alternativas, a única incorreta é a letra D. Para atingir a nota máxima, é necessário que o recém-nascido apresente-se corado, com respiração regular, FC acima de 100 bpm, movimentos ativos e tosse ou espirro ao ser estimulado, o que não é compatível ao que foi exposto no item. Resposta letra A.

135959.

Comentário: Há alguns anos o termo hiperbilirrubinemia significante era mais usado do que atualmente é. O termo hiperbilirrubinemia significante foi considerado como níveis séricos de BT 17 mg dL , hiperbilirrubinemia grave se BT 25 mg dL e hiperbilirrubinemia extrema quando BT 30 mg dL. Na avaliação da icterícia do RN 35 semanas deve-se considerar os fatores de risco para hiperbilirrubinemia indireta significante relacionados a seguir - Icterícia nas primeiras 24-36 horas de vida - Incompatibilidade materno-fetal Rh (antígeno D Mãe negativo e RN positivo), ABO (mãe O e RN A ou B) ou antígenos irregulares (c, e, E, Kell, outros) - Idade gestacional de 35 e 36 semanas (independentemente do peso ao nascer) - Aleitamento materno exclusivo com dificuldade ou perda de peso 7% em relação ao peso de nascimento - Irmão com icterícia neonatal tratado com fototerapia - Presença de céfalo-hematoma ou equimoses - Descendência asiática - Mãe diabética - Deficiência de glicose-6-fosfato desidrogenase - Bilirrubina total (sérica ou transcutânea) na zona de alto risco (percentil 95) ou intermediária superior (percentis 75 a 95) antes da alta hospitalar. Resposta Letra D.

135964.

Comentário: Na grande maioria das vezes, os sinais e sintomas de hipoglicemia em neonatos são

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

inespecíficos. Os mais frequentes incluem irritabilidade, recusa alimentar, sucção débil, letargia, apneia, hipotonia, hipotermia, crises de cianose, instabilidade vasomotora, dificuldade respiratória, convulsões mioclônicas ou multifocais, e, muito raramente, coma. Muitos neonatos são assintomáticos ou apresentam mínimos sinais e sintomas, o que requer especial atenção, principalmente nos RN de maior risco. Febre alta pode ser sinal de sepse neonatal e sudorese excessiva pode ocorrer em situações de baixo débito sistêmico ou na síndrome de abstinência do recém-nascido. Resposta correta Letra C.

135989.

Comentário: Temos uma criança com uma icterícia após as primeiras 24h de vida, na zona II de Kramer, ou seja, com icterícia acometendo até tronco e umbigo. Isso nos fala a favor de um quadro benigno e não de um quadro como incompatibilidade sanguínea. Podemos estar diante da icterícia do leite materno, e a conduta é apenas continuar estimulando o aleitamento materno em livre demanda. O fato de a bebê dormir muito, também faz parte da rotina de sono de um recém-nascido. Se isso não representa no exame físico um rebaixamento do nível de consciência, não temos com o que nos preocupar. A criança perdeu 7,8% do peso de nascimento até o 7º dia, sendo o limite esperado até 10%, logo, nada fora do esperado, não é mesmo E a criança apresenta ainda mancha mongólica e ectasia de vasos superficiais na cicatriz umbilical, que não representam nenhum quadro patológico. Logo, a resposta correta está na letra A.

108629.

Comentário: O leite materno, por suas inúmeras propriedades, é o melhor alimento para o bebê, seja ele a termo ou não. A escolha da via de administração do leite materno depende da idade gestacional e condições clínicas do recém-nascido. Recém-nascidos com 32-34 semanas de idade gestacional começam a apresentar a adequada coordenação entre sucção, deglutição e respiração, necessárias à amamentação ao seio. Em caso de ausência dessa coordenação, ou de condições clínicas adequadas, optamos pela administração de leite materno ordenhado administrado por sonda orogástrica. Resposta correta letra C .

108770.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

Comentário: As cardiopatias congênitas afetam 1-2 em cada 1.000 nascidos vivos, e cerca de 30% não recebem diagnóstico hospitalar, e vem a evoluir com hipóxia, choque e óbito. Elas representam 10% dos óbitos infantis. Portanto, implementar um teste de triagem das cardiopatias significa tentar reduzir a taxa de mortalidade infantil por esta causa. O teste tem como finalidade identificar precocemente as cardiopatias congênitas críticas, as quais o fluxo pulmonar ou sistêmico é dependente de canal, como a atresia pulmonar, a coarctação grave de aorta e a transposição de grandes vasos. Nos casos de resultado anormal, deve ser realizada nova aferição após 1h. Se o resultado anormal se mantiver, a criança deverá realizar um ecocardiograma dentro das próximas 24h. Resposta letra A .

84456.

Comentário: A avaliação complementar dos RNs com toxoplasmose confirmada ou nascidos de mulheres com toxoplasmose aguda durante a gestação envolve a realização de alguns exames. São eles Sorologia presença de IgM antitoxoplasma ou títulos de IgG 4 (quatro) ou mais vezes maior que os títulos maternos sugerem toxoplasmose congênita. Hemograma pode ser encontrado linfocitose com eosinofilia (até 20%). Essas são alterações mais comuns no hemograma. Pode haver anemia e trombocitopenia. Bioquímica elevação da bilirrubina direta (mas classicamente não está associada à acolia fecal), proteínas totais e albumina são mais baixas que os valores de referência. Exames de imagem podem evidenciar dilatação ventricular e calcificações cerebrais. Fundoscopia permite avaliação da retinite. Avaliação liquórica mesmo nos pacientes assintomáticos podem ser demonstradas alterações em cerca de 35% dos casos. O LCR terá aspecto xantocrômico, com pleocitose, elevados valores de proteínas e baixos níveis de glicose. Resposta letra A.

66941.

Comentário: Temos aqui um bebê de seis meses, que não realizou teste do pezinho, com um atraso no desenvolvimento motor, além de mixedema, pele seca, obstipação e déficit de crescimento, notados desde os 2 meses de vida. Por isso, o teste do pezinho é tão importante o hipotireoidismo congênito, (sem dúvida, a principal hipótese descrita pelo enunciado) em geral, é

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

assintomático ao nascimento, e as alterações se manifestam nos primeiros meses de vida, podendo resultar em sequelas graves. São sinais que sugerem a doença atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, diminuição no ritmo do crescimento, palidez, bradicardia, mixedema, persistência de fontanela posterior, choro rouco, extremidades frias, hérnia umbilical, icterícia prolongada, macroglossia e sucção débil. Não há duvidas, portanto, de que o gabarito está correto. Resposta letra D.

66985.

Comentário: Questão clássica e objetiva. Guarde isso malformação de parede abdominal sem membrana recobrindo o conteúdo exteriorizado gastrosquise. A gastrosquise é uma fenda que envolve toda a espessura da parede abdominal sem envolver o cordão umbilical. Invariavelmente, o defeito é localizado no lado direito do cordão umbilical. Alças intestinais e outros órgãos abdominais podem protruir através desta abertura, sem apresentar membrana peritoneal recobrindo o conteúdo exteriorizado, o que a diferencia da onfalocele. A gastrosquise pode ser diagnosticada por meio da ultrassonografia a partir da 12ª semana de gestação. Deve ser diferenciada da onfalocele, uma vez que esta última apresenta uma associação mais frequente com anomalias cromossômicas e outras malformações, o que modifica a conduta e aconselhamento pré-natal em cada caso. Resposta correta letra A.

341080.

Comentário: O teste do olhinho, ou teste do reflexo vermelho, faz parte do programa de detecção e intervenção precoce para a prevenção de deficiências visuais, do Ministério da Saúde. A resposta normal ao teste é a presença de reflexo vermelho brilhante (em tons de vermelho, laranja ou amarelo) quando a luz incide sobre a pupila, bilateralmente, implicando que as principais estruturas internas do olho estão transparentes, permitindo que a retina seja atingida de forma normal. Assim, um reflexo vermelho bilateral é o resultado normal esperado e a família deve ser tranquilizada. Resposta letra A.

341081.

Comentário: O teste do olhinho, ou teste do reflexo vermelho, faz parte do programa de detecção e

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

intervenção precoce para a prevenção de deficiências visuais, do Ministério da Saúde. A resposta normal ao teste é a presença de reflexo vermelho brilhante (pode apresentar-se em tons de vermelho, laranja ou amarelo) quando a luz incide sobre a pupila, bilateralmente, implicando que as principais estruturas internas do olho (córnea, câmara anterior, íris, pupila, cristalino, humor vítreo e retina) estão transparentes, permitindo que a retina seja atingida de forma normal. Qualquer alteração que impeça a passagem da luz irá promover alteração do reflexo. Um recém-nascido que apresente um reflexo ausente ou duvidoso em qualquer olho deverá ser encaminhado ao oftalmologista, para exame oftalmológico completo. Resposta letra D.

341082.

Comentário: O Teste da Orelhinha, ou exame de emissões otoacústicas evocadas , consiste na produção de um estímulo sonoro e na captação do seu retorno por meio de uma sonda introduzida na orelha do RN. É um teste de triagem auditiva capaz de identificar alterações no sistema auditivo pré-neural. O teste é um direito assegurado por lei e deve ser realizado para todos os RN, de preferência ainda no hospital, a partir de 48 horas de vida. Testes realizados antes de 48 horas de vida tem alta chance de falso positivo, devido à presença do vérnix caseoso. Na impossibilidade de realizar o teste antes da alta da maternidade, o teste deverá ser realizado até 28 dias de vida, em serviço ambulatorial. Resposta letra A.

313442.

Comentário: As calcificações abdominais são achados comuns nos estudos convencionais do abdome, e sua localização e padrões são importantes para a correta interpretação e diagnóstico. A causa mais comum é a peritonite meconial, resultado de peritonite asséptica secundária à perfuração intestinal pré-natal. A causa da perfuração antenatal pode ser íleo meconial, atresia ileal ou qualquer outra patologia que cause obstrução intestinal distal em um neonato. Sendo assim, dentre as condições listadas, a única que não cursa com calcificação abdominal é a imaturidade funcional do cólon. Resposta letra B.

307063.

Comentário: Diante de um recém-nascido com um quadro de icterícia que vem aumentando

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

progressivamente associado a acolia fecal e colúria, temos que pensar obrigatoriamente em icterícia colestática. No período neonatal, duas doenças que podem causar esse quadro são a atresia de vias biliares e a hepatite neonatal. A presença de acolia fecal persistente sugere obstrução biliar (atresia), mas a acolia também pode ocorrer na hepatite neonatal. De qualquer forma, antes de estabelecer um diagnóstico definitivo, uma investigação complementar deve ser realizada, por isso só podemos afirmar que estamos diante de uma coletas neonatal. Icterícia do leite materno e icterícia fisiológica não causam acolia e colúria. Resposta letra C.

307064.

Comentário: A presença de icterícia em um lactente de 20 dias de vida é uma situação preocupante. É claro que presença de icterícia é bastante comum nos primeiros dias de vida e, na maioria das vezes, vai refletir apenas um quadro apenas fisiológico. No entanto, diante de qualquer recém-nascido com um quadro de icterícia que persiste por mais do que 2 semanas, é obrigatória a dosagem de bilirrubina total e frações. Uma das razões disso é a identificação dos quadros de colestase neonatal, caracterizados pelo aumento da bilirrubina direta. Dentre as opções de conduta apresentadas pela banca, a mais importante seria o encaminhamento para um especialista, visto que banho de sol, administração de interferon alfa e a suspensão no leite materno não tem nenhuma relação com melhora do quadro clínico desses pacientes. Sabemos que uma das principais causas de colestase no período neonatal é a atresia das vias biliares, que deve ser rapidamente diagnosticada para que o procedimento cirúrgico (cirurgia de Kasai) seja realizado ainda nas primeiras 8 semanas de vida. Resposta letra D.

307065.

Comentário: Estamos diante de um recém-nascido a termo com um quadro clássico de colestase neonatal, uma vez que temos uma icterícia persistente associada a acolia fecal e colúria. Nesse contexto, lembre-se de duas doenças importantes no período neonatal que causam icterícia colestática atresia de vias biliares e a hepatite neonatal (assertivas III e IV corretas). A icterícia fisiológica tem início entre o 2 e 4 dia, cursa com predomínio de bilirrubina indireta e não cursa com sinais de doença no exame físico (I incorreta). A polêmica está na assertiva II, pois não

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

encontramos em nenhuma referência de pediatria que o hiperesplenismo é uma causa possível de hiperbilirrubinemia direta. Dessa forma, só podemos afirmar que as assertivas III e IV estão corretas, mas a banca também considerou o item II correto. Resposta letra D.

307080.

Comentário: Agora em relação à epidemiologia da sífilis congênita no Brasil, vamos procurar a alternativa correta A letra A está correta a OMS estima que a ocorrência de sífilis complique um milhão de gestações por ano em todo o mundo, levando a mais de 300 mil mortes fetais e neonatais e colocando em risco de morte prematura mais de 200 mil crianças. No Brasil, nos últimos cinco anos, foi observado um aumento constante no número de casos de sífilis em gestantes, sífilis congênita e sífilis adquirida. A letra B está incorreta como vimos, houve aumento de sífilis pediátrica e nos adultos. A letra C está incorreta na verdade, nos últimos 10 anos houve aumento no coeficiente de mortalidade infantil por sífilis que passou de 2,2 por 100 mil nascidos vivos em 2009, para 5,9 por 100 mil nascidos vivos em 2019. A letra D está incorreta houve aumento dos casos de sífilis, provavelmente devido à elevação nos números de testagem, decorrente da disseminação dos testes rápidos, mas também à diminuição do uso de preservativos, à redução na administração da penicilina na Atenção Básica e ao desabastecimento mundial de penicilina. Resposta letra A.

278621.

Comentário: QUestão extremamente difícil sobre a fisiopatologia da encefalopatia hipóxico-isquêmica A letra A está errada o cálcio aumentado no meio intracelular promove ativação de proteases que convertem xantina-desidrogenase em xantina-oxidase, gerando radicais livres. O acúmulo do cálcio citosólico é o principal fator entre as múltiplas lesões e a cascata de eventos irreversíveis que causam a morte celular induzida pela hipóxia-isquemia e reperfusão. A letra B está errada o cálcio aumentado no meio intracelular também promove ativação da fosfolipase A2, causando maior geração de radicais livres pelas vias da cicloxigenase e lipoxigenase. O aumento do íon cálcio no meio intracelular ativa a liberação de neurotransmissores excitatórios, como o glutamato e o aspartato, que têm suas ações mediadas principalmente pelo receptor NMDA (N

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

metil D aspartato). O receptor NMDA é responsável, ainda, pela maior permeabilidade celular ao cálcio é um mecanismo de retroalimentação. A letra C está correta NMDA e AMPA são receptores gliais específicos que determinam a entrada de cálcio no compartimento intracelular, com ativação de enzimas como protease e fosfolipase. A leta D está errada como vimos, o aumento do íon cálcio no meio intracelular que ativa a liberação de neurotransmissores excitatórios, como o glutamato e o aspartato. Resposta letra C.

278622.

Comentário: As principais referências citam como fatores clínicos indicativos de pior prognóstico uma encefalopatia grave e a presença de convulsões de início precoce e ou de duração prolongada. Sabemos que a presença de hipertensão intracraniana indica a presença de lesão ativa, por isso também está associada a piores desfechos. Já em relação aos exames complementares, a presença de anormalidades na parte posterior da cápsula interna, nos gânglios da base ou no tálamo na ressonância magnética também são associados a resultados neurológicos insatisfatórios e morte. Por fim, um eletroencefalograma persistentemente anormal é preditivo de resultados adversos. As sequelas neurológicas permanentes podem ser leves, como dificuldades específicas de aprendizagem ou distúrbio de déficit de atenção, ou podem ser graves e incapacitantes, como paralisia cerebral, epilepsia, deficiência visual e distúrbios cognitivos graves. A poliúria não é um indicador de mau prognóstico. Resposta letra C.

275993.

Comentário: Os parâmetros que indicam a necessidade de reanimação são presença de hipotonia e ausência de respiração choro. Ao constatarmos uma dessas alterações, devemos realizar o clampeamento imediato do cordão umbilical e levar o RN para o berço, a fim de proceder aos passos iniciais, que consistem em aquecer, posicionar a cabeça em leve extensão, aspirar boca e narinas se necessário e secar (alternativa A correta). Após essas medidas, iremos avaliar 2 parâmetros frequência cardíaca e respiração. Se a FC for 100 bpm, houver apneia ou gasping, devemos iniciar a ventilação com pressão positiva. Em RN nascidos com menos de 34 semanas, a FiO2 inicial será de 30% (alternativa B incorreta), enquanto naqueles nascidos com 34 semanas, a

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

ventilação inicial será feita em ar ambiente, durante 30 segundos. O próximo passo na reanimação, caso FC ou respiração permaneçam alterados, é checar a técnica da ventilação (posição da cabeça, perviedade das vias aéreas, posição da máscara, pressão do ambu) (alternativa C correta). Se após mais 30 segundos de VPP com técnica adequada ainda houver necessidade de reanimação, devemos proceder a intubação traqueal. A massagem cardíaca estará indicada caso a FC fique 60 bpm apesar das ventilações adequadas por meio da cânula traqueal com FiO2 a 100% (alternativa D correta). Se mesmo após 1 minuto de massagem cardíaca a FC permanecer 60, está indicada a administração de adrenalina intravenosa na dose de 0,01 a 0,03 mg kg (alternativa E correta). Resposta letra B.

279050.

Comentário: Diversas alterações anatômicas e funcionais observadas nos primeiros meses de vida do bebe podem causar sintomas gastrointestinais que, muitas vezes, têm repercussões negativas para o recém-nascido e sua família. Regurgitações, vômitos, cólica e constipação intestinal são manifestações frequentes no período neonatal e, na maioria das vezes, irá refletir apenas uma imaturidade funcional do cólon. A presença de calcificações não é comum e pode indicar várias patologias, como íleo meconial, atresia jejunal ou ileal, anomalia anorretal com fístula, mas não um mecanismo fisiológico. Resposta letra D.

278631.

Comentário: A hipotermia terapêutica é a principal medida de neuroproteção utilizada no tratamento da encefalopatia neonatal. Está indicada nos RNs com IG 35 semanas, com peso de nascimento 1800 g, que tenham menos que 6 horas de vida e que preencham um dos seguintes critérios 1) Gasometria arterial de sangue do cordão ou do paciente na primeira hora de vida com pH 7,0 2) História de evento agudo perinatal (descolamento de placenta, prolapso de cordão) 3) APgar 5 ou menos no décimo minuto de vida 4) Necessidade de ventilação mecânica além do décimo minuto de vida. O resfriamento corporal total deve ser iniciado antes da sexta hora de vida e mantido por até 72 horas, com objetivo de manter temperatura central entre 33 e 34ºC (esta faixa pode variar um pouco, mas a maioria das referências traz o alvo de 33,5 ou - 0,5 C). Resposta letra D.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

279051.

Comentário: Mais de 85% dos casos de enterocolite necrotizante (EN) ocorrem em recém-nascidos prematuros, sendo o maior fator de risco associado à patologia. No entanto, perceba que a questão solicita uma causa de EN em RN termo. Logo, sabemos que os eventos hipóxico isquêmicos representam um mecanismo etiológico para necrose isquêmica e inflamatória do intestino. Desta forma, as cardiopatias congênitas cianóticas ganham destaque, em função da instabilidade hemodinâmica e das baixas taxas de saturação de oxigênio, ocasionando hipóxia tecidual. Sendo assim, as cardiopatias congênitas representam fatores de risco para EN. Resposta letra A.

278636.

Comentário: Bem direta o principal fator de risco para o desenvolvimento da enterocolite necrotizante é a prematuridade, havendo uma relação inversa entre idade gestacional e a incidência da doença - quanto mais prematuro for o RN, maior a chance de a doença ocorrer. O baixo peso ao nascer também é um fator de risco importante. Outros fatores de risco incluem exposição prolongada a antibióticos, alimentação artificial, uso de agentes hiperosmolares, asfixia neonatal, cateterização umbilical, policitemia, uso de indometacina e metilxantinas. Resposta letra D.

278644.

Comentário: As hérnias diafragmáticas congênitas são caracterizadas por uma descontinuidade de desenvolvimento do diafragma que permite que as vísceras abdominais herniem para o tórax. Aproximadamente 95% dos defeitos são posterolaterais, conhecido como hérnia de Bochdalek (alternativa A correta e D incorreta). A hérnia de Morgagni é caracterizada por defeito anterior periesternal (alternativa B incorreta). As HDC localizam-se à esquerda em 80-85% dos casos, à direita em 10-15% e bilateral em menos de 2% dos casos. Não existe uma hérnia com epônimo de Stoppa - o que existe é a técnica de Stoppa, que consiste no reparo cirúrgico aberto de hérnias ventrais. Resposta letra A.

231344.

Comentário: Toda a icterícia tem tem início antes de 24 horas deve ser considerada patológica e,

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

por isso, investigada. O enunciado já nos adianta que existe uma incompatibilidade entre o sistema ABO materno e neonatal, ou seja, mãe O (auto-anticorpos anti-A e anti-B naturais) e neonato B (possui o antígeno B na superfície de suas hemácias, que podem ser agredidas ou marcadas para lise pelos auto-anticorpos anti-A maternos). Logo, a principal hipótese para a icterícia precoce é a doença hemolítica perinatal pela incompatibilidade ABO. Para dar seguimento ao caso, serão necessários exames complementares, como hemograma completo, contagem de reticulócitos e dosagem de bilirrubina total e frações. As dosagens seriadas de bilirrubina e hematócrito serão necessárias para se acompanhar a progressão da doença e necessidade de fototerapia ou exsanguineotransfusão. Resposta letra C.

231349.

Comentário: A ventilação pulmonar é o procedimento mais importante e efetivo na reanimação do RN em sala de parto. A VPP está indicada na presença de apneia, respiração irregular ou gasping e ou FC 100 bpm, após os passos iniciais da reanimação. A presença de hérnia diafragmática não somente não tem indicação de VPP como é uma contraindicação para tal. Resposta letra D.

231351.

Comentário: Estamos diante de um recém-nascido com um desconforto respiratório iniciado logo nas primeiras horas de vida. A hipótese diagnóstica mais provável, dentre as várias possíveis, deve ser estabelecida com base na identificação de fatores de risco, no aspecto radiográfico e na evolução clínica. A doença da membrana hialina é uma condição típica de recém-nascidos prematuros e, por isso, não é um diagnóstico provável em uma criança de 39 semanas. A sepse neonatal pneumonia sempre deve ser considerada diante da presença de desconforto respiratório, porém, não há o relato de qualquer fator de risco que aponte para esta condição, como um tempo de bolsa rota prolongado. A síndrome de aspiração meconial costuma ter evolução grave e não tem o aspecto radiográfico descrito. Por mais que houvesse o relato de líquido amniótico meconial, não houve relato de sofrimento fetal e a criança nasceu com boas condições de vitalidade, como indicado pelo Apgar. Hipertensão pulmonar persistente cursa com a clássica labilidade ao manuseio. Resta-nos a possibilidade de taquipneia transitória e, de fato, esta condição representa o

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

melhor diagnóstico. A condição caracteriza-se por um retardo na absorção de líquido pulmonar e o grande fator de risco é o nascimento por uma cesárea eletiva. A radiografia irá revelar, tipicamente, congestão hilar, aumento da trama vascular, derrame pleural e cardiomegalia, além de hiperinsuflação. O tratamento consiste em oxigenoterapia e suporte geral. Resposta letra C.

249289.

Comentário: Questão direta aqui O objetivo do acompanhamento ambulatorial do prematuro é a chance de detecção de possíveis desvios do crescimento normal, principalmente quanto ao peso, comprimento e perímetro cefálico. Além disso, muito importante também - apesar de não citado na questão, é o acompanhamento do desenvolvimento neuropsicomotor deste bebê. Resposta letra C.

249205.

Comentário: Questão muito mal feita. pois não fala sobre a composição da composição que será oferecida. Segundo o Ministério da Saúde, estes minerais constituintes dos ossos e cartilagens são transferidos para o feto em grande quantidade e de forma facilitada pela placenta no 3º trimestre da gestação. Diante da necessidade de suplementação de cálcio e fósforo, apesar de não haver sido realizado nenhum estudo randomizado justificando a conduta, tradicionalmente tem-se utilizado suspensão de fosfato tribásico de cálcio preparada em farmácia, com a seguinte formulação Fosfato tribásico de cálcio 3,19g. Água (qsp) 100mL. Essa formulação contém 13mg de cálcio e 6mg de fósforo por mL, com proporção Ca P aproximada de 2 1, o que permite adequada absorção. A suplementação pode ser administrada de duas a quatro vezes por dia, no intervalo das mamadas, na dose de 2mL kg dia. Questão que caberia um recurso, mas o gabarito divulgado foi a letra D. Resposta letra D.

249212.

Comentário: Causas frequentes de icterícia neonatal (período que vai até 27 dias completos pós-nascimento) são a icterícia fisiológica, icterícia do leite materno e a deficiência de G6PD. Logo, letras B, C e D já estão excluídas Na anemia falciforme as manifestações clínicas geralmente são iniciadas após o 6º mês de vida, quando começam a diminuir os níveis de Hb Fetal (HbF). As crises encontradas são vasoclusiva, sequestro, hemolítica e aplástica. A crise hemolítica se apresenta

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

com anemia e icterícia acentuadas, geralmente associada à infecção, com diminuição de Hb, reticulocitose e aumento de bilirrubina indireta. Resposta letra A.

249215.

Comentário: Vamos aproveitar a questão para revisar os termos mostrado Letra A A polidactilia é um termo médico utilizado para descrever dedos extras nas mãos e ou dedos a mais nos pés. INCORRETA Letra B Joelho valgo, ou geno valgo, é quando os joelhos estão desalinhados, voltados para dentro, encostando um no outro. Essa alteração pode ser notada à partir do 8 anos de idade, porque até esta fase o mais comum é que as pernas estejam arqueadas para fora. INCORRETA Letra C A sindactilia é uma malformação embriológica extremamente rara que acomete os dedos. Ela consiste na fusão entre dois ou mais dedos das mãos ou dos pés, podendo ocorrer tanto em partes moles (sindactilia cutânea) quanto em ossos (sinostose). CORRETA Letra D O dedo em garra (ou pés em garra) é uma flexão de uma ou duas articulações do segundo, terceiro, quarto ou quinto dedo do pé. INCORRETA Resposta letra C.

201775.

Comentário: A hérnia diafragmática congênita é uma condição que é mandatória a intubação endotraqueal na sala de parto, antes mesmo das medidas de reanimação. Deve ser realizado tal procedimento para garantir que o ar fornecido vá exclusivamente para os pulmões, pois se este paciente for submetido a ventilação com pressão positiva, pode ocorrer o aumento das vísceras abdominais que se encontram dentro da caixa torácica e, consequentemente, evoluirá com piora da insuficiência respiratória. Resposta letra D.

201783.

Comentário: De acordo com as Diretrizes da Sociedade Brasileira de Pediatria de Reanimação neonatal atualizadas em 2016, temos o seguinte considerando-se a frequência de RN que precisam de algum procedimento de reanimação e a rapidez com que tais manobras devem ser iniciadas, é fundamental que pelo menos um profissional de saúde capaz de realizar os passos iniciais e a ventilação com pressão positiva por meio de máscara facial esteja presente em todo parto. A única responsabilidade desse profissional deve ser o atendimento ao RN . Isso significa que em cada

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

parto deverá ter profissional capacitado para fazer a VPP. Uma crítica para essa questão é que a alternativa B está mal redigida, dando a entender de que todos os nascimentos exigem tal conduta. De todo modo, até por exclusão daria para acertar a questão o atendimento médico em sala de parto deve ser presencial e não à distância (letra A incorreta) o profissional de saúde deverá ser capacitado para iniciar as manobras de reanimação e fazer a VPP, não podendo haver atraso nas manobras, nem para chamar um médico, já que temos o Golden minute que deverá ser obedecido (letra C incorreta) o profissional que irá atender o RN em sala de parto deverá ser exclusivamente dedicado ao atendimento do mesmo, não podendo ser o obstetra (letra D incorreta) os procedimentos invasivos são de atribuição médica (letra E incorreta). Resposta letra B.

215524.

Comentário: Questão bastante simples Todas representam patologias frequentes no período neonatal, com exceção da pneumonia lobar. Quanto presente, as pneumonias neonatais tendem a ser mais difusas do que apresentar um padrão localizatório, como o esperado numa pneumonia lobar. Resposta letra C.

219860.

Comentário: A teste da orelhinha consiste no exame de emissões otoacústicas evocadas e a triagem deve contemplar todos os recém-nascidos. O teste do pezinho é importante para o diagnóstico precoce de algumas condições potencialmente danosas, porém a tirosinemia não faz parte do teste oferecido pelo Ministério da Saúde. O teste do coraçãozinho ou da oximetria deve ser feito entre 24 a 48h de vida, para o diagnóstico de cardiopatias congênitas críticas. O reflexo vermelho é o exame de rastreamento para anormalidades oculares, desde a córnea até o segmento posterior. Nesse exame, pode ser detectado as opacidades dos meios transparentes do globo ocular, e não da retina. Resposta letra A.

212163.

Comentário: Vamos analisar as alternativas A) CORRETA No que se refere a toxoplasmose congênita, cerca de 70% das crianças acometidas são assintomáticas ao nascimento. No entanto, têm elevadas frequências de prematuridade, retardo do crescimento intrauterino, anormalidades

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

liquóricas e cicatrizes de coriorretinite. Aproximadamente 10% têm manifestação grave nos primeiros dias de vida. B) ERRADA O diagnóstico de toxoplasmose aguda ou congênita pode ser comprovado por meio de testes sorológicos. A detecçãode IgM denota a produção do feto infectado, mas pode não estar presente ao nascimento, o que não permite afirmar que a sua negatividade denota ausência de infecção. C) ERRADA Ficar atento as questões oculares e, para tal, realizar o teste da orelhinha é algo bastante complicado. Fechando os olhos para essa aberração escrita na alternativa, o teste da orelhinha é feito com as emissões otoacústicas. No entanto, a audiometria é o exame de eleição para detecção de lesões auditivas. D) ERRADA Além dos exames sorológicos, outros exames também são importantes. Um exemplo são os exames de imagem, que podem detectar envolvimento do sistema nervoso central, o que corroboraria com o diagnóstico. E) ERRADA A forma subclínica é a mais comum, com história materna, sorologia positiva no recém-nascido, alterações leves do liquor e, posteriormente, surgimento de sequelas oculares e neurológicas. Resposta letra A.

187778.

Comentário: Estamos diante de um recém-nascido que apresenta vários fatores de risco para sepse neonatal, tais como ruptura prolongada das membranas amnióticas (18 horas de bolsa rota), trabalho de parto prematuro (antes de 37 semanas) e alterações clínicas (dificuldade respiratória moderada - Silverman-Anderson 4). Nesse contexto, devemos sempre realizar rastreio infeccioso completo e iniciar antibioticoterapia empírica de amplo espectro, em geral, com ampicilina gentamicina. Resposta correta letra B.

182736.

Comentário: Em prematuros, faz-se necessário adotar uma estratégia ventilatória que vise à otimização do volume pulmonar, evitando tanto a atelectasia como a hiperinsuflação, tolerando hipercapnia moderada e mantendo os valores de oxigenação arterial dentro de limites restritos, além de adotar uma atitude agressiva para reduzir o suporte ventilatório, tendo sempre em mente a extubação traqueal. Logo, vamos avaliar as alternativas A) ERRADA Níveis mais elevados de PaCO 2 vêm sendo tolerados, permitindo uma ventilação mais gentil, no intuito de minimizar a

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

lesão pulmonar induzida por parâmetros altos do respirador. Apesar de mais estudos serem necessários, a tendência atual é aceitar uma PaCO 2 moderadamente alta, entre 45-65 mmHg. B) ERRADA A hiperóxia no período neonatal pode ser tão deletéria quanto a hipóxia. O oxigênio apresenta efeitos deletérios como toxicidade pulmonar, aumentando o líquido no interstício, seguida de fibrose e metaplasia do epitélio bronquial. Portanto, a oferta de oxigênio deve ser limitada ao mínimo necessário para manter a PaO 2 entre 50-70 mmHg e a saturação no oxímetro de pulso entre 90-94%. C) ERRADA A PEEP deve ser adequada para cada tipo de doença. Recém-nascidos com DMH requerem PEEP entre 4-6 cmH 2 O, porém, o uso de PEEP superior a 4 cmH 2 O deve ser evitado em neonatos que apresentam shunt direita-esquerda, hipotensão arterial, baixa complacência pulmonar, hipoventilação com PaCO 2 elevada e nos prematuros abaixo de 1.000 g. D) CORRETA Um dos fatores mais importantes durante a ventilação mecânica é usar um volume corrente reduzido. Em prematuros com doença pulmonar, a CRF está diminuída, e algumas áreas do pulmão, colapsadas. Um volume corrente ideal seria aquele que conseguisse abrir estas áreas colapsadas sem causar volutrauma. Atualmente, a opção é pelo emprego de volumes correntes em torno de 4-6 ml kg, particularmente em prematuros extremos. Resposta letra D.

187789.

Comentário: Sobre os distúrbios metabólicos no período neonatal A- Incorreta. Sinais e sintomas ocorrem raramente, a menos que o Ca sérico total seja 7 mg dl (1,75 mmol l) ou Ca ionizado 3 mg dl (0,75 mmol l). Os sinais incluem hipotonia, taquicardia, taquipneia, apneia, deficiência alimentar, nervosismo, tetania e convulsões. B- Incorreta. São fatores de risco para hipocalcemia precoce prematuridade, ser pequeno para a idade gestacional, diabetes materno e asfixia perinatal. C- Correta. Sintomas como hipotonia, taquicardia, apneia, dificuldade alimentar e convulsões podem representar diversos distúrbios metabólicos, como a hipoglicemia e a hipocalcemia. D- Incorreta. Em relação aos filhos de mãe diabética, o rastreio se estende, via de regra, para 24 a 48 horas, a não ser que haja alterações nas avaliações metabólicas iniciais. Resposta letra C.

182751.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

Comentário: Vamos avaliar as alternativas A) ERRADA Em relação à faixa etária pediátrica, o predomínio da transmissão do vírus HIV se dá pela via vertical. B) CORRETA Na faixa etária abaixo de 5 anos, considera-se a transmissão vertical responsável por praticamente 100% dos casos de aids. C) ERRADA Excetuando a via vertical, as principais vias de transmissão horizontal do HIV são sexual, sanguínea ou ocupacional. O simples convívio social não é causa de transmissão do vírus HIV. D) ERRADA Sem tratamento, as gestantes infectadas pelo HIV transmitem a infecção para seus filhos em 25 a 30% dos casos. Resposta letra B.

187803.

Comentário: Questão difícil, mas vamos raciocinar da seguinte forma A icterícia pode ser o primeiro sinal de disfunção hepática. Outras manifestações clínicas podem estar presentes, como colúria (urina escura), acolia fecal (fezes descoradas) e hepatomegalia. Esses sinais contribuem para a identificação de colestase, porém oferecem poucos indícios para definição da etiologia, fazendo-se ncessários exames complementares que auxiliem na diferenciação da patologia de base. Entre as causas, as mais prevalentes são a atresia de vias biliares e a hepatite neonatal. A atresia biliar é definida como ausência ou obliteração dos ductos biliares extra-hepáticos, sendo a principal indicação de transplante hepático em crianças. Os recém-nascidos desenvolvem icterícia progressiva nas primeiras 8 semanas de vida e podem apresentar acolia fecal, entretanto, muitas vezes no início do quadro apresentam bom estado geral e adequado ganho de peso. A colúria é um sinal frequente, porém pode não ser facilmente identificado, em consequência do débito urinário aumentado nessa faixa etária, diluindo o material biliar. Já a coloração das fezes é um elemento importante no diagnóstico, pois diante da obstrução total, não deverá conter pigmentos que possam torná-la amarelada ou esverdeada. Além disso, outras condições não obstrutivas podem gerar um quadro de colúria, enquanto que a acolia persistente é um sinal específico de obstrução. Resposta correta letra D.

182816.

Comentário: Os testes não treponêmicos tornam-se positivos duas semanas após o desaparecimento do cancro duro. Os títulos sofrem redução espontânea com o passar do tempo.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

Após o tratamento adequado tendem a negativar em seis a 12 meses, podendo permanecer baixo por toda a vida. Fenômeno esse que se chama cicatriz sorológica . Os testes treponêmicos positivam em torno de 15 dias após o contágio, podendo assim permancer pelo resto da vida. São consideradas gestantes inadequadamente tratadas e, portanto fetos portadores de sífilis congênita, os seguintes casos de sífilis diagnosticada durante a gestação -Gestantes que utilizaram o esquema penicilínico em dose não compatível com a fase da doença -Se o tratamento penicilínico não foi finalizado 30 dias antes do parto -Se não ocorreu tratamento concomitante do parceiro, mesmo que este apresente teste não treponêmico negativo -Se não apresentar documentado todas as doses do tratamento. Resposta letra C.

152631.

Comentário: Questão simples. O tratamento da sífilis congênita é sempre com penicilina. Como não há descrição de alterações liquóricas, podemos usar tanto a penicilina procaína quanto a cristalina. Importante lembrar também que o tratamento da gestante com sífilis também é com penicilina. As alérgicas devem ser dessensibilizadas. Na impossibilidade, usa-se eritromicina, porém essa gestante não é considerada adequadamente tratada. Resposta letra A.

152640.

Comentário: O ponto crítico para o sucesso da reanimação neonatal é a ventilação pulmonar adequada. A ventilação pulmonar é o procedimento mais simples, importante e efetivo na reanimação do RN em sala de parto. Assim, após os cuidados para manter a temperatura e a permeabilidade das vias aéreas do RN, a presença de apneia, respiração irregular e ou FC 100 bpm indica a VPP. Esta precisa ser iniciada nos primeiros 60 segundos de vida (The Golden Minute). Somente depois disso é que avaliaremos a necessidade de O2 suplementar, intubação orotraqueal, massagem cardíaca e uso de drogas na sala de parto. Resposta correta Letra A .

152645.

Comentário: Segundo o documento científico do Programa de Reanimação Neonatal da Sociedade Brasileira de Pediatria, a presença de apneia, respiração irregular e ou FC 100 bpm indica a VPP (ventilação com pressão positiva). Ela deve ser iniciada nos primeiros 60 segundos de vida. Existe

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

uma contraindicação importante do uso da VPP, que impõe a necessidade do uso de ventilação através cânula traqueal em sala de parto, que é a presença da hérnia diafragmática. Outras indicações de cânula traqueal são ventilação com máscara facial não efetiva ou prolongada, necessidade de de massagem cardíaca e ou de adrenalina. Resposta letra D .

152630.

Comentário: Quando estamos diante de uma criança que apresenta dismorfimos em face como fenda palpebral estreita, filtro nasal hipoplásico, lábio superior afilado e retrognatia, devemos sempre pensar na Síndrome alcoólica fetal, termo genérico que engloba uma gama de características físicas, mentais, comportamentais e cognitivas, secundárias à exposição intrauterina ao álcool. Trata-se de uma doença congênita completamente passível de prevenção, mas que infelizmente acomete 1 a cada 1000 nascidos vivos. Além das alterações fenotípicas relatadas, o paciente evoluirá com baixo desenvolvimento ponderoestatural, alterações estruturais do sistema nervoso central como redução do volume encefálico (além de microcefalia), hipoplasia de corpo caloso e funcionamento anormal das amígdalas. Resposta letra A.

158776.

Comentário: Quando a gestante adquire a infecção primária pelo vírus da rubéola ocorre a infecção da placenta durante a fase de viremia, tenham esta gestante sintomas ou não. Sabemos que a idade gestacional é, de fato, o principal determinante da gravidade da doença e do risco de transmissão ao feto. O risco de transmissão é alto no primeiro trimestre, diminui no segundo e volta a aumentar nas últimas semanas de gestação...O grande temor é essa alta taxa de transmissão do primeiro trimestre, período da organogênese, determinando inúmeras mal formações Após as 16 semanas não são comuns as mal formações, ainda que ocorra a infecção fetal. Resposta certa A

131340.

Comentário: Os fatores de risco maiores para o desenvolvimento de hiperbilirrubinemia grave em recém-nascidos com 35 semanas ou mais são Níveis de bilirrubina na zona de alto risco (Bilirrubina maior que 5mg dl nas primeiras 24h de vida), Incompatibilidade ABO, Rh com coombs direto positivo ou outra doença hemolítica, idade gestacional de 35-36 semanas, história de irmão que

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

necessitou de fototerapia, cefalohematoma ou sangramento importante, aleitamento materno exclusivo e raça asiática. Resposta correta Letra C .

131345.

Comentário: A infecção congênita pelo CMV ocorre mais frequentemente quando a mãe se infecta pela primeira vez durante a gestação e, mais raramente, é resultado de reativação de um processo latente. Se a mãe desenvolve a infecção primária na gestação, ela transmite o vírus em 30% dos casos. Entre os RN afetados, somente 10% nascem com infecção sintomática, e a grande maioria, isto é, 90% desses bebês são ASSINTOMÁTICOS. Do grupo dos sintomáticos, 90% desses apresentam sequelas e aproximadamente 10% evoluem para óbito. A maior gravidade da infecção sobre o feto ocorre quando a transmissão ocorre em fases iniciais da gestação, ao passo que a maior probabilidade de contaminação se dá no último trimestre. A transmissão vertical (mãe-feto) encontra-se associada à eliminação do vírus pelo RN em sua urina, saliva e secreções da nasofaringe durante vários meses. Resposta letra B.

131350.

Comentário: Vamos analisar as opções sobre as afecções cutâneas mais frequentes do neonato A - Correta. O milium sebáceo são pápulas amarelo-esbranquiçadas que aparecem na fronte, asas do nariz e genitália, correspondendo a pequenos cistos queratogênicos, causados por obstrução dos folículos pilossebáceos. B - Correta. Os hemangiomas capilares maculares transitórios são comuns em pálpebras e pescoço, também são achados físicos normais em recém-nascidos. C - Correta. O eritema tóxico é uma erupção cutânea composta de pápulas ou lesões vesicopustulosas que surgem de um a três dias após o nascimento, sendo localizado na face, tronco e membros. É classificado como um exantema benigno, desaparecendo em uma semana. D - INCORRETA. Máculas brancas não são comuns na pele do recém-nascido. E - Correta. O vérnix caseoso é uma substância graxenta, branco-amarelada (sebo e debris de queratinócitos), que recobre a superfície cutânea das dobras. Gabarito letra D.

140164.

Comentário: Justamente pela importância dos fatores de risco na gênese da SMSL, é que

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

precisamos conhecê-los, pois a modificação deles está associada à redução da sua incidência (1) Fatores maternos e antenatais elevação na alfafetoproteína no segundo trimestre de gestação tabagismo álcool e drogas ilícitas desnutrição ausência de cuidado pré-natal baixo nível socioeconômico mães solteiras ou jovens pequeno intervalo entre as gestações hipóxia intrauterina RCIU (2) Fatores da criança idade (pico entre 2-4 meses) sexo masculino raça e etnia (maior incidência em negros) deficit de crescimento ausência de aleitamento não usar chupetas prematuridade dormir em posição prona ou decúbito lateral doença febril recente imunização incompleta exposição ao tabagismo (pré e pós-natal) dormir em superfícies macias compartilhar a cama com os pais ou outras crianças estresse térmico, hiperaquecimento, climas frios De acordo com a Academia Americana de Pediatria, para a prevenção do quadro, as seguintes medidas devem ser tomadas crianças menores de um ano nascidas a termo ou prematuras devem ser posicionadas na posição supina para dormir (o decúbito lateral NÃO deve ser recomendado). Essas crianças devem dormir no mesmo quarto que os pais, mas no próprio berço. O colchão deve ser firme e materiais macios (travesseiros ou brinquedos) devem ser evitados no local de sono da criança. Resposta E.

131380.

Comentário: Todas as opções trazem indicações de intubação orotraqueal (IOT) na sala de reanimação neonatal depressão respiratória mantida após ventilação com máscara e balão autoinflável, suspeita ou diagnóstico de hérnia diafragmática, e apgar menor que 3 no primeiro minuto (embora o cálculo do apgar em si, não seja necessário para indicar manobras de reanimação, a presença de apneia e bradicardia são itens para iniciá-la). Com as novas recomendações de 2016 da SBP (Sociedade Brasileira de Pediatria), a presença de mecônio e neonato deprimido não é mais indicação absoluta de IOT. Mas na época do concurso, esta regra ainda valia. Como a opção D traz uma alternativa incoerente, a questão foi anulada.

131386.

Comentário: Quando o assunto é reanimação neonatal, ainda se utiliza o ABC . O A corresponde à via aérea pérvia (através de aspiração de boca e narinas e posicionamento correto da cabeça, com

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

ligeira extensão cervical) o B corresponde à respiração (ventilação com máscara ou tubo orotraqueal e pressão positiva) e o C corresponde à circulação (massagem cardíaca, drogas e expansores de volume). Gabarito letra C.

131393.

Comentário: Sempre devemos atentar para os passos iniciais da reanimação para não haver confusão. Todos os pacientes com menos de 37 semanas de gestação e aqueles de qualquer idade gestacional sem vitalidade adequada ao nascer precisam ser conduzidos à mesa de reanimação, indicando-se os seguintes passos prover calor, posicionar a cabeça em leve extensão, aspirar vias aéreas (se necessário) e secar o paciente . Tais passos devem ser executados em, no máximo, 30 segundos. Resposta correta Letra A .

131331.

Comentário: Logo após o nascimento, a necessidade de reanimação é avaliada por três perguntas gestação a termo Recém-nascido respirando ou chorando Tônus muscular bom Quando a criança estiver hipotônica ou em apneia, deve ser feito o clampeamento imediato do cordão umbilical e a criança deve ser conduzida à mesa de reanimação para os passos inicias aquecer, posicionar a cabeça em leve extensão, aspirar as vias aéreas (se for necessário) e depois secar. Tudo isso deve ser feito em até 30 segundos e a frequência cardíaca e a respiração são avaliadas. Se houver respiração irregular ou apneia ou FC menor que 100 bpm, a ventilação com pressão positiva deve ser iniciada. Isso é habitualmente feito com balão autoinflável e máscara facial. Resposta letra D.

134844.

Comentário: A reposição de vitamina K intramuscular logo após o nascimento tem como objetivo prevenir a ocorrência da doença hemorrágica do recém-nascido, que é mais susceptível por apresentar níveis mais baixos de fatores da coagulação, menores reservas de vitamina K e por ter baixo aporte da vitamina quando alimentado ao seio materno. Resposta letra D.

134851.

Comentário: É fato que sempre que ouvimos o termo hemorragia retiniana nos remetemos imediatamente à possibilidade de abuso infantil, não é verdade Porém, tome cuidado isso pode

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

estar presente nas primeiras semanas de vida de uma criança, em associação ou não com hemorragias conjuntivais. A alteração pode ser decorrente do esforço relacionado ao parto vaginal e não demanda qualquer intervenção específica. Resposta letra A.

134064.

Comentário: De acordo com as Diretrizes do Ministério da Saúde, a Triagem Auditiva Neonatal (TAN) deve ser realizada em todos os recém-nascidos e não apenas naqueles com indicador de risco para deficiência auditiva, uma vez que esta pode ser encontrada em crianças com e sem indicadores de risco, na mesma proporção. Preferencialmente, a TAN deve ser realizada nos primeiros dias de vida (24 a 48 horas de vida) ainda na maternidade, e no máximo, durante o primeiro mês de vida. Resposta letra C.

134060.

Comentário: De acordo com o Manual de Reanimação Neonatal proposto pela Sociedade Brasileira de Pediatria, os recém-nascidos com 34 semanas ou mais que apresentem apneia, respiração irregular e ou frequência cardíaca abaixo de 100 bpm devem receber ventilação por pressão positiva com balão auto inflável e máscara em ar ambiente. O uso do oxigênio suplementar fica reservado para os casos que não apresentarem melhora com esta medida inicial, devendo ser, então, ofertado oxigênio a 40%. Resposta letra B.

134067.

Comentário: A sífilis na gestação é um grave problema de saúde pública, responsável por altos índices de morbimortalidade intrauterina. Ela ainda é observada em parcela significativa de mulheres, o que favorece diretamente a ocorrência de sífilis congênita. Como evento sentinela, significa que a manutenção da ocorrência, juntamente com a falta de controle, indicam falhas no programa de DST (controle de sífilis adquirida) e também no seguimento pré-natal (aumento do número de casos de sífilis congênita). Devemos sempre ter em mente que a sífilis é uma doença curável se o tratamento for instituído corretamente, e a sífilis congênita pode ser evitada por ações de saúde adequadas. Resposta correta Letra A .

134820.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

Comentário: Questão sobre pesquisa de maturidade pulmonar fetal. A razão lecitina-esfingomielina (L E) ainda que não seja mais tão utilizada quanto no passado, durante muitos anos foi considerada o exame padrão-ouro. Antes de 34 semanas, a lecitina e a esfingomielina estão presentes no líquido amniótico em concentrações semelhantes. Entre 32 e 34 semanas de gestação, a concentração de lecitina começa a aumentar em relação a da esfingomielina. Atualmente, no entanto, considera-se a polarização fluorescente o exame de primeira linha para avaliação de maturidade pulmonar, com valor limiar de 55mg g. Este ensaio automatizado mede a razão surfactante-albumina no líquido amniótico não centrifugado e fornece resultados em aproximadamente 30 minutos. Apesar de apresentar um dado já desatualizado, a banca considerou como resposta a letra D.

110531.

Comentário: Um dos principais sinais de alerta para o desenvolvimento de hiperbilirrubinemia significativa constitui-se na presença de icterícia precoce, ou seja, aquela que surge antes de 24 horas de vida. O seu aparecimento está associado a 8 vezes o risco de o RN alcançar BT superior a 25 mg dl, quando comparado ao paciente sem icterícia precoce. Além da icterícia nas primeiras 24h de vida, os outros fatores de risco considerados maiores são Bilirrubina sérica na zona de alto risco antes da alta hospitalar, incompatibilidade materno-fetal Rh ou outra doença hemolítica, idade gestacional de 35 e 36 semanas, irmão com história de fototerapia, céfalo-hematoma ou equimoses, dificuldade no aleitamento materno com perda de peso excessiva (5% em relação ao peso de nascimento) e etnia asiática. Resposta correta Letra C .

110536.

Comentário: Cerca de 90% das crianças que nascem com infecção congênita por CMV são assintomáticas. Quando existem sintomas, os mais comuns são crescimento intrauterino restrito, prematuridade, hepatoesplenomegalia, icterícia, exantema arroxeado, trombocitopenia e púrpura, microcefalia e calcificações intracranianas periventriculares. RNs infectados excretam vírus na saliva e na urina durante anos. Dentre as principais sequelas estão a surdez neurossensorial (acomete 7-10% dos infectados), epilepsia e déficits cognitivos e motores. Resposta letra B.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

110544.

Comentário: Diante de uma criança com icterícia na primeira semana de vida, devemos sempre pesquisar se a hiperbilirrubinemia é às custas de aumento de bilirrubina direta (colestase) ou indireta. Na maior parte dos casos, trata-se de aumento de BI, logo, devemos obrigatoriamente descartar a possibilidade de hemólise imunomediada (incompatibilidade Rh ou ABO), e para tal, solicitamos Coombs direto, a tipagem sanguínea da criança e da mãe e reticulócitos da criança. Outras causas de hiperbilirrubinemia indireta na primeira semana de vida são hemólise não imunomediada (DG6PD, esferocitose hereditária), icterícia do aleitamento materno e hipotireoidismo congênito. A pesquisa de enzimas hepáticas e marcadores de hepatite são solicitados na suspeita de doença hepática, e na presença de hiperbilirrubinemia direta. Resposta correta letra D .

110558.

Comentário: A conduta no atendimento inicial ao RN depende da resposta a quatro perguntas Gestação a termo Respirando ou chorando Tônus muscular em flexão Ausência de mecônio Se a resposta a qualquer uma dessas perguntas é não , como no caso em questão, a conduta adequada é prover calor, posicionar a cabeça, aspiras vias aéreas se necessário, secar e desprezar campos úmidos. Isso deve ser feito nos primeiros 30 segundos do atendimento inicial e então, reavalia-se a respiração e frequência cardíaca (FC). Se houver vitalidade adequada, com respiração rítmica e regular e FC 100 bpm, o RN deve receber os cuidados de rotina na sala de parto. Se o paciente, após os passos iniciais, apresenta apneia, respiração irregular e ou FC The Golden Minute). A VPP pode ser feita com ar ambiente inicialmente em RN com 34 semanas ou mais de idade gestacional com monitorização constante da oximetria de pulso. Os valores desejáveis de SatO2 variam de acordo com os minutos de vida. Quando o RN 34 semanas não melhora e ou não atinge os valores desejáveis de SatO2 com a VPP em ar ambiente, recomenda-se o uso do oxigênio suplementar. Nesse caso, indica-se de preferência a aplicação da mistura O2 ar, ajustando-se a concentração de oxigênio desejada por meio de um blender, oferecendo inicialmente O2 a 40% e ajustando a oferta de acordo com a SatO2 desejável e a FC, ambas determinadas pela oximetria de pulso. Caso o

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

blender ou o oxímetro não forem disponíveis, continuar a VPP com oxigênio a 100%. Resposta letra A.

109985.

Comentário: O quadro descrito na questão é característico de hérnia diafragmática. O desconforto respiratório é um sinal fundamental e geralmente está associado a abdome escavado e aumento do diâmetro da caixa torácica. Os ruídos hidroaéreos também podem ser ouvidos no tórax e há diminuição de murmúrio vesicular à ausculta. O ictus cardíaco pode estar deslocado para a direita se houver desvio de mediastino com uma hérnia diafragmática à esquerda, que, por sinal, é o lado mais comumente acometido (85%). Raramente, o paciente pode se apresentar apenas com manifestações mais tardiamente, como vômitos, em decorrência da obstrução intestinal, ou sintomas respiratórios leves. A conduta inicial envolve suporte ventilatório. Lembre-se de que a ventilação com balão e máscara deve ser evitada, pois aumenta o volume do estômago e do intestino delgado e assim, torna a respiração e oxigenação ainda mais difíceis. Resposta letra C.

109989.

Comentário: A sepse neonatal precoce acomete o RN na primeira semana de vida (em geral, nas primeiras 72h de vida) e tem como agentes etiológicos os patógenos provenientes do trato genital materno, como o Streptococcus agalactiae (grupo B), E. coli e L. monocytogenes . A sepse neonatal tardia, por sua vez, é a que ocorre após uma semana de vida e está associada a patógenos nosocomiais (Gram-negativos, S. aureus e outros) ou comunitários adquiridos após a alta hospitalar. Resposta Letra C .

109993.

Comentário: A infecção congênita por CMV ocorre predominantemente após infecção materna primária, mas também pode ocorrer após reativação de infecção latente na mãe. Cerca de 90% das crianças que nascem infectadas são assintomáticas. Quando existem sintomas, os mais comuns são crescimento intrauterino restrito, prematuridade, hepatoesplenomegalia, icterícia, exantema arroxeado, trombocitopenia e púrpura, microcefalia e calcificações intracranianas periventriculares. RNs infectados excretam vírus na saliva e na urina durante anos. Dentre as principais sequelas

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

estão a surdez neurossensorial (acomete 7-10% dos infectados), epilepsia e déficits cognitivos e motores. Resposta letra C.

109996.

Comentário: Em geral, todas as infecções congênitas podem causar crescimento intrauterino restrito, prematuridade, hepato e ou esplenomegalia e outras inúmeras manifestações, no entanto, quando temos um RN com erupção petequial associada a acometimento ocular (catarata bilateral, glaucoma, retinopatia ou microftalmia) e cardiopatia congênita (principalmente persistência do canal arterial ou estenose pulmonar), devemos obrigatoriamente pensar em Rubéola Congênita. Nos casos de sífilis congênita temos algumas características marcantes como lesões cutaneomucosas e lesões ósseas no CMV congênito temos as calcificações intracranianas periventriculares, coriorretinite e surdez neurossensorial na Toxoplasmose congênita, por fim, observamos calcificações intracranianas difusas, hidrocefalia e retinocoroidite. Resposta correta Letra A .

109779.

Comentário: O esquema de consultas preconizado pela Sociedade Brasileira de Pediatria para o follow-up de prematuros estabelece que a primeira consulta deve ser realizada após 7-10 dias da alta hospitalar. Podemos observar, no entanto, que a criança em questão apresentou até seu terceiro dia de vida uma perda ponderal de cerca de 10%, ou seja, perdeu em 3 dias o esperado para uma semana. Por isso, a primeira consulta deverá ser adiantada, com a finalidade de se avaliar o peso da criança, corrigir possíveis erros de posicionamento e de pega durante a amamentação, esclarecer dúvidas da mãe e estimular o aleitamento materno exclusivo. Resposta correta letra A .

110024.

Comentário: Diante de uma criança com qualquer malformação, a conduta inicial mais importante é a busca ativa, através de um exame físico cuidadoso, de outras malformações associadas e de alterações fenotípicas que possam sugerir uma síndrome genética associada. Assim como no caso de qualquer outra anormalidade, o exame físico detalhado é o primeiro passo na investigação. Gabarito letra C.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

86654.

Comentário: A INCORRETA. A antibiocoterapia venosa (ex penicilina cristalina para tratamento de sífilis congênita), fototerapia e controle glicêmico (ex filhos de mães diabéticas ou neonatos GIG) são itens de prescrição médica absolutamente compatíveis com o alojamento conjunto mãe-bebê. As indicações de UTI neonatal são prematuridade 34-35 semanas, peso de nascimento 2 kg, necessidade de suporte ventilatório, suporte hemodinâmico, presença de crises convulsivas, distúrbios hidroeletrolíticos, anemia grave, necessidade de exsanguineotransfusão, entre outros. B Correta. O parto cesária, dificuldades de deambulação, doença mental controlada não são contraindicações ao alojamento conjunto. Apenas a psicose puerperal grave é uma contraindicação à amamentação, mas a mãe pode permanecer próximo ao filho desde que com supervisão e com suporte de terceiro. C Correta. Cabe à equipe multiprofissional (pediatras, obstetras, enfermeiros, técnicos) o cuidado com o binômio mãe-bebê, que inclui anamnese exame físico, controle de sinais vitais, suporte e apoio com a amamentação, cuidados higiênicos e orientações. D Correta. A presença de infecções congênitas (ex toxoplasmose, rubéola, sífilis, herpes, HIV) não contraindicam o alojamento conjunto, e o bebê pode usar antimicrobianos e antivirais na enfermaria, em convivência com sua mãe. E Correta. Um neonato a termo, com peso de nascimento adequado, em amamentação exclusiva, com bom estado geral saudável pode receber alta a partir de 48 horas de nascimento. Gabarito letra A.

86679.

Comentário: Nosso RN não respondeu bem às medidas iniciais do atendimento na sala de parto, e a questão quer que você escolha a melhor conduta. Após os cuidados para manter a temperatura e a permeabilidade das vias aéreas do RN, a presença de apneia, respiração irregular e ou FC 100 bpm indica a VPP. Esta precisa ser iniciada nos primeiros 60 segundos de vida (The Golden Minute). No caso de RN 34 semanas (como o nosso), deve-se iniciar a ventilação com ar ambiente. Uma vez iniciada a ventilação, recomenda-se o uso da oximetria de pulso para monitorar a oferta do oxigênio suplementar. Deve-se aplicar sempre o sensor neonatal na região do pulso radial ou na palma da mão direita e, a seguir, conectá-lo ao cabo do oxímetro. Os valores

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

desejáveis de SatO2 variam de acordo com os minutos de vida do recém-nascido. Quando o RN 34 semanas não melhora e ou não atinge os valores desejáveis de SatO2 com a VPP em ar ambiente, recomenda-se o uso do oxigênio suplementar. Indica-se, de preferência, a aplicação da mistura O2 ar, ajustando-se a concentração de oxigênio desejada por meio de um blender. Caso o blender ou o oxímetro não forem disponíveis (como na questão), iniciar a VPP com ar ambiente, ficar atento à apropriada insuflação pulmonar e à normalização da FC e, se não houver melhora em 90 segundos, continuar a VPP com oxigênio a 100%. Resposta letra B.

86684.

Comentário: Sempre que estivermos diante de uma gestante com VDRL reagente durante a gestação, a primeira pergunta que devemos fazer é o tratamento foi adequado ou foi inadequado No caso descrito, temos um exemplo de tratamento inadequado, pois foi realizado com menos de 30 dias antes do parto e o parceiro não foi tratado. Vamos relembrar o que é considerado um tratamento inadequado para sífilis materna é todo tratamento realizado com qualquer medicamento que não seja a penicilina tratamento incompleto, mesmo tendo sido feito com penicilina tratamento inadequado para a fase clínica da doença instituição de tratamento dentro do prazo dos 30 dias anteriores ao parto ausência de documentação de tratamento anterior ausência de queda dos títulos (sorologia não-treponêmica) após tratamento adequado parceiro não tratado ou tratado inadequadamente ou quando não se tem a informação disponível sobre o seu tratamento. Quando o tratamento não foi realizado ou foi inadequado, o recém-nascido deve ser submetido à realização dos seguintes exames VDRL do sangue periférico, hemograma, radiografia de ossos longos e análise do liquor. A conduta terapêutica será definida de acordo com a avaliação do quadro clínico e dos resultados obtidos nesses exames e pode ser uma das três seguintes 1) Quando há alteração liquórica, o tratamento deve ser feito com penicilina cristalina por 10 dias. Os parâmetros utilizados para a caracterização de neurossífilis incluem a celularidade, a proteinorraquia e o VDRL do liquor. O achado de leucocitose (mais de 25 leucócitos mm3, no período neonatal) e concentração elevada de proteínas (mais de 150 mg dl, no período neonatal) devem ser consideradas como evidências para o diagnóstico de neurossífilis. A presença de VDRL positivo no

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

liquor estabelece este diagnóstico, independentemente de haver alterações na celularidade e ou na concentração de proteínas. 2) Quando não há alterações clínicas, radiológicas, hematológicas e ou liquóricas e a sorologia for negativa, pode ser realizado o tratamento com penicilina G benzatina por via intramuscular na dose única de 50.000 UI Kg, desde que o acompanhamento seja garantido 3) Quando há alterações clínicas e ou sorológicas e ou radiológicas e ou hematológicas (e a análise do liquor é normal), o tratamento deverá ser feito com penicilina G cristalina ou penicilina G procaína durante 10 dias. Resposta letra B.

86623.

Comentário: Há como estarmos, aqui, diante de uma icterícia fisiológica NÃO Icterícia com 22h de vida... As principais causas de icterícia nas primeiras 24 horas de vida são os quadros de anemia hemolítica, assim, é obrigatória a realização da avaliação da hemoglobina, hematócrito e contagem de reticulócitos. Neste sentido, o diagnóstico diferencial se dá principalmente entre as seguintes condições anemia hemolítica isoimune, deficiência de G6PD e esferocitose hereditária. A doença hemolítica do recém-nascido pode ocorrer pela incompatibilidade ABO, Rh ou por subgrupos. Na nossa questão, há como ser incompatibilidade Rh, uma vez que a mãe é Rh negativo. Caso o teste de Coombs viesse positivo, a principal hipótese seria essa. Entretanto, temos aqui um Coombs negativo A incompatibilidade ABO é a causa mais comum de doença hemolítica do recém-nascido, em que os anticorpos maternos podem ser formados contra as céluas A e B. Geralmente, a mãe é do tipo O, e o RN do tipo A ou B, como na nossa questão. A maioria dos casos é leve (diferentemente da incompatibilidade Rh), com a icterícia sendo a única manifestação clínica. Resposta letra B.

86629.

Comentário: Atente para os seguintes detalhes parto cesáreo, ausência de trabalho de parto, fiO2 30% e cisurite. Eles são a chave para o diagnóstico deste desconforto respiratório apresentado pelo RN. A taquipneia transitória do recém-nascido, ou síndrome do pulmão úmido, é uma condição que está relacionada ao retardo da absorção do líquido pulmonar após o nascimento. A criança nasce afogada O grande fator de risco para o desenvolvimento do quadro parece ser o nascimento

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

na ausência de trabalho de parto. De que forma isso é possível Pelo nascimento através da operação cesariana eletiva (por isso o parto cesáreo é um fator de risco para a condição). O tratamento é essencialmente de suporte. Em geral, o desconforto respiratório não é grave e são necessárias baixas concentrações de oxigênio, como o nosso paciente em questão. Os aspectos radiográficos típicos da taquipneia incluem um aumento da trama vascular, a presença de cisuras marcadas e, por vezes, pequenos derrames. Também pode haver hiperinsuflação e cardiomegalia. Resposta letra E.

86862.

Comentário: Questão que poderia ter gerado confusão na época do concurso, mas que não foi motivo de questionamentos em nosso fórum. Sabemos que, recentemente, passou-se a se recomendar de modo formal que seja feito o clampeamento tardio do cordão umbilical. Essa conduta parece ter efeitos benéficos com relação aos índices hematológicos na idade de 3-6 meses. O Ministério da Saúde, em 2011, publicou um importante documento sobre o tema em que afirmava que o momento ideal para pinçar o cordão de todos os recém-nascidos, independentemente de sua idade gestacional, é quando a circulação do cordão umbilical cessou, o cordão está achatado e sem pulso (aproximadamente 3 minutos ou mais depois do nascimento). Depois de as pulsações do cordão terem cessado (aproximadamente 3 minutos após o parto), procede-se o clampeamento e o corte, de acordo com ténicas estritas de higiene e limpeza . Por este documento, não teríamos dúvidas em marcar a opção B, que foi o gabarito. Porém, veja o que é dito no programa de reanimação neonatal da Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda-se que o RN a termo, saudável e com boa vitalidade ao nascer seja posicionado no nível da placenta por um a três minutos, antes de clampear o cordão umbilical . Fica o aprendizado se aparecer uma questão que peça o número exato de minutos, indique 3 Se cair uma opção que traga o tempo entre 1 e 3 minutos, isso também pode estar certo. Resposta letra B.

86878.

Comentário: Questão relativamente simples, que traz de forma resumida achados característicos da sífilis congênita preococe. A sífilis congênita é o resultado da transmissão hematogênica, por via

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

transplacentária, do Treponema pallidum e possui manifestações não encontradas na sífilis adquirida na fase pós natal. As manifestações clínicas dividem-se em dois grupos sífilis congênita preococe (surgem nos primeiros dois anos de vida) e sífilis congênita tardia (surgem após os primeiros dois anos de vida e nada mais são do que sequelas do quadro anterior). As manifestações encontradas na forma precoce incluem manifestações inespecíficas, que podem ser encontradas em outras infecções congênitas, mas também incluem alterações bem sugestivas desse diagnóstico. As mais características são a rinite sifilítica (obstrução nasal intensa com secreção serossanguinolenta), pênfigo palmoplantar (lesões vesicobolhosas encontradas na região palmar e plantar), pseudoparalisia de Parrot (imobilidade do membro por dor nos casos de osteocondrite o enunciado não descreve essa alteração, mas aponta para a existência de dor) e lesões de mucosa (condiloma). A palidez descrita pode estar associada à anemia hemolítica encontrada nesses casos (com Coombs direto negativo). Resposta letra A.

158413.

Comentário: A manobra de Barlow faz parte do exame físico osteoarticular do recém-nascido, assim como a manobra de Ortolani, ambas com o objetivo de pesquisar a displasia congênita do quadril. O Barlow consiste em realizar uma adução do quadril (trazendo em direção à linha média) ao mesmo tempo em que se aplica uma pressão sobre o joelho, direcionando a força posteriormente. O objetivo da manobra é constatar se a cabeça do fêmur pode ser deslizada para fora do acetábulo, pois estaríamos diante de um quadril luxável e a manobra seria então, positiva. Já a manobra de Ortolani, consiste em colocar a cabeça do fêmur de volta ao acetábulo, o qual serve para confirmar o achado positivo do Barlow. Resposta letra E.

158418.

Comentário: Após realizar os cuidados iniciais de reanimação, que consiste em colocar o recém-nascido sob fonte de calor radiante, posicionar em leve extensão cervical, aspirar vias áreas superiores se necessário, secar e desprezar os campos úmidos, devemos avaliar a frequência cardíaca (FC) e respiração. Como a questão explicitou que a criança está em apnéia, devemos dar prosseguimento a reanimação e o primeiro passo a ser instituído, ainda no golden minute, é a

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

ventilação com pressão positiva (VPP) com balão e máscara, em ar ambiente pois trata-se de recém-nascido a termo, o qual deveremos manter durante 30 segundos para posteriormente reavaliar a FC e respiração. Ao inicar a VPP, devemos pedir auxílio para instalar a oximetria de pulso, para fins de monitoração da saturação periférica de oxigênio e, se necessário, realizar incrementos posteriormente em caso de necessidade de prosseguir com a reanimação. Resposta letra B.

362430.

Comentário: A Síndrome do Desconforto Respiratório (SDR) é a afecção respiratória mais frequente no RN pré-termo, sendo mais comum nos RN prematuros com menos de 28 semanas de gestação, do sexo masculino, em filhos de mãe diabética e nos que sofreram asfixia ao nascimento. A deficiência quantitativa e qualitativa do surfactante alveolar é a principal causa da SDR. A evolução clássica da SDR pode ser modificada por meio da administração antenatal de corticoide, assistência ventilatória precoce e uso de surfactante exógeno. Diante disso, vamos analisar as demais afirmativas. Letra A incorreta. A síndrome de escape de ar é uma entidade clínico-radiológica que inclui espectro variado de doenças pulmonares e extrapulmonares, caracterizada pela presença de ar em regiões normalmente não aeradas, resultantes da perda de solução de continuidade do epitélio respiratório. Sua classificação baseia-se na região onde ocorre o acúmulo de ar. As repercussões pulmonares e extrapulmonares da decorrem basicamente do local, da extensão, do volume e da velocidade do acúmulo de gás. Entre os diversos quadros que compõem a síndrome, pela frequência e pela gravidade, assumem importância o enfisema intersticial pulmonar e o pneumotórax. Letra B incorreta. A síndrome de aspiração do mecônio atinge em geral RN a termo ou pós-termo com história de asfixia perinatal e líquido amniótico meconial. Os sintomas respiratórios são de início precoce e progressivo, com presença de cianose grave. Letra C incorreta. A hipertensão pulmonar persistente é uma síndrome clínica caracterizada por hipoxemia grave e refratária, proveniente da diminuição do fluxo sanguíneo pulmonar e shunt direito-esquerdo por meio do forame oval e ou canal arterial. O curto-circuito extrapulmonar decorre do aumento relativo da pressão na artéria pulmonar em relação à sistêmica. Resposta letra D.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

362427.

Comentário: A presença de uma alta avidez na sorologia com IgG para toxoplasmose mostra que esta infecção é antiga, geralmente ocorrendo há mais de 16 semanas. Como a paciente está com sete semanas de gestação, a infecção por T. gondii ocorreu antes da gravidez, não havendo necessidade de investigar ou tratar nem a mãe nem o bebê. Vamos avaliar as alternativas. Letra A incorreta. Os exames de investigação completa (com punção lombar) são feitos quando a mãe apresentou toxoplasmose na gravidez e o bebê tem sinais de doença, sejam clínicos (exame físico ou fundo de olho), radiológicos (na ultrassonografia transfontanela) ou sorológicos (IgM positivo). Letra B incorreta. A sorologia do bebê é realizada em sangue periférico. Letra C correta. Como a doença materna ocorreu antes da gravidez, não há necessidade de investigação ou tratamento do recém-nascido. Letra D incorreta. O tratamento por um ano é realizado quando há diagnóstico de toxoplasmose na criança, ou seja, se houver alteração no exame físico, no fundo de olho, ultrassonografia transfontanela ou IgM positivo. No entanto, a sulfadiazina será feita por 12 meses, mas a pirimetamina e o ácido folínico são administrados por dois a seis meses. Resposta letra C.

362424.

Comentário: A banca conta a história de gestante vivendo com HIV. O problema proposto é o que fazer a respeito da profilaxia antirretroviral para esse recém-nascido (RN) Como se sabe, a definição de risco do RN em adquirir o vírus dita a conduta subsequente. Aqui, muito embora a mãe esteja em terapia antirretroviral (TARV), com boa adesão, há dois fatores de risco importantes (1) ela iniciou a TARV tardiamente e (2) sua carga viral foi 1.000 cópias mL no terceiro trimestre. Ou seja, o bebê ficou desguarnecido durante as primeiras 28 semanas de vida intrauterina e ainda há vírus a circulação Enfim, o que fazer em termos profilaxia antirretroviral para o bebê apresentado Vamos resumir os esquemas indicados RN a termo de alto risco AZT (zidovudina) 3TC (lamivudina) RAL (raltegravir), todos durante 28 dias RN 34-37 sem de alto risco AZT 3TC durante 28 dias NVP (nevirapina) durante 14 dias RN 34 sem ou baixo risco somente AZT por 28 dias. Agora, sim Resolvido ficaremos com a letra A . Vejamos as alternativas Letra B incorreta. AZT em monoterapia seria indicado para bebês de baixo risco. Letra C incorreta. Não se faz o esquema duplo com AZT e

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

NVP a combinação entre estes e o 3TC seria para bebês prematuros, entre 34 e 37 semanas, de alto risco. Letra D incorreta. O dolutegravir não está elencado nos esquemas para os RNs. Resposta letra A.

327286.

Comentário: De acordo com o Ministério de Saúde, em seu Protocolo clínico e diretrizes terapêuticas para prevenção da transmissão vertical de HIV, sífilis e hepatites virais de 2022, são considerados RN de alto risco para transmissão vertical do HIV, aqueles cujas mães preenchem qualquer dos seguintes critérios mães sem pré-natal, mães sem TARV durante a gestação, mães com indicação de profilaxia no momento do parto e que não a receberam, mães com início de TARV após 2ª metade da gestação, mães com infecção aguda pelo HIV durante a gestação, mães com CV-HIV detectável no 3º trimestre, recebendo ou não TARV, mães sem CV-HIV conhecida, Mães com Teste Rápido (TR) positivo para o HIV no momento do parto (sem diagnóstico e ou seguimento prévio). Veja que essa gestante recebeu o diagnóstico de HIV e iniciou TARV já na 20ª semana gestacional, e não tem registro de carga viral após início da TARV. Além disso, não foi relatado uso de AZT injetável durante o parto. Assim, esse RN tem múltiplos critérios para ser considerado de risco para transmissão vertical do HIV. No grupo de alto risco está indicado o esquema profilático composto por três antirretrovirais AZT, 3TC e RAL, com início imediato, sendo administrado por 28 dias. A nota informativa n 6 2021-DCCI SVS MS, citada nas diretrizes de 2022, orienta quanto ao seguimento laboratorial da criança exposta verticalmente ao HIV a carga viral deve ser coletada ao nascimento, com 14 dias de vida, 2 semanas após o término da profilaxia (6 semanas de vida) e 8 semanas após o término da profilaxia (12 semanas de vida). Vale a ressalva toda CV-HIV detectável, independentemente do valor, indica nova coleta imediatamente. Resposta letra B.

298250.

Comentário: O teste do coraçãozinho tem como objetivo rastrear cardiopatias congênitas críticas e deve ser realizado ainda no hospital, em todos os RN com mais de 34 semanas de idade gestacional, entre 24 e 48h de vida. A avaliação é feita pela determinação da oximetria no membro

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

superior direito e um dos membros inferiores. A saturação deve ser maior que 95% nos dois membros e a diferença entre eles não pode ser superior a 3%. Quando há alteração no teste (veja que no bebê do enunciado a diferença entre membros ficou em 4%), devemos repetir a aferição em 1 hora, garantido que o bebê está com as extremidades adequadamente aquecidas. Se a alteração persistir, um ecocardiograma deverá ser solicitado e realizado dentro de 24 horas. Resposta da questão letra C .

298254.

Comentário: Segundo as atuais recomendações, esta gestante é considerada de alto risco, pois o início de TARV ocorreu após 2ª metade da gestação, como também apresenta CV-HIV detectável no 3º trimestre. A primeira coleta de CV-HIV no recém-nascido deve ser realizada imediatamente após o nascimento. O exame deverá ser coletado através de punção periférica (não deve ser feita a coleta de material de cordão umbilical), preferencialmente antes do início da profilaxia com anrretrovirais. No entanto, a coleta não deve atrasar a administração dos medicamentos. A profilaxia deve ser iniciada o mais precocemente possível após o nascimento, preferencialmente nas primeiras quatro horas de vida. O esquema é composto de três antirretrovirais Zidovudina (AZT), Lamivudina (3TC) e Raltegravir (RAL), que deverá ser administrado por 28 dias. Resposta letra A.

298255.

Comentário: No que se refere a gestante, considera-se sucesso de tratamento a diminuição da titulação do VDRL em duas diluições (1 128 para 1 64) até três meses, após a última dose de penicilina, e quatro diluições (1 128 para 1 16) até seis meses, com evolução até a sororreversão (VDRL não reagente). Desta forma, podemos considerar essa mãe como adequadamente tratada. Como o teste não treponêmico da criança não foi maior que o materno e o exame físico é normal, podemos considerar a criança como exposta a sífilis, sem necessidade de tratamento. Devemos realizar o VDRL com 1 mês, 3, 6, 12 e 18 meses de idade, interrompendo o seguimento com dois exames consecutivos de VDRL negativos. Resposta letra A.

298264.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

Comentário: Estamos diante de um recém nascido que apresenta leucocoria bilateral (opacificação do reflexo vermelho) e história familiar de afecção oftalmológica. O enunciado também descreve que não houve intercorrência durante a gestação, o que, a princípio, serve de base para afastarmos a hipótese de toxoplasmose congênita. A atrofia do nervo óptico não cursa com alteração do reflexo vermelho, por isso também descartamos esta alternativa. Ficamos então entre catarata congênita e glaucoma congênito, duas condições que sabidamente alteram o reflexo vermelho. O dado que nos faz marcar como resposta correta a alternativa A é o relato de que o pai realizou cirurgia em idade precoce, além do fato de catarata congênita ser muito mais prevalente que glaucoma infantil primário. Aproximadamente um terço dos casos de catarata congênita são hereditários, enquanto o glaucoma infantil raramente tem base hereditária. É evidente que apenas com a alteração do teste do reflexo vermelho, não se pode afirmar que trata-se de catarata congênita, devendo esta criança ser encaminhada para avaliação mais completa pelo oftalmologista, mas como o autor questionou sobre a hipótese mais provável, esta realmente é a melhor resposta para a questão. Resposta letra A.

286765.

Comentário: A presença de taquipneia e cianose em um RN logo após o nascimento pode representar diversas condições patológicas. Na questao, a ausência de alteração na ausculta pulmonar fala contra a presença de pneumonia, e a pouca (quase nenhuma) resposta ao uso do halo de oxigênio falam contra a presença de taquipneia transitoria. Lembre-se de que na taquipneia transitória as alterações gasométricas são raras, embora possa haver hipoxemia em ar ambiente, que melhora com uma FiO2 menor que 0,50. Além disso, a necessidade de ventilação mecânica é rara nessa doença e, caso isso ocorra, devem-se descartar outros diagnósticos mais compatíveis, como doença da membrana hialina, pneumonia e cardiopatia. O diagnostico mais provável no caso é cardiopatia congênita. Resposta letra B.

286770.

Comentário: O Programa Nacional de Triagem Neonatal iniciou, de forma universal, em 2006, com o rastreamento da fenilcetonúria e hipotireoidismo congênito. Na segunda fase do programa, foram

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

incluídas as hemoglobinopatias e na terceira fase a fibrose cística. Por fim, na fase IV, em 2014, além das quatro doenças anteriormente descritas, foram acrescentadas a hiperplasia adrenal congênita e a deficiência de biotinidase, completando assim seis doenças que, até o momento, são triadas pelo teste do pezinho do ponto de vista nacional. No entanto, algumas unidades federativas como Bahia e Distrito Federal apresentam ampliações do teste, com a inclusão de outras patologias. Resposta letra A.

286771.

Comentário: Questão bem tranquila sobre neonatologia. Quanto ao peso do recém-nascido, temos o seguinte - Peso normal entre 2.500 a 3999g - Baixo peso ao nascer 2.500g (entre 1.500g-2499 g) - Muito baixo peso ao nascer 1.500g (entre 1000g 1499g) - Extremo baixo peso ao nascer 1.000g. Resposta letra C.

286774.

Comentário: A sífilis congênita (SC) é o resultado da transmissão da espiroqueta do Treponema pallidum da corrente sanguínea da gestante infectada para o concepto por via transplacentária ou, ocasionalmente, por contato direto com a lesão no momento do parto (transmissão vertical). A transmissão vertical é passível de ocorrer em qualquer fase gestacional ou estágio da doença materna e pode resultar em aborto, natimorto, prematuridade ou um amplo espectro de manifestações clínicas apenas os casos muito graves são clinicamente aparentes ao nascimento. A infecção transplacentária pode ocorrer durante toda a gestação, por isso o feto é acometido em qualquer estágio de infecção materna (letra A errada e B correta). Todos os RN nascidos de mãe com diagnóstico de sífilis durante a gestação, independentemente do histórico de tratamento materno, deverão realizar teste não treponêmico no sangue periférico. O sangue de cordão umbilical NÃO deve ser utilizado, pois esse tipo de amostra contém uma mistura do sangue da criança com o materno e pode resultar em testes falso-reagentes (letra C errada). No teste não treponêmico, um título maior que o materno em pelo menos duas diluições (ex materno 1 4, RN maior ou igual a 1 16) é indicativo de infecção congênita. No entanto, a ausência desse achado não exclui a possibilidade do diagnóstico de SC. Alguns estudos demonstraram que menos de 30% das

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

crianças com sífilis congênita têm resultado pareado do teste não treponêmico maior que o materno, por isso é fundamental a realização do seguimento de todas as crianças (letra D errada). Resposta letra B.

252268.

Comentário: As decisões quanto à estabilização reanimação dependem da avaliação simultânea da respiração e da FC. A avaliação da respiração é feita por meio da observação da expansão torácica do RN ou da presença de choro. Se a FC for 100 bpm ou o RN não apresenta movimentos respiratórios regulares, devemos iniciar a ventilação com pressão positiva (VPP). Sendo assim, diante de um RN em apneia e FC ausente, o próximo passo é iniciar a VPP. Resposta letra B.

252274.

Comentário: Com 1 minutos de vida Apgar 3. FC presente e 100bpm 1 ponto respiração irregular 1 ponto hipotônico 0 ponto caretas ao estímulo 1 ponto cianose central 0 ponto Com 5 minutos de vida Apgar 6. FC presente e 100bpm 1 ponto respirando espontaneamente 2 pontos algum tônus 1 ponto faz caretas, porém ainda sem tosse ou choro 1 ponto cor com cianose apenas de extremidade 1 ponto Com 10 minutos Apgar 10. FC 100bpm 2 pontos respiração espontânea 2 pontos movimentação ativa 2 pontos chorando 2 pontos completamente corado 2 pontos. Portanto, boletim de Apgar é 3 6 10 Resposta correta letra B

252275.

Comentário: Estamos diante de um RN de 10 dias de vida, em aleitamento materno exclusivo, com icterícia zona III. O RN não recuperou o peso do nascimento, que é esperado até os 10 dias de vida quando a amamentação flui bem, e com relato da mãe de trocar apenas 4 fraldas por dia, sendo que idealmente a troca de fraldas é feita pelo menos seis a oito vezes ao dia. Assim, temos alguns sinais de que a amamentação não está indo tão bem não recuperou o peso de nascimento, diurese baixa e icterícia. Não temos indícios de que há alguma doença subjacente, visto que mãe e RN são B e o exame físico está normal. Sendo assim, estamos diante de uma provável icterícia por baixa ingesta e devemos orientar mamadas mais longas e efetivas, e marcar retorno precoce para reavaliação do peso. Resposta letra D.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

208303.

Comentário: O grande segredo desta questão foi o tratamento materno inadequado, visto que a mãe não foi tratada com penicilina benzatina. Neste caso, o recém-nascido deverá ser submetido a avaliação clínica (que a princípio, está assintomático) e complementar, com avaliação sorológica (VDRL reagente), radiológica, hematológica e liquórica. Por ter apresentado VDRL reagente, o menor deverá ser tratado com penicilina G cristalina. A penicilina G procaína poderia ser uma opção terapêutica, caso a questão tivesse fornecido o resultado do liquor e este fosse normal. Por o VDRL não ter sido negativo, a penicilina G benzatina em dose única não pode ser opção de tratamento para este recém-nascido. Resposta letra D.

208364.

Comentário: Estamos diante de um recém-nascido com fator de risco para hipoglicemia neonatal (mãe com diabetes gestacional), apresentando uma hipoglicemia confirmada pela glicemia capilar 40 mg dl. Como temos um recém-nascido com bom estado geral e assintomático, ele deve ser apenas amamentado. Além disso, deve-se repetir a glicemia capilar conforme protocolo ou discernimento clínico. Em caso de manutenção de valores baixos de glicemia capilar após a amamentação, devemos buscar a confirmação laboratorial com base na glicemia plasmática. O tratamento com flush de glicose a 10% EV só é indicado quando há sintomas (hipotonia, tremores, convulsões), intolerância à dieta oral, níveis de glicemia 25 mg dL e quando a dieta oral não mantém níveis adequados de glicemia. Resposta letra B.

176089.

Comentário: O enunciado apresenta um neonato cuja mãe apresentou positivação da sorologia para toxoplasmose no terceiro trimestre de gestação. A transmissão vertical do patógeno é maior no terceiro trimestre, pois neste momento o fluxo sanguíneo e a permeabilidade placentária são maiores. Felizmente, os danos teciduais tendem a ser menos graves, quando comparados àqueles provocados por infecção do primeiro trimestre. A investigação sorológica inclui a repetição da sorologia materna (IgG e IgM) e a sorologia do neonato (IgG e IgM), com titulação. A presença de IgM positiva ou título de IgG no neonato maiores que o materno indicam infecção fetal. Além disso,

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

é também importante a avaliação de outras complicações associadas à doença, tais como efeitos hematológicos (ex hemograma), complicações oftalmológicas como coriorretinite (ex fundo de olho), e complicações neurológicas (ex punção lombar para avaliar hiperproteinorraquia e USG transfontanela). O tratamento da toxoplasmose congênita é feito com sulfadiazina, pirimetamina e ácido folínico por 12 meses. Resposta letra D.

176115.

Comentário: Sempre que estamos diante de uma questão de icterícia, é importante que saibamos diferenciar trata-se de uma icterícia fisiológica ou patológica Temos um neonato que apresenta icterícia precoce (surge antes de 24 36 horas de vida), ou seja, patológica. O primeiro diagnóstico a ser considerado é de uma anemia hemolítica isoimune, pois o teste de Coombs direto é positivo, seja por incompatibilidade Rh ou ABO. Analisando o grupo e o fator Rh da mãe e do bebê, percebemos que há possibilidade de incompatibilidade ABO, uma vez que a mãe é O e o bebê é A. Além disso, o fato de a mãe ser Rh exclui a possibilidade de incompatibilidade Rh e nos direciona para o diagnóstico de incompatibilidade ABO. Outro dado que poderia nos confundir é a presença de esferócitos no sangue do RN, mas lembre-se na incompatibilidade ABO, podemos ter a presença de esferócitos no sangue do RN devido aos anticorpos maternos ligados às superfícies das hemácias fetais, alterando a forma destas e dando uma falsa impressão de pequenos esferócitos Na esferocitose e na deficiência de G6PD, a icterícia não costuma ocorrer nas primeiras horas de vida e o teste de Coombs direto é negativo. Gabarito letra A.

151949.

Comentário: O enunciado nos apresenta um neonato a termo, com ICTERÍCIA PATOLÓGICA, isto é, aquela que aparece antes de 24 horas de vida. Geralmente, as icterícias precoces são decorrentes de condições hemolíticas (incompatibilidade ABO, incompatibilidade Rh, deficiência de glicose-6-fosfato desidrogenase, esferocitose hereditária etc.), isto é, seja pela presença de anticorpos maternos, condições enzimáticas defeituosas das hemácias ou defeitos de membrana, as hemácias do neonato são destruídas , e, com isso, há maior metabolismo da hemoglobina e seus produtos (biliverdina e bilirrubina). Neste caso, o grupo sanguíneo da mãe é O- e do neonato

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

é A . Vejamos, então a mãe, sendo O, possui anticorpos NATURAIS contra antígenos A e B ela poderia ter anticorpos anti-D (sistema Rh) se já tivesse sido imunizada anteriormente (ex. gravidez anterior, aborto) mas esta informação não é importante para o diagnóstico, pois a presença dos anticorpos naturais anti-A e anti-B maternos marcam as hemácias A neonatais para destruição no sistema reticuloendotelial, antes mesmo que dê tempo na sensibilização pelo sistema Rh. Por isso, se diz que a incompatibilidade ABO, sendo a mãe O-, previne da imunização contra o sistema Rh. Este neonato está hemolisando pela incompatibilidade ABO, e não Rh. Resposta letra B.

151893.

Comentário: O eritema tóxico é uma dermatose comum no recém-nascido, consiste em pápulas ou lesões vesicopustulosas, que aparecem de 1 a 3 dias após o nascimento, de distribuição em face, tronco e membros e que desaparecem após dias, sem necessidade de tratamento. Quando há dúvidas, o estudo anatomopatológico pode ser realizado e ele mostra infiltrado com eosinófilos. A miliária consiste em pequenas vesicopápulas que aparecem uma semana após o nascimento, devido à obstrução ductas das glândulas sudoríparas, em decorrência da sudorese excessiva. O impetigo neonatal é uma infecção da pele, geralmente por S. aureus ou S. pyogenes , que pode ser crostoso ou bolhoso. A melanose pustular, por sua vez, são pústulas de 2-3mm de diâmetro, autolimitadas que aparecem com maior prevalência na raça negra, podem estar presentes ao nascimento e localizam-se na fronte, região retroauricular e cervical, dorso, mãos e pés. Portanto, resposta letra A .

151911.

Comentário: O manejo do recém-nascido com sífilis congênita depende dos achados de exames do paciente (VDRL no sangue periférico, hemograma, radiografia de ossos longos e avaliação liquórica) e do tratamento materno. No entanto, como a questão quer o tratamento de um recém-nascido (RN) com a doença, devemos automaticamente considerar que o VDRL do RN é positivo e maior que o materno. Logo, temos duas possibilidades terapêuticas. Opção 1 penicilina G procaína na dose de 50000 UI kg dose, IM, dose única diária por 10 dias, se VDRL positivo e maior que o materno com avaliação liquórica normal, independente se houver alterações clínicas e ou

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

sorológicas e ou radiológicas e ou hematológicas. Opção 2 penicilina G cristalina na dose de 50000 UI kg dose, IV por 10 dias (12 12 horas nos primeiros 7 dias de vida e de 8 8 horas a partir do oitavo dia de vida), se houver alteração liquórica (VDRL reagente, proteína 150 mg dL ou celularidade 25 células mm 3) ou para todo RN que se encaixe na opção 1. O que podemos observar é que, independente da análise do líquor, todo paciente com sífilis congênita pode ser tratado com Penicilina G cristalina. E perceba que a única alternativa que cita a penicilina procaína está incorreta, pois afirma que são 2 doses diárias e não dose única conforme relatado. Logo, a Penicilina G cristalina seria a melhor opção e a alternativa D é a que melhor responde a pergunta. No entanto, como o RN está na primeira semana de vida, ou seja, com menos de 7 dias, a dose é de 100.000 UI kg dia (2 doses diárias de 50.000 UI kg) e não variável até 150.000 UI kg dia conforme escrito na alternativa D, pois essa dose só seria possível caso fossem administradas 3 doses diárias de 50.0000 UI kg dia, o que só é indicado a partir do oitavo dia de vida. No entanto, a questão não foi anulada e esta alternativa foi o gabarito da questão. Resposta letra D.

151927.

Comentário: Trata-se de uma questão conceitual. Entre 20 e 24 semanas de gestação, ocorre a diferenciação dos pneumócitos do tipo I e do tipo II. Os pneumócitos do tipo II são os responsáveis pela produção do surfactante entre a 25 a e a 30 a semana. Essa substância é formada por fosfolipídios e proteínas e tem a função de reduzir a tensão superficial da interface ar líquido no alvéolo, evitando seu colapso ao final da expiração. Essa estabilidade alveolar, no entanto, só é observada a partir da 33-34 a semana. Por isso, os recém-nascidos pré-termos abaixo dessa idade gestacional têm risco de desenvolver a doença da membrana hialina, ou síndrome do desconforto respiratório. Resposta letra B.

129808.

Comentário: Imediatamente após o nascimento, a necessidade de reanimação depende da avaliação rápida de 4 situações referentes à vitalidade do concepto, sendo feitas as seguintes perguntas - Gestação a termo - Ausência de mecônio - Respirando ou chorando - Tônus muscular bom Se a resposta é sim a todas as perguntas, considera-se que o recém-nascido está com boa

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

vitalidade e não necessita de manobras de reanimação. Resposta letra D.

129750.

Comentário: De acordo com o Manual de Reanimação Neonatal em Sala de Parto recentemente atualizado em janeiro de 2016, no caso de líquido amniótico meconial (seja ele espesso ou fluido), todo recém-nascido que apresentar ritmo respiratório irregular e ou tônus muscular alterado e ou frequência cardíaca abaixo de 100 bpm deve ser prontamente conduzido à mesa de reanimação, e caso realizados os passos iniciais sem resposta, deve ser iniciada ventilação com pressão positiva através de máscara facial em ar ambiente. Resposta letra B.

107851.

Comentário: Questão simples e conceitual. Rns Adequados para a Idade Gestacional (AIG) são aqueles que se encontram entre os percentis 10 e 90, em gráfico próprio de peso para a idade gestacional. Abaixo do percentil 10, classificamos o RN como pequeno para a idade gestacional (PIG) acima do percentil 90, como grande para a idade gestacional (GIG). Resposta correta letra C .

107860.

Comentário: A icterícia não colestática (às custas de aumento de bilirrubina indireta) pode ter como etiologias hemólise (imunomediada incompatibilidade Rh ou ABO- ou não-imunomediada DG6PD, esferocitose, clampeamento tardio do cordão), hemorragia, baixa ingesta de leite materno (icterícia do aleitamento materno), hipotireoidismo congênito, síndrome de Gilbert ou de Crigler-Najjar. A icterícia colestática (com aumento de bilirrubina direta), por sua vez, tem como etiologias infecções congênitas, atresia de vias biliares e erros inatos do metabolismo. Resposta correta letra B .

103786.

Comentário: A listeriose em humanos é causada principalmente pela Listeria monocytogenes. A infecção por essa bactéria gram-positiva ocorre mais frequentemente nos extremos de idade. Na população pediátrica, infecções perinatais predominam e ocorrem normalmente secundárias a infecção materna ou colonização. Portanto a listeriose deve ser incluída no diagnóstico de sepse neonatal. Clinicamente, é indistinguível de infecções por outras bactérias. O diagnóstico de certeza

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

é feito pela identificação da bactéria em exame de cultura do sangue e ou do líquor e o aumento de monócitos na periferia é sugestivo dessa infecção. Fora do período neonatal, a listeriose deve estar incluída no diagnóstico diferencial de infecções graves em imunodeprimidos. Gabarito letra C.

103811.

Comentário: O enunciado nos apresenta um neonato com alguns sinais de ativação endócrina, tais como hipertrofia de glândulas mamárias, hipertrofia de grandes lábios e descarga vaginal sanguinolenta. Durante a gestação, existe a passagem dos hormônios sexuais da mãe para o feto, através da barreira placentária. Nos recém-nascidos do sexo feminino, a ação destes hormônios nos tecidos sexuais e reprodutórios leva à sua estimulação e hipertrofia. Desta forma, pode ocorrer ingurgitamento mamário pelo aumento das glândulas mamárias, hipertrofia de grandes lábios e até a secreção de conteúdo sanguinolento pela vagina, semelhante a uma menstruação, pela estimulação do endométrio da menina. Essas alterações desaparecem na medida em que os hormônios são degradados pelo organismo do recém-nascido. Desta forma, o manejo consiste em orientar os responsáveis de que essas situações são benignas e autolimitadas e, portanto, não necessitam ser tratadas com qualquer medicamento ou procedimento. Gabarito letra D.

103819.

Comentário: Relembrando as definições quanto à idade gestacional 1) pré-termo 37 semanas 2) a termo 37-41 semanas e 6 dias 3) pós-termo 42 semanas. Gabarito letra C.

87467.

Comentário: Questão bem objetiva. Sabemos que o recém-nascido pode ser classificado de diferentes maneiras, tendo por base a sua idade gestacional, seu peso de nascimento e a adequação de seu peso à sua idade gestacional. Vamos relembrar a classificação do recém-nascido quanto ao seu peso de nascimento, que independe da idade gestacional RN Baixo Peso 2.500 g (entre 1.500 e 2.499g) RN Muito Baixo Peso 1500g (entre 1.000 e 1.499g) RN Extremo Baixo Peso 1.000g. Resposta letra B.

87421.

Comentário: O Apgar é um escore que avalia a vitalidade neonatal precoce, desenvolvido pela

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

anestesista Virgínia Apgar na década de 50. Ele é utilizado até os dias de hoje, pela sua simplicidade e informações úteis. No entanto, esse escore não deve ser usado para determinar o início da reanimação ou definir as manobras que serão adotadas. A confecção do boletim de Apgar é derivada da avaliação de cinco parâmetros clínicos respiração, frequência cardíaca, cor, resposta a estímulos e tônus sendo que cada item recebe uma pontuação que pode ser 0, 1 ou 2. Vamos relembrar como é feita a pontuação do Índice de Apgar - Respiração Ausente 0 Lenta ou Irregular 1 Regular, Chorando 2 - Frequência Cardíaca Ausente 0 100 bpm 1 100 bpm 2 - Cor Cianose central ou palidez 0 Cianose de extremidades 1 Rosado 2 - Resposta à Estímulos (cateter nasal) Sem resposta 0 Caretas, alguma reação 1 Tosse ou espirros 2 -Tônus Flácido 0 Alguma flexão de extremidades 1 Movimentos ativos 2 Desta forma, o recém-nascido da questão apresenta respiração irregular (1) frequência cardíaca acima de 100 bpm (2) movimentos ativos (2) extremidades cianóticas (1) choraminga (1) 7. Resposta letra E.

87471.

Comentário: Para classificar o risco ao nascer do recém-nascido é preciso avaliar fatores de risco na história perinatal e no exame físico inicial desta criança. Diante de todos os achados citados peso ao nascer 2.000 g, desconforto respiratório, rotura prematura de membranas 18h antes do parto, febre materna, idade gestacional 35 semanas, não temos dúvida que este recém-nascido apresenta alto risco ao nascer. Na realidade, era preciso só um desses achados para já classificá-lo dessa forma. (Veja a lista abaixo) Na presença de um dos seguintes sinais, devemos classificar como alto risco ao nascer. Peso ao nascer 2000 g ou 4000 g Idade gestacional 35 semanas Temperatura axilar 36 C ou 37,5 C Desconforto respiratório e ou frequência respiratória 60 ou 30 rpm Febre materna ou corioamnionite Rotura prematura de membranas 12 horas antes do parto Palidez ou pletora Infecção intrauterina (TORCH S) Anomalias congênitas maiores Lesões graves devido ao parto Reanimação com pressão positiva massagem cardíaca. Diante de um RN com alto risco ao nascer, devemos referir urgentemente para UTI Neonatal favorecer o contato pele a pele quando as condições da criança e da mãe permitirem controlar glicemia periférica e tratamento da hipoglicemia, se necessário iniciar a amamentação, se possível (exceto se houver contraindicação,

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

como HIV ou HTLV positivo) manter o RN aquecido se houver a rotura prematura de membranas 12 horas e ou febre materna e ou corioamnionite dar primeira dose dos antibióticos recomendados. Resposta letra C.

81953.

Comentário: O recém-nascido é a faixa etária mais susceptível à doença hemorrágica, já que apresenta níveis mais baixos de fatores de coagulação, menores reservas da vitamina K a baixo aporte desta vitamina quando alimentado pelo leite humano. Por essa razão, está recomendada, ao nascimento, a administração de vitamina K 1 mg IM em dose única, para a prevenção da doença hemorrágica do RN. Resposta Letra D.

81919.

Comentário: Todos os pacientes com suspeita de atresia biliar devem ser submetidos à laparotomia exploradora e colangiografia direta para determinar a presença e o local da obstrução. Em pacientes nos quais não se encontra lesão corrigível, deve se efetuar o procedimento de hepatoportoenterostomia (cirurgia de Kasai). Letra B correta.

81973.

Comentário: Você deve se recordar de ter visto isso no exame físico do recém-nascido na maternidade. A descrição do exame físico deste bebê é típica de uma manobra de Ortolani positiva. Vamos relembrar. A displasia do desenvolvimento do quadril pode ser diagnosticada ainda no período neonatal. O quadril na ocasião do nascimento raramente está luxado, mas é luxável. Todos os recém-nascidos devem ser avaliados para esta patologia, sendo o teste de Barlow a manobra mais importante, que consiste em um teste provocativo para luxar um quadril instável. Já o teste de Ortolani é uma manobra para reduzir um quadril recentemente luxado e visa recolocar o quadril em sua posição, o examinador apoia seus quatro dedos na articulação e o polegar na virilha do bebê, procedendo à abertura da coxa. Se positiva, sente-se um clique na mão. Resposta Letra C.

80965.

Comentário: O diagnóstico diferencial da colestase neonatal, que tem o aumento da bilirrubina direta como seu grande marcador, é uma urgência. Isto deve-se ao fato de que num percentual de

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

casos o diagnóstico será atresia de vias biliares. Esta é a principal causa de transplante de fígado na população pediátrica e o sucesso terapêutico depende em grande parte do diagnóstico rápido e intervenção cirúrgica precoce. Todas as outras assertivas são causas de icterícia por hiperbilirrubinemia indireta. Resposta letra A.

60853.

Comentário: Questão estranha, com poucos dados e opções esquisitas. Vamos tentar entendê-la e explorar o tema. Temos aqui um RN nascido a termo, com peso adequado para a idade, sem intercorrências, e está em aleitamento materno exclusivo. O enunciado diz que o bebê apresentou icterícia, mas não define em que momento isso ocorreu. Sabemos que a icterícia que aparece nas primeiras 24 horas de vida (não sabemos se foi esse o caso) quase sempre está relacionada à anemia hemolítica, mas a questão segue dizendo que essas hipóteses foram descartadas, assim como a presença de infecção. Com os dados oferecidos no enunciado, não há justificativa para iniciarmos fórmula láctea, hidratação venosa ou solução glicosada, muito menos um motivo para contraindicar o aleitamento materno. Independentemente da etiologia da icterícia, ela não contraindicará o aleitamento Ficaremos, assim, com a opção C. Sabemos que os bebês amamentados exclusivamente ao seio materno são fisiologicamente mais ictéricos quando comparados aos RN alimentados por fórmula. Isso ocorre devido ao aumento da circulação entero-hepática, por uma ingestão insuficiente associada às dificuldades da amamentação no período inicial, e consequente menor eliminação de mecônio. Pode ser, portanto, que o nosso bebê em questão tenha apresentado a chamada icterícia do aleitamento materno, uma forma precoce de icterícia associada ao leite materno. O aleitamento materno deve, assim, ser estimulado. Resposta letra C.

60833.

Comentário: Alguns dos cuidados imediatos com o recém-nascido filho de mãe HIV positiva são 1. Limpar com compressas macias todo sangue e secreções visíveis no recém-nascido imediatamente após o nascimento e proceder com banho em água corrente ainda na sala de parto. 2. Quando for necessária a realização de aspiração de vias aéreas do recém-nascido, deve-se proceder

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

delicadamente, evitando traumatismos em mucosas. 3. Iniciar a primeira dose do AZT (zidovudina, e não azitromicina) solução oral preferencialmente ainda na sala de parto, logo após os cuidados imediatos ou nas primeiras 2 horas após o nascimento - opções E e A incorretas. 4. Em virtude de haver possibilidade de ocorrência de anemia no recém-nascido em uso de zidovudina, recomenda-se a realização de hemograma completo, possibilitando a avaliação prévia ao início da profilaxia e o monitoramento após 6 e 16 semanas. 5. É recomendado o alojamento conjunto em período integral, com o intuito de aprimorar o vínculo mãe-filho. 6. Recomenda-se a não amamentação e substituição do leite materno por fórmula infantil após aconselhamento. O aleitamento misto também é contraindicado - opção C incorreta. A opção D é claramente incorreta, uma vez que não há indicação para a realização de teste rápido no recém-nascido. O diagnóstico da doença será feito com base, inicialmente, em realizações de carga viral após o primeiro mês de vida. Assim, podemos dizer sem dúvidas que a resposta correta encontra-se na opção B.

60861.

Comentário: Sempre que estivermos diante de uma gestante com VDRL reagente durante a gestação, a primeira pergunta que devemos fazer é o tratamento foi adequado ou foi inadequado No caso descrito, temos um exemplo de tratamento inadequado, pois foi realizado com uma droga diferente de penicilina. Quando o tratamento não foi realizado ou foi inadequado, o recém-nascido deve ser submetido à realização dos seguintes exames VDRL do sangue periférico, hemograma, radiografia de ossos longos e análise do liquor. A conduta terapêutica será definida de acordo com a avaliação do quadro clínico e dos resultados obtidos nesses exames e pode ser uma das três seguintes 1) Quando há alteração liquórica, o tratamento deve ser feito com penicilina cristalina por 10 dias. Os parâmetros utilizados para a caracterização de neurossífilis incluem a celularidade, a proteinorraquia e o VDRL do liquor. O achado de leucocitose (mais de 25 leuc mm^3, no período neonatal) e concentração elevada de proteínas (mais de 150 mg dl, no período neonatal) devem ser consideradas como evidências para o diagnóstico de neurossífilis. A presença de VDRL positivo no liquor estabelece este diagnóstico, independentemente de haver alterações na celularidade e ou na concentração de proteínas. 2) Quando não há alterações clínicas, radiológicas, hematológicas e

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

ou liquóricas, e a sorologia for negativa, pode ser realizado o tratamento com penicilina G benzatina por via intramuscular na dose única de 50.000 UI kg, desde que o acompanhamento seja garantido 3) Quando há alterações clínicas e ou sorológicas e ou radiológicas e ou hematológicas (e a análise do liquor é normal), o tratamento deverá ser feito com penicilina G cristalina ou penicilina G procaína durante 10 dias. Resposta letra A.

60869.

Comentário: Questão objetiva sobre toxoplasmose congênita, com alteração na fundoscopia e no exame do liquor. O esquema recomendado para tratamento da toxoplasmose congênita no RN é - pirimetamina 2 mg kg dia, VO, nos primeiros dois dias, seguido por 1 mg kg dia - sulfadiazina 100 mg kg dia, VO, de 12 12 horas - ácido folínico 5 a 10 mg dia, VO, três vezes por semana sempre utilizado durante o uso da pirimetamina, para reduzir sua toxicidade. Os corticosteroides têm sido recomendados naqueles RN com acometimento grave do SNC, quando a proteína liquórica for 1 g dl e quando houver coriorretinite em atividade. A dose preconizada de prednisona é de 1 mg kg dia, VO, 12 12 horas, até redução da proteinorraquia e da coriorretinite. Resposta Letra D.

60887.

Comentário: Sobre a toxoplasmose congênita A CORRETA. Tanto os RN com infecção comprovada quanto aqueles filhos de mães com infecção aguda durante a gestação devem ser submetidos à avaliação completa. B INCORRETA. Sabemos que mais de 80% dos RN infectados são assintomáticos e, por essa razão, não apenas os sintomáticos devem ser tratados. Se não tratadas adequadamente, desenvolvem sequelas na infância ou na vida adulta. C INCORRETA. A avaliação oftalmológica é fundamental. Coriorretinite é bastante comum e novas lesões após tratamento têm sido descritas em um percentual das crianças tratadas. D INCORRETA. O tratamento da criança infectada sintomática ou assintomática deve ser iniciado precocemente, devendo prolongar-se até um ano de idade naquelas sintomáticas, pois pode minimizar as repercussões oculares, auditivas e visuais, e melhorar o prognóstico. E INCORRETA. Como já vimos, mesmo os bebês assintomáticos devem ser avaliados, investigados e tratados. Resposta letra A.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

60917.

Comentário: Analisando cada uma das opções A - errado. A descrição desta opção é compatível com icterícia patológica. A icterícia fisiológica se torna visível após as primeiras 24 horas de vida, no 2º-3º dia, geralmente atingindo seu máximo entre o 2º e o 4º dias, com 5-6 mg dl, caindo para menos de 2 mg dl entre o 5º e o 7º dias de vida. B - correto. Icterícia antes de 24 horas é sempre patológica, e níveis de bilirrubina maiores que 12 mg dl em bebês a termo apontam para etiologia patológica. C - errado. A boa sucção ao seio não garante que a icterícia seja fisiológica. A avaliação quanto à etiologia da icterícia deve ser além do exame clínico ectoscópico, sendo necessária avaliação laboratorial. D - errado. Diante de um caso de icterícia é importante que sejam solicitados hematócrito e hemoglobina, bilirrubinas totais e frações, além de Coombs direto e tipagem sanguínea do RN. E - errado. O risco de um recém-nascido desenvolver icterícia deve ser avaliado não somente pela história clínica perinatal e familiar, mas também pelos valores laboratoriais de bilirrubina. Resposta letra B.

60931.

Comentário: Vamos ver o que diz cada uma das alternativas A- Incorreta. Icterícia após as 48 horas não constitui fator de risco, principalmente em criança com boa sucção ao seio materno. B- Incorreta. A idade gestacional de 35-36 semanas constitui um fator de risco para o desenvolvimento de icterícia neonatal. C- Incorreta. O sexo masculino, e não o feminino, constitui fator de risco. D- Incorreta. Na incompatibilidade ABO, geralmente a mãe é do tipo O e o bebê do tipo A ou B. Assim, a situação exposta nesta alternativa não é capaz de gerar doença hemolítica por incompatibilidade ABO. Além disso, esse tipo de incompatibilidade não costuma cursar com doença grave, sendo a icterícia a única manifestação na maioria dos casos. E- Correta. Céfalo-hematoma, equimose, sexo masculino, mãe O com filho A e história de irmão que necessitou de fototerapia são fatores de risco para o desenvolvimento de hiperbilirrubinemia grave. Resposta letra E.

324671.

Comentário: A principal hipótese para a alteração descrita no enunciado é a mielomeningocele, a forma mais grave de disrafismo espinhal a chamada forma aberta , envolvendo a coluna vertebral e

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

a medula espinhal. Este defeito de fechamento do tubo neural pode estar localizado em qualquer região ao longo do neuroeixo, mas 75% dos casos encontram-se na região lombossacra. Os recém-nascidos em geral apresentam uma protusão sacular recoberta por uma membrana fina de tecido parcialmente epitelizado, como descrito, contendo tecido neural e meníngeo, ou mesmo sem tecido recobrindo. A mielomeningocele produz disfunção de muitos órgãos e estruturas, incluindo esqueleto, pele, tratos gastrointestinal e genitourinário, além dos sistemas nervoso periférico e central. O grau e a extensão do déficit neurológico depende da localização e das lesões associadas. Pode haver paralisia flácida dos membros inferiores, ausência de reflexos profundos e de sensibilidade, além de bexiga neurogênica, como descrito. O distúrbio de segmentação e a agenesia segmentar vertebral não cursam com a protrusão sacular descrita. O meningioma lombar é um tumor originado nas meninges além de não ser uma condição observada no período neonatal, tampouco cursa com a protrusão sacular descrita no enunciado. Resposta letra C.

324672.

Comentário: O enunciado descreve uma paciente com suspeita pré-natal de falha de fechamento do tubo neural, descrito como um abaulamento na coluna vertebral lombar. A presença de protrusão sacular coberta por membrana fina e avermelhada sugere o diagnóstico de mielomeningocele, a forma mais grave de disrafismo. Sua causa é desconhecida, mas existe uma predisposição genética, além de fatores nutricionais e ambientais. O folato está intrinsecamente envolvido na prevenção e na etiologia das falhas de fechamento do tubo neural, e a suplementação de ácido fólico no período periconcepcional reduz a incidência dessas condições em pelo menos 50%. Resposta letra D.

324673.

Comentário: A mielomeningocele consiste na forma mais grave e mais comum de espinha bífida, respondendo por cerca de 75% de todos os casos. É uma desordem caracterizada pelo fechamento parcial do tubo neural embrionário, decor- rente da proliferação inadequada de células ectodérmicas durante o segundo trimestre de gestação, deixando uma abertura na coluna vertebral, com um saco dorsal contendo líquido e tecido nervoso no seu interior. Vale ressaltar que

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

mielomeningoclee é diferente de meningocele, esta última ocorre quando a medula espinhal e o tecido nervoso não se projetam para dentro do saco. Neste caso, a lesão é geralmente coberta pela pele. Essa abertura pode ocorrer em qualquer região da medula, mas 75% são de localização lombossacral. A maioria das lesões ocorre na região lombar inferior ou na região sacral, uma vez que essa área cos- tuma ser a última parte da coluna a se fechar. Incluem incapacidades crônicas graves, como paralisia ou deformidades dos membros inferiores e da coluna vertebral, distúrbios da sensibilidade cutânea, descontrole urinário e fecal, disfunção sexual, hidrocefalia, dificuldade de aprendizagem e risco de desajustes psicossociais. Portanto, a nossa paciente, RN de 12 horas de vida, apresenta um quadro típico de mielomeningocele O tratamento da mielomeningocele é cirúrgico O reparo da mielomeningocele tem como objetivo a proteção dos elementos neurais expostos e prevenção de infecção do sistema nervoso central. Para melhor prognóstico neurológico, o fechamento do defeito deve ser realizado preferencialmente nas primeiras 48 horas de vida. Este tratamento deve ser realizado por equipe multidisciplinar, incluindo neonatologista, neurocirurgião e cirurgião plástico, dada a complexidade dos pacientes e possibilidade de outras anomalias associadas. Na grande maioria dos casos é realizado o fechamento com sutura primária sem tensão. No entanto, em aproximadamente 25% dos casos os defeitos apresentam maiores dimensões e necessitam de algum método complementar para fechamento. Os retalhos, enxertos e expansores teciduais podem ser utilizados como um método complementar para o fechamento do defeito cutâneo, mas a literatura traz que o método preferencial é o retalho fasciocutâneo. Os retalhos cutâneos comumente utilizados são romboide e zetaplastia, o retalho fasciocutâneo bipediculado bilateral também pode ser indicado, especialmente para fechamento de defeitos amplos, e, por fim, os retalhos musculocutâneos, dos músculos grande dorsal e glúteo máximo, vêm ganhando destaque nos últimos anos como opção de reparo da mielomeningocele. Resposta letra C.

324825.

Comentário: O enunciado descreve uma paciente de 25 dias de vida, cuja mãe não realizou pré-natal, que nasceu a termo e com baixo peso. Ela apresentou icterícia no primeiro dia de vida e

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

o exame físico evidenciou microcefalia e opacificação da zona pupilar de um dos olhos. Este conjunto de dados nos direciona para a hipótese de uma infecção congênita do grupo das TORCH várias delas cursam com restrição de crescimento intrauterino, icterícia neonatal, acometimento ocular (incluindo catarata) e microcefalia, como a toxoplasmose congênita, a citomegalovirose e a síndrome de zika congênita, mas a principal suspeita é a síndrome da rubéola congênita (SRC). Apesar de não ser possível estabelecer o diagnóstico de certeza, enquanto as demais infecções citadas cursam mais frequentemente com coriorretinite, detectável à fundoscopia, a SRC está classicamente associada à catarata congênita. Esta alteração é visível ao exame físico como a opacificação referida no enunciado. A SRC clássica inclui, além da catarata congênita, a cardiopatia congênita (principalmente persistência do canal arterial, com ou sem estenose de artéria pulmonar), a perda auditiva e o crescimento intrauterino restrito. Resposta Rubéola congênita OU Infecção perinatal por rubéola OU Síndrome de rubéola congênita OU Infecção congênita por rubeola.

324826.

Comentário: O enunciado descreve uma paciente de 25 dias de vida, cuja mãe não realizou pré-natal, que nasceu a termo e com baixo peso. Ela apresentou icterícia no primeiro dia de vida e o exame físico evidenciou microcefalia e opacificação da zona pupilar de um dos olhos. Este conjunto de dados nos direciona para a hipótese de uma infecção congênita do grupo das TORCH várias delas cursam com restrição de crescimento intrauterino, icterícia neonatal, acometimento ocular e microcefalia, como a toxoplasmose congênita, a infecção congênita pelo citomegalovírus e a síndrome de zika congênita, mas a principal suspeita é a síndrome da rubéola congênita (SRC). De fato, enquanto as demais infecções citadas cursam mais frequentemente com coriorretinite, detectável à fundoscopia, a SRC está classicamente associada à catarata congênita, visível ao exame físico como a opacificação referida pode ocorrer também glaucoma, retinopatia em sal e pimenta e microftalmia. A SRC clássica inclui, além da catarata, cardiopatia congênita e a perda auditiva. As lesões cardíacas estão presentes em mais da metade dos infectados nas primeiras oito semanas de gestação, e a alteração mais comum é a persistência do canal arterial, com ou sem estenose de ramo de artéria pulmonar. As alterações auditivas se caracterizam por surdez

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

neurossensorial bilateral ou isolada. Além disso, pode haver alteração de sistema nervoso central além da já citada microcefalia, há associação com retardo do desenvolvimento neuropsicomotor, distúrbios comportamentais e psiquiátricos, além de transtorno do espectro autista. As endocrinopatias são manifestações tardias da infecção, incluindo diabetes mellitus tipo 1 e disfunção tireoideana. Resposta Perda de audição OU Surdez congênita OU Surdez. Cardiopatia congênita OU Estenose da artéria pulmonar OU Persistência do canal arterial OU Persistência do ducto arterial.

324827.

Comentário: O enunciado descreve uma paciente de 25 dias de vida, cuja mãe não realizou pré-natal, que nasceu a termo e com baixo peso. Ela apresentou icterícia no primeiro dia de vida e o exame físico evidenciou microcefalia e opacificação da zona pupilar de um dos olhos. Este conjunto de dados nos direciona para a hipótese de uma infecção congênita do grupo das TORCH várias delas cursam com restrição de crescimento intrauterino, icterícia neonatal, acometimento ocular e microcefalia, como a toxoplasmose congênita, a infecção congênita por citomegalovírus (CMV) e a síndrome de zika congênita, mas a principal suspeita é a síndrome da rubéola congênita (SRC). De fato, enquanto as demais infecções citadas cursam mais frequentemente com coriorretinite, detectável à fundoscopia, a SRC está classicamente associada à catarata congênita, visível ao exame físico como a opacificação referida pode ocorrer também glaucoma, retinopatia e microftalmia. Em todo RN cuja mãe teve diagnóstico confirmado de rubéola durante a gestação ou lactente com suspeita de síndrome da rubéola congênita, deve-se realizar a dosagem de IgM e IgG específicas para rubéola. O feto infectado produz anticorpos IgM e IgG mesmo antes do nascimento a presença de IgM específica para rubéola é evidência de infecção congênita. Os anticorpos IgM podem ser detectados em 100% das crianças com síndrome da rubéola congênita até o 5º mês, em 60% de seis a doze meses e em 40% de 12 a 18 meses raramente são detectados após o 18º mês. Como não é possível diferenciar os anticorpos IgG maternos daqueles produzidos pelo próprio feto, devemos realizar o pareamento dos títulos sorológicos. Quando o título se mantém ou é maior após três meses da primeira coleta, podemos confirmar o diagnóstico

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

de infecção congênita. Como a quantidade de IgG materna diminui com o tempo, desaparecendo por volta do sexto mês, a persistência dos títulos de IgG no sangue do lactente é altamente sugestiva de infecção intrauterina. Além da avaliação sorológica, deve-se tentar o isolamento viral por PCR ou cultura o material mais usado é a secreção da faringe posterior por meio de swab. Apesar da investigação de outras infecções congênitas ser justificável, como discutimos acima, o gabarito da banca se restringiu à investigação da SRC. Resposta anticorpos anti-rubéola IgM positivos OU sorologia para rubéola IGM positiva. Anticorpos anti-rubéola IgG persistentes OU alta avidez dos anticorpos anti-rubéola. Demonstração do vírus da rubéola por PCR OU por cultura viral.

284619.

Comentário: A questão foi anulada por não contemplar no enunciado todos os dados necessários para o cálculo do escore de Apgar. De todo modo, vamos aproveitar para nos lembrarmos como a avaliação é feita. O escore de Apgar avalia cinco parâmetros a respiração, a frequência cardíaca, o tônus muscular, a resposta ao cateter nas narinas (omitida no enunciado) e a cor. Para cada um desses parâmetros é atribuída uma pontuação que varia de 0 a 2, da seguinte forma - Respiração 0 ausente 1 irregular 2 regular ou choro. - Frequência cardíaca 0 ausente 1 - 100 bpm 2 - 100 bpm. - Tônus muscular 0 totalmente flácido 1 alguma flexão de extremidades 2 movimentos ativos. - Resposta ao cateter nas narinas 0 sem resposta 1 caretas, alguma reação 2- tosse ou espirro. - Cor 0 cianose central ou palidez 1 cianose de extremidades 2 róseo.

284620.

Comentário: Tal questão deveria ter sido anulada, mas a banca manteve seu gabarito original. Lembre-se de que, após o nascimento, devemos avaliar a respiração e o tônus da criança para determinarmos se há necessidade do clampeamento imediato e início das manobras. Os recém-nascidos que não iniciam movimentos respiratórios regulares e ou aqueles em que o tônus muscular está flácido precisam ser conduzidos à mesa de reanimação, indicando-se os passos iniciais da estabilização na seguinte sequência prover calor, posicionar a cabeça em leve extensão, aspirar boca e narinas (se necessário) e secar. Tais passos devem ser executados em, no máximo, 30 segundos. O gabarito da banca, letra B, indica que a secagem da criança é feita no mesmo

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

momento em que está é recepcionada em campos estéreis, o que não é o proposto pelo programa de reanimação da Sociedade Brasileira de Pediatria. Cabe lembrar que a mesa de reanimação não deve ter qualquer inclinação. Apesar dos recursos, a banca manteve como gabarito a letra C.

284621.

Comentário: A questão foi, corretamente, anulada após os recursos por não trazer qualquer resposta correta. Logo após o nascimento, devemos avaliar a idade gestacional, a respiração e o tônus da criança. Se, ao nascimento, está respirando ou chorando e com tônus muscular em flexão, independentemente do aspecto do líquido amniótico, ele apresenta boa vitalidade. A banca certamente usou o termo vitalidade de forma equivocada para definir os parâmetros que são avaliados durante as manobras de reanimação, mas ainda assim a resposta estaria incorreta. Os parâmetros avaliados são a frequência cardíaca e o padrão respiratório, não a frequência respiratória. Por conta de tudo isso, não houve outra opção a não ser a anulação da questão.

230172.

Comentário: Questão bastante estranha e que trouxe conceitos errados no enunciado. Logo após o nascimento, quando o recém-nascido não está respirando ou não tem tônus adequado, deve ser feito o clampeamento imediato do cordão e a criança deve ser conduzida à mesa de reanimação. As primeiras intervenções a serem executadas são os passos iniciais prover calor posicionar a cabeça em leve extensão aspirar as vias aéreas se necessário secar o recém-nascido. Todos estes passos devem ser executados em até 30 segundos. Após, é feita a avaliação da frequência cardíaca e da respiração. Quando a frequência é menor que 100 bpm, a respiração é irregular ou a criança está em apneia, deve ser iniciada a ventilação com pressão positiva. Era esta a intervenção que a banca queria que fosse indicada. A pergunta que fazemos é o que foi esta oferta de oxigênio por máscara descrita Isso não é recomendado no programa. Além disso, ao iniciarmos a ventilação em uma criança com 34 ou mais semanas, esta deve ser feita em ar ambiente. O gabarito oficial da banca do concurso aceitou a descrição de prover oxigênio, o que está incorreto. O gabarito oficial foi Ventilar com bolsa e máscara OU Ventilar com Ambú e máscara OU Ventilar E oxigenoterapia OU prover oxigênio OU administrar oxigênio OU prover oxigênio por pressão positiva.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

230173.

Comentário: Existem diversas condições perinatais que estão associadas à necessidade de reanimação neonatal e ao quadro de hipóxia. Estas situações incluem condições antenais e fatores associados ao parto. O gabarito inicial da banca indicou as seguintes possibilidades de resposta prematuridade gemelaridade malformações OU anomalias fetais medicamentos utilizados pela parturiente parto cesariano rotura de membranas há mais de 18 horas trabalho de parto prolongado descolamento prematuro de placenta placenta prévia nó verdadeiro de cordão líquido amniótico meconial apresentação não cefálica OU apresentação pélvica ou córmica uso de fórceps. De fato, estas condições podem ser fatores associados ao desenvolvimento de hipóxia. A questão foi anulada sem uma justificativa da banca. É possível que isso tenha ocorrido por não ter ficado claro se deveriam ser citados apenas fatores no enunciado ou fatores gerais.

230174.

Comentário: Questão bem objetiva, que avaliou uma pequena decoreba. Logo após o nascimento, os valores normais de saturação de um recém-nascido são mais baixos do que os observados após os primeiros minutos de vida. As seguintes faixas são consideradas normais até cinco minutos de vida.

176341.

Comentário: O teste do coraçãozinho, ou teste da oximetria, faz parte da triagem neonatal obrigatória é deve ser feito em todos recém-nascidos com mais de 34 semanas entre 24 e 48 horas de vida. A aferição da oximetria é feita membro superior direito e em um dos membros inferiores. Deste modo, o único equipamento necessário é o oxímetro. O gabarito oficial foi Oxímetro de pulso, com monitor OU Oxímetro OU Oxímetro digital OU Saturímetro.

176343.

Comentário: O teste da oximetria visa detectar as cardiopatias congênitas críticas, que irão evoluir com deterioração após o fechamento do canal arterial. Deve ser realizado entre 24 e 48 horas de vida, momento em que a transição da circulação fetal para a neonatal já está mais estabilizada e antes das manifestações clínicas. O gabarito oficial foi Entre 24 e 48 horas de vida OU Entre 1 a

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

dois dias.

176339.

Comentário: O grande objetivo do teste da oximetria, ou teste do coraçãozinho, é justamente a identificação das cardiopatias congênitas consideradas críticas. Chamamos de cardiopatias congênitas críticas aquelas cardiopatias que irão evoluir com grave deterioração clínica no momento do fechamento do canal arterial. Isso pode ocorrer em cardiopatias com fluxo pulmonar dependente do canal arterial (exemplos atresia pulmonar e similares), cardiopatias com fluxo sistêmico dependente do canal arterial (exemplos síndrome de hipoplasia do coração esquerdo, coartação de aorta crítica e similares) e cardiopatias com circulação em paralelo (transposição das grandes artérias). O gabarito oficial da banca foi São cardiopatias cujo fluxo pulmonar ou sistêmico dependem do canal arterial OU Cardiopatias que agravam com o fechamento do canal arterial OU Transposição de grandes vasos.

152201.

Comentário: Existem diversas condições que podem ser avaliadas na história materna e obstétrica que se associam a um maior risco de haver necessidade de alguma medida de reanimação neonatal. Da mesma forma, há fatores relacionados ao parto que também indicam isso. Em seu Programa de Reanimação Neonatal, a Sociedade Brasileira de Pediatria indica os seguintes pontos - Fatores antenatais idade 16 anos ou 35 anos idade gestacional 39 ou 41 semanas diabetes gestação múltipla síndromes hipertensivas rotura prematura das membranas doenças maternas polidrâmnio ou oligoâmnio infecção materna diminuição da atividade fetal aloimunização ou anemia fetal sangramento no 2 o ou 3 o trimestre uso de medicações discrepância de idade gestacional e peso uso de drogas ilícitas hidropsia fetal óbito fetal ou neonatal anterior malformação fetal ausência de cuidado pré-natal. - Fatores relacionados ao parto padrão anormal de frequência cardíaca fetal parto cesáreo anestesia geral uso de fórcipe ou extração a vácuo hipertonia uterina apresentação não cefálica líquido amniótico meconial trabalho de parto prematuro prolapso ou rotura de cordão parto taquitócico nó verdadeiro de cordão corioamnionite uso de opioides 4 horas anteriores ao parto rotura de membranas 18 horas descolamento prematuro da placenta trabalho

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

de parto 24 horas placenta prévia segundo estágio do parto 2 horas sangramento intraparto significante. Assim, no caso clínico, identificamos alguns fatores idade menor de 16 anos idade gestacional menor que 39 semanas (embora a banca tenha indicado no seu gabarito que o fator de risco seria a idade gestacional menor que 38 semanas) rotura de membranas 18 horas. Embora houvesse o relato de infecção materna durante a gestação, tal fator não foi contemplado pela banca em seu gabarito oficial. GABARITO PÓS Resposta Oficial Idade gestacional inferior a 38 semanas Idade materna inferior a 16 anos e rotura de membranas há mais de 18 horas Respostas Equivalentes Gestação menor que 38 semanas mãe menor que 16 anos e rotura de bolsa amniótica há mais de 18 horas Gestação menor que 38 semanas mãe adolescente e perda de líquido amniótico há mais de 18 horas Idade gestacional inferior a 38 semanas Idade materna inferior a 16 anos e rotura de membranas em período prolongado.

152204.

Comentário: Abaixo de 100 bpm. Após os cuidados para manter a temperatura e a permeabilidade das vias aéreas do RN, a presença de apneia, respiração irregular e ou FC 100 bpm indica a Ventilação com Pressão Positiva (VPP). Esta precisa ser iniciada nos primeiros 60 segundos de vida (The Golden Minute). A ventilação pulmonar é o procedimento mais simples, importante e efetivo na reanimação do RN em sala de parto. GABARITO OFICIAL Abaixo de 100 bpm RESPOSTAS EQUIVALENTES Menor do que 100 bpm Inferior a 100 batimentos por minuto GABARITO PÓS Resposta Oficial Abaixo de 100 bpm Respostas Equivalentes Menor do que 100 bpm Inferior a 100 batimentos por minuto.

152206.

Comentário: Questão, no mínimo, polêmica. Não há dúvidas de que o antídoto usado para o uso de opioides é a naloxona. Porém, há vários anos o Programa de Reanimação Neonatal da Sociedade Brasileira de Pediatria não recomenda mais essa medida nos casos em que a criança tem depressão respiratória associada ao uso dessa substância pela mãe. A recomendação atual é de que a ênfase seja dada à ventilação com pressão positiva. Tanto é assim que, surpreendentemente, a banca aceitou, após os recursos, a indicação de adrenalina, pois esta é a

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

principal medicação feita em sala de parto. Porém, cabe lembrar que só há indicação de adrenalina após a massagem cardíaca, quando a frequência cardíaca permanece abaixo de 60 bpm. GABARITO OFICIAL Administrar Naloxone à criança RESPOSTAS EQUIVALENTES Usar Naloxone para a criança. GABARITO PÓS Resposta Oficial Administrar Naloxone à criança Respostas Equivalentes Usar Naloxone para a criança OU repetir adrenalina.

129980.

Comentário: A primeira parte dessa questão era relativamente simples classificar o recém-nascido em relação a sua idade gestacional. Sabemos que um recém-nascido pode ser prematuro (menos de 37 semanas de gestação), a termo (idade gestacional entre 37 semanas e 41 semanas e 6 dias) ou pós-termo (42 ou mais semanas de gestação). Assim, um recém-nascido com 36 semanas é um prematuro (a banca também aceitou o termo prematuro limítrofe). Já a segunda parte da pergunta era mais difícil. Na verdade, o difícil era saber o que a banca queria que fosse indicado Sabemos que, nos primeiros dias de vida, é natural que ocorra perda ponderal. Esta perda relaciona-se com a eliminação do mecônio e contração do líquido extravascular. Uma perda ponderal de até 10% costuma ser considerada fisiológica e espera-se que o peso de nascimento já tenha sido recuperado até o 10 o dia de vida ou final da 2 a semana de vida. Neste caso apresentado, temos um recém-nascido que já se encontra no 16 o dia de vida e que ainda não recuperou o peso de nascimento. Isso não é o habitual (ainda que a recuperação do peso possa ser mais lenta nos prematuros). Por essa razão, a banca queria que o candidato indicasse que esta perda é patológica. Porém, não havia sido pedido que fosse feita a classificação ou a avaliação da perda ponderal mas sim que fosse indicado por qual razão ela ocorre. Difícil saber o que responder assim, não é mesmo Gabarito oficial Prematuro limítrofe OU Prematuro Justificativa A Perda de peso é patológica OU anormal, já que a perda fisiológica de 10% do peso deve estar recuperada entre 10 a 15 dias de vida.

106525.

Comentário: Estamos diante de um recém-nascido ictérico e, por mais que saibamos que a icterícia fisiológica é a principal causa de icterícia no período neonatal, é evidente que este não poderá ser

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

o diagnóstico neste caso. Com apenas 18 horas de vida já é possível observar uma icterícia que alcança a zona III de Kramer. A avaliação complementar nos informa que a hiperbilirrubinemia desta criança relaciona-se com o aumento de bilirrubina indireta e, deste modo, reforçamos a suspeita de que a causa da icterícia seja uma anemia hemolítica. As principais causas de hemólise no período neonatal são aquelas relacionadas à incompatibilidade materno fetal, sendo que a incompatibilidade ABO é a mais comum. Comparando a tipagem sanguínea e Rh da criança e da mãe percebemos que não há possibilidade de incompatibilidade Rh, pois a mãe é Rh positivo, apenas ABO. Assim, o gabarito oficial da banca foi Doença hemolítica do RN por incompatibilidade Sanguínea Materno-fetal do grupo ABO ou Doença hemolítica do RN por incompatibilidade ABO ou Hiperbilirrubinemia por incompatibilidade ABO.

106514.

Comentário: Estamos diante de um recém-nascido que apresenta um quadro de icterícia precoce, provavelmente por uma incompatibilidade ABO. Mesmo sem dispor de gráficos, fique com a seguinte ideia um recém-nascido que tem uma doença hemolítica que leva à icterícia tão precocemente, certamente terá níveis de bilirrubina que indicam a necessidade de fototerapia. A exsanguineotransfusão em geral só será recomendada quando após a fototerapia os níveis de bilirrubina mantém-se elevados, em faixas que demandam a necessidade do procedimento. Só é indicada mais precocemente quando há sinais de encefalopatia ou em casos selecionados de incompatibilidade Rh. O gabarito oficial foi fototerapia.

106515.

Comentário: A grande preocupação relacionada com o aumento da bilirrubina no período neonatal relaciona-se ao maior risco, nesta fase da vida, de passagem do pigmento pela barreira hematoencefálica, levando ao quadro grave de encefalopatia bilirrubínica. O período neonatal é particularmente vulnerável à lesão neurotóxica mediada pela BI em decorrência de vários fatores, como hipoproteinemia (maior teor de bilirrubina livre, que é fração que atravessa a barreira hematoencefálica) deslocamento da bilirrubina de seus sítios de ligação na albumina associado ao uso de determinadas drogas deslocamento da bilirrubina de seus sítios de ligação na albumina na

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

presença de determinadas condições como acidose, aumento dos ácidos graxos livres no soro (secundário a hipoglicemia e hipotermia) e aumento da permeabilidade da barreira hematoencefálica por imaturidade (prematuros), asfixia, infecção, etc. A banca indicou que o rápido aumento da bilirrubina também seria um fator de risco para aumento da toxicidade e o gabarito oficial foi prematuridade baixo peso hipoxia persistente ou acidose sepse hipoalbuminemia aumento da bilirrubina total 1 mg dl hora.

62894.

Comentário: Analisando as opções A verdadeira. A catarata é definida pela opacificação total ou parcial do cristalino e a cegueira causada por catarata congênita e infantil apresenta-se como um enorme problema em países em desenvolvimento. A catarata congênita é uma das causas mais comuns de cegueira uni ou bilateral evitável na infância. Programas de vacinação contra a rubéola e o diagnóstico e tratamento precoce podem diminuir a incidência de cegueira por catarata na infância. Alguns estudos determinaram que existe um período, desde o nascimento, para o desenvolvimento do reflexo de fixação, que termina entre o 2º e o 4º mês de vida, e que a privação visual neste intervalo leva à atrofia do corpo geniculado lateral e, consequentemente, à ambliopia irreversível. O mecanismo da instalação da ambliopia na catarata unilateral é múltiplo, pois pode se associar à privação visual pela catarata, à anisometropia e ao estrabismo. Estes três fatores indutores de ambliopia, quando associados, acarretam uma perda visual mais grave, que exige tratamento e reabilitação precoce. O nistagmo ou a perda do reflexo de fixação, que se desenvolve como resultado da catarata congênita, pode diminuir após a remoção cirúrgica da catarata e do tratamento pós-operatório da ambliopia. B verdadeira. O retinoblastoma é um tumor maligno de células embrionárias localizadas na retina, sendo o tumor intraocular mais comum na infância. O retinoblastoma pode ser verificado em crianças independente de sexo ou de raça. À semelhança de outros tumores, ele tem como causa uma mutação genética. Esse tumor pode estar presente ao nascimento, mas também pode surgir nos primeiros 5 anos de vida. Na maioria dos casos, a ocorrência do retinoblastoma é isolada, pois a família não relata essa doença em parentes, próximos ou distantes. Muitas vezes a família só percebe que a criança tem dificuldades visuais

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

quando o tumor já está em um estado avançado, tornando menores as chances de cura completa, daí a importância da triagem universal através do teste do reflexo vermelho ainda na maternidade. C verdadeira. A Retinopatia da Prematuridade (ROP) é uma doença vasoproliferativa secundária à inadequada vascularização da retina imatura dos recém-nascidos prematuros, que pode levar à cegueira ou a graves sequelas visuais. É uma das principais causas de cegueira prevenível na infância. A proporção de cegueira causada pela ROP é muito influenciada pelo nível de cuidados neonatais (disponibilidade de recursos humanos, equipamentos, acesso e qualidade de atendimento), assim como pela existência de programas de triagem e tratamento. Por conseguinte, existe grande variabilidade de ocorrência da doença em países desenvolvidos e em desenvolvimento. Quanto menor a idade gestacional e o peso, maior o risco de desenvolver a ROP, sendo que o grupo mais frequentemente acometido tem menos de 1.500 gramas de peso ao nascer e ou idade gestacional 32 semanas. D verdadeira. Leucocoria corresponde a um reflexo pupilar anormal branco, róseo ou amarelo-esbranquiçado. Este sinal clínico sugere a presença de anormalidade anterior à retina, que reflete a luz incidente à pupila antes que a luz alcance a retina ou a coroide, podendo decorrer de tumor intraocular, membrana vítrea ou descolamento retiniano. A causa mais comum de leucocoria é o retinoblastoma, um tumor de células retinianas imaturas. Outras causas comuns, em ordem decrescente de frequência, são a persistência hiperplásica do vítreo primitivo, a doença de Coats, a toxocaríase, a retinopatia da prematuridade e o hamartoma astrocítico. Causas menos frequentes são os colobomas de coroide, as hemorragias vítreas organizadas e o meduloepitelioma. Catarata congênita devido às infecções citadas na assertiva e descolamento da retina de longa evolução também devem ser lembrados. E falsa. As apresentações clínicas mais frequentes da toxocaríase ocular são endoftalmite crônica, formação de granuloma no polo posterior ou formação de granuloma periférico. Na forma ocular, os sintomas são geralmente unilaterais (perda visual unilateral), ocorrendo mais comumente em crianças mais velhas. Resposta letra E.

62892.

Comentário: Repare que existem alguns estigmas fenotípicos característicos na criança em questão

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

isso já apontaria para uma provável síndrome genética cromossomial ou por teratogenicidade, como o que temos no caso. Tudo aponta na direção da síndrome alcoólica fetal, que tem alguns critérios que se preenchem para seu diagnóstico. Esses seriam 1. Retardo de crescimento pré ou pós-natal 2. Envolvimento do sistema nervoso, atraso do desenvolvimento neuropsicomotor e alteração do QI e do comportamento 3. Dismorfismo facial. Pelo menos dois sinais dos apresentados a seguir devem estar presentes microcefalia, microftalmia e ou fissura palpebral pequena, filtro nasal hipoplásico com lábio superior fino e hipoplasia de maxilar. É quase universal a história de baixo peso ao nascer e alterações neurológicas já no período neonatal, como sucção débil, hiperexcitabilidade e hipertonia (com eventual aparecimento de opistótono, como no caso). Resposta letra A.

62888.

Comentário: A história tem todos os elementos a favor do diagnóstico de Taquipneia Transitória do Recém-Nascido (TTRN), a síndrome dos pulmões úmidos . Vamos recapitular o que vimos em aula e no nosso rico material didático. 1º elemento idade gestacional próximo do termo para a doença da membrana hialina, geralmente temos um prematuro com menos que 34 semanas de idade gestacional na TTRN, a ausência de trabalho de parto e consequente cesariana geralmente ocorre quando os pulmões ainda não conseguiram absorver o líquido que os preenchia intra-útero geralmente a cesariana eletiva presente nesses casos é marcada para um momento em que a gestação está a termo ou muito próxima a isso. 2º elemento boa saturação de oxigênio apesar de não estar sempre presente a manutenção de uma boa oxigenação fala contra qualquer dos diagnósticos aventados nas outras opções que não a B. 3º elemento radiografia de tórax evidência de congestão pulmonar exatamente pelos motivos já descritos no início dessa explanação. Resposta letra B.

281861.

Comentário: O CPAP consiste em um método de suporte ventilatório capaz de manter uma pressão positiva contínua na via aérea do pacientes. A ideia aqui é abrir mais alvéolos e aumentar a área de troca gasosa, com maior eficiência do sistema respiratório. Como consequência, esperamos que

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

ocorra uma redução do trabalho muscular, melhora da função diafragmática e também do consumo de oxigênio. Como estamos falando de um método que trabalha com pressão positiva, naturalmente, essa pressão é capaz de expulsar o conteúdo líquido presente no interior dos alvéolos e, com isso, reduzir o edema alveolar. Repare que estamos falando um método onde o dispositivo fornece uma pressão contínua e o paciente realiza todo o resto. Ou seja, os ciclos respostórios são espontâneos Outro grande benefício do CPAP é a possibilidade de ventilar o paiente sem invadir a sua via aérea - não é a toa que chamamos esse método de ventilação não-invasiva. Com isso, poupamos o paciente da sedação, da laringoscopia e de todos os outros riscos envolvidos neste processo. Portanto, quando bem indicado, pode reduzir a morbimortalidade dos pacientes. Resposta letra B.

281886.

Comentário: Oftalmia neonatal é uma forma de conjuntivite que ocorre em crianças com menos de quatro semanas de vida. A oftalmia neonatal é uma condição potencialmente grave, que pode levar à cegueira e manifesta-se por hiperemia e edema na conjuntiva, edema palpebral e presença de secreção, que pode ser purulenta. Nesse período, o diagnóstico diferencial costuma ser entre a conjuntivite gonocócica e a conjuntivite por clamídia. Gardnerela, tricomonas e estreptococo do grupo B são agentes que raramente causam esse quadro no neonato. O tempo de incubação da conjuntivite gonocócica é de dois a cinco dias, enquanto da conjuntivite por clamídia é mais longo, entre cinco e 15. A conjuntivite gonocócica pode levar a um quadro grave, que se espalha para as camadas mais profundas da conjuntiva e da córnea. Na conjuntivite por clamídia, a córnea raramente é afetada. Resposta letra B.

215592.

Comentário: Questão direta. Os dentes de Hutchinson (incisivos centrais superiores deformados) são característicos da sífilis congênita tardia. As manifestações da sífilis congênita tardia incluem também fronte olímpica, tíbia em sabre, nariz em sela, articulações de Clutton (derrame articular estéril nos joelhos), retinite, ceratite intersticial, lesão do 8º par craniano, levando à surdez e vertigem, hidrocefalia e retardo mental. Resposta Letra A.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

181168.

Comentário: A opção A está correta. São indicações de realização da TC de crânio antes da punção lombar as situações descritas na afirmativa, pelo risco de herniação nesses casos. A letra B também é correta. Os agentes mais frequentes das encefalites são vírus herpes, vírus da varicela zoster, os vírus do sarampo e da caxumba, além do citomegalovírus e o Epstein Barr e outros enterovírus. A opção C está incorreta, uma vez que diante de qualquer suspeita de imunodeficiência, a primeira a se pensar é o HIV. Infecções graves como osteomielite, sepse, candidíase grave e otites de repetição, por exemplo, levantam a suspeita de imunodeficiência e a pesquisa de HIV está indicada. A opção D é correta. Deve-se considerar o uso de corticoide em qualquer infecção de sistema nervoso central, principalmente nos primeiros dias de doença, o mesmo para casos de vasculopatia pela varicela zoster. Resposta letra C.

157582.

Comentário: Todas são conceituais e estão corretas, exceto a letra D. O tratamento de escolha para a atresia de vias biliares é a cirurgia de Kasai-Moro, que idealmente deve ser feita nos primeiros 60 dias de vida, momento em que os resultados tendem a ser MELHORES Resposta certa D.

157609.

Comentário: Questão tranquila. A polidraminia decorre de uma não absorção do líquido aminiótico ou da sua hiperprodução. Das opções abaixo, a agenesia estaria relacionada a oligo e não poli. Gabarito C.

157614.

Comentário: Questão simples O período neonatal, que corresponde do primeiro dia de nascimento até 28 dias de vida, é mais vulnerável às complicações infecciosas, especialmente bacterianas devido à imaturidade do sistema imune. As principais bactérias causadoras de doenças nesta fase são o Streptococcus agalactiae (grupo B) e gram-negativos entéricos (E. coli, Klebsiella), ambos patógenos da flora vaginal e gastrointestinal materna que podem provocar sepse, pneumonia, infecção urinária e meningite. Portanto, a escolha do esquema de tratamento antibiótico nesta fase

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

é sempre o mesmo, independente da localização da infecção ampicilina gentamicina. Logo, gabarito letra D.

157708.

Comentário: As infecções fúngicas neonatais são responsáveis por cerca de 12% das infecções tardias, estando diretamente relacionadas à contaminação intrahospitalar e tendo como fatores de risco prematuridade extrema, recém-nascidos com menos de 1 kg, uso prolongado de nutrição parenteral, uso de antibióticos de largo espectro e intubação ou acessos vasculares prolongados. Desta forma, bebês nascidos com menos de 27 semanas devem receber antifúngico (em geral, fluconazol) profilático, assim como deve ser estimulado o uso racional de antibióticos, evitando os de largo espectro sempre que possível. Devido ao seu potencial efeito imunossupressor, os corticoides devem também ser usados em situações específicas, e acessos vasculares, sondas e tubos devem ser retirados tão logo não sejam mais necessários. Desta forma, resposta alternativa B.

139755.

Comentário: Estamos diante de um feto que apresentou um quadro de falência cardíaca durante uma contração uterina e que persistiu durante o seu término. Desta forma, podemos afirmar que estamos diante de um sofrimento fetal e, se tratando de um trabalho de parto a termo, possivelmente não se trata de um quadro de imaturidade cardíaca, mas sim de asfixia perinatal, que corresponde a diminuição do fornecimento nutricional e metabólico da mãe para o feto, levando a má perfusão dos órgãos vitais, com consequente hipoxemia, levando ao quadro de bradicardia apresentado. Sendo assim, a resposta correta é a alternativa C

139794.

Comentário: O teste de Galeazzi detecta a presença de deslocamento unilateral congênito do quadril em crianças. Para sua avaliação, a criança é posicionada em decúbito dorsal com os quadris fletidos a 90º graus e os joelhos completamente fletidos. O teste é positivo se um joelho estiver mais alto que o outro. Resposta alternativa A

111930.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

Comentário: Toda icterícia iniciada nas primeiras 24h de vida é considerada patológica. No caso descrito temos mãe O negativo e criança A positivo, com Coombs direto negativo. O tipo de incompatibilidade materno-fetal mais comum é a do sistema ABO, cujo Coombs direto pode ser positivo em 20% a 40% dos casos, e que pode ocorrer na primeira gestação. A doença hemolítica por incompatibilidade Rh implica necessariamente em sensibilização prévia (coombs indireto positivo) e o coombs direto é positivo. Resposta correta Letra C .

111935.

Comentário: Temos um bebê prematuro tardio em aleitamento exclusivo e sem hipoglicemia que com 72 horas de vida apresenta uma perda ponderal de 10% do seu peso de nascimento. Em geral, esta é a perda ponderal máxima, aceitável durante a primeira semana de vida. Não existe indicação de permanecer hospitalizado, mas é necessária uma reavaliação clínica próxima (em 48 horas) com o intuito de acompanhar de perto a evolução do peso. Melhor resposta alternativa A.

111829.

Comentário: As opções de A até C trazem afirmativas corretas em relação ao aleitamento materno, à exceção da letra D. O processo de Aleitamento Materno (AM), que deve se iniciar ainda dentro da 1ª hora de vida na sala de parto, e continuar no alojamento conjunto não é um treinamento fácil ou mesmo instintivo da mãe, de modo que possam aprender sozinhas e umas com as outras. Muito pelo contrário, o AM deve ser ENSINADO, TREINADO com técnica de pega e posicionamento, e APOIADO, pois não é um conhecimento intrínseco das mães. Gabarito letra D.

350850.

Comentário: O enunciado apresenta um recém-nascido (RN) com alguns fatores de risco para a ocorrência de hipoglicemia (prematuridade e pequeno para idade gestacional - PIG), com glicemia capilar de 28 mg dl com 2 horas de vida. A hipoglicemia é o distúrbio metabólico mais frequente em neonatologia e, ainda que transitório, deve ser adequadamente manejado para evitar consequências neurológicas e de desenvolvimento de longo prazo. Os pontos de corte que caracterizam a hipoglicemia neonatal variam com a referência os níveis sanguíneos de glicose dos RN caem para cerca de 30 mg dL com 1 a 2 horas de vida e, logo após, aumentam para mais de

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

45 mg dL. Vamos analisar as afirmativas. Letra A incorreta. É o contrário - o álcool pode levar à leitura mais baixa que a real, e por isso sua utilização deve ser evitada ou o excesso ser removido com algodão seco. Letra B incorreta. O tratamento da hipoglicemia depende da presença de sintomas nos sintomáticos, é feita glicose por via endovenosa (EV) e dos valores aferidos. O tratamento da hipoglicemia assintomática consiste no aumento da frequência de alimentação, apoiando o aleitamento materno pode ser utilizado também o gel de dextrose a 40%. Na impossibilidade do leite materno, pode-se usar fórmula láctea, mas esta não deve ser prescrita de forma regular. Letra C correta. A obtenção de glicemia capilar de extremidades frias ou cianóticas também pode causar uma falsa hipoglicemia. Por isso, deve-se aquecer a extremidade a ser puncionada previamente. Além disso, a hipotermia pode agravar a hipoglicemia. Perceba que este RN tem acrocianose e temperatura abaixo de 36,5ºC logo, corrigir a hipotermia se torna crucial para o controle da glicemia e a aferição correta. Letra D incorreta. A transferência para a UTI seria indicada em casos sintomáticos ou assintomáticos porém refratários, necessitando de glicose EV. De acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria, o tratamento com glicose EV imediata pode ser instituído para um bebê com sinais clínicos e uma concentração de glicose plasmática menor que 40 mg dL, enquanto um bebê em risco, mas assintomático e recebendo leite materno ou fórmula láctea pode requerer apenas uma frequência aumentada de alimentação e necessitaria glicose EV somente se os valores glicêmicos diminuíssem para menos de 25 mg dL (primeiras 4 horas de vida) ou 35 mg dL (4 a 24 horas de vida). Este bebê, portanto, ainda pode ser tratado com alimentação e correção da hipotermia vale destacar, no entanto, que trata-se de um RN com fatores de risco (prematuro e PIG), para o qual uma vigilância mais rigorosa poderia ser indicada. Ainda assim, a alternativa C é uma conduta indiscutível neste caso. Resposta letra C.

350823.

Comentário: A questão aborda a conduta em recém-nascido (RN) de mãe adequadamente tratada para sífilis na gestação, definida em protocolo publicado pelo Ministério da Saúde em 2022. Como não existe uma avaliação complementar que determine com precisão o diagnóstico de sífilis congênita no recém-nascido, esse diagnóstico exige uma combinação de avaliação clínica,

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

epidemiológica e laboratorial. A avaliação inicial deve considerar o histórico materno quanto ao tratamento e seguimento na gestação os sinais e sintomas da criança e o teste não treponêmico (VDRL) de sangue periférico da criança comparado com o da mãe. Em relação ao histórico materno, considera-se tratamento adequado para sífilis na gestação aquele que foi completo para o estágio clínico da sífilis, com benzilpenicilina benzatina, iniciado até 30 dias antes do parto e finalizado antes deste, com respeito ao intervalo recomendado entre as doses. É considerada resposta imunológica adequada a documentação de queda da titulação do teste não treponêmico em pelo menos duas diluições em até três meses, ou quatro em até seis meses. O RN de mulher adequadamente tratada é considerado exposto à sífilis, enquanto aquele cuja mãe não foi tratada ou foi inadequadamente tratada é classificada como caso de sífilis congênita. Todos os RN nascidos de mãe com diagnóstico de sífilis durante a gestação deverão realizar teste não treponêmico no sangue periférico, que será comparado com o teste materno. Um título maior que o materno em pelo menos duas diluições (ex. o materno 1 4 e o do RN maior ou igual a 1 16) é indicativo de infecção congênita. A criança exposta à sífilis (lembre-se, aquela com a mãe adequadamente tratada) com exame físico normal e VDRL até uma diluição maior que o materno não necessita de tratamento, e pode receber alta para acompanhamento ambulatorial. Já aquela que apresentar alterações clínicas ao exame físico ou VDRL duas diluições ou mais acima do materno deverá ser investigada como os filhos de mães inadequadamente tratadas análise liquórica, hemograma e radiografia de ossos longos. A partir desta avaliação clínica e laboratorial, define-se o tratamento. Feita esta revisão, vamos analisar as alternativas. Letra A incorreta. Como vimos, o teste não treponêmico deve ser realizado independente da presença de alterações ao exame físico. Letra B incorreta. Como a mãe teve diagnóstico no pré-natal, a criança deve ser testada independente da testagem materna na maternidade. Letra C incorreta. A criança deve ser avaliada por teste não treponêmico (VDRL), coletado de sangue periférico, não de sangue de cordão. Letra D correta. Como vimos acima, deve ser realizada coleta de VDRL do RN e da mãe, e os resultados devem ser comparados para definição da conduta. Resposta letra D.

350818.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

Comentário: O enunciado apresenta um bebê de pouco mais de um mês com fezes claras, sugerindo a presença de hipocolia ou acolia fecal. A Caderneta de Saúde da Criança, inclusive, traz uma escala de cores classificadas como fezes normais e fezes suspeitas . As fezes normais variam entre as cores amarela e verde enquanto as suspeitas são justamente as de cor mais clara. Acima da escala, consta a seguinte orientação aos pais Observe a cor das fezes da criança usando a escala de cores abaixo. Se a cor das fezes for suspeita, procure com urgência o serviço de saúde . O motivo é que este achado é sugestivo de colestase, uma condição sempre patológica e que exige investigação urgente, principalmente para descartar o diagnóstico de atresia de vias biliares. Esta é uma condição relativamente rara, que acarreta na obstrução das vias biliares e é a causa mais frequente de insuficiência hepática levando à necessidade de transplante na infância por isso, diagnóstico e intervenção precoces são cruciais. Vamos analisar as alternativas. Letra A incorreta. Como vimos, a cor branca não é normal em nenhum momento. A Caderneta de Saúde da Criança inclui fezes claras entre os sinais de perigo, com a seguinte orientação Se a criança tiver menos de 2 meses de idade, você deve procurar IMEDIATAMENTE o serviço de saúde mais próximo de sua casa quando observar algum dos seguintes sinais de perigo . Letra B incorreta. Mesmo que seja um achado isolado, esse aspecto das fezes não é considerado normal. Crianças com atresia de vias biliares muitas vezes encontram-se bem - antes da evolução para insuficiência hepática -, apenas com icterícia, colúria e ou acolia. Letra C correta. Como vimos, a cor clara pode indicar acolia fecal e colestase, sempre patológica. Letra D incorreta. Novamente, a cor clara não é normal em nenhum momento ou frequência. Resposta letra C.

321317.

Comentário: O achado de urina alaranjada ou cor de tijolo na fralda de um recém-nascido frequentemente se deve à presença de cristais de urato, cuja eliminação é normal nos primeiros dias de vida. Não é necessário realizar nenhum exame ou instituir nenhum tratamento, apenas orientar a família que se trata de um achado benigno e manter os cuidados de rotina. Resposta letra A.

292830.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

Comentário: Lembre-se de que nem todas as crianças devem ser conduzidas à mesa de reanimação após o nascimento. Os recém-nascidos a termo e com boa vitalidade devem ser submetidos ao clampeamento oportuno do cordão e permanecer no colo materno. Os recém-nascidos que nascem sem boa vitalidade devem ser submetidos ao clampeamento imediato do cordão e conduzidos à mesa, onde serão realizados os passos iniciais. Como corretamente indicado no enunciado, tais passos devem ser realizados em 30 segundos e consistem em prover calor posicionar a cabeça em leve extensão aspirar as vias aéreas, se necessário e secar a criança. É importante frisar que a aspiração está reservada aos pacientes que apresentam obstrução de vias aéreas por excesso de secreções. Nesses casos, aspirar delicadamente a boca e depois as narinas com sonda traqueal no 8-10 conectada ao aspirador a vácuo, sob pressão máxima de 100 mmHg. Resposta letra C.

259731.

Comentário: Mesmo sem o fornecimento do normograma, era possível definirmos a conduta diante do caso apresentado. Estamos diante de um recém-nascido com 72 horas de vida final do terceiro dia que se apresenta com icterícia. Sabemos que esta alteração é muito comum no período neonatal e, na maior parte das vezes, indica tão somente um processo fisiológico. Não há, no quadro, qualquer elemento par apensarmos que o quadro é patológico o nível de bilirrubina não é muito elevado, não há alterações físicas ao exame da criança. Ao colocarmos o valor da bilirrubina no gráfico fornecido, encontramos que a criança está na faixa de baixo risco para o desenvolvimento de hiperbilirrubinemia grave. Nesta situação, não há impedimento para a alta hospitalar. Estas faixas de risco podem ser usadas para definirmos o tempo necessário para uma nova dosagem de bilirrubina, o que pode impedir a alta hospitalar da criança. Não temos a informação da perda ponderal, mas mesmo sem este dado, não há razão para inferirmos que a perda foi exacerbada. Na ocasião do concurso causou surpresa o relato de duas diureses na véspera, mas a frequência da diurese vai aumentando nos primeiros dias de vida até alcançar a média de seis-oito diureses diárias. Resposta letra D.

259732.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

Comentário: Questão bem direta Logo após o nascimento, a primeira decisão a ser tomada é qual o destino do recém-nascido Deve permanecer no colo materno ou ser encaminhado para a mesa de reanimação . De forma padronizada, a Sociedade Brasileira de Pediatria orienta que isso seja determinado a partir de três perguntas Gestação a termo Respirando ou chorando Tônus muscular em flexão . Quando respondemos sim às três perguntas, deve ser indicado o clampeamento oportuno do cordão e a criança permanece no colo materno. Quando a criança não tem respiração choro ou quando o tônus não é adequado, deve ser indicado o clampeamento imediato do cordão para início imediato dos passos iniciais da reanimação. E, finalmente, quando a criança não é a termos, mas apresenta boa vitalidade, é possível aguardarmos ara o clampeamento do cordão, mas, a seguir, a criança e levada para o berço aquecido. Resposta letra C.

234052.

Comentário: De forma bem direta, a banca perguntou quais são os passos iniciais da reanimação e você os conhece muito bem prover calor (aquecer), posicionar a cabeça em leve extensão, aspirar as vias aéreas (lembre-se de que isso é feito apenas se necessário, isto é, quando há grande quantidade de secreção obstruindo a via aérea) e secar. Todos estes passos devem ser executados de forma rápida em até 30 segundos. Após isso, deve ser feita a avaliação da frequência cardíaca e da respiração somente após essa avaliação é que iremos determinar a necessidade de iniciarmos a ventilação com pressão positiva. Caso a ventilação seja necessária, deve ser instituída ainda nos primeiros 60 segundos de vida da criança (The Golden Minute). Resposta letra C.

234053.

Comentário: Existem alguns fatores de risco que sabidamente aumentam o risco de hiperbilirrubinemia grave nos recém-nascidos com 35 ou mais semanas. Estes fatores são listados em uma tabela publicada há alguns anos pela Academia Americana de Pediatria e subdividem-se em fatores maiores e fatores menores. Os fatores maiores são bilirrubina total sérica ou transcutânea na zona de alto risco antes da alta hospitalar icterícia observada nas primeiras 24 horas incompatibilidade sanguínea ou outras doenças hemolíticas conhecidas idade gestacional

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

entre 35 e 36 semanas irmão com icterícia neonatal tratado com fototerapia céfalo-hematoma ou equimoses aleitamento materno exclusivo, especialmente se há problemas com a amamentação e a perda ponderal for excessiva etnia asiática. Já os fatore menores incluem bilirrubina total sérica ou transcutânea na zona de risco intermediário-alto antes da alta hospitalar idade gestacional entre 37 e 38 semanas icterícia observada antes da alta hospitalar irmão com icterícia neonatal macrossomia ou mãe diabética idade materna 25 anos sexo masculino. Deste modo, o único dos fatores listados nas opções é a icterícia nas primeiras 24 horas. Resposta letra C.

199720.

Comentário: Diante de um recém-nascido de uma mulher que teve o diagnóstico de sífilis durante a gestação, a primeira tarefa é sempre determinarmos se o tratamento materno foi feito de forma adequada ou não. Não temos a descrição de detalhes o tratamento, mas já foi indicado que o mesmo foi adequado. Quando a gestante foi adequadamente tratada, basta realizarmos, em um momento inicial, a análise clínica cuidadosa do recém-nascido e o VDRL do sangue periférico. Nos casos em que a criança estiver assintomática e o VDRL for não reagente, não há indicação de outros exames e basta ser feito o seguimento clínico ambulatorial. Porém, se não houver a garantia de seguimento, recomenda-se uma dose única da penicilina benzatina. Não confunda esta recomendação com aquela feita para os recém-nascidos de mulheres que não foram adequadamente tratadas... Nestes casos, a penicilina benzatina só é uma opção quando a criança está assintomática, o VDRL é não reagente, uma série de outros exames são normais e há garantia de acompanhamento. Resposta letra B.

199667.

Comentário: É fato que este enunciado poderia ter trazido mais elementos, mas devemos destacar as informações principais para chegarmos ao provável diagnóstico. Há o relato de que a criança foi um recém-nascido pré-termo, de que as manifestações tiveram início no período neonatal e se mantém de forma contínua e, principalmente, há o relato de oxigenoterapia no período neonatal. Uma das complicações encontradas no recém-nascido pré-termo é o quadro de displasia broncopulmonar que será caracterizada, essencialmente, pela necessidade de oxigenoterapia

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

prolongada. Estas crianças apresentam manifestações respiratórias crônicas que se exacerbam em vigência de infecções respiratórias (por isso essas crianças são candidatas ao uso do palivizumabe anticorpo monoclonal para o vírus sincicial respiratório nos primeiros dois anos de vida). O quadro de fibrose cística seria um diagnóstico diferencial importante, mas não tem aa associação com o quadro no período neonatal. Ademais, as bancas costuma trazer também s descrição de quadro gastrointestinal para pensarmos nesta condição. A possibilidade de asma deve ser considerada diante do lactente sibilante, mas também não se associa com a oxigenoterapia no período neonatal o mesmo para as imunodeficiências primárias. Resposta letra A.

199700.

Comentário: Para a equipe Medgrupo, desde a época do concurso, essa pergunta não tem resposta correta. No tratamento da meningite no período neonatal, classicamente, é recomendado a ampicilina associada a um aminoglicosídeo. Pode também ser feito o acréscimo de uma cefalosporina de terceira geração. A banca trouxe como resposta cefepime como monoterapia, o que não costuma ser recomendado, já que a ampicilina é feita associada com outras medicações. Apesar do recurso na época, a banca manteve o gabarito. Resposta da banca letra A.

172957.

Comentário: Estamos, muito provavelmente, diante de uma doença hemolítica por incompatibilidade Rh. A mãe é Rh negativo e foi previamente sensibilizada, como indicado pelo teste de Coombs indireto positivo. A criança apresenta-se com hemólise imunomediada (há reticulocitose e o Coombs direto é positivo). Perceba que a opções A e D indicam apenas que este é o diagnóstico, mas não são estes dados que indicam o tratamento com a exsanguineotransfusão (EST). De fato, a incompatibilidade Rh é uma das principais situações nas quais ainda poderá ser necessária a indicação de EST. Eventualmente, os níveis de bilirrubina são tão elevados e potencialmente neurotóxicos que não há sequer tempo para aguardarmos a ação da fototerapia. A indicação pode ser feita com base em gráficos, mas há dois critérios que eventualmente são citados, são eles na hemólise por incompatibilidade Rh, a EST pode ser indicada logo após o nascimento, quando a bilirrubina indireta for maior do que 4 mg dl e ou hemoglobina 12 g dl no

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

sangue de cordão. Ficou assustado com o grau de decoreba cobrado nesta questão Nós também Resposta letra C.

172967.

Comentário: Diante de uma possibilidade de sífilis congênita, a primeira pergunta a ser respondida é como foi feito o tratamento materno Ao que tudo indica, o tratamento materno foi adequado. O fato de haver um VDRL ainda reagente não significa falha ou necessidade de novo tratamento, posto que o VDRL pode permanecer detectável em títulos baixos durante muito tempo. O teste rápido é um teste treponêmico e também permanece reagente mesmo após o tratamento adequado. Porém, mesmo quando o tratamento materno foi feito de forma adequada, há indicação de que o recém-nascido seja submetido à realização de um VDRL do sangue periférico e à avaliação clínica. Quando o tratamento materno foi adequado e o VDRL é não reagente ou é menor ou igual ao materno, pode ser feito apenas o seguimento clínico-laboratorial da criança. Deste modo, a conduta correta encontra-se descrita na resposta letra B.

172977.

Comentário: Ainda na sala de parto, um recém-nascido pré-termo apresenta sinais de desconforto respiratório, caracterizado por taquipneia e sinais de desconforto, como o batimento de asa nasal e a gemência. A primeira medida nestes casos é o início do CPAP nasal e tal conduta aprece no próprio fluxograma do Programa de Reanimação Neonatal da Sociedade Brasileira de Pediatria. Esta medida é especialmente importante nos casos em que há possibilidade de síndrome do desconforto respiratório (por mais que no caso o recém-nascido já tenha 35 semanas, o quadro ainda é possível). O CPAP tem as seguintes finalidades estabiliza a caixa torácica e otimiza a função do diafragma previne o colapso alveolar e melhora a complacência pulmonar aumenta a capacidade residual funcional conserva a função do surfactante alveolar. Resposta letra C.

150879.

Comentário: Esta questão abordou um tema muito importante na época do concurso a falta de penicilina. Por conta da falta de matéria-prima para produção de penicilina, o Ministério da Saúde passou a recomendar que a penicilina benzatina fosse reservada para tratamento de gestantes

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

com sífilis e a penicilina cristalina para as crianças com sífilis congênita. Na indisponibilidade de penicilina cristalina, penicilina G benzatina e penicilina G procaína, para manejo da sífilis congênita, deve-se usar a ceftriaxona (25 50 mg kg dia, IV ou IM, por 10 a 14 dias). Vale lembrar que os dados atuais ainda são insuficientes para se definir se tal tratamento é eficaz e, por isso, tais crianças devem ter seguimentos em intervalos mais curtos e serem avaliadas quanto à necessidade de retratamento em caso de possível falha terapêutica. Resposta letra D.

150884.

Comentário: Um recém-nascido apresenta icterícia nos primeiros dias de vida e a banca deseja saber se somos capazes de conduzir esse caso corretamente. Sabemos que a causa mais comum de icterícia no período neonatal é a icterícia fisiológica. Porém, sempre que estivermos diante de um recém-nascido ictérico, devemos avaliar se existe a presença de algum dado que nos faça pensar que o quadro não seja apenas fisiológico. Os principais parâmetros que nos fazem pensar que o quadro não é fisiológico são início nas primeiras 24 36 horas de vida, presença de sinais de coléstase, níveis muito elevados de bilirrubina, taxa de aumento de bilirrubina maior do que 5 mg dl dia. No sucinto caso apresentado, tudo nos faz crer que a icterícia apresentada por esse recém-nascido seja tão somente uma icterícia fisiológica. Alguns serviços até optam por realizar, rotineiramente, a avaliação transcutânea dos níveis de bilirrubina, para determinar o seguimento da criança. Porém, isso não deveria retardar a alta hospitalar, posto que a criança já tem mais de 48 horas de vida e não tem qualquer outra intercorrência. Assim, a melhor resposta é a letra A.

126952.

Comentário: Questão bem confusa, que avalia mais o nosso bom senso do que um conhecimento técnico propriamente dito. Todas as alternativas indicam cuidados que serão adotados após o nascimento a administração de vitamina K irá prevenir a doença hemorrágica do recém-nascido o uso do nitrato de prata previne a oftalmia gonocócica o exame detalhado e a antropometria da criança deve ser feitos ainda nas primeiras horas de vida. Porém, dentre as intervenções descritas, qual é a primeira a ser feita A laqueadura do cordão, evidentemente, momento no qual se faz a identificação de duas artérias e uma veia umbilical. Percebam que mesmo que seja feito o

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

clampeamento tardio do cordão, esta medida irá ocorrer antes da realização de quaisquer um dos outros cuidados. Resposta letra C.

126984.

Comentário: Apesar de o enunciado haver um erro (a termo com 36 semanas), isso não nos impede de compreender o solicitado. Temos uma criança filha de uma moradora de rua, com icterícia, hepatoesplenomegalia e dor ao manuseio. Icterícia e hepatoesplenomegalia podem ocorrer em qualquer infecção congênita. A dica da questão é a dor ao manuseio, a chamada Pseudoparalisia de Parrot, que é a manifestação clínica da osteocondrite metafisária, geralmente manifestada nos membros superiores. Logo, deduzimos que o diagnóstico provável é a Sífilis congênita precoce. Diante disso, devemos solicitar o VDRL do sangue periférico do bebê e da mãe, raio-x de ossos longos e punção lombar. E o fundo de olho Para fins diagnósticos ele não é essencial, porém, após diagnosticada sífilis congênita, o fundo de olho é importante para avaliar a presença de coriorretinite, que pode ocorrer na fase aguda da doença. Lembrando que o aspecto do fundo de olho na sífilis congênita é o chamado sal e pimenta . Mas não vamos brigar com a questão por causa do fundo de olho, ok Resposta certa letra A .

127003.

Comentário: Como bem lembrado no enunciado, a icterícia é uma condição muito comum no período neonatal. Justamente por isso, as questões sobre esse tema são tão comuns. Sabemos que a principal causa de icterícia nos primeiros dias de vida é a icterícia fisiológica, decorrente de um esperado aumento nos níveis de bilirrubina indireta após o nascimento. Porém, nem sempre que estivermos diante de um recém-nascido ictérico poderemos afirmar que este quadro é fisiológico. Como ocorre em qualquer outra fase da vida, a icterícia pode ser a manifestação de algum processo mórbido subjacente. Alguns dados de história, de exame físico ou mesmo de avaliação complementar poderão ser usados para pensarmos que o quadro apresentado pelo pequeno paciente merece uma avaliação mais cuidadosa e que, possivelmente, não é apenas fisiológico. Um deles é o início precoce da icterícia, ainda nas primeiras 24-36 horas de vida. É sabido que o acúmulo dito fisiológico da bilirrubina faz com que a icterícia fisiológica surja entre o 2º

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

e o 3º dia de vida, em um recém-nascido a termo, ou entre o 3º e o 4º dia de vida, nos prematuros. O surgimento ainda nas primeiras horas de vida deve sempre levantar a suspeita de causa mórbida subjacente, em especial de uma doença hemolítica (opção A certa). O pico da hiperbilirrubinemia no 3º dia de vida pode ser encontrado nos recém-nascidos a termo com icterícia fisiológica nos prematuros, o pico costuma ser um pouco mais tardio (opção B errada). Algumas condições clínicas aumentam o risco de que a criança apresente uma hiperbilirrubinemia significativa. Uma dessas condições é o céfalo-hematoma (não a bossa serossanguínea opção D errada). Na ocasião do concurso, muitos candidatos questionaram por qual razão a opção C não iria sugerir um quadro patológico. Realmente, a perda ponderal excessiva é um fator de risco para hiperbilirrubinemia significativa. Porém, caso a icterícia esteja, por exemplo, restrita à face, poderemos continuar pensando que o quadro é apenas fisiológico. Por mais que a opção C tenha suscitado dúvidas, aposte no que é certo. Não há dúvidas de que a opção A descreve um quadro patológico. Resposta letra A.

102169.

Comentário: Mesmo sem ver a imagem apresentada, poderíamos saber qual a conduta diante deste caso. Veja os resultados dos exames. Você percebe que a bilirrubina direta está aumentada Por mais que exista mais bilirrubina indireta do que direta, a bilirrubina direta está aumentada. Sempre que a bilirrubina direta representar mais do que 20% da bilirrubina total (quando esta for maior que 5 mg dl), devemos considerar que há aumento e iniciar o diagnóstico diferencial da colestase neonatal. Mesmo que não tivéssemos essa informação laboratorial, deveríamos considerar essa possibilidade, pois a imagem nos mostra fezes acólicas. Sabemos que esse diagnóstico diferencial é considerado uma urgência no período neonatal. Há uma enorme variedade de condições que podem levar ao desenvolvimento desse quadro, mas podemos agrupá-las em dois grandes grupos as causas de colestase intra-hepática e as causas de colestase extra-hepáticas. Dentre as causas de colestase extra-hepáticas, encontramos a atresia de vias biliares extra-hepáticas, uma condição que deve ser prontamente reconhecida, pois o tratamento rápido, ainda nas primeiras oito semanas de vida, é fundamental para o sucesso e bom

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

prognóstico. Vejamos cada uma das afirmativas. A afirmativa A pode ser considerada CERTA. Ainda que não seja comum em uma prova que a conduta seja o encaminhamento e não a condução do caso de forma apropriada, a investigação dos casos de colestase neonatal costuma ser realizada em serviços especializados, com disponibilidade para a realização dos diversos exames complementares que são necessários. A afirmativa B, por enquanto, ainda está ERRADA. É possível que, em se tratando de atresia de vias biliares, a intervenção cirúrgica seja realmente necessária (a cirurgia realizada nesses casos é a cirurgia de Kasai, que corresponde a uma portoenterostomia), porém são necessárias outras avaliações antes do encaminhamento cirúrgico para estabelecimento do diagnóstico. A afirmativa C também está ERRADA ainda que a realização de sorologias possa fazer parte da abordagem do caso, outras avaliações também devem ser feitas e de modo algum a criança poderá ser revista em apenas um mês. Como já dito, a intervenção cirúrgica nos casos de atresia de vias biliares deverá ser feita nas primeiras oito semanas de vida. E, por fim, a afirmativa D está completamente ERRADA. Não há qualquer indicação para se suspender o aleitamento materno e esta conduta não é encontrada na caderneta da saúde da criança. A suspensão do aleitamento materno poderia ser considerada nos casos em que há icterícia do leite materno associada com intensa elevação nos níveis de bilirrubina. Porém, há aumento de bilirrubina indireta, não de direta como neste caso. Resposta letra A.

102176.

Comentário: Não erre Siga sempre o mesmo raciocínio. Diante de uma questão sobre o tema sífilis congênita, a primeira pergunta que deve ser respondida é o tratamento materno foi adequado ou inadequado No caso descrito, o tratamento foi corretamente feito com três doses de penicilina (2.400.000 UI) por 3 semanas, por tratar-se, provavelmente, de uma sífilis com duração indeterminada. O parceiro também foi tratado. Será que estamos diante de um caso em que o tratamento materno foi adequado Não Perceba que o tratamento foi instituído menos de 30 dias antes do nascimento da criança, o que é um dos pontos que caracterizam um tratamento inadequado. Nestas situações, o recém-nascido deve ser submetido à realização de vários exames (VDRL do sangue periférico, radiografia de ossos longos, hemograma e avaliação liquórica) e, a

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

partir dos resultados dos exames, vamos traçar a conduta terapêutica. Nos casos em que há alteração liquórica ou que não há resultado disponível dessa avaliação, o tratamento deve ser feito com 10 dias de penicilina cristalina. Quando o liquor está normal e há qualquer outra alteração (clínica ou laboratorial), o tratamento também tem duração de 10 dias, mas pode ser feita a penicilina cristalina ou a penicilina procaína. Quando todos os exames são normais, incluindo um VDRL não reagente, é possível o tratamento com dose única de penicilina benzatina, desde que exista garantia de seguimento. Como não dispomos dos resultados, poderíamos pensar que havia mais de uma possibilidade de resposta (opções A, B ou C). De fato, na época do concurso, muitos candidatos mostraram-se bastante insatisfeitos com a forma como a questão foi formulada. A resposta oficial da banca foi a letra C. Qual a lógica Bom, a banca nos perguntou qual seria a conduta diante dos dados fornecidos. Neste caso, a melhor conduta seria aquela que melhor cobriria todas as possibilidades, que seria o uso de penicilina cristalina por 10 dias. Porém é fato que o enunciado deixou muito a desejar. Resposta letra C.

102087.

Comentário: A caracterização de uma sepse neonatal em precoce ou tardia relaciona-se com o tempo de vida com o qual as manifestações clínicas começaram. Não há consenso na literatura em relação a esse tempo... Alguns autores usam como ponto de corte 48 horas de vida, outros 72 horas, enquanto outros a primeira semana de vida. no quadro descrito, não há dúvidas de que é uma sepse precoce, pois as manifestações sugiram nas primeiras 48 de vida da criança. De todo modo, o mais importante é compreendermos que, como regra geral, os agente que levam a um quadro de sepse neonatal precoce costumam ser de origem materna, enquanto os que levam à sepse tardia foram adquiridos no hospital ou na comunidade. No caso enunciado, as manifestações apontam para uma sepse precoce, mas a banca fez questão de ressaltar que não há fatores de risco para infecção materna e transmissão de algum agente infeccioso da mãe para a criança... Além disso, aponta um fator de risco para uma infecção nosocomial, que foi a realização de uma intervenção cirúrgica. É fato que o tempo transcorrido entre a intervenção e as manifestação não é comum, ainda assim, foi essa a hipótese da banca. Resposta letra D.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

102093.

Comentário: Uma informação que vai te auxiliar na avaliação desse caso é que, quanto maior o valor no boletim Silverman-Andersen, pior é o quadro respiratório do paciente. Estamos diante de um recém-nascido prematuro que começou a apresentar um quadro de desconforto respiratório ainda na primeira hora de vida e que vem evoluindo com piora progressiva do mesmo. Além da piora clínica, há progressiva diminuição da PaO e aumento da PaCO . Esta piora progressiva nas primeiras seis horas de vida em um recém-nascido prematuro é bem característica do diagnóstico de doença da membrana hialina, ou síndrome do desconforto respiratório. É fato que esse diagnóstico é mais frequente em menores de 34 semanas, pois espera-se que a partir dessa idade o pulmão fetal já esteja maduro. Porém, ainda que com incidência menor, continuamos encontrando essa condição em prematuros maiores de 34 semanas. A taquipneia transitória do recém-nascido não cursa com essa piora progressiva e nem demanda aumento progressivo nas concentrações de oxigênio oferecidas. Resposta letra A.

102131.

Comentário: A criança com exposição vertical ao HIV deve ser submetida a uma série de exames complementares logo após o nascimento e durante os primeiros meses de vida. O objetivo dessa avaliação é a monitorização de alguns dos efeitos adversos relacionados com a exposição intrauterina e pós-natal aos antirretrovirais, a identificação precoce das repercussões sistêmicas da infecção pelo HIV e o diagnóstico de outras infecções. Todos os exames descritos no enunciado devem ser realizados antes da alta hospitalar ou na primeira consulta ambulatorial. Podemos fazer apenas uma ressalva em relação à realização do anti-HIV, logo ao nascer, a sorologia anti-HIV está indicada principalmente quando houver dúvidas em relação ao estado de infecção da mãe. No caso descrito, tal exame seria desnecessário. Que outros exames devem ser feitos Neste momento, nenhum A carga viral é o exame que será realizado para o estabelecimento do diagnóstico da infecção até os 18 meses de idade, mas a proposta do Ministério da Saúde é que o primeiro exame seja realizado apenas entre 4 e 6 semanas de vida, não neste momento. Não há razão para avaliação liquórica esta será realizada apenas se alguma sorologia apontar para alguma outra

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

possível infecção. Resposta letra A.

102164.

Comentário: Estamos diante de um RN que está no quinto dia de vida e se apresenta ictérico. Poderíamos pensar, em um momento inicial, que o quadro é de uma simples icterícia fisiológica, pois a criança ainda está no quinto dia de vida e a icterícia surgiu no terceiro dia. Porém, olhe lá o que a banca disse a icterícia alcança a zona IV de Kramer Isso sinaliza que os níveis de bilirrubina dessa criança devem estar muito elevados, incompatíveis com o diagnóstico de uma simples icterícia fisiológica. Poderíamos pensar que a causa dessa hiperbilirrubinemia seria um quadro de hemólise por incompatibilidade materno-fetal Rh (já que ABO não seria possível, uma vez que o RN é O), mas tanto o Coombs direto do RN quanto o Coombs indireto da mãe são negativos. Poderíamos considerar a hipótese de que há uma hemólise por deficiência de G6PD, mas não há nada no enunciado que sugira isso, como palidez. O que chama a atenção nessa história Essa criança já perdeu quase 10% do seu peso de nascimento e a banca refere mamadas rápidas , provavelmente sugerindo que essas mamadas são insuficientes. Isso indica um quadro de icterícia do aleitamento materno (não do leite materno, que é mais tardia), ou de icterícia por oferta inadequada do leite materno, como indicado na letra D. A questão poderia ter sido melhor enunciada e a perda ponderal poderia ter sido mais intensa. Ainda assim, esta será a principal hipótese. Resposta letra D.

81231.

Comentário: Como fazer Vá para um canto da sua prova e desenhe o genograma dessa família. Você vai observar que não existe um padrão de herança mendeliano clássico, não é mesmo A forma de herança descrita é compatível com uma herança mitocondrial. A herança mitocondrial é considerada um padrão de herança não tradicional, pois não segue o padrão mendeliano clássico. O genoma mitocondrial de um indivíduo é herdado exclusivamente de sua mãe. Deste modo, uma mulher com uma desordem mitocondrial pode ter prole acometida de ambos os sexos, mas os homens afetados não transmitem a doença para a sua prole. O diagnóstico diferencial com um padrão de herança ligado ao X pode ser difícil quando a prole de um homem é toda do sexo

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

masculino porém, no caso enunciado, os tios têm a doença e suas filhas não. Se a doença fosse ligada ao X, esses tios teriam passado o alelo acometido para as suas proles femininas. Resposta letra B.

81245.

Comentário: Existem 2 alternativas para o procedimento de triagem neonatal do hipotireoidismo congênito - Alternativa 1 medida do Hormônio Estimulante da Tireoide (TSH) em amostras de sangue colhidas em papel de filtro. Em caso de TSH 20 mUI L, devemos solicitar nova amostra para dosar TSH e T4 no soro. - Alternativa 2 medida de T4, seguida de medida de TSH na mesma amostra quando o T4 é menor que o percentil 10. No Programa de Triagem Neonatal, os resultados de rastreamento positivos devem sempre ser seguidos de dosagem de T4 (total ou livre) e de TSH em amostra de sangue venoso, obtida com a maior brevidade possível, para confirmação diagnóstica. A realização dos exames nesta sequência permite a detecção da maioria dos casos. Resposta letra A.

81258.

Comentário: Temos aqui um caso de icterícia neonatal e a questão quer que definamos a conduta. Antes de tudo, precisamos avaliar se há algum indício de causa patológica para esta condição. Como não há predomínio da forma direta de bilirrubina, a icterícia não apareceu nas primeiras 24 horas de vida, o valor da bilirrubina total não é muito elevado e não há sintomas associados à icterícia, não há indícios de que estamos frente a uma icterícia patológica. Mesmo assim, precisamos decidir o que deve ser feito com nosso paciente alta Fototerapia Nova dosagem de bilirrubinas Vamos rever os fatores de risco maiores para o desenvolvimento de hiperbilirrubinemia significativa em recém-nascidos 35 semanas de idade gestacional - Icterícia observada nas primeiras 24 horas - Incompatibilidade de grupos sanguíneos com Coombs direto positivo, outra doença hemolítica conhecida (deficiência de G6PD) - Céfalo-hematoma ou contusões equimoses significativas - Prematuridade, com IG de 35-36 semanas - Aleitamento materno exclusivo, particularmente se a perda de peso for excessiva - Irmão mais velho recebeu fototerapia - Nível de BT na zona de alto risco antes da alta hospitalar - Etnia asiática. O nomograma nos mostra que,

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

para um bebê nascido com 38 semanas de idade gestacional, com 48 horas de vida, podemos classificá-lo como em zona de risco intermediário baixo para hiperbilirrubinemia. Vemos, portanto, que o RN em questão não apresenta nenhum fator de risco maior para hiperbilirrubinemia significativa. Sendo assim, a conduta deve ser a alta hospitalar com reavaliação posterior. Resposta letra B.

81272.

Comentário: Frente a um possível caso de sífilis congênita, nossa primeira conduta é avaliar se o tratamento da gestante foi adequado. É a partir disso que vamos definir nossa conduta, antes mesmo de saber da clínica ou de resultados de exames do RN. Lembrem-se de que é considerado inadequado o tratamento nas seguintes situações tratamento realizado com qualquer medicamento que não seja a penicilina tratamento incompleto, mesmo tendo sido feito com penicilina tratamento inadequado para a fase clínica da doença instituição de tratamento dentro do prazo dos 30 dias anteriores ao parto (como em nossa questão) ausência de documentação de tratamento anterior ausência de queda dos títulos (sorologia não treponêmica) após tratamento adequado parceiro não tratado ou tratado inadequadamente ou quando não se tem a informação disponível sobre o seu tratamento. Nos recém-nascidos de mães com sífilis não tratada ou inadequadamente tratada - como a nossa mãe em questão -, independentemente do resultado do VDRL do recém-nascido, realizar hemograma, radiografia de ossos longos, punção lombar (na impossibilidade de realizar este exame, tratar o caso como neurossífilis), e outros exames, quando clinicamente indicados. A partir da avaliação clínica e dos resultados obtidos nesses exames, temos três possíveis condutas 1ª) Quando não há alterações clínicas, radiológicas, hematológicas e ou liquóricas, e a sorologia for negativa, pode ser realizado o tratamento com penicilina G benzatina por via intramuscular na dose única de 50.000 UI kg, desde que o acompanhamento seja garantido. A penicilina benzatina nos casos em que a mãe teve tratamento inadequado só pode ser feita quando o VDRL do recém-nascido é não reagente e todas as condições anteriores foram respeitadas (exame clínico e avaliação complementar normal) 2ª) Quando há alterações clínicas e ou sorológicas e ou radiológicas e ou hematológicas, o tratamento deverá ser feito com penicilina G cristalina ou

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

penicilina G procaína durante 10 dias. Neste caso o exame do líquor deve ser normal 3ª) Quando há alterações liquóricas, o tratamento deve ser feito exclusivamente com penicilina G cristalina, na dose de 50.000 UI kg dose, IV, a cada 12 horas (nos primeiros 7 dias de vida) e a cada 8 horas (após 7 dias de vida), durante 10 dias. Resposta letra A.

81283.

Comentário: As alterações na temperatura de um recém-nascido podem estar, evidentemente, relacionadas com algum processo infeccioso. Porém, percebam que a banca reafirma que não existe qualquer fator de risco para isso na história. Não houve intercorrências no pré-natal e o tempo de bolsa rota foi de apenas uma hora. Há uma informação nessa história que deve chamar a nossa atenção houve uma perda ponderal execessiva. Em apenas 48 horas esse recém-nascido já perdeu quase 10% de seu peso de nascimento. As elevações na temperatura podem ser observadas no segundo ou terceiro dia de vida de crianças que, aparentemente, estão bem. Isso é mais comumente encontrado naqueles que estão em aleitamento materno exclusivo, mas que estão com uma ingestão inadequada. A elevação da temperatura dessas crianças estará associada com aumento do hematócrito e do sódio sérico. Assim, poderíamos até ter dúvidas se marcaríamos a opção B ou C, mas, de fato, a elevação do sódio sérico guarda maior correlação com essa situação. Na época do concurso, alguns candidatos acreditaram que a elevação do sódio sérico estaria relacionada com um quadro de hiperplasia adrenal congênita. Porém, as manifestações clínicas associadas com essa condição não costumam ser tão precoces assim. Resposta letra C.

81230.

Comentário: Paciente prematuro com desconforto respiratório precoce piorando progressivamente. A radiografia de tórax evidencia infiltrado difuso, nos remetendo a imagem de vidro fosco. Tais achados clínicos e radiológicos nos fazem pensar na síndrome do desconforto respiratório (ou doença da membrana hialina), caracterizada pela deficiência quantitativa e qualitativa de surfactante pulmonar associada à imaturidade deste órgão. Atualmente, esse quadro pode ser modificado pelo uso precoce de surfactante exógeno e suporte ventilatório. Esse, sempre que possível, deve ser iniciado com ventilação não invasiva. A ventilação mecânica invasiva está

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

indicada para os casos de insuficiência respiratória ou episódios repetidos de apneia, não descritos na questão. Resposta letra D.

81277.

Comentário: Todos as crianças expostas ao HIV devem ser acompanhadas clínica e laboratorialmente. É importante solicitar um hemograma de controle ao nascimento, devido à possibilidade de anemia pelo uso do AZT. Assim como provas de função hepática e glicemia devem ser solicitadas devido ao risco potencial de alterações metabólicas relatadas em crianças expostas. As sorologias TORCHS (toxoplasmose, rubéola, citomegalovírus, herpes simples) devem ser solicitadas ao nascimento. E há um acompanhamento sorológico e virológico diferenciado de crianças nascidas de mães coinfectadas por HIV com HBV, HCV, HTLV, sífilis e toxoplasmose. E não esqueçam atualmente, a nevirapina deve ser acrescentada ao esquema de quimioprofilaxia da transmissão vertical do HIV para recém-nascidos de mães vivendo com HIV aids que NÃO receberam antirretrovirais na gestação. Não é o caso da questão... Contagens de carga viral e CD4 CD8 devem ser realizadas inicialmente com 1 a 2 meses de idade Resposta letra A.

65738.

Comentário: A questão apresentou um problema, o que gerou sua adequada ANULAÇÃO. Vamos relembrar para os RN de mães com sífilis não tratada ou inadequadamente tratada, independentemente do resultado do VDRL do recém-nascido, realizar hemograma, radiografia de ossos longos e punção lombar. Se houver alterações clínicas e ou sorológicas e ou radiológicas e ou hematológicas, o tratamento deverá ser feito com penicilina G cristalina na dose de 50.000 UI kg dose, por via endovenosa, a cada 12 horas (nos primeiros 7 dias de vida) e a cada 8 horas (após 7 dias de vida), durante 10 dias ou penicilina G procaína 50.000 UI Kg, dose única diária, IM, durante 10 dias. Sabemos que se não houver alterações nos exames, como em nosso paciente em questão, pode-se proceder com penicilina benzatina IM dose única, porém, o acompanhamento deste recém-nascido é obrigatório e, na impossibilidade de garantia do acompanhamento, a conduta deve ser a descrita inicialmente penicilina cristalina ou procaína por 10 dias. Como não há relato sobre a garantia do acompanhamento, a questão fica com duas respostas possíveis e, por

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

isso, foi corretamente ANULADA.

65735.

Comentário: A sepse neonatal precoce está relacionada diretamente a fatores maternos gestacionais e periparto o comprometimento é multissistêmico, e o germe, quando identificável, é oriundo do trato genital materno. A passagem pelo canal de parto, ou condições inadequadas deste (como na questão), são formas importantes de transmissão. A observação clínica, a despeito das limitações, permanece a forma mais prática para o diagnóstico precoce de graves infecções bacterianas. Os sinais iniciais de sepse em RNs podem ser mínimos ou inespecíficos. Achados como recusa alimentar, hipoatividade, irritabilidade, ou simplesmente a impressão de que o RN não parece bem podem levar a suspeita de um quadro infeccioso. Existem apresentações clínicas mais evidentes, como dificuldade respiratória (taquipneia, gemência, retrações torácicas e batimentos de asas nasais), apneia, letargia, febre ou hipotermia, icterícia sem outra causa determinante, vômitos e diarreia, ou ainda manifestações cutâneas. Nesse sentido, a pergunta seria quais são os agentes mais frequentemente implicados na sepse neonatal precoce Sabemos que são o estreptococo do grupo B e as enterobactérias Gram-negativas, dentre as quais se destaca a E.coli. Essa última parece, de fato, ser a principal etiologia na medida em que vemos uma história de um parto com condições inadequadas (no que diz respeito à higiene, certamente), o que favorece a contaminação por germes intestinais fecais. Resposta letra C.

65741.

Comentário: A questão gerou polêmica na ocasião do concurso (com razão). Vamos tentar entendê-la. O primeiro passo para se chegar à conduta correta é estabelecer o diagnóstico, e isso já foi feito no próprio enunciado. Já está definido que estamos diante de uma síndrome do desconforto respiratório (ou Doença da Membrana Hialina - DMH). Qual será o tratamento neste caso Repare em dois detalhes que causaram dúvidas na época do concurso o diagnóstico já está definido (ou seja, não há necessidade de antibióticos, pois já se excluiu a pneumonia sepse neonatal). Além disso, o RN já nasceu, não cabendo mais avaliarmos o que poderia ter sido feito como profilaxia, já que a questão pergunta o que poderia modificar a síndrome (que já está

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

instalada). Cruel, sem dúvidas Sabemos que uma das medidas adotadas na prevenção da DMH é a administração antenatal de corticoide. A recomendação é de que o corticoide seja administrado a todas as gestantes com idade gestacional entre 24 e 34 semanas com risco de dar à luz em até uma semana. Os corticoides utilizados incluem a betametasona e a dexametasona. O uso da medicação reduz a incidência e a mortalidade pela DMH e a mortalidade neonatal de uma forma geral. A banca não precisava ter colocado o corticoide como uma das opções, como fez na opção E. Muita malícia, pois não é uma conduta terapêutica, mas sim profilática. Nesse sentido, as principais medidas terapêuticas que, de fato, modificam o prognóstico da criança portadora da DMH são a assistência ventilatória precoce (invasiva, se necessário), além da administração do surfactante exógeno (pois se trata de um pulmão com quantidade insuficiente de tal substância, no caso) por via traqueal. Apesar de capciosa, a resposta correta está na letra B, de fato.

141622.

Comentário: A icterícia no Recém-nascido (RN) não é fisiológica em qualquer uma das seguintes condições - Icterícia nas primeiras 24 horas de vida - Nível de bilirrubina subindo a uma taxa superior a 5 mg dL em 24h - Nível de bilirrubina maior que 12 mg dL em RN a termo ou 10-14 mg dL em prematuros - Icterícia persistente (mais de 8 dias nos RN a termo e mais de 14 dias em prematuros) - Aumento da bilirrubina direta ou sinais de colestase, como acolia e colúria - Associação com alterações clínicas diversas, como hepatoesplenomegalia. Resposta alternativa A.

141621.

Comentário: Após os cuidados iniciais na sala de parto, iremos avaliar a Frequência Cardíaca (FC) e a respiração para saber se iremos proceder ou não com a reanimação do recém-nascido com baixa vitalidade. Se apresentar apneia ou respiração irregular (gasping) e ou a FC inferior a 100 bpm, deve-se iniciar a ventilação com pressão positiva. Resposta alternativa B

141603.

Comentário: Um dos principais fatores relacionados ao atraso da linguagem é a surdez, por vezes presentes em diferentes graus e por etiologias distintas. Dessa forma, quanto antes se diagnosticar problemas de audição e tratá-los, melhor para o desenvolvimento da criança. O teste da orelhinha é

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

um exame de triagem neonatal obrigatório no Brasil, devendo todo recém-nascido realizá-lo. O grande objetivo é identificar crianças com perda auditiva, para que elas possam receber tratamento antes de 6 meses de idade. O teste é feito por Emissões Otoacústicas Evocadas, que consiste na emissão de um estímulo sonoro e captação de seu retorno, avaliando somente o sistema auditivo pré-neural (sistema de condução e cóclea). Ou seja, se uma criança evoluir atraso na linguagem e não apresentou anormalidades no teste da Orelhinha, não podemos descartar que ela tenha o sistema auditivo íntegro, devendo ser submetida a uma nova avaliação auditiva, principalmente com a realização do Bera, exame que avalia a integridade funcional das vias auditivas nervosas desde a orelha interna até o córtex cerebral. Resposta alternativa B

141593.

Comentário: O coto umbilical cai ao redor de sete dias e deixa em seu lugar uma ferida, que no começo exsuda um pouco, mas logo seca e epiteliza-se, ao mesmo tempo em que se afunda pela retração progressiva dos cordões fibrosos dos vasos fetais. Entretanto, em alguns casos, pode se formar um granuloma após a queda. Sua etiologia ainda não é bem documentada, porém é uma condição comum e, na maioria das vezes, sem grandes repercussões clínicas. Normalmente regride após 28 depois da queda do coto umbilical, entretanto, caso não haja regressão espontânea, o uso de bastão de nitrato de prata a 2% está indicado. O quadro clínico é uma descarga serossanguinolenta, e a limpeza local com álcool a 70% é essencial, pois a infecção secundária é uma complicação frequente. Caso não haja melhora da descarga serossanguinolenta após o tratamento, suspeitar de persistência de úraco ou do conduto onfalomesentérico. Resposta C.

365580.

Comentário: Pelo menos metade dos recém-nascidos (RN) com sífilis congênita (SC) é assintomática ou pouco sintomática, sendo a história materna fundamental para determinar o risco de infecção. Um RN de mulher que teve a sífilis não tratada de forma adequada é considerado como tendo sífilis congênita e o tratamento dependerá da alteração de exames laboratoriais e presença de sintomas. Já o RN mãe adequadamente tratada na gestação, poderá ser apenas um

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

RN exposto à sífilis, sem necessidade de tratamento no período neonatal, mas com necessidade de seguimento ambulatorial ou poderá ser um RN com sífilis congênita. A distinção entre o RN exposto à sífilis e com sífilis é determinada pela comparação do títulos de VRL do binômio e também pela avaliação clínia do RN. Vamos às alternativas. Letra A incorreta. RN com diagnóstico de neurossífilis deve ser tratado com penicilina cristalina. A penicilina procaína pode se usada quando há o diagnóstico de sífilis congênita e exclusão de acometimento do sistema nervoso central (por meio do exame do líquor). Letra B incorreta. O RN assintomático, de mãe adequadamente tratada na gestação, e com VDRL NÃO MAIOR que o materno em duas diluições é considerado exposto à sífilis e deve ter seu seguimento garantido. Deve-se realizar o teste não treponêmico (VDRL) com 1, 3, 6, 12 e 18 meses de idade. A partir de 18 meses de idade, se não houver achados clínicos e laboratoriais sugestivos, pode-se excluir sífilis congênita. No caso de dois testes VDRL não reagentes consecutivos, também pode-se interromper o seguimento. Espera-se que as titulações de VDRL da criança diminuam aos 3 meses de idade, devendo ser não reagentes aos 6 meses. A persistência da titulação do VDRL reagente após seis meses de idade indica necessidade de internação, investigação e início de tratamento. Letra C incorreta. A realização do teste treponêmico (como TPHA) não é obrigatória para o diagnóstico de sífilis congênita. Até 18 meses de idade da criança, um teste treponêmico positivo pode resultar da transferência passiva de anticorpos maternos no período intrauterino. Entretanto, um teste reagente após os 18 meses idade confirma o diagnóstico - se os anticorpos foram produzidos pela criança, irão persistir mesmo após este momento. Lembre-se que crianças com teste treponêmico reagente após 18 meses de idade e que não tenham histórico de tratamento prévio deverão ser investigadas, receber tratamento e ser notificadas como caso de sífilis congênita. Letra D correta. Todos os RN nascidos de mãe com diagnóstico de sífilis na gestação deverão realizar o teste não treponêmico. A conduta quanto ao resultado do teste varia dependendo do tratamento da mãe, se adequado ou não. Vale lembrar que no caso de mães com tratamento inadequado na gestação, deve-se realizar no RN teste não treponêmico de sangue periférico(ao mesmo tempo que sua mãe), hemograma completo, glicemia, radiografia de ossos longos e coleta de líquor. Resposta letra D.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

365578.

Comentário: O Programa Nacional de Triagem Neonatal (PNTN) preconiza a realização de diversos testes para detecção precoce de afecções graves ou que possam afetar o desenvolvimento da criança. O teste do pezinho oferecido pelo Ministério da Saúde faz parte do PNTN e tem em seu escopo as seguintes doenças fenilcetonúria, hipotireoidismo congênito, doença falciforme e outras hemoglobinopatias, fibrose cística, hiperplasia adrenal congênita e deficiência de biotinidase. O rastreio da toxoplasmose congênita e de outras hiperfenilalaninemias foi incorporado recentemente ao PNTN. Note que todas as doenças apresentadas na questão são rastreadas pelo teste do pezinho, mas não da forma como apresentado em algumas alternativas. Letra A incorreta. A triagem do hipotireoidismo congênito é realizada através da dosagem do TSH e não do T4 livre. O recém-nascido (RN) com triagem neonatal alterada deve coletar TSH e T4 livre séricos, sendo indicado tratamento conforme os resultados. Se o TSH for maior que 40 mU L na triagem neonatal, o tratamento deve ser iniciado assim que os exames confirmatórios forem coletados. Letra B incorreta. O indicador indireto fibrose cística (FC) na triagem neonatal é a dosagem de tripsinogênio imunorreativo (TIR). Acredita-se que o aumento do TIR sérico seja secundário ao refluxo de secreção pancreática, provocado pela obstrução dos ductos no pâncreas. Se a função pancreática estiver normal por ocasião do nascimento, o teste poderá ser negativo mesmo em casos de fibrose cística. Quando o teste for positivo com valores acima do padrão adotado (70 ng mL), deve ser repetido em até 30 dias de vida. Caso persista positivo, deve-se solicitar o teste do suor (dosagem de cloro) para confirmar ou afastar a doença. Letra C correta. A triagem neonatal da fenilcetonúria é feita a partir da dosagem de fenilalanina. A fenilcetonúria é um erro inato do metabolismo que leva à intoxicação aguda ou progressiva pelo acúmulo de fenilalanina, por ausência ou deficiência da enzima fenilalanina hidroxilase, que converte a fenilalanina em tirosina . Letra D incorreta. Para triagem da anemia falciforme, utiliza-se os métodos de focalização isoelétrica ou cromatografia líquida de alta resolução (HPLC). O resultado é descrito com a hemoglobina (Hb) detectada em maior concentração em primeiro lugar, por exemplo FA diz respeito à Hb fetal em maior quantidade e a seguir Hb A. Esse resultado indica o padrão normal. Quando há Hb fetal, Hb A e Hb S, o

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

resultado é FAS e indica traço falciforme. No caso da anemia falciforme (SS), há apenas a presença de Hb fetal e Hb S - resultado FS. Resposta letra C.

365576.

Comentário: Questão direta sobre Reanimação Neonatal. Vamos às alternativas. Letra A correta. A ventilação com pressão positiva (VPP) está indicada na presença de FC 100 bpm e ou apneia ou respiração irregular, após os passos iniciais da reanimação neonatal. Antes de iniciar a ventilação, deve-se posicionar o pescoço do recém-nascido (RN) em leve extensão e aplicar a máscara na face, no sentido do queixo para o nariz. O ajuste entre face e máscara é crítico para o sucesso da ventilação, devendo-se visualizar uma leve expansão torácica. A necessidade de O2 suplementar é excepcional em RN 34 semanas se a VPP com máscara facial é aplicada com a técnica adequada. Quando o RN não melhora com a VPP em ar ambiente, recomenda-se sempre verificar e corrigir a técnica da ventilação antes de oferecer oxigênio (O2) suplementar. Letra B incorreta. Segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP), o RN nascido com boa vitalidade, independente do aspecto do líquido amniótico, deve ser deixado em contato pele-a-pele com a mãe. Deve-se conduzir à mesa de reanimação o bebê com idade gestacional 34 semanas que não está respirando ou chorando ou não inicia movimentos respiratórios regulares e ou o tônus muscular está flácido. Letra C incorreta. Os passos iniciais de estabilização podem estimular os movimentos respiratórios e compreendem ações para manutenção da normotermia e das vias aéreas pérvias, devendo ser executados em, no máximo, 30 segundos, seguidos da avaliação da respiração e da frequência cardíaca (FC) do recém-nascido (RN). A VPP está indicada na presença de FC 100 bpm e ou apneia ou respiração irregular, após os passos iniciais da reanimação neonatal. A massagem cardíaca está indicada apenas se, mesmo após o segundo ciclo de VPP com checagem da técnica de ventilação, a FC estiver abaixo de 60 bpm. Nesses casos, deve-se realizar a intubação orotraqueal do RN e reiniciar a ventilação, seguida de massagem cardíaca coordenada com ventilação (3 1) e oxigênio a 100% . Deve-se considerar cateterismo venoso e administração de adrenalina. Letra D incorreta. Estudos de RN 34 semanas de gestação e com boa vitalidade ao nascer indicam que o clampeamento do cordão superior a 60 segundos, quando comparado ao

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

clampeamento imediato, facilita a transição cardiorrespiratória após o parto, é benéfico em relação à concentração de hemoglobina nas primeiras 24 horas e aumenta a concentração de ferritina nos primeiros 3 a 6 meses. Por isso, no RN com boa vitalidade, o cordão deve ser clampeado no mínimo 60 segundos após o nascimento. Resposta letra A.

349705.

Comentário: Questão sem muita margem para discussão, já que solicita uma definição. Segunda a Organização Mundial da Saúde, a microcefalia é definida como recém-nascidos com perímetro cefálico inferior a 2 desvios-padrão abaixo da média para idade gestacional e sexo. Já a microcefalia grave, solicitada no enunciado, é definida em recém-nascidos com perímetro cefálico inferior a 3 desvios-padrão, ou seja, mais de 3 desvios-padrão abaixo da média para idade gestacional e sexo. Um paciente com perímetro cefálico acima de 2 desvios-padrão tem, por definição, macrocefalia. Resposta letra A.

322172.

Comentário: Vamos analisar as afirmativas sobre a síndrome da rubéola congênita (SRC), que se caracteriza principalmente por alterações cardíacas e oculares e surdez. O seguimento longitudinal das crianças infectadas intraútero pelo vírus da rubéola revela, de fato, que a surdez é a manifestação mais comum desta síndrome. Trata-se de surdez neurossensorial, e não condutiva, e ocorre por degeneração da cóclea e do órgão de Corti (alternativa A incorreta). Os defeitos cardíacos estão presentes em mais de 50% dos infectados nas primeiras semanas de gestação, e a alteração mais comum é a persistência do canal arterial, com ou sem estenose de ramo da artéria pulmonar (alternativa B incorreta). Diferente das outras infecções congênitas, a rubéola tem dois picos de transmissão um no primeiro e outro no terceiro trimestre. A infecção causa os danos mais graves quando a mãe é infectada no início da gravidez, especialmente nas primeiras 12 semanas. Depois de 18 semanas da gestação, o risco de SRC é baixo os defeitos são raros com a infecção a partir da 20ª semana de gestação (alternativa C correta). Algumas manifestações tardias já foram descritas, mas sua frequência não é tão alta diabetes mellitus ocorre em 20% e disfunção tireoideana em 5% dos casos (alternativa D incorreta). Não há tratamento específico para a SRC,

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

nem tampouco para a infecção aguda materna (alternativa E incorreta) o uso de imunoglobulina pode ser considerado em gestantes expostas ao vírus, mas não garante a prevenção da infecção fetal. Por isso, é importante que as mulheres sejam vacinadas pelo menos 30 dias antes de engravidar. A resposta inicial foi a afirmativa C mas, apesar de não termos identificado erro - apenas pequenas variações, de acordo com a referência, no tempo descrito na letra C -, a questão foi anulada pela banca.

322181.

Comentário: O íleo meconial é uma forma de obstrução intestinal intraluminal causada por mecônio espesso localizado no íleo terminal. No Brasil, ocorre em cerca de 1 a cada 10 mil nascidos vivos. Esta pode ser a manifestação inicial em cerca de 10 a 15% dos pacientes portadores de fibrose cística e em mais de 90% dos pacientes com a condição, o diagnóstico associado é de fibrose cística. Entendeu a diferença Quase sempre o quadro de íleo meconial ocorre por causa da fibrose cística, mas uma minoria dos portadores de FC desenvolvem essa complicação Outras condições que podem levar ao quadro de íleo meconial são aganglionose extensa e prematuridade com peso muito baixo ou extremamente baixo ao nascimento. Os fatores de risco associados a este último grupo, que resultam em hipo ou dismotilidade intestinal, são retardo de crescimento intrauterino, hipertensão materna, administração prolongada de agentes tocolíticos, doença da membrana hialina, hemorragia intraventricular e persistência do canal arterial. O quadro clínico é de distensão abdominal e atraso da eliminação de mecônio, além de vômitos inicialmente claros, que evoluem para biliosos. Na ausência de sinais de complicação (como perfuração intestinal), o tratamento inicial é clínico, com enema, hidratação e antibioticoterapia. A cirurgia fica reservada para casos com complicação ou na ausência de resposta ao tratamento clínico. Resposta letra E.

305312.

Comentário: Logo após o nascimento, os parâmetros usados para avaliar a vitalidade do recém-nascido são o padrão respiratório e o tônus. Se o recém-nascido está respirando ou chorando e apresenta tônus adequado em flexão, considera-se que há boa vitalidade e podemos aguardar para realizarmos o clampeamento, ainda que seja um recém-nascido prematuro. Nos

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

nascidos com menos de 34 semanas, devemos aguardar pelo menos 30 segundos nos nascidos com 34 ou mas semanas, aguardamos entre 1 e 3 minutos. O clampeamento também deve ser imediato nas situações em que há comprometimento da circulação placentária, como no descolamento prematuro de placenta, nó verdadeiro ou placenta prévia. Resposta letra E.

305313.

Comentário: Podemos realizar a avaliação da Frequência Cardíaca (FC) do recém-nascido através de diferentes métodos na sala de parto, a saber palpação do cordão umbilical, ausculta do precórdio, avaliação pelo oxímetro de pulso ou pelo monitor cardíaco. Vejamos cada uma das opções. A opção A está incorreta o monitor cardíaco permite a detecção acurada, rápida e contínua da FC. O acompanhamento da FC por meio do monitor cardíaco com três eletrodos parece o mais indicado para a condução da reanimação em sala de parto. A opção B está incorreta não é feita a palpação do pulso carotídeo. A opção C está correta e a D está incorreta tanto a palpação do cordão quanto a ausculta precordial subestimam a FC. Por fim, a oximetria de pulso é capaz de detectar de forma contínua a frequência de pulso, mas demora para detectá-la e subestima a FC. Resposta letra C.

274384.

Comentário: Lembre-se de que a idade gestacional, por si só, não indica a necessidade do clampamento imediato do cordão umbilical. Podemos aguardar pelo menos 30 segundos para clampear o cordão do RN com idade gestacional inferior a 34 semanas e de 60 a 180 segundos para os RN com 34 ou mais semanas, desde que apresentem bom tônus muscular, esteja respirando e ou chorando, ou seja, apresentem boas condições de vitalidade. No descolamento prematuro de placenta, no prolapso de cordão e no nó verdadeiro de cordão, a circulação placentária não está intacta, por isso o clampeamento deve ser imediato. O mesmo é válido para os RN de qualquer idade gestacional que não tenham boas condições de vitalidade. Tais crianças devem ser submetidas ao clampeamento imediato do cordão para o início das manobras de reanimação. Resposta letra A.

261256.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

Comentário: A afirmativa está certa. A hipoglicemia no período neonatal pode ser um evento completamente assintomático, bem como ser acompanhada de uma série de manifestações inespecíficas. Além da sonolência excessiva, hipoatividade e convulsões, outros sinais e sintomas incluem letargia, apneia, cianose, choro fraco ou agudo, recusa alimentar e vômitos, tremores ou abalos. Resposta letra A.

261257.

Comentário: A afirmativa está certa. A hipoglicemia no período neonatal é, em linhas gerais, o resultado de um desequilíbrio entre a taxa de produção de glicose e de utilização da mesa. Isso pode ser o resultado de diversos mecanismos fisiopatológicos no período neonatal pode haver limitação na gliconeogênese por estoques inadequados de glicogênio pode haver aumento na utilização, seja por quadros de hiperinsulinismo quanto por quadros de aumento da demanda metabólica. Alguns erros inatos do metabolismo podem levar a este quadro, como as desordens dos metabolismo do glicogênio, desordens da gliconeogênese, desordens do metabolismo de aminoácidos, do metabolismo de carboidratos ou de ácidos graxos. O diagnóstico definitivo de cada uma dessas condições depende outras avaliações complementares. Resposta letra A.

261258.

Comentário: A afirmativa está errada. Lembre-se de que, logo após o nascimento, devemos responder três perguntas Gestação a termo Respirando ou chorando Tônus muscular em flexão . Quando respondemos sim às três perguntas, deve ser indicado o clampeamento oportuno do cordão e a criança permanece no colo materno. Quando a criança não tem respiração choro ou quando o tônus não é adequado, deve ser indicado o clampeamento imediato do cordão para início imediato dos passos iniciais da reanimação. No caso descrito, o recém-nascido encontrava-se em apneia e hipotonia, devendo ser feito o clampeamento imediato. Resposta letra B.

261259.

Comentário: A afirmativa está errada. É fato que a cronologia dos eventos descritas no enunciado não ficou muito clara. Em que momento foi feita a avaliação da frequência cardíaca e da saturação de oxigênio. Lembre-se de que quando a criança é levada à mesa de reanimação, as primeiras

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

etapas do atendimento são os passos iniciais (prover calor, posicionar a cabeça, aspirar as vias aéreas, se necessário, e secar). Apenas após estes passo é feita a avaliação da frequência cardíaca quando a criança está em apneia, com respiração irregular ou frequência cardíaca menor que 100 bpm, devemos iniciar a ventilação com pressão positiva, quando o oxímetro e o monitor cardíaco são então posicionados. Quando não há melhora, a técnica é checada e, se ainda assim não houver melhora, devemos avaliar a intubação. A massagem cardíaca só é indicada quando a frequência persiste abaixo de 60 bpm apesar de todas as medidas anteriores. Resposta letra B.

261260.

Comentário: A redação do enunciado foi extremante confusa, mas a afirmativa parece estar certa. Não fica claro em que momento foi feita a avaliação da frequência cardíaca e da saturação de oxigênio. Lembre-se de que quando a criança é levada à mesa de reanimação, as primeiras etapas do atendimento são os passos iniciais (prover calor, posicionar a cabeça, aspirar as vias aéreas, se necessário, e secar). Apenas após estes passo é feita a avaliação da frequência cardíaca quando a criança está em apneia, com respiração irregular ou frequência cardíaca menor que 100 bpm, devemos iniciar a ventilação com pressão positiva, quando o oxímetro e o monitor cardíaco são então posicionados. A banca certamente quis indicar que os passos iniciais já foram feitos e, neste momento, a próxima etapa é o início da ventilação com balão e máscara em ar ambiente, pois a criança tem 34 ou mais semanas. Resposta letra A.

261261.

Comentário: A afirmativa está certa. A ocorrência de problemas durante a gestação, parto ou nascimento são fatores de risco para o desenvolvimento de uma criança. O escore de Apgar não deve ser utilizado para determinar as manobras de reanimação, mas é um marcador da vitalidade do recém-nascido e nos permite avaliar a eficácia das manobras de reanimação. Neste contexto, é uma informação importante durante o acompanhamento de uma criança. Resposta letra A.

261262.

Comentário: A afirmativa está correta. O céfalo-hematoma consiste em uma hemorragia subperióstea, tipicamente associada com algum tocotraumatismos. Trata-se de uma condição de

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

resolução espontânea, que não costuma demandar qualquer intervenção específica, mas pode associa-se com complicações. Uma destas complicações é o aumento no risco de hiperbilirrubinemia grave durante a reabsorção do sangue. Isto pode, inclusive, levar à icterícia ainda nas primeiras 24 horas de vida. Resposta letra A.

261263.

Comentário: A afirmativa está correta. As fraturas de clavícula são as fraturas mais comuns no período neonatal. Costumam estar associadas com alguma dificuldade no parto vaginal, em especial quando há distócia de ombro, ainda que possam ocorrer em partos cesáreos ou mesmo em partos sem complicações. As fraturas completas, com deslocamento, costumam ser identificadas mais precocemente e já levam ao surgimento de alterações clínicas no período neonatal imediato. As alterações incluem a presença de crepitações, edema, diminuição na movimentação do membro e dor com a movimentação passiva. A radiografia simples confirma o diagnóstico e o prognóstico é bom, sendo indicada penas conduta expectante. Resposta letra A.

284364.

Comentário: A afirmativa está errada. O termo epigenética se refere a mudanças que alteram a expressão genética, sem, no entanto, alterar a sequência primária do DNA. Tais mudanças incluem processos como metilação, acetilação e fosforilação. Estas mudanças podem ser passadas de uma célula para outra, ou seja, podem ser herdadas. Diferentemente do que acontece nas mudanças na sequência genômica, as alterações epigenéticas podem ser reversíveis. Resposta letra B.

250103.

Comentário: Afirmativa completamente errada, que mistura conceitos para tentar te confundir. O teste do reflexo vermelho (o famoso teste do olhinho) é um teste de triagem neonatal simples que deve ser feito em todos os RNs antes da alta hospitalar. Com o uso do oftalmoscópio simples, o pediatra realiza uma fundoscopia buscando a presença do reflexo vermelho. Alterações neste exame podem indicar comprometimento dos meios transparentes oculares, podendo ser sinal de catarata congênita, glaucoma,retinoblastoma, etc. AO identificar uma alteração no teste do reflexo vermelho, o pediatra deve encaminhar o RN para uma consulta com oftalmologista. Já a triagem da

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

retinopatia da prematuridade deve ser feita entre a 4 e a 6 semanas de vida para todo RN com peso de nascimento 1500 g ou com idade gestacional 32 semanas ou ainda para RNs entre 32 e 37 semanas que apresentaram alguma intercorrência neonatal, como doença da membrana hialina, sepse, transfusão de sangue, gestação múltipla e hemorragia intraventricular. Afirmativa incorreta. Resposta letra B.

250106.

Comentário: O teste da orelhinha é realizado com o método de emissões otoacústicas evocadas, que consiste na emissão de um estímulo sonoro e na captação do seu retorno (eco), sendo registrado no computador e confeccionado em um gráfico. Avalia apenas o sistema auditivo pré-neural, ou seja, sistema de condução e cóclea. Os procedimentos neurofisiológicos e avaliação de possíveis alterações na via neural até o tronco cerebral só são possíveis com o potencial auditivo de tronco encefálico, que é o teste a ser realizado em pacientes que apresentaram falha no teste da orelhinha. Resposta errado.

250112.

Comentário: Afirmativa INCORRETA. O quadro clínico da sífilis congênita pode ser classificado em dois estágios precoce (identificada até dois anos de vida) e tardia (após dois anos de vida). O recém-nascido com sífilis congênita precoce pode ser prematuro ou pequeno para a idade gestacional, sendo que a maioria das manifestações clínicas serão identificadas apenas nos primeiros três meses de vida. Isso significa que o recém-nascido pode ser - e até costuma ser - completamente assintomático ao nascer. Cuidado com o jogo de palavras as lesões ósseas (osteocondrite e periostite) são mesmo encontradas na maioria das crianças sintomáticas com sífilis congênita precoce, mas a maioria das crianças são assintomáticas, essa é a ideia. Gabarito B.

250113.

Comentário: Em relação a incompatibilidade ABO, sabemos que um teste de Coombs direto negativo não exclui o diagnóstico. No entanto, em discordância dos tipos sanguíneos entre mãe e feto A e B, ou vice versa, apesar de ser possível a reação imunomediada, ela não ocorre na primeira gestação, mas após a mesma, quando ocorre sensibilização materna. Afirmativa ERRADA.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

239316.

Comentário: A afirmativa está errada. O achado de microcefalia e baixo peso é até compatível com a toxoplasmose congênita, e esta infecção cursa com calcificações. Todavia, na toxoplasmose as calcificações são tipicamente descritas em todo o parênquima cerebral. A descrição de calcificações periventriculares é típica da citomegalovirose congênita. Resposta letra B.

239317.

Comentário: A afirmativa está errada. A prescrição de sulfadiazina, pirimetamina e ácido folínico estaria apropriada para o diagnostico de toxoplasmose congênita, mas não é este o caso. A descrição de calcificações periventriculares é típica da citomegalovirose congênita. Na toxoplasmose as calcificação são tipicamente descritas em todo o parênquima cerebral. O tratamento da citomegalovirose, quando indicado, é feito com ganciclovir. Resposta letra B.

239318.

Comentário: A afirmativa está correta. Esta criança apresenta, muito provavelmente, uma infecção congênita. Ainda que algumas manifestações sejam inespecíficas, a descrição de calcificações periventriculares é típica da citomegalovirose congênita. Tal condição pode cursar com várias alterações oculares, incluindo coriorretinite. Esta é a alteração ocular mais comumente encontrada e se correlaciona com um pior prognóstico neurológico, sendo necessária a avaliação oftalmológica. Resposta letra A.

239319.

Comentário: A afirmativa está errada. A descrição de calcificações periventriculares é típica da citomegalovirose congênita e não é rotineiramente indicada esta avaliação durante o acompanhamento da gestante. é interessante notar que mesmo as mulheres infectadas antes da concepção podem transmitir o vírus para o concepto, seja por reativação de uma infecção latente ou por reinfecção por outra cepa. É fato que a infecção aguda durante a gestação aumenta o risco de contaminação fetal, mas essa avaliação não é rotineiramente feita pelo Ministério da Saúde. Resposta letra B.

239320.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

Comentário: A afirmativa está errada. O provável diagnóstico desta criança, sugerido pela presença das calcificações periventriculares, é da citomegalovirose congênita. Não há qualquer forma de profilaxia específica indicada para a prevenção da contaminação por este vírus. Resposta letra B.

239321.

Comentário: A afirmativa está correta. A descrição de calcificações periventriculares é típica da citomegalovirose congênita, o provável diagnóstico deste lactente. Os achados laboratoriais tipicamente encontrados são aumento das aminotransferases séricas, plaquetopenia e aumento das bilirrubinas direta e indireta. Outras alterações hematológicas podem incluir anemia hemolítica, neutropenia, linfopenia, linfocitose ou reação leucemoide. Resposta letra A.

214420.

Comentário: Na caderneta de saúde da criança encontramos uma tabela que lista os principais fatores de risco associados a alterações no desenvolvimento. Diante desses fatores, a avaliação do neurodesenvolvimento da criança é feita com mais cautela. São considerados fatores de risco ausência de pré-natal, problemas na gestação parto ou nascimento, prematuridade, peso abaixo de 2500 gramas, icterícia grave, hospitalização no período neonatal, doenças graves (como meningite, traumatismo craniano e convulsões), parentesco entre os pais, casos de deficiência ou doença mental na família, fatores de risco ambientais (como violência doméstica, depressão materna ou alcoolismo entre os moradores da casa, suspeita de abuso sexual, entre outros). A criança apresentada pela banca apresenta vários desses fatores, que aumentam a chance de ter alteração do neurodesenvolvimento. A afirmativa está errada. Resposta letra B.

196631.

Comentário: A afirmativa está correta. Este recém-nascido apresenta, provavelmente, o diagnóstico de sífilis congênita (as lesões bolhosas descritas são bem típicas desta condição). A sífilis congênita é considerada um evento sentinela da qualidade de assistência pré-natal. Deve-se entender que cada caso de sífilis congênita representa uma falha na identificação da gestante infectada ou na aplicação das medidas de prevenção para diminuir a transmissão. Deste modo, sua ocorrência obriga a investigação retrospectiva dos casos para obter informações sobre a

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

assistência prestada e propor medidas pertinentes. Resposta letra A.

196642.

Comentário: A descrição da ausência de pré-natal é um dado frequentemente encontrado nos enunciados de questões que trazem casos clínicos de uma infecção congênita, pois sugerem que a condição poderia ter sido identificada caso o acompanhamento da gestante tivesse ocorrido de modo apropriado. Porém, mesmo sem este dado, deveríamos considerar o diagnóstico de uma das principais infecções congênitas de nosso meio a sífilis. Lembre-se de que a história de prematuridade e a restrição ao crescimento intrauterino podem ser identificadas em diversas condições, porém, as lesões cutâneas bolhosas encontradas nas topografias descritas são bem características da infecção pelo Treponema pallidum e recebem o nome de pênfigo palmoplantar. Diversas outras alterações podem ser encontradas nestas crianças, tais como obstrução nasal e rinite serossanguinolenta, lesões ósseas (periostite e osteocondrite, levando à pseudoparalisia de Parrot) e outras lesões cutâneas e mucosas, como o condiloma plano e lesões maculopapulares. Além da esplenomegalia, pode haver hepatomegalia. A icterícia também é um achado possível e pode estar relacionada a um quadro de hepatite ou a um processo de hemólise, ou seja, associa-se tanto com o aumento da bilirrubina direta quanto da bilirrubina indireta. Deste modo, a afirmativa está correta. Resposta letra A.

196669.

Comentário: A afirmativa está absolutamente errada, por mais de uma razão. Este recém-nascido, provavelmente, apresenta um quadro de sífilis congênita. Ainda que a prematuridade e o baixo peso ao nascimento possam ser identificados em outras infecções congênitas, a descrição do pênfigo palmoplantar é bastante típica da sífilis. Como não houve o acompanhamento pré-natal, estamos diante de um recém-nascido de uma gestante com sífilis que não foi tratada e, deste modo, uma série de exames são indicados, dentre eles a análise do liquor. Lembre-se de que na presença de alterações liquóricas (aumento da proteinorraquia, da celularidade ou VDRL reagente), o tratamento deve ser feito obrigatoriamente com a penicilina cristalina por via intravenosa. Se por qualquer razão não for possível a análise do liquor, devemos presumir que há neurossífilis e indicar

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

o tratamento para tal. Ademais, no caso apresentado, ainda que análise do liquor se revelasse normal, não seria possível o tratamento apenas com a penicilina benzatina, pois a criança encontra-se sintomática. Nos casos de recém-nascido de mulheres que não foram tratadas ou que foram inadequadamente tratadas, o tratamento com a penicilina benzatina só é possível quando a criança se encontra assintomática, todos os exames estão normais (incluindo um VDRL do sangue periférico não reagente) e há garantia de acompanhamento. Resposta letra B.

196691.

Comentário: A afirmativa está errada e aborda um ponto muito importante para o manejo prático destas situações. O caso traz um recém-nascido que, provavelmente, tem sífilis congênita (as lesões descritas caracterizam o pênfigo palmoplantar, típico desta condição). As lesões cutâneas e os fluidos corporais dessas crianças possuem Treponema pallidum e podem ser fonte de contaminação. As precauções de contato devem ser indicadas para todos os recém-nascidos com sífilis congênita suspeita ou comprovada e devem permanecer pelas primeiras 24 horas após o início do tratamento. Algumas horas após o início da terapia com penicilina, já ocorre o desaparecimento de treponemas viáveis nas lesões. Resposta letra B.

196701.

Comentário: A afirmativa está correta. O provável diagnóstico deste recém-nascido é o de sífilis congênita. A principal alteração que nos faz supor isto é a descrição das lesões bolhosas, que configuram o pênfigo palmoplantar encontrado nesta condição. As consequências da infecção irão depender do momento em que a infecção ocorreu e do tempo transcorrido para o início do tratamento. Além do abortamento ou do óbito fetal, podemos ter a prematuridade e a restrição ao crescimento intrauterino. A restrição ao crescimento intrauterino irá fazer com que, ao nascimento, o recém-nascido seja considerado pequeno para a idade gestacional. Resposta letra A.

196703.

Comentário: A afirmativa está correta. Este recém-nascido, muito provavelmente, apresenta um quadro de sífilis congênita. Diversas manifestações inespecíficas podem ser encontradas nesta condição, mas a descrição das lesões bolhosas na região palmar e plantar é bem típica e sugere

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

este diagnóstico. Os achados ósseos são comuns na sífilis congênita precoce e podem ser identificados em até 60 ou 80% dos casos não tratados. Comumente encontramos lesões múltiplas e simétricas. São observadas alterações por periostite e desmineralização da cortical na região das metáfises e diáfise e também encontramos osteocondrite, afetando as articulações. A desmineralização e destruição óssea da região medial proximal da metáfise da tíbia recebe o nome de sinal de Wimberger. A dor causada pelas lesões e eventuais fraturas leva à imobilidade álgica dos membros, constituindo a pseudoparalisia de Parrot. A criança demonstra irritabilidade e recusa para movimentar um dos membros, sendo mais comum o acometimento dos membros superiores. Resposta letra A.

214494.

Comentário: Afirmativa INCORRETA. A manobra de Barlow é utilizada para induzir deslocamento em quadris instáveis . Nesta manobra, o examinador segura as coxas do bebê em adução e flexãoe as pressiona posteriormente, na tentativa de induzir o deslocamento da articulação do quadril (é uma manobra provocativa). Quando positiva, o examinador sente o deslocamento da articulação ocorrendo. Na manobra de Ortolani, fazemos o oposto ela é realizada para reduzir a cabeça femoral deslocada. O examinador segura as coxas com o polegar e indicador e com o quarto e quinto dedos, eleva o grande trocanter enquanto faz a abdução do membro. Dizemos que a manobra é positiva quando sentimos na mão um clique do quadril. Para avaliar fratura de clavícula, devemos palpá-la cuidadosamente (na presença de fratura, sente-se uma crepitação local e o recém-nascido expressa dor). As paralisias braquiais acontecem por estiramento exagerado do plexo braquial durante o parto (na paralisia de Erb-Duchenne, por exemplo, o RN é incapaz de abduzir, rodar externamente e supinar o antebraço, mantendo postura fixa do membro superior aduzido, rodado internamente e pronado). Gabarito B.

196640.

Comentário: No caso em tela, em relação aos cuidados com o recém-nascido, devemos lembrar que é absolutamente contraindicado o aleitamento materno. Além disso, devemos iniciar AZT imediatamente após o nascimento (via oral e em xarope), mantendo-se por 4 semanas de vida

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

independente da idade gestacional ou do peso ao nascimento. Resposta letra B. Além disso, em casos como o exposto, em que a mãe fez o TARV corretamente mas segue com carga viral maior ou igual a 1.000 cópias (ou desconhecida) em sorologia do 3º trimestre (pós 34 semanas), devemos adicionar a nevirapina oral, lembrando que, caso o peso ao nascimento seja menor que 1,5 kg como a hipótese sugerida, este conduta é contraindicada.

179206.

Comentário: Aproveite esta questão para entender melhor alguns conceitos que, frequentemente, são confundidos. A transmissão transplacentária do toxoplasma ocorre, essencialmente, quando a mulher adquire a infecção aguda durante a gestação. Por esta razão é tão importante determinar se a infecção ocorreu antes ou após a concepção. Os títulos de anticorpos da classe IgM contra o toxoplasma nem sempre são úteis para apontar uma infecção aguda, pois podem permanecer elevados por longos períodos. Uma avaliação que pode auxiliar o obstetra a identificar o momento da infecção materna é a avaliação do índice de avidez de IgG, pois resultados elevados no índice de avidez indicam que a infecção aguda ocorreu há mais de três a quatro meses. Avaliando os resultados da gestante, podemos concluir que a infecção aconteceu há menos do que quatro meses porque o índice de avidez é baixo Não E isto é um equívoco comum. O índice de avidez pode manter valores considerados baixos por mais de um ano e não deve ser utilizado isoladamente para diagnóstico de toxoplasmose aguda gestacional. A avaliação inicial deste recém-nascido deveria ter incluído a realização de sorologia... A análise do liquor, a princípio, estaria reservada para os casos em que há alterações clínicas ou sorológicas do recém-nascido ou quando há confirmação de infecção aguda materna (o que não houve). De todo modo, esta avaliação foi feita e mostrou-se alterada. Lembre-se de que todas as crianças com infecção congênita deverão ser tratadas durante o primeiro ano de vida com sulfadiazina, pirimetamina e ácido folínico (a banca indicou o uso de ácido fólico, o que está incorreto). O que a banca queria saber, na verdade, é se o candidato era capaz de indicar a corticoterapia neste caso. Quando há coriorretinite em atividade ou quando a proteinorraquia está muito elevada (1 g dl), devemos acrescentar prednisona prednisolona até a melhora do processo inflamatório. Como a resposta

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

indicava o uso de ácido fólico, seria até possível ter sido pedida a anulação da questão, mas não parece ter havido pedido de recurso. Resposta letra B.

179211.

Comentário: Existem determinadas situações que constituem fatores de risco para o desenvolvimento de hiperbilirrubinemia grave no período neonatal. É importante que você se familiarize com elas, pois as perguntas sobre isso são frequentes. Os fatores de risco considerados maiores pra a hiperbilirrubinemia grave são bilirrubina total sérica ou transcutânea na zona de alto risco antes da alta hospitalar icterícia observada nas primeiras 24 horas incompatibilidade sanguínea ou outras doenças hemolíticas conhecidas idade gestacional entre 35 e 36 semanas irmão com icterícia neonatal tratado com fototerapia céfalo-hematoma ou equimoses aleitamento materno exclusivo, especialmente se há problemas com a amamentação e a perda ponderal for excessiva etnia asiática. A opção B poderia nos deixar em dúvidas, pois é possível o desenvolvimento de incompatibilidade ABO quando a mãe é A e o recém-nascido é B, porém, o mais comum é que na incompatibilidade ABO a mãe seja O e o recém-nascido A ou B. Resposta letra D.

179209.

Comentário: Diversas situações podem ser consideradas fatores de risco para o desenvolvimento de sepse neonatal. Essas situações podem ser separadas em fatores materno e fatores do recém-nascido. Dentre os fatores materno, encontramos os seguintes febre materna, infecção urinária no parto (nos casos tratados no início da gestação, não há aumento do risco), colonização materna pelo Streptococcus agalactiae , ruptura das membranas maior do que 18 horas, infecção do trato genital. Já em relação aos fatores do recém-nascido, encontramos taquicardia fetal, prematuridade, Apgar menor no quinto minuto menor que 7, sexo masculino (opção A correta) e primeiro gemelar. Resposta letra A.

179177.

Comentário: Existem diversas alterações clínicas que são comuns a várias infecções congênitas, como a restrição ao crescimento intrauterino, a presença de hepatomegalia ou de petéquias. Deste

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

modo, o mais importante é conseguirmos identificar o que há de mais peculiar no enunciado. Neste caso, a principal informação que devemos destacar é a descrição das calcificações periventriculares. As calcificações intracranianas podem ser encontradas em várias infecções congênitas, como na toxoplasmose congênita ou síndrome da infecção pelo vírus Zika, porém, a descrição da distribuição periventricular é típica da citomegalovirose congênita. Além disso, o citomegalovírus está relacionado com o desenvolvimento de surdez e a infecção congênita por este agente é a principal causa de surdez neurossensorial não hereditária na infância. Resposta letra E.

154320.

Comentário: Para acertar essa questão, o ideal era que você tentasse se lembrar de todos os detalhes do teste antes da leitura das opções, ou poderia acabar se confundindo. O teste do coraçãozinho , ou teste da oximetria, é uma avaliação que faz parte da triagem neonatal obrigatória e tem como objetivo permitir a identificação precoce de algumas cardiopatias congênitas críticas (condições que poderão evoluir com grave deterioração clínica quando começar a ocorrer o fechamento do canal arterial). O teste é realizado entre 24 e 48 horas e consiste na avaliação da oximetria do membro superior direito (que sempre informa a saturação pré-ductal) e de um dos membros inferiores (que sempre informa a saturação pós-ductal). O teste é considerado normal quando a saturação em ambas as medidas é maior ou igual a 95% e a diferença entre os membros é menor que 3%. Quando é encontrada alguma alteração, a primeira conduta é repetir o teste após uma hora. Caso a alteração se mantenha, a conduta é realizar um ecocardiograma em até 24 horas. Resposta letra D.

154329.

Comentário: O exantema macular, a icterícia e as petéquias são alterações inespecíficas e que podem ser encontradas em diversas infecções congênitas. O que deve chamar nossa atenção nessa história é a descrição de uma coriza hemorrágica e a osteocondrite, mais típicas dos quadros de sífilis congênita. As manifestações clínicas identificadas na sífilis congênita incluem, além dessas manifestações, outras, como condiloma plano, pênfigo palmoplantar e lesões de periostite. As infecções descritas nas letras B, C e E seriam de transmissão perinatal ou nosocomial e não

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

levariam às alterações típicas do acometimento intraútero. A doença hemorrágica do recém-nascido manifesta-se por sangramentos. Resposta letra A.

152176.

Comentário: A atresia de vias biliares extra-hepáticas é uma das principais causas de colestase no período neonatal, mas não parece ser a causa de icterícia neste caso. A icterícia pode, de fato, ser a primeira manifestação clínica das crianças com a doença, mas nas costuma estar presente ainda na primeira semana de vida. Ao nascimento, as crianças costumam apresentar arvore biliar ainda pérvia e o desenvolvimento da obliteração é progressivo. É até possível que nos primeiros dias de vida a criança com diagnóstico de atresia de vias biliares desenvolva icterícia por outro mecanismo qualquer, mas não pela atresia propriamente dita. Pensamos nessa condição principalmente quando a icterícia se prolonga por mais do que duas semanas ou quando há sinais de colestase. Resposta letra B.

152175.

Comentário: A icterícia é o resultado do acúmulo de bilirrubina direta ou indireta no organismo. Sabemos que a elevação nos níveis de bilirrubina indireta no período neonatal é bastante preocupante. A bilirrubina é um composto neurotóxico e o recém-nascido é especialmente vulnerável a esse efeito. A impregnação do sistema nervoso central pode levar ao desenvolvimento de encefalopatia bilirrubínica, uma condição potencialmente fatal. A conduta diante de uma recém-nascido ictérico irá depender do nível de bilirrubina por ele apresentado. Quando houver níveis muito elevados, potencialmente neurotóxicos, podem ser necessárias a adoção de alguma intervenção, como a fototerapia ou, em casos excepcionais, a exsanguineotransfusão. A fototerapia atua sobre a bilirrubina indireta, transformando-a em um composto capaz de ser excretado na urina ou no fígado, sem necessidade de conjugação. Os níveis de bilirrubina que indicam a necessidade de cada uma dessas intervenções variam em função de vários parâmetros, como a idade gestacional, o tempo de vida e a presença de alguns fatores de risco. No caso apresentado, como a icterícia já alcança a zona IV, não há dúvida de que deve ser feita a quantificação do nível sérico de bilirrubina, para definição de conduta. Resposta letra A.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

152061.

Comentário: A questão nos apresenta um recém-nascido com icterícia na primeira semana de vida. A afirmativa final nos lembra um conceito importantíssimo O grande problema relacionado com a icterícia no período neonatal relaciona-se ao potencial neurotóxico da bilirrubina indireta. Sabemos que o recém-nascido é especialmente vulnerável à neurotoxicidade da bilirrubina, que pode levar ao estabelecimento da encefalopatia bilirrubínica, potencialmente fatal, e ao estabelecimento da forma crônica. Inicialmente, a banca tinha considerado que a afirmativa estava correta, porém, isso foi modificado após recurso perceba que o problema não é a icterícia , mas sim a hiperbilirrubinemia indireta. Um quadro de icterícia por aumento de bilirrubina direta, por exemplo, não se associa com manifestações neurológicas. Assim, a afirmativa está errada. Resposta letra B.

152064.

Comentário: A afirmativa está correta e poderia ser interpretada de forma independente do caso apresentado. Sabe-se que, no período neonatal, a icterícia tem uma progressão craniocaudal. Deste modo, níveis mais baixos de bilirrubina indireta levam à presença de icterícia apenas na face, enquanto a presença de icterícia nas mãos e pés associa-se com níveis bem mais elevados de bilirrubina. Com base nessa informação, a superfície corporal da criança pode ser dividida em zonas dermográficas, as famosas zonas de Kramer. Cada uma das cinco zonas foi classicamente correlacionada com um determinado nível de bilirrubina sérico. Porém, sabemos que isso não deve substituir a avaliação precisa dos níveis de bilirrubina, pois a avaliação pode sofrer variação em função do avaliador. Na zona I, há icterícia apenas na cabeça e pescoço na zona II, até a cicatriz umbilical na zona III, até os joelhos na zona IV, ate os tornozelos e ou antebraços e, por fim, na zona V, na região palmar e plantar. Resposta letra A.

152066.

Comentário: Este é o tipo de questão na qual dá para entender o que a banca quis dizer, mas a verdade é que a redação do texto é, no mínimo, questionável. Sabemos que a causa mais comum de icterícia no período neonatal é a icterícia fisiológica, decorrente de um esperado acúmulo de bilirrubina nos primeiros dias de vida durante a transição do metabolismo de bilirrubina da vida intra

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

para a extrauterina. A icterícia fisiológica, em um recém-nascido atermo, tem início entre o 2 o e o 3 o dia de vida. Toda icterícia que se manifesta nas primeiras 24 horas de vida é, a priori , um quadro patológico e que demanda investigação. O problema com a afirmativa é que formas patológicas de icterícia podem manifestar-se também após 24 horas de vida A afirmativa está errada, pois formas de icterícia patológica podem surgir já nas primeiras 24 horas de vida, mas não entenda com isso que surgem apenas neste período, certo Resposta letra B.

152081.

Comentário: A afirmativa está errada. O teste do coraçãozinho ou teste da oximetria é uma avaliação que faz parte da triagem neonatal obrigatória e tem como objetivo permitir a identificação precoce de algumas cardiopatias congênitas críticas. O teste é realizado entre 24 e 48 horas de vida (não entre 12 e 24 horas) e consiste na oximetria do membro superior direito (que sempre informa a saturação pré-ductal) e de um dos membros inferiores (que sempre informa a saturação pós-ductal). Resposta letra B.

289520.

Comentário: O recém-nascido descrito apresenta sinais de infecção congênita prematuridade, peso abaixo do esperado para a idade gestacional, hepatoesplenomegalia e alterações neurológicas. Os achados descritos no enunciado são compatíveis com toxoplasmose congênita, condição em que há transmissão hematogênica transplacentária do Toxoplasma gondii . A avaliação sorológica do RN é dificultada pela presença de anticorpos maternos da classe IgG. A presença de títulos na criança quatro ou mais vezes maiores que os títulos maternos (preferencialmente em testes realizados pelo mesmo ensaio e em paralelo com o da mãe) podem sugerir infecção congênita. Nas crianças não infectadas, o título dos anticorpos IgG diminui progressivamente até que ocorra negativação em torno de um ano de vida. Já a presença de IgM antitoxoplasma em amostra do RN, que idealmente deve ser coletada após o 5º dia de vida, pode estabelecer o diagnóstico de infecção congênita. A pesquisa de IgA antitoxoplasma tem o mesmo significado que a pesquisa de IgM, mas os testes sorológicos para detecção de IgA são pouco disponíveis no Brasil. Portanto, a assertiva está certa. Resposta letra A.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

289527.

Comentário: O recém-nascido descrito apresenta sinais de infecção congênita prematuridade, peso abaixo do esperado para a idade gestacional, hepatoesplenomegalia e alterações neurológicas. Os achados descritos no enunciado são compatíveis com toxoplasmose congênita, condição em que há transmissão hematogênica transplacentária do Toxoplasma gondii . As principais manifestações clínicas, quando presentes, são c alcificações intracranianas difusas hidrocefalia coriorretinite líquor com inexplicável pleocitose ou proteína elevada hepatoesplenomegalia. A surdez neurossensorial pode estar presente e ser leve ou grave. Não é certo que quadro seja progressivo, mas o acompanhamento e o tratamento precoce reduzem sua evolução. Portanto, a assertiva está certa. Resposta letra A.

131851.

Comentário: Se formos levar ao pé da letra, esta questão não traz uma resposta correta. Quando, logo após o nascimento, a criança não se apresenta com bons sinais de vitalidade (choro ou respiração regular e tônus adequado), deve ser conduzida à mesa de reanimação para a adoção dos passos iniciais aquecer, posicionar, aspirar e secar. Após esses passos, é feita a avaliação da frequência cardíaca e da respiração. As crianças que têm frequência cardíaca menor do que 100 bpm, respiração irregular e ou apneia devem ser submetidas à ventilação com pressão positiva. O que causou surpresa nesta questão foi o fato de os passos iniciais não terem sido descritos. Porém, aqui vale a máxima não brigue com a questão. Existe alguma outra intervenção descrita que seria executada antes da ventilação Faríamos a massagem cardíaca A intubação Por isso, vamos assumir que os passos iniciais foram omitidos no enunciado, mas tinham sido feitos, e vamos iniciar a ventilação habitualmente com balão autoinflável. Resposta letra B.

105558.

Comentário: De forma bem simples, a banca indicou que este recém-nascido tem sinais de choque. No que consiste o tratamento imediato Na reposição volêmica vigorosa, em um momento inicial, seguida do uso de drogas vasoativas caso o quadro persista. Não há dúvidas de que essa ressuscitação volêmica deva ser feita com uma solução cristaloide, como o soro fisiológico (apenas

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

com isso poderíamos excluir três alternativas e ficarmos apenas com as opções B e D), mas pode haver dúvidas em relação ao volume. É aceito que seja feita a prescrição de 10 ml kg, 20 ml kg ou 10-20 ml kg... Porém, como a dopamina ainda é a medicação mais empregada para o tratamento da hipotensão período neonatal, a opção B seria a melhor alternativa. Resposta letra B.

105554.

Comentário: O uso de CPAP nasal é uma estratégia muitíssimo utilizada nas UTI neonatais em diferentes situações clínicas, tais como síndrome do desconforto respiratório, taquipneia transitória do recém-nascido, síndrome de aspiração meconial e displasia broncopulmonar. O uso precoce de CPAP em recém-nascidos de maior risco para síndrome do desconforto repsiratório é capaz de promover a estabilização alveolar e prevenir o colapso expiratório, atuando de forma profilática no desenvolvimento de doença mais grave. Pode atuar de forma terapêutica, permitindo a reabertura de alvéolos colabados. Nos casos em que há hipercarbia mais acentuada, o CPAP não será uma estratégia suficiente e será necessária a ventilação mecânica invasiva. Resposta letra B.

105566.

Comentário: As principais formas de incompatibilidade materno-fetal são a incompatibilidade ABO e a incompatibilidade Rh. Na incompatibilidade ABO, a situação mais comum é uma mãe O e um recém-nascido A ou B o quadro pode ocorrer em uma primeira gestação. Na incompatibilidade Rh, temos uma mãe Rh negativo e um recém-nascido Rh positivo. Lembre-se de que, para produzir os anticorpos anti-D, a mulher deve ter sido sensibilizada anteriormente, como em uma gestação prévia. A identificação de anticorpos ligados na superfície das hemácias fetais pode ser feita pelo teste de Coombs direto (o Coombs indireto é realizado na gestante para identificação dos anticorpos anti-D). Vale lembrar que, na incompatibilidade Rh, o Coombs direto no recém-nascido será invariavelmente positivo. Porém, na incompatibilidade ABO, o teste poderá ser positivo ou negativo. Resposta letra D.

105544.

Comentário: Esta questão aborda diversas avaliações que são feitas para o rastreamento de algumas condições ainda no período neonatal. Vejamos o que é dito em cada uma das alternativas.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

A opção A está ERRADA o teste de Ortolani faz parte da avaliação de todo recém-nascido, mas é um teste que se propõe a fazer o rastreamento da displasia do desenvolvimento do quadril, não do joelho. Apenas para relembrar, o teste de Ortolani é capaz de promover a redução de uma articulação que está luxada, ou seja, recoloca a cabeça do fêmur no acetábulo. A opção B também está ERRADA a triagem metabólica neonatal identifica o hipotireoidismo, não o hiper. Lembre-se de que o atual programa do Ministério da Saúde prevê o rastreamento também da fibrose cística, deficiência de biotinidase e hiperplasia adrenal congênita, (mas ainda não são todos os Estados que fazem o rastreamento de todas as condições. A opção C está ERRADA a pesquisa do reflexo vermelho (teste do olhinho) identifica opacidades no eixo visual, como a catarata congênita. A opção E está ERRADA o teste da oximetria (teste do coraçãozinho) consiste na avaliação da saturação de oxigênio no membro superior direito e em um dos membros inferiores. O teste normal é aquele que o valor é 95% em ambas as medidas e a diferença é 3%. A única afirmativa CERTA é a letra D o teste da orelhinha (emissões otoacústicas evocadas) avalia o sistema de condução e a cóclea. O teste é feito colocando-se um fone externo no ouvido da criança consiste na emissão de um estímulo sonoro e na captação do seu retorno (eco), sendo registrado no computador e confeccionado um gráfico. Avalia, assim, apenas o sistema auditivo pré-neural, ou seja, sistema de condução e cóclea. Resposta letra D.

105562.

Comentário: Existem diversos mecanismos que podem levar a uma restrição ao crescimento intrauterino. Um deles foi lembrado neste enunciado, que é a exposição do feto a alguns hormônios, mais especificamente, aos glicocorticoides. Ainda que os glicocorticoides maternos sejam convertidos em grande parte durante a passagem placentária em análogos inertes, pode ocorrer diminuição das enzimas responsáveis por essa conversão e maior exposição aos hormônios ativos, o que levaria à restrição de crescimento. Essa restrição decorre do fato de que os glicocorticoides são capazes de antagonizar os efeitos anabólicos de diferentes vias responsáveis pelo crescimento intrauterino. Resposta letra C.

108232.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

Comentário: Questão bem difícil de ser avaliada. Vamos relembrar os conceitos mais importantes. A avaliação de uma possível sífilis congênita parte da determinação da adequação do tratamento materno. Este é um dos primeiros problemas identificados na avaliação desse caso. É sabido que mesmo indivíduos tratados podem permanecer com títulos baixos de VDRL durante muito tempo. Assim, no caso enunciado, a positividade do VDRL neste momento não significa que esta mulher ainda esteja infectada. Porém, teríamos que ter a comprovação de que o tratamento foi de fato feito de forma correta e de que o título neste momento era menor do que o identificado na última vez. Por essa razão, o mais provável é que a banca desejasse que esse tratamento fosse considerado um tratamento inadequado. Diante de um recém-nascido de mulher inadequadamente tratada, quatro exames são fundamentais VDRL do sangue periférico, hemograma, avaliação do líquor e radiografia de ossos longos. No enunciado foi omitida a realização do hemograma, o que torna a conduta incorreta. Além disso, o tratamento com penicilina cristalina não é feito com a dose descrita. Prescreve-se 50.000 U kg dose de 12 em 12 horas nos primeiros sete dias de vida e de 8 em 8 horas do oitavo dia em diante. Assim, a afirmativa está incorreta. Resposta letra B.

108209.

Comentário: Era possível inferirmos a resposta correta mesmo sem conhecermos o diagnóstico, pois a retinopatia da prematuridade está, evidentemente, associada com a prematuridade. Este quadro se estabelece quando ocorre algum fator, após o nascimento, que promove a vasoconstrição seguida de parada de crescimento vascular em uma retina que ainda não está vascularizada.. Os principais fatores relacionados com o desenvolvimento desta condição são a oxigenoterapia, a idade gestacional e o peso de nascimento. A associação de leucocoria com estrabismo deve nos alertar em relação à possibilidade de um outro diagnóstico, que é o diagnóstico de retinoblastoma. Ainda que a idade média de diagnóstico seja aos dois anos, o diagnóstico pode ser estabelecido aos 5 anos. Assim, a afirmativa está errada. Resposta letra B.

108229.

Comentário: Temos uma gestante Rh negativo, previamente sensibilizada, como apontado pelo teste de Coombs indireto positivo. Sabemos que, em uma situação como essa, se o recém-nascido

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

for Rh positivo, haverá risco para o desenvolvimento de um quadro de eritroblastose fetal ou de doença hemolítica grave no período neonatal. Porém, não há recomendação para clampeamento precoce de cordão em uma situação como essa. Além disso, como isso pode levar ao desenvolvimento de icterícia precoce, essa criança deverá ser submetida à avaliação da presença de icterícia mesmo antes do final do primeiro dia de vida. Como regra geral, recomenda-se que seja feita uma avaliação sumária do recém-nascido ainda na sala de parto e um exame mais completo nas primeiras horas de vida. Deste modo, a afirmativa está errada. Resposta letra B.

108233.

Comentário: Logo após o nascimento, identificou-se que um recém-nascido a termos encontrava-se em apneia e foram realizados os passos inicias da reanimação. Ainda que a descrição dos passos iniciais não tenha sido aquela que habitualmente esperaríamos encontrar (aquecer, posicionar, aspirar e secar), a banca indica que isso foi corretamente feito em até 30 segundos. Porém, mesmo após esse passos, a criança permaneceu em apneia. Neste momento, a conduta correta é o início da ventilação com pressão positiva, habitualmente feita com balão autoinflável e máscara facial. Sempre que há indicação de ventilação, recomenda-se a colocação de um sensor de oximetria para aferição da saturação no membro superior direito. A ventilação deve ser feita com uma frequência de 40 a 60 por minuto e a concentração de oxigênio ofertada irá variar conforme a idade gestacional. Havendo a disponibilidade de oxímetro e blender na sala de parto, os recém-nascidos com 34 ou mais semanas devem ser ventilados em ar ambiente e aqueles com menos de 34 semanas com uma concentração de oxigênio de 40%. Devemos nos lembrar ainda de que nos primeiros 5 minutos, o valor esperado de saturação de oxigênio é entre 70-80%. Assim, a afirmativa está errada. Resposta letra B.

79684.

Comentário: A questão traz diversos distúrbios respiratórios neonatais e deseja saber qual delas não pode persistir além de 48 horas. A doença da membrana hialina, assim como a pneumonia, a síndrome de aspiração meconial e o pneumotórax espontâneo são entidades patológicas que têm ampla variedade no seu espectro clínico de apresentação. Suas manifestações, indubitavelmente,

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

podem persistir por vários dias, ou mesmo semanas, a depender da evolução (que pode, inclusive, ser fatal). A controvérsia fica acerca da taquipneia transitória do RN. Segundo o Nelson 19ª edição, a maioria dos neonatos recupera-se em 3 dias (72 horas) e não em 48h... Por outro lado, de fato, dentre as opções a TTRN é a que mais provavelmente se recupera em até 48h, e talvez tenha sido isso que o autor tenha desejado perguntar. A questão gerou polêmica, em função da redação mal feita do enunciado. Apesar da elaboração do recurso, a banca manteve seu gabarito. Gabarito letra D.

79683.

Comentário: Vamos analisar as opções no contexto da prevenção da transmissão vertical do HIV A Correta. Toda gestante infectada pelo HIV deve receber TARV durante a gestação e seu início deve ser precoce, entre a 14a e a 28a semana de gestação. B INCORRETA. A cesareana eletiva deve ser indicada para gestantes HIV que não realizaram profilaxia antirretroviral combinada durante a gestação, que usaram apenas monoterapia com AZT ou que tenham sua carga viral com 34 semanas ou mais de gestação, desconhecida ou superior a 1.000 cópias mL. C Correta. Deve-se administrar Zidovudina (AZT) desde o início do trabalho de parto até o nascimento e o clampeamento do cordão umbilical. D INCORRETA. O recém-nascido deve receber AZT solução oral, preferencialmente ainda na sala de parto, nas primeiras 2 horas após o nascimento. Não se recomenda a coleta de sorologia ao nascimento. Segundo o Ministério da Saúde, colhe-se carga viral aos 1-2 meses e 4 meses. A sorologia ao nascer para o neonato está indicada apenas se ele tiver sido abandonado, ou naquelas situações em que a mãe não tem documentação confiável da sua infecção. E Correta. O aleitamento materno está terminantemente contraindicado nos casos de mães com sorologia positiva para HIV e, portanto, seus bebês devem receber fórmula infantil adequada. Em função de duas opções incorretas, B e D, a banca anulou a questão.

82127.

Comentário: ERRADO. O Teste do Reflexo Vermelho (TRV), também conhecido como Teste do Olhinho , é um exame que embora extremamente simples, é capaz de identificar a presença de diversas enfermidades visuais como a catarata congênita e o retinoblastoma. Diversas outras

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

doenças também podem ser triadas por aplicação do TRV, e confirmadas através de diagnóstico diferencial de leucocorias, como a Retinopatia da Prematurida, o Glaucoma Congênito, o Retinoblastoma, a Doença de Coats, a Persistência Primária do Vítreo Hiperplásico (PVPH), Descolamento de Retina, Hemorragia Vítrea, Uveíte (Toxoplasmose, Toxocaríase), Leucoma e até mesmo Altas Ametropias. Contudo, não é o exame ideal para avaliação de coriorretinites, as quais seriam melhor avaliadas com outro exame O fundo de olho ou fundoscopia.

82123.

Comentário: CERTO. Em uma situação em que a mãe é do grupo sanguíneo A e Rh positivo (possui apenas anticorpos naturais anti-B) e seu bebê é do grupo sanguíneo O Rh positivo (não possui em sua superfície eritrocitária nem antígenos A, e nem B), não há incompatibilidade ABO ou Rh (as hemácias do recém-nato não sofrem hemólise), e, portanto, estas não seriam as causas da icterícia deste paciente. Contudo, o retardo na eliminação do mecônio leva a uma exacerbação da circulação entero-hepática de bilirrubina indireta, podendo levar a um quadro de icterícia.

82100.

Comentário: ERRADO. O enunciado nos apresenta um recém-nascido que apresenta um conjunto de sinais artéria umbilical única, ausência de reflexo vermelho, baixa saturação de oxigênio em membro superior direito e retardo na eliminação de mecônio. Existem muitos sinais que, reunidos, devem nos fazer pensar na possibilidade de uma síndrome genética. A presença de artéria umbilical única é sugestiva de anormalidades do trato geniturinário a saturação baixa em MSD sugere cardiopatia a ausência do reflexo vermelho, leucocoria e, finalmente, o atraso na eliminação de mecônio poderia, no contexto de uma síndrome genética, ser decorrente de ânus imperfurado (hipótese descartada ao exame físico) ou aganglionose colônica. A doença de Hirschsprung pode estar associada a diversas síndromes genéticas, como Down, Smith-Lemli-Opitz (anomalias oculares, neurológicas, geniturinárias e cardiopatias), hipoplasia cartilagem-cabelo, e hipoventilação congênita (curso de Ondine). Sendo assim, o enema contrastado será capaz de identificar o segmento colônico são (dilatado) daquele agangliônico (estreito). Contudo, afirmar categoricamente que retardo na eliminação de mecônio é INDICATIVO de megacólon congênito é incorreto, pois tal

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

sinal pode estar presente também em outras condições, tais como malformações intestinais e fibrose cística. Por isso, a banca optou pela anulação da questão.

82040.

Comentário: Correta. Tendo em vista a presença de um desconforto respiratório, está indicado o uso do CPAP ainda na sala de parto. O CPAP nasal, associado aos avanços nos cuidados respiratórios, na terapia de suporte e nos sistemas de monitorização, surge como uma perspectiva de ventilação não invasiva para minimizar a lesão pulmonar. Indica-se o CPAP principalmente nas seguintes condições RN com peso inferior a 1.500 g, na presença de qualquer sinal de aumento do trabalho respiratório. Nesse caso, instalar o CPAP precocemente. Se possível, desde o nascimento. RN com peso superior a 1.500 g, mantendo SatO2 abaixo de 89% em oxigênio igual ou superior a 40%. Pós-extubação traqueal para todos os RN com peso inferior a 1.500 g. Apneia neonatal. Sendo assim, fica claro que a afirmativa está correta.

82044.

Comentário: Incorreta. Diante da presença de um quadro de desconforto respiratório em um recém-nascido prematuro, devemos sempre pensar no diagnóstico de Síndrome do Desconforto Respiratório (Doença da Membrana Hialina), por uma deficiência de surfactante pulmonar. Além disso, bolsa rota por mais de 18 horas, prematuridade e baixo peso ao nascer são fatores de risco para Sepse Neonatal Precoce então, este diagnóstico deve ser fortemente considerado. A pneumonia (muitas vezes clinicamente indistinguível da sepse) também é um importante diagnóstico, porém o agente principal é o estreptococo do grupo B, e não A. Afirmativa errada, portanto.

82058.

Comentário: Correta. Dada a presença de desconforto respiratório, além da prematuridade e baixo peso, é evidente que o RN não será capaz de receber dieta por via oral. Entretanto, é fundamental que alimentação seja iniciada o mais precocemente possível (tão logo seja confirmada estabilidade hemodinâmica e descartada a presença de enterocolite necrosante), uma vez que sua omissão deixa o RN sob risco de todas as complicações associadas à inanição luminal, como

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

adelgaçamento da mucosa, achatamento das vilosidades e translocação bacteriana. Deve ser iniciada a alimentação trófica, com volumes muito pequenos (10-20 ml kg dia) com a finalidade de induzir maturação intestinal em vez de fornecer nutrientes. Preferencialmente, deve ser utilizado o colostro da própria mãe. Resposta Letra A.

82087.

Comentário: ERRADA. O enunciado nos traz um neonato prematuro de 32 semanas, cuja causa do trabalho de parto foi ignorada e o tempo de bolsa rota foi maior que 18 horas, ou seja, dois fatores de risco para INFECÇÃO NEONATAL PRECOCE. Ele deselvolve uma síndrome de angústia respiratória logo após o nascimento, que podem ser decorrentes tanto da DOENÇA DA MEMBRANA HIALINA como de uma PNEUMONIA INFECCIOSA, condições com clínica e radiografias idênticas. Haja vista a gravidade do caso, e a impossibilidade imediata de fazer a distinção entre estes dois diagnósticos etiológicos, é fundamental iniciar a coleta de exames de sangue e líquor, e logo em seguida, o tratamento para ambas (surfactante e antibióticos). SOMENTE, após os resultados de hemograma, PCR, hemoculturas e cultura de líquor, pode-se optar pela suspensão dos antibióticos caso, afasta-se a possibilidade de sepse.

64322.

Comentário: O exame clínico desta gestante sugere a presença de sífilis, e a questão nos pede duas complicações para o feto decorrentes desta hipótese. Que alterações podemos ter no feto e no recém-nascido com sífilis congênita Além da prematuridade e do baixo peso ao nascimento, as principais alterações são aquelas da chamada sífilis congênita precoce hepatomegalia com ou sem esplenomegalia, lesões mucocutâneas como, por exemplo, placas mucosas e pênfigo palmo-plantar periostite ou osteíte ou osteocondrite (com alterações características ao estudo radiológico), pseudoparalisia dos membros, sofrimento respiratório com ou sem pneumonia, rinite serossanguinolenta, icterícia, anemia e linfadenopatia generalizada (principalmente epitroclear).

334885.

Comentário: Nos disrafismos espinhais ocultos há frequentemente a presença de um estigma cutâneo, que sugere falha no fechamento do sistema nervoso central. A mancha mongólica é

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

caracterizada por um acúmulo irregular de melanócitos, geralmente em região sacral, que decorre de um defeito de migração destas células. A maioria tem resolução espontânea com o tempo. O sinus dérmico é uma pequena protuberância que representa um pertuito epitelial da pele até tecidos mais profundos, resultante da provável separação incompleta do ectoderma ao neuroectoderma subjacente. É um dos sinais que demandam investigação para disrafismo. O nevo auricular é uma pequena lesão cutânea em orelha, não tendo relação com o sistema nervoso central. Os pelos finos em região anal não estão ligados ao disrafismo, ao contrário da presença de pelos em região sacral. O ânus imperfurado é uma malformação do trato gastrointestinal. Resposta letra B.

334888.

Comentário: Acerca da icterícia neonatal, vamos avaliar as alternativas. Letra A incorreta. A icterícia do leite materno é uma condição caracterizada por aumento da bilirrubina indireta após a primeira semana de vida. Os bebês apresentam-se saudáveis, com bom ganho ponderal, sem qualquer alteração da função hepática. Não há tratamento específico porque é o quadro tende a ter resolução espontânea. A interrupção do aleitamento materno só é indicada se os níveis de bilirrubina estiverem muito altos. Letra B incorreta. O tratamento da hiperbilirrubinemia irá variar conforme os valores de bilirrubina no sangue e a idade do bebê. Letra C incorreta. A deficiência da conjugação da bilirrubina observada nos prematuros leva a um aumento de bilirrubina indireta. Letra D correta. A causa mais comum de icterícia patológica (aquela que se inicia precocemente) é a incompatibilidade ABO. Letra E incorreta. A zona de Kramer que representa níveis mais altos de bilirrubina é a zona 5, em que há acometimento de todo o corpo, inclusive de mãos e pés. Resposta letra D.

334889.

Comentário: O Método Canguru é um modelo de assistência ao recém-nascido prematuro e ou baixo peso e sua família, internado na Unidade de Tratamento Intensivo Neonatal, voltado para o cuidado humanizado, que reúne estratégias de intervenção biopsicossocial. Tem como vantagens reduzir o tempo de separação mãe pai-filho facilitar o vínculo afetivo mãe pai-filho possibilitar maior

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

competência e confiança dos pais no cuidado do seu filho, inclusive após a alta hospitalar estimular o aleitamento materno, permitindo maior frequência, precocidade e duração possibilitar ao recém-nascido adequado controle térmico contribuir para a redução do risco de infecção hospitalar reduzir o estresse e a dor propiciar melhor relacionamento da família com a equipe de Saúde favorecer ao recém-nascido uma estimulação sensorial protetora em relação ao seu desenvolvimento integral melhorar a qualidade do desenvolvimento neuropsicomotor. Resposta letra B.

343411.

Comentário: O enunciado descreve um quadro clássico de síndrome da rubéola congênita - doença que se caracteriza principalmente por alterações cardíacas, oculares e surdez. A criança infectada intraútero com o vírus da rubéola pode apresentar manifestações transitórias no período neonatal, incluindo hepatoesplenomegalia, hepatite, icterícia, plaquetopenia com petéquias e púrpura, anemia hemolítica e meningoencefalite, dentre outras mais da metade das crianças tem evidências de crescimento intrauterino restrito. Dentre as manifestações permanentes, destacam-se a surdez neurossensorial, manifestação mais comum no seguimento longitudinal os defeitos cardíacos estão presentes em mais de 50% dos infectados nas primeiras semanas de gestação, sendo a alteração mais comum a persistência do canal arterial, com ou sem estenose de ramo da artéria pulmonar e as lesões oculares, como catarata, glaucoma, retinopatia (aspecto clássico de sal e pimenta) e microftalmia. Podem ocorrer também alterações de sistema nervoso central, como microcefalia, atraso do desenvolvimento e distúrbios comportamentais e manifestações tardias, como as endocrinopatias, incluindo diabetes mellitus tipo 1 e disfunção tireoideana. Vamos relembrar as principais características das outras infecções congênitas citadas As principais manifestações da sífilis congênita precoce, que ocorre nos primeiros dois anos de vida, são as lesões cutâneas, como exantema e pênfigo palmoplantar rinite serossanguinolenta anemia hemolítica com Coombs direto negativo acometimento ósseo (periostite e osteocondrite) e de sistema nervoso central (neurossífilis) lesões condilomatosas e lesões oculares. A infecção congênita por herpes simples é rara e grave, sendo mais comum a transmissão perinatal a infecção intrauterina se manifesta

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

classicamente com vesículas cutâneas ou escaras de cicatrização, alterações oculares e microcefalia ou hidrocefalia. A maioria dos RN com citomegalovirose congênita é assintomática ao nascimento 10% apresentam manifestações clínicas, dentre as quais se destacam microcefalia, calcificações intracranianas tipicamente periventriculares e coriorretinite. Resposta letra C.

334891.

Comentário: Sobre as apneias no recém-nascido, vamos avaliar as alternativas. Letra A correta. São fatores de risco para a apneia no prematuro administração de sulfato de magnésio ou opióides na mãe, sepse neonatal, parto traumático e ou asfixia perinatal. Letra B incorreta. A apneia da prematuridade tem início, geralmente, no segundo ou terceiro dias de vida. Fica mais evidente com duas a três semanas de vida. Letra C incorreta. Pausas respiratórias periódicas são pausas de 5 a 10 segundos de duração que podem vir acompanhadas de quedas discretas da saturação e ou frequência cardíaca, que retornem espontaneamente, sem intervenção médica. Letra D incorreta. O uso do CPAP melhora a capacidade residual funcional, reduz risco de colapso das vias aéreas superiores, reduzindo o risco de apneia de origem mista ou obstrutiva. Letra E incorreta. As principais medicações para o tratamento são a cafeína, a aminofilina e a teofilina. A cafeína é preferida por sua maior meia-vida, maior segurança e menor risco de efeitos adversos. Resposta letra A.

343421.

Comentário: Estamos diante de um recém-nascido (RN), nascido de parto cesárea, com 40 semanas de idade gestacional. Perceba que o desconforto respiratório foi iniciado logo após o nascimento , com necessite de oxigênio inalatório. Em pouco tempos já houve melhora do quadro, não havendo mais necessidade de oxigenoterapia. Essa quadro clínico é característico da Taquipneia Transitória do Recém-Nascido (TTRN), também chamada de síndrome do pulmão úmido, consiste em um quadro caracterizado por um desconforto respiratório leve ou moderado, autolimitado, com evolução benigna, e que é decorrente de um distúrbio na reabsorção do líquido pulmonar. A doença se manifesta logo após o nascimento e a taquipneia é o principal achado clínico. A frequência respiratória pode ser bastante elevada e pode haver a presença de outras

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

manifestações de desconforto, tais como a gemência e as retrações. A evolução é característica e o quadro resolve-se em 24-72 horas (em alguns locais é descrito que pode ser prolongar por até cinco dias, mas não é isso que habitualmente encontramos nos enunciados). A radiografia até pode ser normal, mas costuma apresentar hiperinsuflação pulmonar aumento da trama vascular pulmonar com a presença de hilo congesto, de onde irradiam-se condensações (estrias) lineares cissuras espessadas (cissurite derrame cissural) eventualmente, discreta cardiomegalia e ou derrame pleural. O tratamento consiste essencialmente em suporte. Os cuidados gerais incluem o controle térmico, a monitorização da saturação de oxigênio, jejum (quando a frequência respiratória diminuir, pode-se oferecer o leite materno ordenhado através de sonda orogástrica), hidratação e controle da glicemia. Resposta letra D.

301284.

Comentário: A mãe que apresentou uma soroconversão com baixa avidez após as 16 semanas de gestação, tendo assim diagnóstico confirmado de toxoplasmose, além da clínica sugestiva da doença (adenomegalia). A transmissão da doença para o bebê pode ocorrer em qualquer fase da gestação. A confirmação do caso de toxoplasmose congênita pré-parto é possível se for detectado DNA do T. gondii em amostras de líquido amniótico da mãe, sendo indicado o início do tratamento para reduzir as manifestações clínicas da doença no bebê. Resposta letra A.

301285.

Comentário: Segundo Ministério da Saúde, é considerado como caso confirmado de toxoplasmose congênita aquele em que há presença de DNA de Toxoplasma gondii em amostras de líquido amniótico da mãe ou em tecido fetais, líquor, sangue ou urina da criança resultados de anticorpos IgM ou IgA e IgG anti-T. gondii reagente até seis meses de vida níveis séricos de anticorpos IgG anti-T. gondii em ascensão em pelo menos duas amostras seriadas com intervalo mínimo de três semanas durante os primeiros 12 meses de vida IgG anti-T. gondii persistentemente reagente após 12 meses de idade retinocoroidite ou hidrocefalia ou calcificação cerebral (ou associações entre os sinais) com IgG reagente, afastadas outras infecções congênitas e mãe com toxoplasmose confirmada na gestação. Resposta letra A.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

301286.

Comentário: São considerados casos confirmados de toxoplasmose congênita aqueles que apresentam pelo menos uma das seguintes situações presença de DNA de Toxoplasma gondii no líquido amniótico, tecidos fetais, líquor, sangue ou urina da criança resultados positivos de IgM ou IgA e IgG anti toxoplasma até seis meses de vida níveis séricos de anticorpos IgG em ascensão em pelo menos duas amostras seriadas com intervalo mínimo de três semanas durante os primeiros 12 meses de vida IgG persistentemente reagente após 12 meses de idade retinocoroidite ou hidrocefalia ou calcificação cerebral com IgG reagente e afastadas outras infecções congênitas e mãe com toxoplasmose confirmada na gestação. Assim, podemos ter apenas alterações nos exames, sendo a presença de alterações clínicas dispensável. Resposta errado.

301287.

Comentário: A avaliação sorológica do RN é dificultada pela presença de anticorpos maternos da classe IgG. Nas crianças não infectadas, o título dos anticorpos IgG diminui progressivamente até que ocorra negativação em torno de um ano de vida. Já a presença de IgM antitoxoplasma em amostra do RN pode estabelecer o diagnóstico de infecção congênita, mas sensibilidade do teste é baixa, especialmente se a mãe tiver sido tratada durante a gestação com sulfadiazina e pirimetamina. Se a infecção tiver ocorrido no início da gestação, a sensibilidade do teste também estará reduzida. Portanto, os exames podem vir a ser positivos em uma criança não infectada e irem se normalizando ao longo dos primeiros meses de vida, bem como uma criança infectada pode ter falso-negativo de IgM por baixa sensibilidade do teste. Assim, não devemos nos basear apenas nas sorologias para definir presença de infecção e início de tratamento. Resposta errada.

301288.

Comentário: Independente do enorme caso clínico, basicamente a questão recordou a tríade clássica da toxoplasmose congênita, que são hidrocefalia, calcificações cerebrais e coriorretinite. Logo, o item está correto.

301289.

Comentário: Independente do enorme caso clínico, basicamente a questão quer saber qual o

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

tratamento para toxoplasmose congênita. O tratamento do recém-nascido é feito com sulfadiazina e pirimetamina durante todo o primeiro ano de vida, na tentativa de impedir que as formas trofozoíticas ainda circulantes se encistem. A espiramicina pode reduzir a transmissão da mãe para o feto em até 60%, mas quando a infecção fetal estiver comprovada, é indicado o uso de sulfadiazina e pirimetamina, que reduzem a transmissão para o feto e a possibilidade de comprometimento grave do recém-nascido. Resposta item errado.

301290.

Comentário: Independente do enorme caso clínico, basicamente a questão quer saber qual os exames mandatórios diante de um recém-nato com quadro de suspeito de sepse tardia. Devem ser, no mínimo, ser avaliados com um hemograma (com diferencial da série branca), hemocultura, urocultura e de outros locais, como lesão de pele, osso, derrames. Se a sintomatologia for clara (ex desconforto respiratório e taquipneia), a punção lombar pode ser postergada. Mas nos casos em tela, em que se tem a suspeita clínica e sem fatores localizatórios, devemos obrigatoriamente realização a radiografia de tórax e a punção lombar, além de iniciar a antibioticoterapia empírica. Resposta item certo.

301291.

Comentário: A sepse neonatal deve ser encarada como um quadro clínico de gravidade, visto que trata-se de um indivídio com baixa maturidade imunológica. Logo, devemos introduzir o tratamento empírico, com posterior mudança a depender do resultado da cultura. Se os resultados da cultura são negativos, mas o neonato tem sinais clínicos de sepse, o médico deve decidir se o tratamento deve ser continuado. As principais bactérias que causam sepse tardia neonatal são Staphylococcus epidermidis plasmocoagulase negativo, Staphylococcus aureus , Pseudomonas. Contudo, deve-se lembrar que sepses tardias podem também ser decorrentes de EGB, E . coli ou mesmo outras bactérias. Resposta item errado.

273312.

Comentário: Diante de um caso de provável infecção congênita, devemos buscar as características que são mais específicas e que nos ajudarão a chegar ao diagnóstico mais provável. Neste caso, a

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

presença de calcificações intracranianas periventriculares é a pista principal para o diagnóstico, já que tipicamente é encontrada nos casos de infecção por CMV. As demais alterações descritas (microcefalia, hepatoesplenomegalia) também são manifestações compatíveis com a infecção por esse agente. Na toxoplasmose congênita, também ocorrem calcificações intracranianas, mas estas são difusas. Na sífilis congênita, as alterações mais comuns são pênfigo palmoplantar, rinite serosanguinolenta, osteocondrite e alterações liquóricas. Na síndrome da rubéola congênita, as alterações mais encontradas são cardiopatias congênitas (PCA e estenose pulmonar), catarata, perda auditiva e retardo do crescimento intrauterino. Resposta letra C.

268902.

Comentário: Vamos analisar cada alternativa A) CORRETA. As 3 perguntas feitas no momento do nascimento são o RN é a termo está respirando ou chorando tem bom tônus A resposta SIM para todas elas indica o clampeamento tardio do cordão e a ausência de necessidade de levar o RN para o berço de reanimação, colocando-o em contato pele a pele com a mãe logo após o nascimento. Se o único NÃO for para a primeira pergunta, ainda assim podemos indicar o clampeamento tardio do cordão - a diferença está no tempo no RN nascido a partir de 34 semanas, aguardamos de 60 a 180 segundos para clampear o cordão, enquanto nos nascidos com 34 semanas aguardamos de 30 a 60 segundos. Os prematuros devem ser levados, após o clampeamento, para a mesa de reanimação, para realização dos passos iniciais (aquecer, posicionar, aspirar se necessário e secar), mesmo que tenham boa vitalidade. b) INCORRETA. Ambos podem (e devem) ser colocados em contato pele a pele com a mãe logo após o nascimento, desde que tenham boa vitalidade. No RN de 35 semanas, aguardaremos de 30 a 60 segundos para clampear o cordão - neste período, ele pode ficar em contato com a mãe. c) INCORRETA. O oxigênio em excesso é prejudicial ao RN A recomendação é de iniciar a ventilação com FiO2 de 21% para os RNs nascidos a partir de 34 semanas e 30% para os que nasceram antes dessa idade gestacional. d) INCORRETA. Nascimento 37 semanas prematuro, independente do peso de nascimento. O que muda é a classificação quanto ao peso de nascimento aqueles que nascem com peso entre 2499 e 1500g são considerados de baixo peso entre 1000 e 1499 g, muito baixo

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

peso e 1000g, extremo baixo peso. e) INCORRETA. A temperatura corporal do RN deve ser mantida entre 36,5 e 37 graus - a hipotermia comprovadamente aumenta o risco de morbidade e mortalidade perinatal. Resposta letra A.

274614.

Comentário: Questão conceitual. Consideramos período neonatal o período que vai desde o nascimento até 28 dias de vida (ou 27 dias, 23 horas e 59 minutos). Podemos subdividir esse período em precoce e tardio, sendo considerado precoce o período desde o nascimento até 6 dias, 23 horas e 59 minutos e tardio, o intervalo do sétimos dia até 27 dias, 23 horas e 59 minutos. Essa subclassificação tem importância principalmente para dados epidemiológicos relacionados a mortalidade neonatal, já que as causas variam nesses dois períodos. Resposta letra B.

274619.

Comentário: Questão conceitual e bem tranquila. O período neonatal é caracterizado pelo dia do nascimento até os 28 dias de vida. A sepse neonatal é a infecção grave e com repercussões sistêmicas que acontecem neste período. É dividida em sepse neonatal precoce, que acontece até 72 horas de vida (embora alguns autores considerem até 7 dias) e sepse neonatal tardia, que ocorre entre 72 horas e 28 dias de vida. Os principais agentes da sepse neonatal precoce são Streptococos agalactie, E. coli e Listeria monocytogenes, enquanto os da sepse neonatal tardia são os Staphylococos aureus, Staphylococos coagulase negativos e bactérias gram negativas. Resposta letra A.

266449.

Comentário: Recém-nascido, apresentando na tomografia computadorizada de crânio, calcificações periventriculares, iremos pensar em citomegalovirose congênita. Na toxoplasmose congênita iremos ter a presença de calcificações intracranianas difusas. Afirmativa incorreta. Resposta letra B.

266450.

Comentário: Prematuro com idade gestacional de 28 semanas, apresentando desconforto respiratório após o nascimento, provavelmente estamos diante de um quadro de doença da membrana hialina, também chamada de síndrome do desconforto respiratório. O principal fator de

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

risco associado a essa condição é a prematuridade, mas outros fatores também podem favorecer o quadro, como diabetes materno, parto operatório, sexo masculino, asfixia e segundo gemelar. As principais manifestações clínicas são taquipneia, gemência e aumento do trabalho respiratório, indicado pela presença de batimento de asa nasal e retração da musculatura respiratória. O aspecto radiológico é dividido em quatro graus, a depender das alterações encontradas, são eles grau I - leve (granulações finas) grau II - moderada (granulação bem evidente em vidro moído) grau III - grave (broncograma aéreo alcançando a periferia dos campos pulmonares, discreto borramento cardíaco) grau IV - opacidade total dos campos pulmonares, área cardíaca imperceptível. Afirmativa correta. Resposta letra A.

266452.

Comentário: A solicitação da radiografia de ossos longos faz parte da avaliação do RN exposto à sífilis congênita, justamente em busca dos achados descritos, que são bem característicos da doença - até 20% dos RNs podem ter como única manifestação da sífilis a presença dessas alterações radiográficas. Clinicamente, a osteocondrite pode se manifestar como a pseudoparalisia de Parrot, lesão dolorosa que faz com que o RN movimente pouco o membro. O problema aqui é a palavra patognomônico, o que foi motivo de bastante questionamento - apesar de bem típico, estes achados não são exclusivos da sífilis congênita. A banca não alterou o gabarito mesmo após a formulação do recurso. Gabarito liberado pela banca letra A.

291516.

Comentário: A conduta inicial descrita no enunciado foi correta diante de um recém-nascido sem boas condições de vitalidade, deve ser feito o clampeamento imediato do cordão e a criança deve ser conduzida ao berço aquecido para os passos iniciais da reanimação, que devem ser realizados em 30 segundos (cabe indicar que a avaliação não é feita 30 segundos após secarmos a criança, como o enunciado pode ter deixado a entender). Quando, após esta avaliação inicial, o recém-nascido se encontra em apneia, com respiração irregular e ou frequência cardíaca menor que 100 bpm, devemos iniciar a ventilação com pressão positiva com balão e máscara facial. Não se deixe enganar pelo relato de líquido amniótico meconial a sequência de atendimento deve ser a

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

mesma. Casos após 30 segundos de ventilação não ocorra a melhora e sejam identificados sinais de obstrução, pode ser indicada a aspiração traqueal. Essa aspiração é feita uma única vez caso a criança persista bradicárdica ou com apneia respiração irregular, a ventilação deve ser retomada com a máscara facial e seguimos o fluxograma habitual. Logo, neste momento, vamos iniciar apenas a ventilação com pressão positiva. Resposta letra A.

263397.

Comentário: Esta questão aborda os cuidados com o recém-nascido banhado em mecônio, algo que passou por mudança significativas em 2016. Os conceitos mais importantes são os seguintes se logo após o nascimento, o recém-nascido for a termo, estiver respirando ou chorando e com tônus muscular em flexão, ele apresenta boa vitalidade e deve continuar junto de sua mãe depois do clampeamento do cordão. Porém, se o paciente com líquido amniótico meconial não iniciou movimentos respiratórios regulares ou o tônus muscular está flácido, como no caso, é necessário levá-lo à mesa de reanimação e realizar os passos iniciais, sendo prudente incluir a aspiração de vias aéreas superiores, que deve ser feita com sonda traqueal número 10. A banca indicou que tais passos já foram feitos. Caso após os passos iniciais seja identificada bradicardia ou respiração irregular apneia, a ventilação com pressão positiva deve ser iniciada, com balão e máscara facial. Casos após 30 segundos de ventilação não ocorra a melhora e sejam identificados sinais de obstrução, pode ser indicada a aspiração traqueal. Resposta letra D.

291526.

Comentário: Todas as condições citadas estão incluídas no teste do pezinho, mas a que pode ter resultados falso-negativos é o rastreamento da hiperplasia adrenal congênita. O uso de glicocorticoide antenatal pela mãe, devido a sua passagem transplacentária, pode suprimir a produção de 17 OH progesterona no neonato, ocasionando resultados falso negativos. Em geral, isso não ocorre com a prednisona, que não tem grande passagem placentária. Ocorre, especialmente, quando a corticoterapia antenatal é indicada para a indução da maturação pulmonar na possibilidade de parto prematuro, com betametasona ou dexametasona. Esta é uma das razões pelas quais a coleta do teste do pezinho em prematuros com menos de 34 semanas

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

costuma ser diferenciada, sendo necessária nova coleta com 28 dias ou na alta hospitalar. Resposta letra C.

263424.

Comentário: O teste da oximetria, ou teste do coraçãozinho, faz parte da triagem neonatal e é indicado para todos os recém-nascidos a partir de 34 semanas. Como bem lembrado no enunciado, o teste tem o objetivo de identificar cardiopatias congênitas críticas, que são aquelas que evoluem com grave deterioração clínica no momento do fechamento do canal arterial. O exame é feito entre 24 e 48 horas de vida e consiste na avaliação da oximetria no membro superior direito e em um dos membros inferiores. O teste é considerado normal quando ambas as medidas são maiores ou iguais a 95% e quando a diferença entre elas é menor que 3%. Quando o teste estiver alterado, a primeira conduta é a repetição do mesmo uma hora depois. Quando há confirmação da alteração, um ecocardiograma deve ser realizado em até 24 horas. No caso em tela, temos uma medida abaixo de 95 e diferença é maior que 3%. Neste caso, o primeiro passo é repetir o teste em uma hora. Resposta letra D.

230564.

Comentário: Síndrome da Zika congênita pode apresentar microcefalia grave (geralmente -3 desvios padrões), couro cabeludo redundante, osso occipital proeminente, atrofia cortical com calcificação principalmente subcortical, cicatrizes retinianas, manchas maculares pigmentares focais, hipertonia muscular precoce e artrogripose (contraturas congênitas) Apesar de alguns estudos mostrarem risco maior de cardiopatia congênita em RNs infectados com Zika (até 10-15%) essa associação ainda não está clara. Ademais, 1% dos casos mostrou cardiopatia com repercussão clínica. Portanto, cardiopatia congênita não está nos achados clássicos da síndrome da Zika congênita. Resposta correta letra D

244484.

Comentário: Aqui temos duas informações muito importantes a história de diabetes gestacional, e o peso da criança que, pelo gráfico, é caracterizado como grande para idade gestacional (GIG). Estas duas condições aumentam o risco de hipoglicemia neonatal, sendo fatores de risco para este

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

distúrbio metabólico. Por isso, a monitorização da glicemia deste bebê é fundamental. Resposta Letra B.

230574.

Comentário: A prematuridade é uma síndrome complexa, com múltiplos fatores etiológicos, e está associada a um amplo espectro de condições clínicas. As lesões cerebrais no recém-nascido pré-termo são múltiplas, e a HPIV (hemorragia intra-periventricular) permanece a lesão mais descrita e conhecida, principalmente a da matriz germinativa, podendo evoluir, nos casos mais graves, para sangramento para dentro do sistema ventricular adjacente ou para a substância branca periventricular. O infarto hemorrágico periventricular pode estar associado às convulsões secundárias à HPIV. A encefalopatia hipóxico-isquêmica está associada à asfixia perinatal. Resposta Letra D.

227415.

Comentário: ERRADO. O teste do coraçãozinho é um teste de triagem para o diagnóstico precoce de cardiopatias congênitas críticas (ducto dependente). A aferição deve ser feita no membro superior direito e em um dos membros inferiores. O teste deve ser realizado entre 24 e 48 horas de vida. O resultado é considerado normal se saturação periférica maior ou igual a 95% em ambas as medidas (membro superior direito e membro inferior) e diferença menor que 3% entre as medidas do membro superior direito e membro inferior. Na questão o teste está alterado, porém antes de solicitar ecocardiograma, o RN deve ser aquecido e o exame repetido após 1 h. Só então, se continuar alterado, solicitamos um ecocardiograma.

227416.

Comentário: CERTO. O teste do olhinho (reflexo vermelho) é o exame de rastreamento (screening) para anormalidades oculares, desde a córnea até o segmento posterior. Nesse exame, pode ser detectado as opacidades dos meios transparentes do globo ocular.. O exme é realizado em todo RN antes da saída da maternidade. Em um ambiente escuro, jogamos a luz do oftalmoscópio nos olhos do RN a uma distancia de 40 a 45 cm. A luz percorre o eixo visual, bate na retina e retorna como uma bola vermelha - reflexo vermelho. Se houver qualquer coisa obstruindo ou opacificando

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

o eixo visual o reflexo vemelho não será formado.

227417.

Comentário: CERTO. A triagem auditiva universal por meio das emissões otoacústicas transientes (EOAT) e pesquisa do reflexo cócleo palpebral (RCP). Os RN com triagem auditiva normal e sem fatores de riscos para perda auditiva realizam esse teste 1 vez, porém aqueles com presença de quaisquer fatores de risco ou com alteração nesse exame de triagem devem seguir investigação realizando teste de potencial evocado auditivo do tronco encefálico (PEATE) e acompanhados por uma equipe multidisciplinar e realizar avaliações periódicas durante os dois primeiros anos de vida

206175.

Comentário: Na primeira hora após o parto, o estado de consciência da mãe e do bebê favorece a interação entre eles. Nesse período, o profissional de saúde deve favorecer ao máximo o contato íntimo pele a pele entre mãe e bebê, evitando procedimentos desnecessários ou que possam ser realizados mais tarde. A separação da mãe e do bebê e a sedação da mãe privam o binômio desse momento tão especial. Após a finalização dos procedimentos de sala de parto, a mãe e o bebê devem ir para um local dentro da maternidade que permita à eles ficarem juntos 24 horas por dia até a alta hospitalar. Para isso, foi implantado o sistema de alojamento conjunto nas maternidades. O Ministério da Saúde destaca inúmeras vantagens que o alojamento conjunto oferece para a mãe e a criança, tais como 1) Humanização do atendimento do binômio mãe-filho e sua família. 2) Convivência contínua entre mãe e bebê, o que facilita o conhecimento mútuo e a satisfação imediata das necessidades físicas e emocionais do RN. Bebês em alojamento conjunto choram menos e dormem mais (permanecem no estado sono quieto) do que quando se encontram em berçários. 3) Maior envolvimento dos pais e ou de outras pessoas significativas no futuro cuidado com a criança. 4) Promoção do estabelecimento precoce do vínculo afetivo entre a mãe e o seu filho. Há relatos de que o alojamento conjunto aumenta a ligação afetiva da mãe a sua criança e reduz os casos de abuso ou de negligência infantil e de abandono da criança. 5) Promoção do aleitamento materno. Vários estudos demonstram o efeito benéfico do alojamento conjunto na prática da amamentação descida do leite mais rápida, melhor atitude em relação ao aleitamento

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

materno e tempo mais prolongado de amamentação. 6) Oportunidade para as mães, em especial as primigestas, aprenderem noções básicas dos cuidados com os RN. Isso aumenta sua autoconfiança. 7) Tranquilidade para as mães que ficam inseguras quanto ao atendimento prestado a seus filhos quando não estão perto deles. A ansiedade pode inibir a produção de ocitocina, importante para a liberação do leite materno e para a contração do útero, enquanto a presença da criança e seu choro costumam estimular o reflexo de ejeção do leite. 8) Troca de experiências com outras mães quando compartilham o mesmo quarto, em especial com mães mais experientes que também estão cuidando dos seus filhos. 9) Maior interação entre a mãe e sua família e os profissionais de saúde responsáveis pela atenção à criança. 10) Diminuição do risco de infecção hospitalar. Há vários relatos de redução das taxas de infecção neonatal após a implantação do alojamento conjunto em maternidades. Com base nisso, podemos afirmar que as opções A e C são corretas. A opção D também está correta, visto que uma vez estando em alojamento conjunto, as crianças que demandam certos cuidado estarão mais bem assistidas. Resposta letra B.

206159.

Comentário: Vamos começar de baixo para cima D) CORRETA a ruptura prematura de membranas é p fator de risco mais associado a sepse neonatal, como também é o mais cobrado em provas. Para ser fator de risco, o tempo deve ser superior a 18 horas. C) CORRETA Acredito que esse não deixa dúvidas...toda mãe colonizada com streptotococo do grupo B e não tratada no intraparto, é considerada o fator de risco. Percebam que a mãe apresentou urocultura positiva pro agente e, apesar do tratamento, vale lembrar que a pesquisa deveria ser repetida com 35 semanas de gestação, porém a criança nasceu antes. Logo, esta alternativa também está correta. B) CORRETA Prematuridade, principalmente muito baixo peso e extremo baixo peso, é considerado um fator de risco para sespse neonatal. A) ERRADA Por fim, o gabarito da questão. Outros fatores maternos podem estar relacionados, mas mães multíparas não representam fator de risco para sepse neonatal. Resposta letra A.

206088.

Comentário: Hipoglicemia é a ocorrência de oferta inadequada de glicose a partir de níveis séricos

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

abaixo dos valores normais para idade. Não há consenso acerca desses valores, mas sabe-se que recém-nascidos a termo com menos de 24h de vida podem apresentar glicemia 30 a 35 mg dL na primeira medição, elevando-se para 45 mg dL após o início da alimentação. Devemos tratar a hipoglicemia em crianças sintomáticas com bolus de glicose a 10% 2ml kg IV, ou da mesma maneira, crianças assintomáticas mas com glicemia abaixo de 25 mg dL. Na hipoglicemia assintomática, devemos oferecer alimentação (seio materno ou complemento) e aferir a glicemia novamente após 30 minutos. Apesar de o limite máximo dos níveis de glicose sanguínea em RN saudáveis não ser claramente definido, costuma-se considerar o limiar para diagnóstico de hiperglicemia nos neonatos como 126 mg dL no sangue. A concentração de glicose sanguínea 180 mg dL, ou presença de glicosúria com diurese osmótica, é geralmente considerada indicação para intervenção terapêutica. Tanto a hipoglicemia quanto a hiperglicemia conferem risco de dano ao SNC e, por isso, devem ser sempre prevenidos e tratados. Resposta letra B.

206126.

Comentário: Questão que se baseou no PROTOCOLO CLÍNICO E DIRETRIZES TERAPÊUTICAS PARA PREVENÇÃO DA TRANSMISSÃO VERTICAL DE HIV, SÍFILIS E HEPATITES VIRAIS. Assim, percebe-se que todas as opções estão certas e foram integralmente extraídas do documento, com exceção da letra B. Vamos, então, ao correto Para casais que desejam a concepção, recomenda-se - Aguardar até 6 meses após sinais sintomas relacionados à infecção pelo vírus Zika quando o homem foi infectado - Aguardar até 8 semanas após sinais sintomas relacionados à infecção pelo vírus Zika quando a mulher foi infectada. Resposta letra B.

177244.

Comentário: Diante de qualquer alteração durante o teste do reflexo vermelho (ausência do reflexo vermelho em 1 ou ambos os olhos) é mandatório o encaminhamento ao oftalmologista. Lembre-se que o teste do olhinho é um teste de triagem neonatal que tem objetivo de rastrear possíveis doenças do segmento posterior do olho (catarata congênita, retinoblastoma), presentes no recém-nascido após o nascimento. Esse teste deve ser realizado pelo pediatra antes da alta na maternidade. Resposta correta letra B.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

177253.

Comentário: Questão direta sobre definições em neonatologia. O recém-nascido é chamado prematuro ou pré-termo quando possui idade gestacional abaixo de 37 semanas completas, sendo considerado pré-termo tardio quando nasce entre 34 e 36 semanas e 6 dias (como no caso) pré-termo moderado ou muito prematuro que nasce entre 30 e 33 semanas e 6 dias e, 30 semanas um pré-termo extremo. Agora utilizando a curva de Fenton para classificarmos o recém-nascido de acordo com o peso ao nascer, vimos que estamos diante de um recém-nascido pequeno para idade gestacional (abaixo do percentil 10). A classificação em simétrico e assimétrico será comparativa de acordo com a estatura e o perímetro cefálico. Classificamos como assimétrico quando o agravo nutricional do recém-nascido (baixo peso) ocorre no fim da gestação, que o perímetro cefálico e a estatura serão respeitadas, ou seja, estariam adequados ao recém-nascido, na faixa da normalidade. No entanto, observamos que a criança da questão nasceu toda pequena, com todos os dados antropométricos em baixos percentis (abaixo do p10), o que implica que o deficit nutricional foi precoce, antes do pico de crescimento em comprimento e da cabeça, sendo assim classificado como simétrico , ou seja, o recém-nascido é proporcionalmente pequeno em toda a sua antropometria. Gabarito letra A.

177263.

Comentário: Temos aqui um RN que com duas horas de vida apresentou dificuldade respiratória, taquipneia e febre, com uma história materna que representa um importante fator de risco para sepse uma infecção do trato urinário não tratada. Diante de uma sepse provável, deve-se seguir com realização de exames para isolamento do microrganismo (hemocultura, exame do líquor, urinocultura, cultura do aspirado traqueal) e exames inespecíficos (testes hematológicos e imunológicos). Dado o potencial risco de gravidade para o recém-nascido, logo após a coleta do material para culturas, a antibioticoterapia deve ser iniciada empiricamente. Assim, a melhor resposta para a questão (apesar de super incompleta) é a encontrada na opção E.

183870.

Comentário: Questão conceitual cuja informação encontra-se incorreta. Os valores de corte de

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

perímetro cefálico considerados como microcefalia foram alterados pelo Ministério da Saúde em 2017 para 30,24 cm para meninas e 30,54 cm para meninos. A questão leva em consideração os valores adotados pela OMS, que estão desatualizados. E ainda assim, o autor não informa a idade gestacional para a qual ele utiliza os valores de perímetro cefálico citados. Portanto, é uma questão que coube recurso.

158009.

Comentário: Toda questão que apresentar a associação de microcefalia com calcificações intracranianas periventriculares, sempre lembrar do diagnóstico de infecção congênita por Citomegalovírus. A Toxoplasmose também causa calficicações, porém estas são difusas e grosseiras. A varicela zóster também causa microcefalia e calcificações, mas é não comum em topografia periventricular. O herpesvírus de manifesta com microcefalia associada a hidrocefalia e o HIV normalmente não apresenta alterações em exame de imagem. Resposta letra E.

158022.

Comentário: O diagnóstico é uma lesão muito comum nos recém-nascidos a termo, o eritema tóxico neonatal. Apesar do nome, não apresenta qualquer relação com toxicidade. Trata-se de lesões eritematosas, maculopapulares ou pustulosas que geralmente tem início ainda na primeira semana de vida e acomete face, tronco, nádegas e membros proximais, poupando palmas e solas. São lesões autolimitadas e que não requer nenhum tratamento específico, somente orientação aos genitores com relação a benignidade da patologia. Um dos seus diagnósticos diferenciais é a melanose pustulosa neonatal, que são lesões já presentes ao nascimento e que podem acometer todo o corpo, inclusive a região palmoplantar. Consistem em pústulas que evoluem com pequenas máculas hipercrômicas com um halo esbranquiçado ao redor, que podem persistir por cerca de três meses e também não necessita de tratamento, somente orientações. A miliária rubra, outro diagnóstico diferencial, é conhecida popularmente por brotoeja , que são lesões vesicopapulares por obstrução ductal das glândulas sudoríparas écrinas, em decorrência da sudorese excessiva, geralmente por excesso de roupas. As pérolas de Epsteins são lesões em cavidade oral do milium sebáceo e a crosta láctea é uma forma da dermatite seborréica nos bebês. Resposta letra D.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

158035.

Comentário: O tratamento do recém-nascido com toxoplasmose congênita deve ser realizado por 12 meses com Pirimetamina e Sulfadiazina. O uso prolongado da Pirimetamina está relacionado a toxicidade que cursa com anemia e neutropenia. Desta forma, este medicamento deve ser sempre utilizado em associação ao Ácido folínico na dose de 10 mg administrados 3 vezes por semana. Resposta letra C.

154467.

Comentário: De acordo com as novas diretrizes brasileiras de Reanimação Neonatal, em caso de recém-nascido (RN) a termo que apresente boas condições de vitalidade ao nascer, ou seja, que constate respiração ou choro e presença de tônus, deve ser mantido no colo da mãe, estimular a amamentação na primeira hora e realizar todos os cuidados nessas condições. No entanto, trata-se de um RN pós-termo e, diante deste fato, mesmo em boas condições de vitalidade, o paciente deve ser levado à sala de reanimação e ser submetido aos 4 passos iniciais Aquecer (proporcionar calor em berço aquecido), Posicionar (leve extensão cervical ou uso do coxim, se necessário), Aspirar se necessário (bocas e narinas, nessa ordem) e por fim, Secar e desprezar campos úmidos. Percebam que as letras em maiúsculo foram a setença A PAS , mnemônico para se levar pra prova que é justamente o que desejamos para a vida dos RNs (sim, a paz é com s). Resposta letra C.

168529.

Comentário: Esta questão baseou-se no protocolo do Ministério da Saúde que traz as Diretrizes de Atenção da Triagem Auditiva Neonatal. O caso traz uma criança sem fatores de risco aparentes para uma deficiência auditiva. A recomendação inicial é a realização da triagem pelo teste de emissões otoacústicas, o popular teste de orelhinha . Quando não há resposta satisfatória, o teste deve ser repetido (não mais do que duas vezes) e, na persistência da falha, realiza-se o teste de potencial evocado de tronco encefálico. Quando há falha no teste, o mesmo é repetido. Se a criança passa neste segundo teste e não tem fatores de risco, basta o acompanhamento na atenção básica. Se há falha, indica-se o diagnóstico otorrinolaringológico ou audiológico se a criança passa e tem fatores de risco, é indicado o monitoramento em serviços diversos de saúde

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

auditiva. Como, agora, a criança passou, basta o acompanhamento na atenção básica com a avaliação do desenvolvimento. Na época da prova, foi questionado se não poderia ser feito atendimento em conjunto com o especialista, mas não é isso o que encontramos no protocolo citado e os programas tem justamente o objetivo de garantir que não ocorra um excesso de encaminhamento, com sobrecarga da rede especializada. Resposta letra C.

129001.

Comentário: Sobre a fototerapia, temos A) A função da fototerapia é converter a bilirrubina indireta através da fotoisomerização, em um isômero mais hidrossolúvel, facilmente excretado pela bile e pela urina, sem a necessidade de conjugação hepática. Incorreta. B) A eficácia da fototerapia depende da energia de luz emitida, da distância do bebê e a lâmpada, da área de pele exposta e do espectro de luz, não havendo diferença significativa de acordo com a cor da pele da criança. Incorreta. C) As principais complicações associadas à fototerapia são hipertermia, desidratação, diarreia, hiperemia cutânea e síndrome do bebê bronzeado. Correta. D) Nas icterícias associadas ao leite materno, caso os níveis de bilirrubina não sejam muito elevados, é possível manter a amamentação. A tendência é a estabilização dos níveis de bilirrubina e queda gradual. Incorreta. E) A fototerapia é abordagem eficaz tanto nos casos de icterícia patológica ou fisiológica, devendo ser iniciada quando houver indicação. Incorreta. Resposta letra C.

129007.

Comentário: A sepse neonatal precoce é aquela que ocorre nos primeiros 7 dias de vida e está relacionada a infecção por germes da flora genital materna, ocorrida de forma ascendente ou durante o parto vaginal. Os germes mais comumente envolvidos nestes casos são o estreptococo beta hemolítico do grupo B, a Escherichia coli e a Listeria monocytogenes . Desta forma, o esquema empírico preconizado pelo Ministério da Saúde é a associação de ampicilina (200mg Kg dia) e gentamicina (4 mg Kg dia). Resposta letra A.

104780.

Comentário: Vamos analisar cada uma das opções sobre exames laboratoriais na sepse neonatal A - Correta. Apesar de inespecífica, a proteína C-reativa guarda relação de grande sensibilidade com

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

a sepse neonatal, haja vista não haver outras causas inflamatórias comumente implicadas nessa alteração laboratorial. B - Incorreta. É exatamente o oposto quando há elevação de formas jovens, isto é, relação entre neutrófilos imaturos neutrófilos maduros igual ou acima de 0,2, há maior associação com sepse neonatal (alto valor preditivo positivo). C, D e E - Incorretas apesar de uma retenção de escórias poder estar associada à falência renal no contexto da sepse, a avaliação da creatinina (bem como das substâncias citadas em D e E) não guardam relação direta com a infecção bacteriana neonatal. Gabarito letra A.

104772.

Comentário: Recomenda-se que o tratamento da oftalmia gonocócica para o neonato seja feito com Ceftriaxone 25-50mg kg dia, IM, no máximo 125mg em dose única. A mãe e o parceiro devem sempre ser tratados para gonorréia e infecção por clamídia e submetidos a exame genital e exame sorológico para sífilis, anti-HIV, hepatite B e C e aconselhamento. Portanto, segundo a avaliação medgrupo não existe resposta correta ao caso do enunciado. Apesar da elaboração de recurso na época do concurso, a banca manteve como gabarito a letra D.

111280.

Comentário: Pequenas vesículas císticas localizadas na rafe mediana do recém-nascido são as chamadas Pérolas de Ebstein, que são acúmulos de células epiteliais no palato duro, que desaparecem espontaneamente após algumas semanas do nascimento e, portanto, não necessitam de tratamento. Resposta certa Letra E .

97845.

Comentário: O enunciado nos traz um neonato prematuro de 28 semanas e 950g que desenvolve, logo após o nascimento, uma síndrome respiratória caracterizada por gemência, retrações intercostais e subcostais. Ora, a prematuridade é o fator de risco mais importante para o desenvolvimento da doença da membrana hialina (DMH), condição provocada pela insuficiência de surfactante. Além disso, a gestante deu entrada na maternidade apresentado febre e rotura prolongada de membrana amniótica (2 dias), ambos fatores de risco para sepse pneumonia neonatal. Portanto, o neonato apresenta uma síndrome respiratória que pode ser provocada tanto

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

por DMH quanto por pneumonia. Além dos sinais sintomas clínicos quase indistinguíveis, o aspecto da radiografia de tórax na prática não permite a diferenciação de ambas as doenças. Por isso, muitas vezes, inicia-se tratamento para ambas as condições concomitantemente.

97846.

Comentário: Os principais fatores de risco associados à doença da membrana hialina são 1) prematuridade principal fator 2) Asfixia Perinatal 3) Mãe Diabética 4) Sexo Masculino e Raça Branca 5) Hemorragia Materna 6) Parto Cesáreo 7) Gestações Múltiplas. Por sua vez, os fatores de risco para pneumonia neonatal são 1) Corioamnionite clínica febre materna (38ºC), FC materna 100 bpm, leucometria materna 20.000 mm^3, FC fetal 160 bpm, útero doloroso 2) Rotura de membranas amnióticas 18 horas 3) Trabalho de parto prematuro e sem causa aparente 4) Colonização materna pelo Streptococcus agalactie (estreptococo beta-hemolítico do grupo B). As condições acima são classicamente reconhecidas como fatores de risco nos livros-texto de pediatria e neonatalogia. Entretanto, a banca ainda incluiu no gabarito outros fatores de risco que não são reconhecidos por nossa equipe como situações predisponentes nem à pneumonia neonatal e nem à DMH, tais como uso do oxigênio em alta concentração e biotrauma.

97847.

Comentário: A abordagem terapêutica inicial de um neonato prematuro e que nasce com depressão respiratória é a SEQUÊNCIA DE REANIMAÇÃO, que inclui 1) passos iniciais de calor radiante, posicionar cabeça, aspirar vias aéreas, secar 2) Ventilar com máscara orofacial e balão oxigênio. Neonatos com menos de 29 semanas de gestação ou menos de 1.500 g devem ser envolvidos em Saco Plástico de polietileno para evitar a perda de calor hipotermia e deverão colocar touca. O tratamento da síndrome respiratória inclui a intubação orotraqueal e administração de SURFACTANTE INTRATRAQUEAL, e administração de ANTIBIÓTICOS venosos (ampicilina gentamicina) para cobertura de germes causadores de pneumonia. A instituição de suporte ventilatório (ventilação mecânica invasiva ou CPAP nasal) se fará de acordo com a gravidade clínica.

97848.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

Comentário: A avaliação complementar deste neonato deve incluir exames que façam parte da rotina para prematuros, e exames para investigação de pneumonia sepse e doença da membrana hialina. Sendo assim, serão necessários glicemia, eletrólitos (Na, K, Ca, Mg), hemograma completo, proteína C-reativa, culturas (hemocultura, urinocultura), gasometria arterial e radiografia de tórax.

97753.

Comentário: O enunciado nos traz um lactente de 2 meses com dois sinais clínicos que já no início da descrição nos deve remeter ao diagnóstico rinite dor à manipulação de membro (osteocondrite) sífilis congênita. Prosseguindo a leitura do caso, identificamos outros sinais que corroboram nossa hipótese inicial, tais como baixo peso ao nascer, osteíte osteocondrite de úmero esquerdo, hepatomegalia, esplenomegalia, anemia e, hiperbilirrubinemia. Portanto, diante de um caso de sífilis congênita precoce (2 anos) suspeito, é necessário solicitar a internação e prosseguir com a investigação através de exames complementares, que incluem VDRL de sangue periférico, punção liquórica com VDRL e bioquímica celularidade, e radiografia de ossos longos. O tratamento da sífilis congênita é feito com penicilina G cristalina EV por 10 dias. A única possibilidade de resposta é a letra A, mas nossa crítica à opção é a afirmação de pesquisa de treponemas no sangue , a qual não é realizada. A confirmação laboratorial da doença se faz mediante a pesquisa de testes sorológicos treponêmicos (FTAbs) ou não-treponêmicos (VDRL). Gabarito liberado pela banca letra A.

80739.

Comentário: A Caderneta de Saúde da Criança foi implantada pelo Ministério da Saúde para substituir o Cartão da Criança e reúne o registro dos mais importantes eventos relacionados à saúde infantil. Além do cartão de vacina, a Caderneta apresenta o registro da história obstétrica e neonatal indicadores de crescimento e desenvolvimento aspectos importantes da alimentação como aleitamento materno dados sobre a saúde bucal, auditiva e visual intercorrências clínicas além de orientações para a promoção da saúde e prevenção da ocorrência de acidentes e violência doméstica. Em uma sessão da caderneta intitulada DADOS SOBRE GRAVIDEZ, PARTO E PUERPÉRIO, há possibilidade de registrar as sorologias realizadas (ou não realizadas) durante a

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

gestação dos seguintes agravos HIV (CID-10 Z21) sífilis (CID-10 A53), toxoplasmose (CID-10 B58) e hepatite B (CID-10 B18). Em relação ao HIV, as gestantes portadoras deverão iniciar a profilaxia da transmissão vertical a partir da 14ª semana, com terapia antirretroviral tripla. A zidovudina (AZT) intravenosa deverá ser administrada a todas as parturientes no momento do parto e a AZT solução oral para todos os recém-nascidos expostos ao HIV, durante seis semanas. A nevirapina deve ser acrescentada à quimioprofilaxia aos recém-nascidos com 35 semanas ou mais de idade gestacional, cujas mães infectadas pelo HIV não receberam antirretroviral na gestação, mesmo que a mãe tenha recebido AZT injetável no momento do parto. Em relação à sífilis, todas as gestantes devem ser tratadas e os recém-nascidos precisam ser investigados e, se for o caso, tratados com penicilina. A avaliação clínica do caso clinicorradiológico laboratorial define o melhor esquema terapêutico. Em relação à toxoplasmose, devemos tratar a gestante agudamente infectada e todas as crianças com toxoplasmose congênita comprovada mesmo assintomáticas, devem ser tratadas por 12 meses com sulfadiazina, pirimetamina e ácido folínico. Usa-se corticoide na presença de coriorretinite grave ou proteinorraquia 1 g dl. Em relação à hepatite B, em situações em que o recém-nascido é filho de mãe HBsAG positiva, a imunoglobulina humana anti-hepatite B também está indicada nas primeiras doze horas de vida, além da primeira dose da vacina contra hepatite B que todo recém-nascido deve receber. Resposta letra C.

97742.

Comentário: O enunciado nos traz um lactente de 6 meses, nascido a termo, AIG e sem intercorrências no período neonatal. Ao exame físico apresenta várias anormalidades neurológicas, tais como macrocrania (perímetro cefálico acima do percentil 90) síndrome de atraso global do desenvolvimento, com atraso motor grosseiro (não rola, não senta com apoio), atraso adaptativo (não segura objetos) e atraso cognitivo (interação pobre com o examinador) síndrome piramidal, caracterizada por paresia proximal, hipertonia e hiperreflexia de membros superiores e inferiores e síndrome sensorial com baixa acuidade visual (dificuldade de acompanhar objetos) com cicatriz de corioretinite bilateral. A tomografia de crânio revela hidrocefalia e calcificações difusas pelo parênquima. A reunião de todos estes achados nos remete à possibilidade de INFECÇÃO

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

CONGÊNITA, mais especificamente, a toxoplasmose. As calcificações intracranianas também estão presentes na citomegalovirose, mas a distribuição é periventricular. Gabarito letra B.

138704.

Comentário: Estamos diante de um recém-nascido que mostrou-se ictérico ainda nas primeiras 24 horas de vida. Sabemos que as doenças hemolíticas são as principais causas de surgimento de uma icterícia tão precoce. A banca nos informou que os níveis de bilirrubina estão elevados em relação aos valores de referência. O ideal é que sempre possamos plotar os dados fornecidos em normogramas que indiquem se há ou não necessidade da fototerapia em função do nível da bilirrubina, do tempo de vida e da presença de alguns fatores de risco. Ainda assim, como regra geral, quando a icterícia surge tão precocemente, a fototerapia costuma estar indicada. Gabarito oficial fototerapia.

75465.

Comentário: Questão clássica sobre o tema infecções congênitas . Sabemos que as infecções congênitas podem ter uma série de manifestações clínicas em comum. Em todas podemos ter manifestações cutâneas, oftalmológicas e viscerais. O que nos permite estabelecer o provável diagnóstico apenas com base na clínica e na realização de exames não específicos é a identificação de alterações características de um diagnóstico, que não sejam compartilhadas pelas demais. No caso enunciado, a alteração característica é a identificação das calcificações periventriculares, que sugerem o diagnóstico de citomegalia congênita. Sempre que uma criança com infecção congênita apresentar calcificações intracranianas, devemos pensar em duas possibilidades toxoplasmose congênita e citomegalia congênita. A distinção entre essas se dá pelo padrão de distribuição das calcificações. Na toxoplasmose as mesmas são difusas já na citomegalia, podemos ter a distribuição periventricular. Não é sempre que o tratamento é indicado porém, caso seja, a droga de escolha é o ganciclovir. Resposta letra B.

304871.

Comentário: Este enunciado traz uma informação bastante preocupante além da icterícia, esta criança apresenta hipocolia, um sinal de colestase no período neonatal. Diversas condições podem

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

ser causa de colestase no período neonatal, incluindo causas infecciosas, metabólicas ou cirúrgicas. Uma das maiores preocupações relacionadas com a colestase neste período é o fato de que uma parte destas crianças tem como causa desta alteração a atresia de vias biliares. Nesta condição, ocorre o desenvolvimento de obliteração progressiva com fibrose das vias biliares, ocasionando a interrupção da drenagem biliar e acúmulo de bile, com lesão hepática. É obrigatório que seja prontamente iniciada a investigação, pois a intervenção cirúrgica (cirurgia de Kasai) deve ser realizada ainda nas primeiras semanas de vida. Lembre-se de que a icterícia do leite materno pode ser uma causa de icterícia persistente no período neonatal, mas cursa apenas com o aumento da bilirrubina indireta. A hepatite neonatal idiopática também é causa de colestase, mas cursa com aumento da bilirrubina direta. Por fim, os quadros de alergia ao leite de vaca não costumam ter repercussões hepáticas. Resposta letra C.

351627.

Comentário: Vamos analisar as alternativas sobre a abordagem do pediatra nesse caso de reanimação neonatal com evolução para óbito Letra A incorreta. O pediatra apresentou conduta inicial correta frente a um RN a termo que nasceu hipotônico realizou o clampeamento imediato do cordão, levou o RN ao berço aquecido, secou e reposicionou o RN para garantir a abertura das vias aéreas. Após os passos iniciais, realizou a avaliação da frequência cardíaca (FC). Como a FC foi 100bpm, iniciou a ventilação com pressão positiva com ar ambiente e monitorizou o paciente. O paciente não apresentou boa resposta à VPP, cuja técnica foi checada e estava adequada. Nesse momento o pediatra iniciou massagem cardíaca, e aqui está o erro. De acordo com as diretrizes de reanimação neonatal da SBP, se o paciente, após a correção da técnica da ventilação, não melhorar, está indicado o uso de interface alternativa para a VPP a máscara laríngea ou a cânula traqueal . Assim, o pediatra deveria ter obtido uma via aérea avançada e otimizado a ventilação antes de proceder à massagem cardíaca. Letra B incorreta. A via preferencial para administração de adrenalina na reanimação neonatal é a endovenosa. O cateterismo venoso umbilical é o procedimento de eleição para garantir um acesso venoso central. Letra C correta. Como vimos acima, a intubação traqueal antecede à indicação de massagem cardíaca nos procedimentos de

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

reanimação neonatal na sala de parto. Letra D incorreta. A anamnese é fundamental para identificação dos riscos e otimização do atendimento neonatal. Resposta letra C.

351628.

Comentário: Vamos analisar as afirmativas sobre a triagem neonatal de cardiopatias congênitas De fato, o teste do coraçãozinho detecta as cardiopatias dependentes de canal. Contudo, o teste é incapaz de detectar cardiopatias não dependentes de canal. Ou seja, as cardiopatias mais comuns, como a comunicação interventricular ou a comunicação interatrial, por exemplo, não são detectadas pelo teste. Quanto ao momento da realização, o teste do coraçãozinho deve ser feito entre 24 e 48h de vida, antes da alta hospitalar. Um teste alterado implica na realização de ecocardiograma e avaliação cardiológica minuciosa, para confirmação diagnóstica, antes da alta. Quanto à técnica de avaliação, esta é feita através da determinação da oximetria do membro superior direito (pré-ductal) e qualquer dos membros inferiores. De acordo com os fluxogramas mais atuais, é considerando imediatamente positivo o teste que apresente SpO2 menor ou igual a 89% no membro superior direito ou no membro inferior. O teste é considerado duvidoso quando houver SpO2 entre 90% e 94% ou uma diferença entre as medidas do membro superior direito e o membro inferior maior ou igual a 4%. Nesta situação, o teste deve ser realizado novamente após uma hora por até duas vezes. A persistência da alteração após a terceira avaliação implica em teste positivo. Por fim, o teste do coraçãozinho deve ser realizado em todos os recém-nascidos. O sopro por si só não necessariamente indica uma cardiopatia congênita. Apenas a presença de sopros cardíacos considerados patológicos (sopro sistólico ou sopro contínuo) deve ser considerada sugestiva de cardiopatia congênita.

354079.

Comentário: Quando falamos de fisiologia cardiopulmonar do recém-nascido, devemos nos lembrar que a transição da circulação fetal para a vida pós-natal está relacionada às estruturas presentes na vida fetal (ducto venoso, forame oval e canal arterial) e às resistências da circulações pulmonar e sistêmica. O feto apresenta resistência pulmonar aumentada, pois seu pulmão ainda não está em contato com grande quantidade de oxigênio, que é um vasodilatador pulmonar, então, nesse

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

momento, a resistência pulmonar é superior à sistêmica, o que faz com que o sangue flua através do forame oval e do canal arterial da direita para a esquerda, chegando à aorta e mantendo a circulação sistêmica, de onde retorna para a placenta para ser oxigenado. Quando o cordão umbilical é clampeado, diminui-se a quantidade de sangue que chega ao átrio direito, ou seja, diminui o retorno venoso à direita, e isso acontece pois grande parte desse sangue vinha através da placenta pelo ducto venoso. Uma vez que ocorreu o nascimento, há a expansão pulmonar, o aumento da pressão alveolar e arterial de oxigênio, que promove a queda da resistência vascular pulmonar - os capilares pulmonares então se enchem de sangue e aumenta o retorno venoso para átrio esquerdo. O átrio esquerdo fica com altas pressões, o que leva ao fechamento do forame oval. Ao cair a resistência pulmonar, o shunt se inverte da esquerda para a direita (da circulação sistêmica com maior pressão para a pulmonar com menor pressão) até o fechamento do canal arterial, terminando a transição da circulação fetal para a neonatal. Entender isso explica porque o clampeamento tardio do cordão é tão importante, pois mantém o fluxo placentário para coração direito e impede que a resistência vascular sistêmica aumente de forma abrupta ao clampear, o que permite que o shunt da direita para a esquerda continue acontecendo, ou seja, mantém a circulação sistêmica enquanto a pressão pulmonar cai, sem comprometer o débito cardíaco na transição, e ainda mantém o retorno venoso aumentado para átrio esquerdo. Entendendo isso, vamos analisar as alternativas. Letra A incorreta. O clampeamento tardio do cordão mantém o retorno venoso ao coração direito ao invés de diminui-lo. Além disso, na vida neonatal a resistência vascular sistêmica aumenta é a pulmonar que diminui. Letra B incorreta. De fato, como vimos, o clampeamento tardio mantém o retorno venoso alto para o coração direito, porém a resistência vascular sistêmica está aumentando na vida neonatal. Letra C incorreta. Após o nascimento, o retorno venoso ao coração esquerdo está aumentando, pois os capilares pulmonares ficaram cheios, o que só ocorre pela queda da resistência vascular pulmonar, não por um aumento dela. Letra D incorreta. Clampeamento tardio mantém retorno venoso ao coração direito aumentado, além disso, a resistência vascular pulmonar está caindo com a vasodilatação pulmonar. Letra E correta. Após o nascimento, o retorno venoso ao coração esquerdo está aumentado e a resistência

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

vascular pulmonar está caindo enquanto a sistêmica aumenta. Resposta letra E.

368170.

Comentário: Todas as questões que envolvem a reanimação do recém-nascido (RN) devem seguir as diretrizes de reanimação neonatal da Sociedade Brasileira de Pediatra. De acordo com estas diretrizes para RN de 34 ou mais semanas de idade gestacional, vamos às alternativas Letra A incorreta. Não existe mais a recomendação de estímulo tátil vigoroso no RN que não começa a respirar logo após o nascimento, muito menos no RN que já está no bberço de reanimação e já foi submetido aos primeiros passos. O que se recomenda, no RN que não começa a respirar logo que nasce, é fazer o estímulo tátil no dorso, de modo delicado e no máximo duas vezes, para ajudar a iniciara respiração antes do clampeamento imediato do cordão. Letra B incorreta. A ventilação com pressão positiva estará recomendada no RN que apresenta frequência cardíaca (FC) abaixo de 60bpm, portanto, que necessitará de massagem cardíaca, ou nos RN que estão com ventilação com pressão positiva com máscara por tempo prolongado. Letra C correta. Os passos iniciais da reanimação são colocar o RN sob fonte de calor radiante, secar corpo e fontanela e desprezar campos úmidos, posicionar a cabeça em leve extensão e aspirar vias aéreas se obstruídas. Se, após estes passos, o RN apresenta FC 100bpm, apneia ou respiração irregular, está indicado iniciar a ventilação com pressão positiva (VPP) com máscara em ar ambiente, além de realizar a monitorização do RN com oxímetro de pulso no membro superior direito e monitor cardíaco. Lembrando que a indicação e início da VPP deve ser feita no primeiro minuto após o nascimento pois ela é considerada a manobra mais efetiva na redução de morbimortalidade. Letra D incorreta. Nos RN a termo não há indicação de suplementação de oxigênio nas manobras iniciais. Resposta letra C.

336262.

Comentário: Questão de tema muito importante e bem clássico de algumas provas. Sempre que temos um prematuro que apresenta um quadro de obstrução intestinal, com distensão do abdome, dor, vômitos biliosos e sangramento gastrointestinal e que agrava com sinais sistêmicos como instabilidade hemodinâmica, distúrbios da perfusão, acidose metabólica, hipotensão e coagulação

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

intravascular disseminada, deve nos fazer pensar imediatamente no diagnóstico de enterocolite necrosante, que consiste na necrose da mucosa intestinal, que pode evoluir para perfuração, peritonite e sepse. A questão ainda nos fornece uma imagem que evidencia ar circundando a imagem do fígado, ou seja, pneumoperitônio. Isso significa que estamos diante de uma doença grave e de perfuração intestinal. Logo, a conduta é a intervenção cirúrgica. Nos casos de enterocolite necrosante sem perfuração, devemos instituir a antibioticoterapia, dieta zero, terapia nutricional parenteral, podendo ser necessário a ressuscitação volêmica, suporte ventilatório e aminas. Resposta letra C.

345713.

Comentário: Diante de um recém-nascido em que se detecta alteração da frequência cardíaca após os passos iniciais realizados após o nascimento, a maneira mais rápida e fidedigna de monitorizá-lo é através de eletrodos cardíacos. A oximetria de pulso permite uma monitorização contínua, mas não apresenta rapidez em detectar o pulso. Já a ausculta e a palpação do cordão umbilical podem subestimar a frequência cardíaca e não permitem a monitorização contínua. Resposta letra C.

345714.

Comentário: Usamos o conceito de hipotensão para definir se o bebê está estável ou não hemodinamicamente, porém os conceitos de hipotensão em neonatologia apresentam pouca correlação com a fisiologia. Alguns estudos defendem que a hipotensão é considerada se a pressão arterial média for menor que a idade gestacional. Contudo, este dado não deve ser considerado isoladamente. Outras referências utilizam a definição de hipotensão quando a PAM 30 mmHg porque estaria associada a aumento da mortalidade. Porém, não há recomendação para sua utilização já que não apresenta correlação com a fisiologia. Há ainda protocolos que consideram como hipotensão caso um dos componentes da pressão arterial (sistólica, diastólica ou PAM) estiverem abaixo do 3º percentil. Portanto, não há uma definição clara e e consensual sobre a hipotensão na faixa etária neonatal. Resposta letra D.

337633.

Comentário: Para responder essa questão, vamos relembrar os principais conceitos sobre

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

classificação do recém-nascido. Existem três maneiras principais de classificar um RN quanto ao peso ao nascimento, quanto à idade gestacional e quanto à adequação do peso para idade gestacional. Quanto ao peso, consideramos baixo peso ao nascer o peso inferior a 2500g (letra A incorreta), muito baixo peso ao nascer o peso entre 1000g e 1499g e extremo baixo peso ao nascer o peso inferior a 1000g (letra B incorreta). Quanto à idade gestacional, consideramos pré-termo o RN nascido com menos de 37 semanas, a termo o nascido entre 37 e 41 semanas e 6 dias e pós-termo o RN nascido com 42 semanas ou mais de gestação. O pré-termo pode ser subdividido em pré-termo tardio (entre 34 e 36 semanas e 6 dias), pré-termo moderado (de 32 a 33 semanas e 6 dias) e muito pré-termo (de 28 a 31 semanas e 6 dias), que podem em algumas classificações ser apenas chamados de pré-termo , sendo o termo pré-termo extremo reservado para RN menor que 28 semanas (letra C correta). Quanto à adequação do peso para idade gestacional, consideramos pequeno para idade gestacional (PIG) o RN abaixo do percentil 10, adequado para idade gestacional (AIG) o RN entre os percentis 10 e 90 e grande para idade gestacional (GIG) o RN acima do percentil 90 (letra D incorreta). Resposta letra C.

320439.

Comentário: O enunciado descreve um recém-nascido (RN) com tumefação dorsal mediana na altura da coluna lombar, coberta por uma fina membrana e com extravasamento lento de líquido claro. Esta descrição é sugestiva da presença de mielomeningocele, um defeito grave de fechamento do tubo neural, constituindo um disrafismo espinhal em que ocorre herniação e exposição da medula espinhal e do seu conteúdo. Pode haver ruptura do revestimento cutâneo da massa cística durante o parto, já que a pele não está totalmente desenvolvida, com consequente vazamento de liquor, como descrito no caso, e exposição do conteúdo da lesão, aumentando o risco de infecções, principalmente meningite. A abordagem terapêutica inclui antibioticoterapia venosa e correção cirúrgica do defeito o mais cedo possível, preferencialmente nas primeiras 24 horas de vida, para prevenir infecções e futuras complicações muitas vezes, é necessária a colocação de shunt ventriculoperitoneal, quando há hidrocefalia associada. Resposta letra A.

320441.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

Comentário: O recém-nascido (RN) descrito no enunciado apresentou sangramento gastrointestinal e no coto umbilical, ainda nos primeiros dias de vida. Ele está em bom estado geral, com contagem de plaquetas e função hepática normais, mas TAP e PTT encontram-se prolongados. Este quadro é sugestivo de sangramento por deficiência de vitamina K ou doença hemorrágica do recém-nascido, que resulta de deficiências transitórias, mas severas, nos fatores dependentes de vitamina K. Ocorre tipicamente entre dois e sete dias de vida, em bebês em aleitamento materno exclusivo e que não receberam profilaxia com vitamina K ao nascimento (história sugerida pelo relato de parto domiciliar). Caracteriza-se por hemorragia, mais frequentemente gastrointestinal, nasal, subgaleal, intracraniana ou pós-circuncisão, e exames laboratoriais demonstram que tanto o tempo de protrombina quanto o tempo de tromboplastina parcial estão prolongados. O tratamento é feito com administração de vitamina K no caso de sangramento grave, principalmente em prematuros ou quando há doença hepática associada, pode ser necessária transfusão de plasma fresco ou sangue total. Resposta letra B.

337641.

Comentário: Em relação aos distúrbios metabólicos do recém-nascido (RN), vamos analisar cada uma das alternativas. A letra A está incorreta. Recém-nascidos com hipoglicemia frequentemente são assintomáticos. A hipoglicemia, nestes casos, é geralmente detectada pela triagem de glicose no sangue em bebês de risco ou como um achado laboratorial incidental. No RN sintomático, os sinais são inespecíficos e refletem as respostas do sistema nervoso à privação de glicose. Estes podem ser categorizados como achados neurogênicos (autonômicos) ou neuroglicopênicos. Neurogênicos agitação tremores sudorese irritabilidade taquipneia e palidez. Neuroglicopênicos déficit de sucção choro fraco ou agudo mudança no nível de consciência (letargia, coma) convulsões e hipotonia. Em RNs, os sinais adicionais de hipoglicemia incluem apneia, bradicardia, cianose e hipotermia. A letra B está correta. Alguns grupos são considerados de risco para hipoglicemia, dentre eles filhos de mãe com diabetes prematuros baixo peso ao nascer RN pequeno ou grande para idade gestacional, etc. Os protocolos para rastreio de hipoglicemia variam a depender da referência consultada. Uma das possibilidades é realizar a glicemia capilar com 3, 6,

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

12 e 24 horas de vida e após isso, em intervalos de 8 a 12 horas conforme protocolos das unidades. Alguns locais indicam a glicemia capilar com 1h, 3, 6 e 12 horas de vida e após de 6 6 horas. A letra C está incorreta. Pelo contrário. A diabetes gestacional ou pré-gestacional materna, administração de drogas à gestante (tocolíticos, agentes beta adrenérgicos ou hipoglicemiantes orais) e hipertensão e pré-eclâmpsia são fatores de risco para desenvolvimento de HIPOglicemia transitória neonatal. A letra D está incorreta. Apesar de o limite máximo dos níveis de glicose sanguínea em RN saudáveis não ser claramente definido, costuma-se considerar o limiar para diagnóstico de hiperglicemia nos neonatos como 126 mg dL no sangue. A hiperglicemia neonatal transitória geralmente se resolve em poucos dias, e por isso, a estratégia de tratamento deve ser a mais conservadora possível. Na presença de glicemia 250 mg dL (alguns autores consideram 180 mg dL) ou se existir manifestação clínica, como diurese osmótica, a terapêutica com infusão de insulina exógena pode ser instituída. Resposta letra B.

336288.

Comentário: Bebê prematuro com desconforto respiratório tem uma alta chance de ter a síndrome do desconforto respiratório do RN (doença da membrana hialina). Esta síndrome ocorre pela deficiência do surfactante pulmonar, levando ao colapso dos alvéolos. Além da prematuridade, outros fatores de risco são asfixia, diabetes materno e nascimentos múltiplos. Curiosamente, temos na história um fator de proteção, que é a doença hipertensiva materna. Então como confirmar a hipótese Pela radiografia, que evidencia uma imagem reticulogranular difusa (padrão em vidro fosco). A administração de corticoide antenatal está indicada para a mãe com risco de parto prematuro (com IG de 24 a 33 semanas e 6 dias), para prevenir a ocorrência desta doença. A taquipneia transitória ocorre em prematuros tardios próximos do termo, geralmente em crianças nascidas por cesarianas eletivas sem trabalho de parto. A pneumonia seria uma hipótese mais provável se tivéssemos bolsa rota prolongada, história materna de infecção urinária, corioamnionite, além de um bebê com manifestações sistêmicas, como distúrbios de perfusão, por exemplo. A radiografia é semelhante à da síndrome do desconforto respiratório. Resposta letra A.

335111.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

Comentário: Questão direta sobre reanimação neonatal de um bebê que nasce a termo. Se o bebê está hipotônico ou não está respirando chorando, deve ser levado à mesa de reanimação imediatamente e os primeiros passos serem instituídos prover calor, posicionar a cabeça, aspirar as vias aéreas, se necessário, e secar. Se, ainda assim, a frequência cardíaca se mantiver abaixo de 100 bpm ou se a respiração estiver irregular, deve ser iniciada ventilação com pressão positiva com ar ambiente. Resposta letra C.

334762.

Comentário: Em relação às infecções congênitas e suas características, vamos avaliar cada uma das doenças apresentadas. 3. A presença de calcificações intracranianas difusas, hidrocefalia, coriorretinite, líquor com pleiocitose ou proteína elevada e hepatoesplenomegalia, são características marcantes da toxoplasmose congênita. Nessa doença temos a clássica tríade de Sabin coriorretinite, calcificações intracranianas e hidrocefalia. 1. A presença de rash maculopapular (palmas das mãos e plantas dos pés), rinite persistente, osteocondrite e periostite e pseudoparalisia de Parrot, são características marcantes da sífilis congênita. A pseudoparalisia de Parrot é uma condição decorrente da osteocondrite (lesões metafisárias, tipicamente no úmero, fêmur e tíbia). A rinite persistente é caracterizada pela coriza sifilítica frequentemente é a primeira manifestação, ocorrendo em até 40% dos casos. Apresenta-se com secreção serossanguinolenta, como consequência da erosão da mucosa, e traz desconforto para a mamada e a respiração. 2. Catarata, cardiopatia congênita (persistência do canal arterial ou estenose pulmonar), perda auditiva e retardo de crescimento intrauterino, são características da rubéola congênita. As lesões cardíacas estão presentes em mais da metade dos infectados nas primeiras oito semanas de gestação. A alteração mais comum é a persistência do canal arterial, com ou sem estenose de ramo da artéria pulmonar. A retinopatia da rubéola apresenta um aspecto de sal e pimenta , que é a alteração ocular mais comum. 4. Calcificações periventriculares, microcefalia, trombocitopenia, hepatoesplenomegalia e petéquias, caracterizam a citomegalovirose congênita. Já vimos que também podemos encontrar a presença de calcificações na toxoplasmose congênita, porém, aqui as calcificações serão tipicamente periventriculares. A microcefalia e a presença de calcificações

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

guarda relação com o prognóstico intelectual no futuro. Resposta letra C.

306701.

Comentário: Após os chamados passos iniciais (aquecer, posicionar, aspirar se necessário e secar o RN) em 30 segundos, avaliam-se frequência cardíaca e respiração se houver FC 100bpm e ou o RN não apresentar movimentos respiratórios regulares (apneia respiração irregular), procede-se à ventilação com pressão positiva com balão e máscara. Esta precisa ser iniciada nos primeiros 60 segundos de vida (minuto de ouro). A ventilação pulmonar é o procedimento mais importante e efetivo na reanimação do RN em sala de parto. Resposta letra C.

305006.

Comentário: A atresia de vias biliares, que cursa com obliteração dos ductos biliares extra-hepáticos, é um dos diagnósticos diferenciais mais importantes em quadros de colestase neonatal. A detecção da atresia em tempo hábil é fundamental, pois o retardo na correção cirúrgica pode levar a falência hepática terminal. Os pacientes apresentam hiperbilirrubinemia às custas predominantemente de BD. É interessante notar que os valores de bilirrubina total habitualmente não são muito altos raramente maiores que 12mg dl. Quanto às enzimas hepáticas, tendem a estar aumentadas, sendo que as canaliculares (GGT e FA) encontram-se geralmente mais elevadas que as tissulares (TGO e TGP). Os níveis de albumina e fatores da coagulação podem ser normais no começo, alterando-se conforme o paciente evolui para dano hepático, caso o diagnóstico seja retardado.

291628.

Comentário: Questão clássica de prova que se repete todo ano. O diabetes mellitus gestacional é fator de risco para diversas complicações fetais, neonatais e no desenvolvimento a longo prazo. As principais complicações neonatais são macrossomia, hipoglicemia neonatal, cardiopatias congênitas, deficiência de ferro, hiperbilirrubinemia, anormalidades neurológicas, hipocalcemia, hipomagnesemia e policitemia. Além disso, as taxas de aborto espontâneo, natimorto, mal formações congênitas e morbidade e mortalidade perinatal são maiores nesse grupo de recém-nascidos. Resposta letra A.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

291629.

Comentário: A questão traz um recém-nascido filho de mãe hipertensa, pequeno para a idade gestacional (PIG), com baixo peso ao nascer, que evoluiu com uma glicemia de 12mg dL, ou seja, um bebê de risco apresentando hipoglicemia nas primeiras horas de vida. Qual a conduta Sabemos que o valor que define hipoglicemia não é consensual na literatura, mas um resultado abaixo de 40 mg dL geralmente não requer discussão. Independentemente da presença de sintomas, quando estamos diante de um recém-nascido com hipoglicemia abaixo de 25mg dl, a abordagem inicial deve ser feita com infusão em bolus de 2 mL Kg de glicose a 10% (letras A, D e E erradas). A letra B está errada, pois o controle de glicemia para recém-nascidos de risco é feito da seguinte maneira com 1, 2, 3, 6, 12 e 24 horas, e após, a cada 8 a 12 horas, até 72 horas de vida. Resposta letra C.

291630.

Comentário: O enunciado descreve duas informações cruciais que definem qual será o manejo dessa criança 1) o parceiro da gestante não foi tratado (indicando risco de reinfecção) 2) aumento dos títulos de VDRL depois do tratamento. Esses critérios nos autorizam definir um tratamento inadequado para sífilis na gestação e, por conta disso, o recém-nascido será obrigatoriamente submetido à realização do VDRL do sangue periférico, hemograma completo, radiografia de ossos longos e punção lombar. Quando houver alterações líquóricas compatíveis com neurosífilis, o tratamento só pode ser feito com a penicilina cristalina, por 10 dias. Quando encontramos outras alterações, mas líquor normal, o tratamento pode ser feito com a penicilina cristalina ou penicilina procaína. O seguimento ambulatorial é recomendado para todo recém-nascido exposto e deve ser feito até 2 anos. Resposta letra C.

313306.

Comentário: Boa questão para fazer uma revisão do tema. O teste do coraçãozinho ou da oximetria de pulso é o teste de triagem para cardiopatias congênitas críticas que consiste na aferição da oximetria de pulso em todo recém-nascido com idade gestacional 34 semanas. A aferição deve ser realizada no membro superior direito e em um dos membros inferiores entre 24 e 48 horas de vida, antes da alta hospitalar. Resposta letra A.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

313307.

Comentário: Diante desse achado ao exame fisico, vamos analisar cada uma das alternativas. A letra A é a resposta correta. O hematoma subgaleal, corresponde a hemorragia abaixo da aponeurose epicraniana que conecta os componentes frontal e occipital dos músculos fronto-occipitais. Apresenta-se como massa de consistência firme a flutuante, às vezes se estendendo para o pescoço ou fronte, sua borda é bem definida e à palpação pode apresentar crepitação, principalmente na periferia. Aletra B está incorreta. O cefalo-hematoma é uma coleção sanguínea subperiostal, que se desenvolve após o parto e se expande durante o primeiro dia de vida à medida que o sangue se acumula. É arredondado e limitado a um osso. Ocasionalmente pode haver fratura subjacente. As letras C, D e E, são sinônimos. A bossa serossanguinea (caput succedaneum) é a alteração mais frequentemente encontrada após o nascimento. Caracteriza-se por edema de couro cabeludo, depressível, de limites imprecisos que inicialmente se restringe à área de apresentação do parto e que pode se deslocar para outras regiões conforme o decúbito. Resposta letra A.

313308.

Comentário: O tratamento da atresia de vias biliares consiste na tentativa de desobstruir a via biliar por meio de uma anastomose do intestino delgado com a porta hepatis. Essa técnica foi criada por Kasai, na década de 1950, e continua sendo a melhor opção para restabelecer o fluxo de bile para o tubo digestivo. Essa operação é tanto melhor sucedida quanto mais precocemente realizada, devendo ser realizada idealmente antes dos 60 dias de vida do paciente. Após esse período, as taxas de sucesso em promover uma drenagem biliar satisfatória com desaparecimento da icterícia são menores. Pacientes com diagnóstico tardio, além dos seis meses de idade, ou que não obtiveram desaparecimento da icterícia com a portoenterostomia (cirurgia de Kasai) devem ser encaminhados a um programa de transplante de fígado. Resposta letra B.

313310.

Comentário: A via preferencial para a infusão de medicações na sala de parto é a endovenosa, sendo a veia umbilical de acesso fácil e rápido. O cateter venoso umbilical deve ser inserido de

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

emergência, assim que há indicação do uso de medicações na sala de parto. A administração de medicações por via traqueal só pode ser usada para a adrenalina e uma única vez, geralmente sendo administrada por via endotraqueal enquanto se realiza o procedimento do cateterismo umbilical. A dose indicada da adrenalina endotraqueal é de 0,05-0,10 mg kg. Para a reanimação neonatal devemos preparar a adrenalina na diluição de 1 10.000 em soro fisiológico, isto é, 1 mL de adrenalina 1 1000 em 9 mL de SF. Devemos preparar 5 ml desta solução e administrar 0,5 - 1,0 mL kg. Resposta letra C.

313311.

Comentário: Apesar da maioria das infecções congênitas serem assintomáticas ao nascimento, todas as condições apresentadas podem cursar com edema generalizado, com exceção do herpes simples. Dentre as manifestações possíveis da doença de chagas congênita, temos a hepatoesplenomegalia, distúrbios neurológicos, meningoencefalites, tremores, convulsões, zonas de necrose com sequelas, edemas generalizados, icterícia, hemorragias cutâneas, cianose, hidrocele, pneumonite, alterações bilaterais de fundo de olho, corioretinite e opacificação do corpo vítreo, chagomas metastáticos, entre outras. Já a herpes simples congênita geralmente causa vesículas cutâneas ou escaras de cicatrização, alterações oculares e micro hidrocefalia, mas edema generalizado não está presente. Resposta letra D.

313312.

Comentário: Segundo o Ministério da Saúde, através do documento Atenção à Saúde do Recém-Nascido Guia para os Profissionais de Saúde , os seguintes princípios devem ser adotados para melhorar os efeitos da terapia com o surfactante - Estimular o uso de corticoide antenatal em gestantes de risco para parto prematuro. - Implementar recursos suficientes de pessoal, equipamentos e laboratório para o cuidado de RN com insuficiência de múltiplos órgãos. Além disso, manter vigilância constante da qualidade do atendimento a esses pacientes. - Preferir os preparados contendo surfactante endógeno de animais, principalmente nas situações em que a lesão inflamatória é extensa, como na síndrome do desconforto respiratório (SDR) grave, pneumonias, síndrome de aspiração meconial (SAM) e na síndrome do desconforto respiratório

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

agudo (SDRA). - Iniciar com dose de 100mg kg de fosfolípides. Caso o paciente apresente melhora da função pulmonar, manter essa dose se houver necessidade de novo tratamento. Nas situações em que há lesão inflamatória extensa (SDR grave, pneumonias, SAM e SDRA), considerar o uso de doses maiores, próximas a 150mg kg de fosfolípides. A necessidade de doses adicionais deve ser individualizada. Resposta letra B.

313313.

Comentário: A cianose pode ser classificada em localizada ou periférica, e generalizada ou central. A cianose periférica (ou acrocianose), aparece nas regiões plantares e palmares. Seu surgimento não corresponde a doença sistêmica grave, sendo considerado um sinal benigno e comum no período neonatal. A cianose central é observada quando a concentração de hemoglobina não saturada excede 5g dL, uma intercorrência relativamente comum no recém-nascido que frequentemente possui níveis de hemoglobina acima de 15 g dL. A cianose central, quando presente, deve ser sempre investigada, procurando-se afastar cardiopatias congênitas, hipertensão pulmonar e afecções graves do parênquima pulmonar. Resposta letra D.

313314.

Comentário: O milium sebáceo está presente em 40% dos RNs e manifesta-se por pequenos pontos brancos (menor que 1mm), localizados na base do nariz, queixo e fronte, devido à distensão e obstrução das glândulas sebáceas, decorrentes da ação do estrógeno materno desaparecem em poucas semanas. A letra A refere-se ao lanugo, B ao vernix caseoso, C são as manchas mongólicas e E o eritema tóxico. Resposta letra D.

313315.

Comentário: Estamos diante de um RN pré-termo com taquipneia, retração subcostal e tiragem intercostal importantes, gemidos expiratório e crises de cianose. Achados radiológicos pouca expansão pulmonar, infiltrado micronodular difuso (vidro fosco) e aerobroncogramas - quadro compatível com a Síndrome do Desconforto Respiratório (SDR) ou doença da membrana hialina (item II correto). A deficiência quantitativa e qualitativa do surfactante alveolar é a principal causa da SDR. A evolução clássica da SDR pode ser modificada por meio da administração antenatal de

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

corticoide, assistência ventilatória precoce e uso de surfactante exógeno. O CPAP pode ser usado o mais precocemente possível, ainda na sala de parto (afirmativa I está correta). A administração de surfactante está indicada para aqueles bebês que têm a doença claramente estabelecida ou que foram intubados por desconforto respiratório precoce (afirmativa III está incorreta). Visto isso, estão corretas as afirmativas I e II. Resposta letra B.

305036.

Comentário: Temos um RN a termo que nasce hipotônico, com respiração regular. Esse bebê deve ser imediatamente levado à mesa de reanimação, onde são realizados os passos iniciais, em até 30 segundos prover calor, posicionar cabeça, aspirar vias aéreas se necessário, secar. Mesmo após as medidas iniciais, o bebê mantém frequência cardíaca abaixo de 100bpm e respiração irregular. Está indicada então a ventilação com pressão positiva, realizada com máscara facial e balão (ou ventilador manual em T). Nos bebês a termo, indica-se que a ventilação seja feita inicialmente com ar ambiente apenas quando necessário, devemos ajustar a concentração de O2 em incrementos de 20% por vez, objetivando atingir a saturação desejada e sempre corrigindo a técnica de ventilação. Já nos bebês abaixo de 34 semanas, devemos iniciar a ventilação fornecendo O2 a 30% e aumentar conforme necessário, guiados pela saturação. Resposta da questão letra C

260687.

Comentário: Estamos frente a um recém-nascido ictérico com 24 horas de vida Icterícia precoce (24 horas de vida) até que se prove o contrário não é fisiológica e deve ser investigada, principalmente para hemólise...para avaliação de hemólise é necessário solicitar hemograma e reticulócitos. Bilirrubinas totais e frações deve ser solicitado para confirmar a hipótese de hiperbilirrubinemia indireta (esperada na doença hemolítica) e também para definir a conduta (fototerapia ou exsanguineotransfusão). O coombs direto auxilia no diagnóstico de doença hemolítica imunomediada quando positivo (nesse caso a hipótese seria doença hemolítica por incompatibilidade ABO). Vale lembrar que na incompatibilidade ABO não é necessária uma gestação anterior para ocorrer a aloimunização, como ocorre no sistema Rh. No sistema ABO é

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

comum as gestantes já estarem sensibilizadas previamente por antígenos semelhantes presentes em outros microoganismos. Por último, não há qualquer motivo para contraindicar o aleitamento materno, devendo ser estimulado. Resposta correta letra E

260688.

Comentário: Diante de um récem-nato que apresenta baixas condições de vitalidade ao nascimento, como o caso em tela, em que foi constatado respiração irregular, prontamente deveremos levar para a mesa de reanimação após o clampeamento do cordão umbilical, para proceder com os cuidados iniciais, que consiste em fornecer A PAS para o bebê, que consiste em A quecer , ou seja, colocar o recém-nato sob uma unidade de calor radiante P osicionar, com uma leve extensão cervical A spirar, inicialmente boca e depois as narinas, mas somente se presença de secreções S ecar o paciente e desprezar os campos úmidos. Após os passos iniciais, iremos avaliar a frequência cardíaca e respiração para decidir se iremos ou não iniciar as manobras de reanimação. Resposta letra D.

287351.

Comentário: Atualmente, o teste do pezinho tem a capacidade de rastrear as seguintes doenças fenilcetonúria, hipotireoidismo congênito, doenças falciforme e outras Hemoglobinopatias, fibrose Cística, hiperplasia adrenal congênita, deficiência de biotinidase e toxoplasmose congênita (foi contemplada em 2020). Em relação a Hiperplasia adrenal congênita, a principal deficiência enzimática descrita é da enzima 21-hidroxilase e o rastreio pode ser feito pela dosagem da 17-hidroxiprogesterona, que estará aumentada em tal condição. O momento de realização é entre o 3º e o 5º dia de vida do bebê devido às especificidades das doenças diagnosticadas atualmente. Uma das razões para evitarmos a coleta nas primeiras 48 horas de vida é uma maior percentual de resultados falso-positivos para hipotireoidismo congênito (por um aumento transitório de TSH após o nascimento) e de falso-negativos para fenilcetonúria (pela baixa ingestão de proteínas). Perceba que a questão não apresenta nenhuma resposta correta, mas a banca divulgou o gabarito como letra D. Resposta letra D.

287906.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

Comentário: Vamos avaliar cada item separadamente I. CORRETO A miliária são lesões típicas do períod neonatal, ocasionadas por obstrução ductal das glândulas sudoríparas écrinas, em decorrência de sudorese excessiva (clima quente, roupas excessivas ou febre). Pode ter dois subtipos a cristalina, que são vesículas em gotas de orvalho localizadas na fronte do recém-nato a rubra, também conhecida como brotoeja, que são vesísculas eritematosas em região da fronte, cervical e axilar. II. CORRETO A dermatite da área da fralda irritativa primária é provavelmente a afecção cutânea mais freqüente na primeira infância, constituindo fonte significativa de desconforto para a criança. Há conseqüente maceração da pele, que se torna mais susceptível à irritação ocasionada pelo contato prolongado da urina e das fezes com a pele da região coberta pelas fraldas. Freqüentemente surge infecção secundária por Candida ou por bactérias como Bacillos faecallis , Proteus, Pseudomonas, Staphylococcus e Streptococcus . III. ERRADO O impetigo pode ser causado por dois diferentes agentes o Staphylococcus aureus e o Streptococcus pyogenes. Resposta letra C.

287911.

Comentário: Vamos analisar as afirmativas a assertiva A está incorreta a icterícia fisiológica é uma adaptação neonatal ao metabolismo da bilirrubina indireta e se manifesta após as primeiras 24 horas de vida. A assertiva B está incorreta icterícia de início precoce é aquela que certamente ocorre por um processo patológico. A icterícia após as primeiras 24 horas de vida pode se dever à icterícia fisiológica, ou icterícia do aleitamento materno. A assertiva III está correta. A icterícia do leite materno inicia a partir da segunda semana de vida em crianças em aleitamento materno exclusivo e pode perdurar por até 12 semanas de vida. Resposta Letra B.

255622.

Comentário: Os fatores de maior risco para hiperbilirrubinemia indireta incluem - Mãe de tipagem O, e ou Rh negativo (lembrar que a mãe tem que produzir anticorpos anti-A e ou anti-B para ocasionar icterícia no recém-nascido logo, se ela for AB, conforme a alternativa A, ela não produzirá tais anticorpos) - Irmão prévio que necessitou de tratamento para icterícia neonatal - Mãe diabética - Peso de nascimento entre 2.000 e 2.500 g e ou idade gestacional entre 35 e 38 semanas (maior

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

risco entre 35 e 36 semanas) - Sexo masculino - Baixo aporte de leite materno na primeira semana de vida, com perda exagerada de peso pelo recém-nascido - Alta precoce da maternidade (antes de completar 48 horas de vida) Logo, somente a alternativa C representa uma opção correta. Resposta letra C.

255623.

Comentário: Vamos analisar as assertivas em relação à sífilis congênita A) Correta. A sífilis congênita pode ser precoce (é aquela em que as manifestações clínicas se apresentam logo após o nascimento ou pelo menos durante os primeiros 2 anos.) ou tardia (é a denominação reservada para a sífilis que se declara após o segundo ano de vida). B) Incorreta. O VDRL é muito sensível e pouco específico. C) Incorreta. Nos últimos anos percebemos um aumento no número de casos notificados. D) Incorreta. Nos recém-nascidos de mães com sífilis inadequadamente tratada, é necessário o tratamento sim Consideramos o recém nato como tendo a doença. Portanto, o nosso gabarito é a letra A.

234416.

Comentário: Vamos analisar as alternativas a letra A está correta a doença é causada pelo vírus da rubéola, um vírus RNA do gênero Rubivirus da família togaviridae. A transmissão pode ocorrer de forma horizontal (direta ou indireta) ou vertical (a partir da mãe para o seu feto no útero ou recém-nascido durante o parto). A letra B está correta os pródromos são mais comuns nos adolescentes e adultos e costumam estar ausentes nas crianças. Essa fase tem duração de poucos dias e podemos encontrar sintomas inespecíficos, como febre baixa, odinofagia, conjuntivite, cefaleia, mal-estar e anorexia. A letra C está incorreta a principal forma de transmissão da doença é por meio de secreções respiratórias contaminadas. A letra D está correta o diagnóstico é baseado no quadro clínico característico doença leve com linfadenmegalia, principalmente suboccipital e retroauricular, e exantema maculopapular. Resposta letra C.

232126.

Comentário: Para entender a icterícia do recém-nascido é preciso antes compreender o papel da bilirrubina. Nossas hemácias (glóbulos vermelhos) têm uma vida média de 120 dias. Todos os dias,

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

milhões de hemácias novas são produzidas na medula óssea e milhões de hemácias velhas são destruídas no baço. Um dos produtos liberados neste processo de destruição é a bilirrubina, um pigmento amarelo-esverdeado. A bilirrubina gerada pela destruição das hemácias velhas no baço é chamada bilirrubina indireta. A bilirrubina indireta é captada pelo fígado e processada, transformando-se me bilirrubina direta. A bilirrubina direta é eliminada do fígado através das vias biliares, indo em direção ao trato gastrointestinal, onde é excretada nas fezes. A bilirrubina direta ao chegar aos intestinos sofre metabolização e torna-se um pigmento de coloração marrom, que é responsável pela cor característica das nossas fezes. Uma pequena parte da bilirrubina direta produzida no fígado acaba retornando para a corrente sanguínea (circulação entero-hepática). Essa pequena quantidade bilirrubina direta é filtrada pelos rins e eliminada na urina. Parte da coloração amarelada da urina se dá pela presença desse pigmento. A icterícia do neonato é um fenômeno comum e transitório, principalmente nos bebês que nascem antes da 38ª semana de gravidez. Cerca de 50% dos bebês a termo e 80% dos bebês prematuros desenvolvem icterícia. A icterícia neonatal ocorre habitualmente por elevação da bilirrubina indireta, devido aos seguintes motivos 1) As hemácias dos recém-nascidos apresentam uma vida média mais curta que as dos adultos. Enquanto uma hemácia adulta vive, em média, 120 dias, as hemácias dos bebês duram cerca de 80 dias apenas. 2) Os bebês têm proporcionalmente mais hemácias no sangue que os adultos. Enquanto 40% do sangue do adulto é composto por glóbulos vermelhos, nos recém-nascidos essa taxa chega a ser de 60% (isso ocorre pois, na vida intrauterina a saturação é mais baixa 70 a 80% e há necessidade de uma maior massa eritrocitária). 3) O fígado do recém-nascido é imaturo e sua capacidade de conjugação e excreção de bilirrubina é limitada. 4) Há aumento da circulação entero-hepática, já q una vida intrauterina o feto não evacua e o responsável em eliminar bilirrubina é mãe, através do cordão umbilical. Portanto, a produção de bilirrubina nos bebês é bem maior que nos adultos e sua capacidade de metabolização e eliminação é bem menor. O resultado disso é uma hiperbilirrubinemia indireta (acúmulo de bilirrubina indireta no sangue) com consequente deposição de pigmentos amarelados na pele. única correta é a letra E.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

232128.

Comentário: O escore de Apgar avalia cinco parâmetros a respiração, a frequência cardíaca, o tônus muscular, a resposta ao cateter nas narinas e a cor. Aproveite para lembrar-se de que para cada um desses parâmetros é atribuída uma pontuação que varia de 0 a 2, da seguinte forma (1) Respiração 0 ausente 1 irregular 2 regular ou choro (2) Frequência cardíaca 0 ausente 1 - 100 bpm 2 - 100 bpm (3) Tônus muscular 0 totalmente flácido 1 alguma flexão de extremidades 2 movimentos ativos (4) Resposta ao cateter nas narinas 0 sem resposta 1 caretas, alguma reação 2- tosse ou espirro e (5) Cor 0 cianose central ou palidez 1 cianose de extremidades 2 róseo. Logo, o que avaliamos é o padrão respiratório, não a frequência respiratória. Resposta letra C.

227099.

Comentário: A colestase neonatal é um distúrbio potencialmente grave, se não diagnosticada e tratada precocemente. A icterícia colestática é sempre patológica, ocorre após as primeiras 2 semanas e indica disfunção hepatobiliar (letra D correta). Ela se caracteriza por aumento de bilirrubina direta, icterícia, colúria e hipocolia fecal e a sua causa extra-hepática mais comum é a atresia de vias biliares (letra A correta). A causa tóxico-medicamentosa mais frequente nesta faixa etária está relacionada ao uso de nutrição parenteral (letra C correta). A incompatibilidade Rh ou ABO são causas de icterícia precoce, que envolve anemia hemolítica e aumento de bilirrubina INDIRETA (letra B incorreta). Resposta letra B.

232130.

Comentário: Questão clássica Bebê a termo, nascido de parto cesáreo, com taquipneia ao nascer, com radiografia evidenciando aumento de trama vascular é a história da taquipneia transitória. A taquipneia transitória do recém-nascido é caracterizada por um desconforto respiratório leve a moderado geralmente de evolução benigna, decorrente de retardo na absorção do líquido pulmonar após o nascimento. Com boa e rápida resolução (responde bem a baixa concentração de oxigênio e dura em média 48h a 72h para melhora). Situações em que a reabsorção do liquido pulmonar está prejudicada, como cesariana eletiva sem trabalho de parto, asfixia perinatal, diabetes e asma brônquica materna e policitemia, predispõem à ocorrência desta condição. A síndrome de aspiração

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

meconial ocorre em bebês pós-termo e o raio-x apresenta infiltrado grosseiro e difuso. Bebês com hipertensão pulmonar se apresentam com labilidade clínica e dessaturação ao mínimo manuseio. Como não há no enunciado nada que nos sugira quadro infeccioso e a bolsa foi rota no ato, não pensamos em pneumonia ou sepse neonatal. Gabarito correto Letra D.

232131.

Comentário: A questão traz um RN com icterícia nas primeiras 24 horas de vida, logo, uma icterícia patológica sendo inevítavel a investigação. Entre as as causas, a hemólise por incompatibilidade ABO ou RH são as principais. Neste caso, temos uma situação ABO, já que a mãe é O e o bebê é B . Por isso, temos que solicitar bilirrubina total e frações, Coombs direto, hematócrito ou hemoglobina, hematoscopia e reticulócitos. A principal suspeita é a incompatibilidade ABO e a conduta terapêutica (fototerapia, por exemplo) será definida após os resultados laboratoriais, dependendo dos níveis de bilirrubina. Resposta Letra B.

227101.

Comentário: Vamos avaliar as alternativas A) Correta. A síndrome clínica da sífilis congênita precoce surge até o 2 ano de vida e deve ser diagnosticada por meio de uma avaliação epidemiológica criteriosa da situação materna e de avaliações clínica, laboratorial e de estudos de imagem na criança. Além da prematuridade e do baixo peso ao nascimento, as principais características dessa síndrome são, excluídas outras causas hepatomegalia com ou sem esplenomegalia, lesões cutâneas (como por exemplo, pênfigo palmo-plantar, condiloma plano), periostite ou osteíte ou osteocondrite (com alterações características ao estudo radiológico), pseudoparalisia dos membros, sofrimento respiratório com ou sem pneumonia, rinite sero-sanguinolenta, icterícia, anemia e linfadenopatia generalizada (principalmente epitroclear). Outras características clínicas incluem petéquias, púrpura, fissura peribucal, síndrome nefrótica, hidropsia, edema, convulsão e meningite. B) Incorreta. A sífilis tardia se manifesta após o segundo ano de vida, e não mês. C) Correta. A sífilis congênita é o resultado da disseminação hematogênica do Treponema pallidum, da gestante infectada não-tratada ou inadequadamente tratada para o seu concepto, por via transplacentária. A suspeita diagnóstica de sífilis congênita precoce baseia-se

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

usualmente na sorologia materna, realizada de rotina no início da gestação, com frequência no terceiro trimestre e no parto. D) Correta. Justifica-se a realização da radiografia de ossos longos nos casos suspeitos de sífilis congênita tendo em vista que entre 4% a 20% dos recém-nascidos assintomáticos infectados, as imagens radiológicas representam a única alteração. Resposta letra B.

227316.

Comentário: A manutenção da temperatura corporal depende de um equilíbrio entre os mecanismos de produção e os de eliminação de calor. O recém-nascido pré-termo é especialmente vulnerável para o desenvolvimento de hipotermia por apresentar características que levam ao aumento da perda de calor e outros que diminuem a produção de calor. A hipotermia nesta população é preocupante, pois é fator de risco para pior prognóstico, aumentando a morbidade e a mortalidade neonatais. Diversas alterações podem ser observadas no quadro em seu material que aborda os cuidados com o recém-nascido pré-termo, o Ministério da Saúde cita as seguintes sucção débil, hipotonia, letargia, taquipneia ou apneia, taquicardia ou bradicardia, tremores, quedas na saturação de oxigênio, acidose, vasoconstrição, pele com coloração vermelho brilhante (falha na dissociação da oxihemoglobina), edema ou esclerema (devido alteração na permeabilidade capilar), diminuição da produção de surfactante e aumento do consumo de oxigênio, com depleção das reservas calóricas. Resposta letra D.

246796.

Comentário: A presença de colestase em um lactente deve levantar imediatamente a hipótese de atresia de vias biliares, condição grave que necessita de intervenção cirúrgica precoce (preferencialmente até a 8 semana de vida). A atresia das vias biliares extra-hepáticas, definida como ausência ou obliteração dos ductos biliares extra-hepáticos, representa a principal causa de insuficiência hepática com necessidade de transplante do órgão em crianças. Trata-se de uma patologia em que um dos sinais notado pelos familiares é a presença de fezes esbranquiçadas (pela colestase). Hepatoesplenomegalia e icterícia com predomínio de bilirrubina direta fazem parte do quadro. Ganho de peso adequado pode ocorrer. O que fala contra esse diagnóstico é a

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

presença de fezes coradas Resposta letra E.

199498.

Comentário: Vamos analisar as alternativas referentes a icterícia neonatal A) CORRETA O recém-nascido (RN) produz uma quantidade de bilirrubina muito maior que uma criança maior. Enquanto um escolar produz cerca de 3 a 4 mg kg de bilirrubina por dia, um RN normal produz de 6 a 8 mg kg por dia. Isso ocorre devido a um aumento da massa eritrocitária e de uma meia-vida menor dessas hemácias em comparação às crianças maiores. B) CORRETA O aleitamento materno está associado a um aumento na incidência de icterícia neonatal, tanto pela má alimentação do RN nos primeiros dias de vida (diminuição do trânsito intestinal), quanto pelo aumento da circulação êntero-hepática. C) CORRETA As doenças hemolíticas são as principais causas de icterícia precoce, ou seja, nas primeiras 24 horas de vida. As incompatibilidades Rh ou ABO são as mais comumentes associadas a este quadro. D) ERRADA As coleções sanguíneas extravasculares (ex cefalohematoma) ocasiona sobrecarga de bilirrubina pelo hepatócito, devido a degradação da hemoglobina presente na coleção sanguínea, sendo uma causa comum de hiperbilirrubinemia indireta. Devido a uma única palavra, a alternativa está incorreta. Resposta letra D.

202730.

Comentário: A adrenalina está indicada quando a ventilação adequada e a massagem cardíaca efetiva não levaram à elevação da FC para valores 60 bpm. A adrenalina aumenta a pressão de perfusão coronariana, principalmente por meio da vasoconstrição periférica. Recomenda-se sua administração por via endovenosa. Enquanto o cateterismo venoso umbilical está sendo realizado, pode-se administrar uma única dose de adrenalina (0,05-0,10 mg kg) por via traqueal, mas sua eficácia é questionável. Caso utilizada a via traqueal, se não houver aumento imediato da FC, administrar a adrenalina endovenosa. Esta é aplicada na dose de 0,01-0,03 mg kg - o que significa dizer que a dose é de 0,1 a 0,3 mL kg. Doses elevadas (0,1 mg kg) não devem ser empregadas no período neonatal, pois levam à hipertensão arterial grave, diminuição da função miocárdica e piora do quadro neurológico. Embora em outros países existam seringas de adrenalina prontas para uso

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

na diluição 1 10.000, em nosso meio a adrenalina disponível apresenta-se em ampolas na diluição de 1 1.000. Desse modo, até o momento, é obrigatório preparar a adrenalina na diluição de 1 10.000 em soro fisiológico, para aplicação na reanimação neonatal. Quando não há reversão da bradicardia com a adrenalina endovenosa, assegurar que a VPP e a massagem cardíaca estão adequadas, repetir a administração de adrenalina a cada 3-5 minutos (sempre por via endovenosa, na dose 0,03 mg kg) e considerar o uso do expansor de volume. Resposta letra D.

202751.

Comentário: Questão interessante Fique atendo a pergunta...qual dos achados DETERMINA a escolha do tratamento. O que isso quer dizer Simplesmente que, na presença de um achado específico, a opção terapêutica já estará automaticamente definida. E sabemos que qualquer alteração liquórica (proteína 150 mg dL ou VDRL no líquor reagente ou celularidade 25 células mm 3) torna obrigatoriamente a penicilina G cristalina como a única opção de tratamento, por via endovenosa e com duração de 10 dias. Se o líquor fosse absolutamente normal, mas a criança apresentasse qualquer alteração clínica e ou sorológicas e ou radiológicas e ou hematológicas e que não apresentam alterações liquóricas, o tratamento poderá ser realizado tanto com a penicilina G cristalina quanto a penicilina G procaína. Entendeu a diferença Resposta letra C.

202756.

Comentário: Diversas infecções congênitas cursam com baixo peso, anemia e hepatoesplenomegalia, sendo estas manifestações bastante inespecíficas. No entanto, os outros demais achados representam, junto com as calcificações intracranianas, a chamada tríade clássica de Sabin, que representam as manifestações clínicas específicas da toxoplasmose congênita. Vale lembrar que a coriorretinite é o comprometimento clássifo mais frequente, bilateral em até 80% dos casos. Já as calcificações intracranianas elas apresentam um padrão grosseiro, difuso, diferentemente de outras patologias que apresentam distribuição mais específica, como as calficicações periventriulares da infecção congênita pelo citomegalovírus. Resposta letra B.

202774.

Comentário: Perceba que além do parceiro não ter sido tratado, o tratamento foi iniciado dentro dos

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

30 dias que antecedem o parto. Logo, definimos que o tratamento para sífilis durante a gestação foi INADEQUADO. Diante disso, temos que solicitar para a criança hemograma, VDRL, radiografia de ossos longos, punção lombar e iniciar o tratamento penicilínico. A escolha da penicilina vai variar de acordo com as alterações encontradas nos exames. Resposta letra C.

199597.

Comentário: Logo após o nascimento, deve ser feita a avaliação de três parâmetros, que irão determinar se o recém-nascido deve ser conduzido à mesa de reanimação ou poderá permanecer junto à mãe. Tais parâmetros são avaliados por três perguntas gestação a termo Respirando ou chorando Tônus muscular em flexão O aspecto do líquido amniótico não é mais usado para determinar a necessidade de manobras diferenciadas. Quando respondemos sim às três perguntas citadas, ainda que a criança esteja banhada em líquido meconial, poderá ser submetida ao clampeamento tardio do cordão e permanecer no colo materno. Resposta letra A.

199616.

Comentário: A questão aborda a triagem neonatal para cardiopatias congênitas críticas, o popular teste do coraçãozinho. A recomendação é de que o teste seja feito entre 24 e 48 horas de vida da seguinte forma realiza-se a aferição da oximetria no membro superior direito (para avaliação da saturação pré-ductal) e em algum dos membros inferiores (para avaliação da saturação pós-ductal). Considera-se normal quando ambas as medidas são maiores ou iguais a 95% e quando a diferença entre elas é menor que 3%. Quando o teste estiver alterado, a primeira conduta é a repetição do mesmo uma hora depois. Quando há confirmação da alteração, um ecocardiograma deve ser realizado em até 24 horas. No caso descrito, temos a descrição de uma saturação de 92% e a resposta original da banca havia sido a letra C, porém, tal afirmativa está incompleta a banca omitiu os valores que devem ser observados na saturação e, deste modo, a questão foi anulada.

196757.

Comentário: Questão simples e direta sobre sífilis congênita. Um ponto importante para considerar um tratamento materno adequado para sífilis, é a documentação de queda do título do teste não treponêmico em pelo menos duas diluições em três meses ou de quatro diluições em seis meses,

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

após a conclusão do tratamento, o que significa uma resposta imunológica adequada. Sendo assim, essa gestante deveria apresentar um título de VDRL de, no mínimo, 1 16 no último trimestre, o que não aconteceu. Desta forma, consideramos um tratamento inadequado e o recém-nascido deverá ser obrigatoriamente submetido à realização dos seguintes exames VDRL do sangue periférico, hemograma completo, radiografia de ossos longos e análise liquórica. Além disso, alguma forma de tratamento deverá ser instituída. Resposta letra A.

196767.

Comentário: Questão clássica de prova. Quando temos não como resposta à qualquer uma das perguntas feitas após o nascimento (a termo chorando ou respirando tônus em flexão), devemos solicitar o clampeamento imediato do cordão umbilical, levar o recém-nascido à mesa de reanimação e iniciar os passos iniciais, lembra deles Os passos são aquecer, posicionar a cabeça com leve extensão do pescoço, aspirar vias aéreas (primeiro a boca e depois as narinas), se necessário, secar e desprezar campos úmidos. Tudo isso é feito em 30 segundos. Em seguida, devemos avaliar a frequência cardíaca e a respiração. Resposta letra B.

196814.

Comentário: Questão com duas respostas, pois a varicela congênita pode se apresentar tanto com catarata, como com microcefalia. A síndrome congênita é caracterizada por cicatrizes cutâneas com distribuição tipo herpes-zóster, hipoplasia de membros e anormalidades no sistema neurológico (ex microcefalia, atrofia cortical, convulsões e retardo mental), nos olhos (ex coriorretinite, microftalmia e catarata), no sistema renal (ex hidroureter e hidronefrose) e no sistema nervoso autônomo (bexiga neurogênica, disfunção da deglutição e pneumonia por aspiração). Esta questão deveria ter sido anulada, mas a banca liberou o gabarito como letra A.

215148.

Comentário: O início do uso da via enteral deve ser o mais precoce possível, usando o que se chama dieta enteral mínima ou dieta trófica. O início da dieta por via enteral deve ser postergado se o Recém-Nascido (RN) estiver hipotenso, necessitando de doses crescentes de drogas vasoativas ou muito acidótico, que não se aplica ao caso em tela. Logo, eliminamos a alternativa B por ora.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

Com relação ao alimento, a primeira escolha deve ser sempre o leite da própria mãe. Na falta dele, a segunda opção é o leite de doadoras obtido em bancos de leite humano, uma vez que esse leite precisa ser pasteurizado e passar por controle de qualidade adequado. Neste momento, eliminamos as alternativas A e C. Dando continuidade, independente se leite da própria mãe ou de banco de leite, ambos precisam ser fortificados com aditivos multicomponentes assim que o volume recebido passar de 100 ml kg dia, com boa tolerância. Se o RN apresentar crescimento inadequado, a fórmula própria para pré-termo pode ser introduzida em algumas dietas. Logo, entre as alternativas que restaram, a letra D é a resposta mais adequada para a questão, visto que as adições para fortificar o leite só será realizada quando o RN estiver recebendo um maior volume de dieta, o que não se aplica neste momento. Resposta letra D.

187504.

Comentário: Estamos diante de um recém-nascido a termo, com bom peso ao nascimento e em aleitamento materno exclusivo. Durante o exame físico você observa uma criança em excelente estado geral, sem qualquer anormalidade. O que fazer Praticamente nada Essa criança não apresenta fatores de risco para o desenvolvimento de hipoglicemia após o nascimento, ou seja, devemos apenas incentivar o aleitamento materno exclusivo. Resposta correta letra E.

174362.

Comentário: Antes de iniciar a sequência de reanimação neonatal para esse prematuro, lembre-se que a temperatura corporal na admissão é um forte preditor de morbidade e mortalidade, sobretudo em recém-nascidos (RN) pré-termos. A presença de temperatura corporal 36,0ºC na admissão é fator independente de risco para mortalidade e morbidade por agravar ou favorecer distúrbios metabólicos, desconforto respiratório, enterocolite necrosante e hemorragia intracraniana em RN 34 semanas. Por isso, devemos garantir a temperatura ambiente na sala de parto entre 23 - 26ºC. Se recapitularmos o fluxograma de reanimação neonatal, vamos nos lembrar de que, logo após o nascimento, devemos avaliar se o recém-nascido é a termo, se está respirando e ou chorando, e se tem bom tônus. Quando pelo menos um desses parâmetros estiverem ausentes, recomenda-se o clampeamento imediato do cordão e o recém-nascido será levado à mesa de reanimação (sob

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

fonte de calor radiante) para início dos passos iniciais (aquecer, posicionar, aspirar se necessário e secar). Tudo isso é feito em 30 segundos. O grande detalhe é que, em recém-nascidos abaixo de 34 semanas, logo depois de posicioná-lo sob fonte de calor radiante sem secá-lo, devemos introduzir o corpo, exceto a face, dentro do saco plástico e, a seguir, realizar as manobras necessárias. O saco plástico só será retirado depois da estabilização térmica na unidade neonatal. Tal prática deve ser suplementada pelo emprego de touca dupla para reduzir a perda de calor na região da fontanela cobrir o couro cabeludo com plástico e, por cima, colocar touca de lã ou algodão. Gabarito letra C.

174370.

Comentário: A questão apresenta um recém-nascido (RN) prematuro tardio, com baixo peso ao nascer e que não apresenta necessidade de ser reanimado, pois a frequência cardíaca está acima de 100 bpm e a respiração está regular. Logo, o que esse RN tem Um desconforto respiratório precoce, que pode ser somente uma taquipnéia transitória como outra patologia relacionada. A conduta inicial nesses casos é dar conforto ao RN, evitando que ele aumente o esforço respiratório. Para tal, a conduta mais indicada é o uso do CPAP, que pode ser feito por meio de máscara facial conectada ao circuito de ventilação manual em T. Resposta letra A.

187509.

Comentário: A hemorragia peri-ventricular é uma afecção neurológica que acomete sobretudo os prematuros, com risco inversamente proporcional à idade gestacional. O sangramento ocorre na matriz germinativa subependimária, na junção entre o núcleo caudado e o tálamo. O diagnóstico é feito através da USG transfontanela, realizada rotineiramente na primeira semana de vida em recém-nascidos com peso inferior a 1500 gramas ou idade gestacional inferior a 32 semanas ou idade gestacional superior a 32 semanas com fatores de risco. Resposta correta letra B.

187511.

Comentário: Sabemos que existem várias formas de avaliar a frequência cardíaca durante a reanimação neonatal palpação do cordão umbilical, ausculta do precórdio com o estetoscópio, oximetria de pulso e monitor cardíaco. A palpação do cordão umbilical e a ausculta do precórdio

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

com o estetoscópio subestimam a frequência cardíaca. A oximetria de pulso detecta de forma contínua a frequência de pulso, mas demora para detectá-la e, automaticamente, também subestima a FC. Já o monitor cardíaco permite a detecção acurada, rápida e contínua da FC, sendo então o melhor método para se avaliar a FC do recém-nascido nos primeiros minutos de vida. Resposta correta letra D.

174356.

Comentário: O enunciado apresenta um recém-nascido a termo com icterícia precoce (antes das primeiras 24 horas de vida), isto é, característica de icterícia patológica. Os principais diagnósticos diferenciais que devemos estabelecer para os quadros de icterícia precoce são as doenças hemolíticas, sejam hereditárias ou autoimunes. Portanto, nesses casos devemos solicitar bilirrubina total e frações (direta ou indireta) tipagem sanguínea (avaliar as incompatibilidades por grupos) Coombs direto do recém-nascido (a fim de avaliar a presença de anticorpos ligados à superfície das hemácias) e coombs indireto da mãe hematócrito ou hemoglobina (anemia) hematoscopia (esferócitos no sangue periférico Esferocitose hereditária ou Incompatibilidade ABO) e contagem de reticulócitos . O tratamento nesse caso não vai incluir suplementação com leite humano do banco de leite ou fórmula infantil, e sim fototerapia. Logo, gabarito letra E.

174361.

Comentário: O manejo do recém-nascido com suspeita de sífilis congênita é baseado no tratamento prévio materno. Diante de uma mãe que sabidamente apresentou VDRL positivo na gestação e que não tenha sido tratada, devemos considerar que o RN apresenta alta possibilidade de ter contraído a doença. Nesses casos, independente da sua condição clínica e laboratorial (VDRL) atual, o menor deverá ser tratado. Resposta letra C.

188028.

Comentário: Relembrando o fluxograma de reanimação neonatal, sabemos que, se após os passos iniciais, a criança apresentar uma frequência cardíaca menor que 100 bpm, respiração irregular e ou apneia, devemos iniciar a ventilação com pressão positiva por 30 segundos. Resposta correta letra C.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

172813.

Comentário: O enunciado apresenta um lactente de 2 meses com uma possível infecção congênita, caracterizada por sinais gerais (palidez e baixo ganho ponderal), comprometimento visceral (adenomegalias, hepatomegalia e esplenomegalia), e possível comprometimento ósseo, indicado pelo relato de dor ao manuseio. Esta última característica é bastante sugestiva do diagnóstico de sífilis congênita. A dor relacionada com a movimentação pode levar ao choro durante o manuseio e também à pseudoparalisia de Parrot. Resposta letra B.

172750.

Comentário: Se após os passos iniciais, a criança apresenta-se com frequência cardíaca menor que 100 bpm, respiração irregular ou apneia, devemos iniciar a ventilação com pressão positiva durante 30 segundos. Quando não há melhora, deve-se checar a técnica e considerar a intubação quando as medidas são ineficazes. As compressões torácicas estão recomendadas quando a criança já tiver sido intubada e ventilada durante 30 segundos pela cânula com oxigênio suplementar (não se esqueça de que a ventilação é a intervenção mais importante de toda a reanimação). Logo, gabarito letra D.

172556.

Comentário: O índice Apgar é um escore de avaliação da vitalidade neonatal precoce, desenvolvido para avaliar os neonatos que necessitam de reanimação e para avaliar sobrevida. É muito importante lembrar que o cálculo desse índice não deve adiar o início das manobras de reanimação, que devem ser iniciadas precocemente, e o cálculo deve ser feito após a estabilização do paciente, retrospectivamente. São cinco os parâmetros clínicos para a confecção do índice respiração, frequencia cardíaca, cor, resposta a estímulos e tônus, e cada um deles recebe uma pontuação variando entre 0, 1 e 2- mínima total de 0, máxima de 10. Deve-se calcular o Apgar no 1º e 5º minutos de vida e, se menor ou igual a 6, o escore deve continuar a ser calculado com intervalos de 5 minutos até que se obtenha nota maior ou igual a 7. No RN em questão, temos no 1º minuto Choro forte 2 Frequência cardíaca 100 bpm 2 Movimentos ativos 2 Tonus (que não foi descrito, mas podemos entender como normal) 2 Cianose de central 0 Assim, seu Apgar no 1º

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

minuto foi 8. No 5º minuto, o relato é de que houve apenas cianose nas extremidades (1 ponto), restante normal. Assim, o Apgar no 5º minuto é de 9 (perde-se apenas 1 ponto do total de 10 pela cianose de extremidades). Resposta letra A.

149130.

Comentário: Questão do tipo Sem noção pois descreve diversos detalhes com datas e números em relação ao vírus Zika. Nesse tipo de questão o aluno deve manter a calma e procurar algum dado que ele tenha certeza para acertar a questão (nessa, o dado de fácil conhecimento é a relação entre o vírus Zika e a microcefalia). Contudo, vamos analisar um trecho de um texto de 2 de julho de 2016 da Organização Mundial da Saúde que nos descreve alguns dos detalhes citados na questão O vírus Zika é um flavivírus transmitido por mosquitos e foi, pela primeira vez, identificado em macacos, no Uganda, em 1947, através de uma rede que monitorizava a febre amarela. Foi mais tarde identificado em humanos, em 1952, no Uganda e na República Unida da Tanzânia. Foram registados surtos da doença do vírus Zika em África, nas Américas, na Ásia e no Pacífico. Entre os anos 1960 e os anos 1980, foram encontradas infecções humanas em África e na Ásia, normalmente acompanhadas de doença ligeira. O primeiro grande surto da doença causado pela infecção por Zika foi notificada na ilha de Yap (Estados Federados da Micronésia), em 2007. Em Julho de 2015, o Brasil notificou uma associação entre a infecção pelo vírus Zika e a síndrome de Guillain-Barré. Em Outubro de 2015, o Brasil notificou uma associação entre a infecção pelo vírus Zika e a microcefalia. Outro trecho nos diz Depois de uma análise exaustiva das evidências, existe um consenso científico de que o vírus Zika é causa de microcefalia e síndrome de Guillain-Barré. Continuam a ser feitos intensos esforços para investigar a ligação entre o vírus Zika e vários distúrbios neurológicos, no quadro de uma investigação rigorosa. Perceba que segundo esse último trecho podemos afirmar que existe um consenso e NÃO apenas uma forte suspeita que o vírus Zika causa microcefalia. Esse dado, o aluno deve conhecer Portanto, a alternativa incorreta é a letra C.

155444.

Comentário: Estamos diante de um recém-nascido que se apresenta ictérico ainda nas primeiras 24 horas de vida. Devemos pensar, inicialmente, na possibilidade de uma doença hemolítica. As

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

causas mais comuns de hemólise nas primeiras horas de vida são os quadros de incompatibilidade materno-fetal (incompatibilidade ABO ou Rh). Comparando o tipo sanguíneo e o fator Rh da mãe e do recém-nascido, observamos que poderia haver tanto uma incompatibilidade Rh quanto uma incompatibilidade ABO. Um erro grave da banca foi não nos dar informações sobre o teste de Coombs indireto materno (lembre-se de que na incompatibilidade RH, a mulher deve ser Rh negativo e ter o Coombs indireto positivo, o que indica que houve a sensibilização prévia), porém, ainda assim, podemos chegar ao diagnóstico. Os quadros de incompatibilidade Rh sempre irão cursar com um teste de Coombs direto positivo no recém-nascido. Por mais que o teste de Coombs direto indique a presença de anticorpos na superfície das hemácias, nem sempre estará positivo nas incompatibilidades ABO. Além disso, na incompatibilidade Rh os quadros costumam ser mais graves e há descrição de outras manifestações associadas, como palidez ou taquicardia, ausentes nesta história. Resposta letra B

148577.

Comentário: O escore de Apgar é uma medida da vitalidade neonatal, com base em parâmetros clínicos como respiração, frequência cardíaca, presença de tônus, cor e responsividade, avaliados no primeiro e quinto minutos de vida. Um Apgar menor que 6 no primeiro minuto sugere a necessidade de ressuscitação, porém vale lembrar que este método não deve ser usado para indicar a reanimação neonatal, mas sim a frequência cardíaca abaixo de 100 bpm e ou a ausência de choro respiração. O Apgar não é um bom preditor de prognóstico para sequelas neurológicas e não é usado para estimar a idade gestacional, sendo o método de Capurro ou escore de Ballard utilizados para este fim. Resposta letra C.

148587.

Comentário: Os Recém-Nascidos (RN) de alto risco são definidos como aqueles que apresentam uma possibilidade maior de complicações precoces, tais como hipoglicemia, sepse ou distúrbios hidroeletrolíticos e metabólicos, que podem acometer nas primeiras 48 horas de vida. Sabendo as complicações esperadas, fica mais fácil definir quais são tais RNs de risco. Incluem todo RN pequeno (PIG) e grande (GIG) para a idade gestacional, assim como todo RN pré-termo (37

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

semanas) ou pós-termo (42 semanas). Também entram todo RN com baixo peso ao nascer (peso ao nascimento 2.500 gramas) e todo RN com peso ao nascimento 4.000 gramas. Logo, perceba que o oposto de um fator de risco não é necessariamente um fator de proteção, conforme descrito em diversas alternativas. Resposta letra D.

149131.

Comentário: Estamos diante de um RN a termo com icterícia tardia as custas de hiperbilirrubinemia indireta. Sabemos que as doenças hemolíticas imunes (incompatibilidade Rh ou ABO) normalmente se manifestam precocemente, assim como a icterícia fisiológica, que normalmente surge entre o segundo e terceiro dias de vida e desaparece até o quinto dia. A atresia de vias biliares é uma causa clássica de icterícia por aumento de bilirrubina direta, o que automaticamente já descartamos. Logo, a únicas hipóteses que restaram entre as listadas são a icterícia do leite materno, associada a substâncias do próprio leite e a criança persiste com icterícia a partir da segunda semana de vida, assim como o hipotireoidismo, que associa-se a níveis de Hematócrito baixo ou normal, como foi apresentado. Resposta letra B.

148551.

Comentário: Questão simples e direta A Doença das Membranas Hialinas apresenta como principal fator de risco a prematuridade, pois somente após 34 semanas de gestação é quando o recém-nascido apresentará quantidade suficiente de surfactante no organismo. Logo, a grande maioria dos recém-nascidos prematuros apresentarão a patologia. Vale ressaltar também que a profilaxia materna com corticóide é um fator de proteção para o desenvolvimento da doença, assim como doença hipertensiva materna e ruptura prematura de membranas, pois tais situações aceleram a maturação pulmonar. A gestação múltipla é um fator de risco para prematuridade e, por consequência, para o desenvolvimento da doença. Resposta letra E.

148584.

Comentário: A questão apresenta 3 situações para analisar se podem ser ou não causas de icterícia na infância. A sepse neonatal pode ser uma causa de hiperbilirrubinemia indireta assim como o aleitamento materno, este último relacionado a má alimentação da criança com diminuição

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

do trânsito intestinal e aumento da circulação êntero-hepática. A Colescistite Aguda, em alguns casos, pode apresentar icterícia causada por edema do ducto colédoco contíguo ou, mais provavelmente, por cálculos no colédoco. Logo, todas as assertativas estão corretas. Resposta letra C.

148592.

Comentário: Questão conceitual sobre transmissão vertical do HIV... Vale a pena revisar o tema A - O risco da transmissão vertical continua por meio da amamentação, mesmo quando a mulher está em uso de TARV. Além disso, cabe ressaltar que o aleitamento cruzado, o aleitamento misto e o uso de leite humano com pasteurização domiciliar são terminantemente contraindicados. Certa. B - Todo RN exposto deve iniciar a primeira dose do AZT solução oral, preferencialmente, ainda na sala de parto, logo após os cuidados imediatos, ou nas primeiras quatro horas após o nascimento. E em expostos ao HIV cujas mães não fizeram uso de ARV durante o pré-natal ou não tem carga viral menor que 1.000 cópias mL documentada no último trimestre de gestação, acrescentar nevirapina ao esquema da profilaxia, com início o mais precoce possível, nas primeiras 48 horas de vida. Certa C - E em caso de confirmação da infecção nos menores de 12 meses, a TARV se inicia imediatamente. Entre 12 meses e 4 anos de vida, recomenda-se iniciar a TARV em situações determinadas 1) pacientes sintomáticos, classificados nas categorias B do CDC (exceto aqueles com um único episódio de pneumonia bacteriana) ou C 2) paciente com percentual de LT-CD4 25% OU 3) pacientes com carga viral 100.000 cps ml. Certa D - Nesse caso a sorologia após os 12 meses de idade é solicitada apenas para documentar a soronegatividade para o HIV. Certa. E - Em mulheres com carga viral desconhecida ou maior que 1.000 cópias mL após 34 semanas de gestação, a cesérea eletiva na 38a semana de gestação diminui o risco de transmissão vertical. Resposta E.

162536.

Comentário: Os principais fatores de risco da retinopatia da prematuridade são prematuridade, baixo peso e exposição prolongada a altos níveis de oxigênio, que é o grande vilão deste enredo patológico, cuja a ação deletéria é provavelmente mediada pela atuação de radicais livreis. Além

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

disso, outras condições de estresse orgânico também contribuem para a instalação da doença, como desconforto respiratório, apneia, hipotensão, bradicardia, hipercarbia, acidose, infecção, anemia e necessidade de transfusão sanguínea. Logo, gabarito letra C.

162543.

Comentário: Mesmo o enunciado não narrando o momento do início da icterícia, com uma história de icterícia a 25 dias, isso não é mais uma icterícia fisiológica. E diante disso devemos inicialmente avalair se a icterícia se faz à custa de bilirrubina direta ou indireta. Note que a presença de colúria e acolia fala a favor de colestase, aumento de bilirrubina direta. Diante de uma colestase neonatal, obrigatoriamente devemos pensar em atresia de vias biliares. Ao nascer, o RN desenvolve fibrose das vias biliares e consequentemente colestase e geralmente não encontramos outros comemorativos, como foi apresentado no enunciado. Gabarito B.

155423.

Comentário: Vamos analisar as alternativas no que se refere à avaliação genético-clínica do recém-nascido, segundo a diretriz brasileira A) Correta O exame físico com a descrição pormenorizada do fenótipo morfológico (exame genético-clínico) e, quando necessário, a documentação fotográfica, fornecem a informação mais importante para a definição diagnóstica, associado a história familiar, já que a maioria dos quadros dismórficos são de diagnóstico clínico. B) Correta As anomalias maiores são aquelas sendo de reconhecimento óbvio quando externas e de fácil diagnóstico com métodos de imagem quando internas. O recém-nascido com pelo menos três malformações maiores e associadas ou não a defeitos menores, caracterizam as síndromes malformativas. C) Correta Tal alteração pode ser encontrada na população normal. D) Correta As anomalias menores são aquelas comuns a diversas doenças genéticas como também podem ser encontradas na população normal. A presença de três anomalias menores indica a pesquisa de anomalias maiores. E) Errado O cariótipo faz parte dos exames de triagem das síndrome malformativas, porém não é essencial na maioria delas, visto que as anomalias cromossômicas correspondem a um pequeno número de casos. Resposta letra E.

155424.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

Comentário: Segundo o Ministério da Saúde, caso a resposta do recém-nascido não seja satisfatória no teste da emissão otoacústica (testa da orelhinha), o neonato deverá retornar reteste) no período de 30 dias para nova avaliação. Lembrar que caso o primeiro teste não seja feito logo após nascimento, o reteste deverá ser repetido antes dos 3 meses de idade. Resposta letra B.

162515.

Comentário: A questão pergunta qual é a afirmativa errada sobre citomegalovírus na gravidez. O rastreamento durante o pré-natal não está indicado pois não há intervenção eficaz. A maior parte das pacientes infectadas, seja na primoinfecção ou recorrência, são assintomáticas. A transmissão pode ocorrer durante a gestação, o parto ou mesmo durante a amamentação. A letra D não entra no questionamento se há ou não indicação de amamentar, apenas afirma que a transmissão vertical pode ocorrer neste momento. Logo, ela é verdadeira. Já a afirmativa E está errada, pois não há contraindicação contra a amamentação para as mulheres com CMV, mesmo que ele seja agudo, pois a infecção transmitida por essa via não causa doença significativa. Esta é a única afirmativa errada. Resposta letra E.

155341.

Comentário: Vamos à análise de cada alternativa A) Certa Pode ser transmitida ao feto em qualquer estágio da gravidez. No entanto, a maior gravidade ocorre quando a transmissão se dá em fases iniciais da gestação, ao passo que a maior probabilidade de contaminação é no último trimestre. B) Errada Existem formas graves, porém estas correspondem a uma parcela mínima (1-2%) dos infectados. Chama-se doença de inclusão citomegálica e caracteriza-se por icterícia, hepatoesplenomegalia, petéquias, microcefalia, coriorretinite e calcificações cerebrais periventriculares, além de outros sinais e sintomas que podem estar presentes. C) Errada A sífilis pode ser transmitida ao concepto em qualquer estágio clínico da doença ou em qualquer idade gestacional. A transmissão do agente se dá através da via transplacentária ou da contaminação do bebê durante sua saída pelo canal de parto. D) Errada Na presença de infecção fetal, o vírus pode ser excretado pela urina do recém-nascido até 1 ano de idade ou mais, necessitando de isolamento para evitar contaminação na maternidade. E) Errada A infecção adquirida após o quarto mês de

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

gestação, em geral, não se encontra associada a malformações fetais e nem à persistência do vírus. Sendo assim, o risco é maior nos estágios iniciais da gestação. Resposta letra A.

155351.

Comentário: Questão simples e direta Segundo o Ministério da Saúde, considera-se como adequado o tratamento da sífilis na gestante quando instituído dentro do prazo de 30 dias anteriores ao parto. É muito importante esta definição, pois o manejo do recém-nascido levará em consideração se o tratamento materno foi adequado ou não. Resposta letra B.

137808.

Comentário: A questão descreve, tão somente, os passos iniciais da reanimação neonatal. Os recém-nascidos hipotônicos ou em apneia devem ser submetidos ao clampeamento imediato do cordão umbilical e aos quatro passos iniciais, que são prover calor, posicionar a cabeça em leve extensão, aspirar as vias aéreas (se necessário) e secar. Lembre-se de que tais passos devem ser realizados em até 30 segundos. Após os mesmos, faz-se a avaliação da frequência cardíaca (pela ausculta do precórdio) e da respiração a partir da avaliação desses parâmetros, as condutas subsequentes serão decididas. Resposta letra C.

137823.

Comentário: Sobre a Icterícia temos as seguintes associações 1) O hipotireoidismo congênito pode se apresentar no neonato através de uma icterícia persistente e de difícil resolução. (1C) 2) A icterícia fisiológica é aquela que se inicia apenas após as primeiras 24 horas de vida, não relacionada a outros achados como colúria ou acolia fecal. (2E) 3) Na atresia de vias biliares é característico a presença de colúria, acolia fecal e icterícia com elevação importante de bilirrubina direta. (3A) 4) Nos casos de incompatibilidade ABO e Rh, podemos observar icterícia patológica, que se inicia precocemente (nas primeiras 24 horas de vida). (4B) 5) A icterícia do leite materno se trata da forma tardia de icterícia relacionada ao leite materno. (5D) Resposta letra B.

137815.

Comentário: A banca já nos informou de que esta criança tem o diagnóstico comprovado de toxoplasmose congênita e não podemos nos esquecer do seguinte conceito todo recém-nascido

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

com toxoplasmose congênita confirmada deve receber tratamento durante 12 meses, independentemente da sintomatologia. O tratamento é feito com pirimetamina, sulfadiazina e ácido folínico. Nos casos em que há retinocoroidite em atividade, como no caso descrito, ou proteinorraquia acima de 1.000 mg dl, associa-se corticoterapia até melhora do processo inflamatório. Resposta letra C.

137840.

Comentário: O Teste do Coraçãozinho consiste basicamente em uma oximetria de pulso, na qual deve ser aferida e comparada a saturação de oxigênio entre a mão direita e os pés, avaliando diferença nesta aferição. É um dos exames obrigatórios de triagem neonatal e deve ser realizado ainda na maternidade, antes da alta do recém-nascido. Permite a suspeição e o diagnóstico precoce de cardiopatias congênitas graves. Caso seja observada qualquer saturação abaixo de 95% ou diferença de 3% ou mais entre as duas medidas, a oximetria precisa ser reavaliada em uma hora. Caso permaneça um destes achados, o bebê não deve ter alta antes de realizar ecocardiograma. Resposta letra A.

126894.

Comentário: A questão se refere ao Teste do Pezinho. Vamos avaliar cada alternativa A Incorreta . O momento ideal para a coleta deste teste de triagem neonatal é entre o 3º e o 7º dia de vida, nunca antes de 48h de amamentação e nunca depois de 30 dias. B Correta . Através da dosagem de TSH faz-se a pesquisa de hipotireoidismo congênito. C Correta . Para a pesquisa de fibrose cística, faz-se a medida de tripsina imunorreativa em sangue do papel filtro. D Correta . A pesquisa de hiperplasia adrenal congênita é feita pela dosagem da 17-OH-progesterona no sangue do papel filtro. Resposta Letra A .

126918.

Comentário: Na ausência de gráfico para melhor avaliação, temos que ter em mente algumas estimativas. Crianças a termo com peso inferior a 2,5kg são PIG e com peso acima de 4,0kg são GIG. O percentil 50 para perímetro cefálico e estatura para a termos é cerca de 35cm e 50cm, respectivamente. Logo, temos uma criança AIG com estatura e perímetro cefálico normais.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

Resposta Letra D .

131652.

Comentário: Sobre as recomendações para Reanimação Neonatal em sala de parto temos A) Recém-nascido (RN) a termo, vigoroso e sem líquido amniótico meconial, não necessita de nenhuma manobra de reanimação e pode ser colocado imediatamente em contato pele a pele com a mãe logo após o nascimento. CORRETA. B) Para um RN a termo, saudável e com boa vitalidade ao nascer pode ser realizado o clampeamento tardio do cordão umbilical, que reduzirá o risco futuro de anemia do lactente. CORRETA. C) Logo após o clampeamento imediato do cordão, o RN com peso inferior a 1500 gramas é recepcionado em campos aquecidos, colocado sob calor radiante, e envolvido em filme plástico transparente de polietileno sem ser secado, com o intuito de reduzir ao máximo a perda de calor. CORRETA. D) A característica do mecônio não influencia as manobras a serem realizadas. Seja o mecônio espesso ou fluido, caso o RN nasça deprimido, deve ter o mecônio retirado da hipofaringe e traqueia sob visualização direta através de cânula traqueal acoplada a dispositivo de aspiração específico. INCORRETA. E) A avaliação da coloração da pele e mucosas do RN não é mais utilizada para decidir procedimentos na sala de parto, pois trata-se de parâmetros subjetivos, que não se correlacionam com a saturação de oxigênio. CORRETA. Resposta letra D.

131654.

Comentário: A questão nos fornece um recém-nascido com sinais clínicos de sepse neonatal precoce pneumonia neonatal febre, hipoatividade, taquipneia, desconforto respiratório. A sepse neonatal precoce consiste naquela que ocorre nos primeiros sete dias, mais comumente nas primeiras 48 horas de vida e está relacionada à infecção por germes da flora genital materna, ocorrida de forma ascendente ou durante o parto vaginal. O germe mais comumente envolvido é o estreptococo beta hemolítico do grupo B, Streptococcus agalactiae . Resposta letra E.

131656.

Comentário: O teste do reflexo vermelho é um teste de triagem neonatal que deve ser feito em todos os recém-nascidos. É simples, feito com oftalmoscópio em ambiente escuro, pelo próprio

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

pediatra. É uma triagem para detecção de anormalidades grosseiras do segmento posterior do olho, como pontos pretos, leucocoria ou assimetria. A leucocoria pode ocorrer em doenças como catarata, retinoblastoma, retinopatia da prematuridade e coriorretinite. Um teste alterado indica a necessidade de avaliação por especialista. A Academia Americana de Pediatria recomenda a realização do reflexo vermelho periodicamente em todas as crianças de 0 a 2 anos de idade. Resposta Letra D .

126927.

Comentário: No exame para Toxoplasmose no primeiro trimestre de gestação temos IgM e IgG negativos, o que significa que a gestante nunca teve contato com o Toxoplasma gondii. Porém, no terceiro trimestre de gestação temos tanto IgM quanto IgG positivos, logo, temos soroconversão gestacional, o que comprova a infecção durante o período gestacional. Portanto, não é necessário solicitar o teste de avidez. E é importante lembrar que no final da gestação a probabilidade de transmissão é maior, porém a gravidade da infecção é menor. Resposta correta Letra B .

131659.

Comentário: As principais características de uma Crise Convulsiva Febril Simples ou Típica são -Mais comum entre 6 meses e 5 anos de idade -Ocorre com temperaturas de 38 C ou mais -Crises tônico-clônicas generalizadas -Duração de menos de 15 minutos -Sem sintomas pós-ictais, apenas sonolência discreta -Crise única em 24 horas -Ausência de danos neurológicos a longo prazo. Resposta letra A.

131660.

Comentário: Em crianças muito jovens, como os recém-nascidos, muitas vezes não se observa os sinais clássicos de irritação meníngea, como rigidez de nuca e os sinais de Kernig e Brudzinski. Podem estar presentes outras alterações que nos devem fazer suspeitar do quadro alternância de irritabilidade e letargia, crises convulsivas, tremores de extremidades, dificuldade na amamentação, febre, hipotonia, taquipneia, desconforto respiratório dentre outros. Resposta letra C.

127162.

Comentário: As crianças nascidas a termo, com tônus adequado e que estejam respirando

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

chorando podem ser submetidas ao clampeamento tardio do cordão e permanecerem junto ao colo materno. Porém, quando algum desses parâmetros não estiver presente, o recém-nascido deve ser conduzido à mesa de reanimação. Os primeiros passos são chamados de passos iniciais e devem ser realizados na seguinte ordem prover calor, posicionar a cabeça (com uma leve extensão), aspirar as vias aéreas se houver necessidade (primeiro a boca e depois as narinas), e secar. Todos esses passos devem ser executados em, no máximo, 30 segundos. Resposta letra C.

127168.

Comentário: Vejamos as manifestações clínicas de cada doença I- Rubéola quando sintomática, as principais são deficiência auditiva, retardo do crescimento intrauterino, cardiopatias congênitas, como a persistência do canal arterial e estenose pulmonar, e manifestação ocular, sobretudo, catarata II- Citomegalovírus microcefalia, calcificações intracranianas periventriculares, coriorretinite, perda auditiva neurossensorial, prematuridade, retardo do crescimento intrauterino, hepatoesplenomegalia, hepatite, icterícia, pneumonia, trombocitopenia III- Toxoplasmose calcificações intracranianas difusas, coriorretinite, hidrocefalia, retardo mental e hepatoesplenomegalia IV- Herpes simples vesículas cutâneas, alterações oculares e hidro microcefalia V- Sífilis congênita precoce lesões cutâneo-mucosas, lesões ósseas, hepatoesplenomegalia, anemia, coriorretinite e outros. Resposta correta letra C.

100961.

Comentário: O torcicolo congênito é um sinal clínico, e não um diagnóstico. A causa mais comum de torcicolo congêntico é o Torcicolo MUSCULAR Congênito (TMC), representando 20% dentre todas elas. As demais causas correspondem a traumas de clavícula com lesão de plexo braquial, tumores malformações de SNC, desordens oculares, desordens ósseas (síndrome de Klippel-Feil), deslocamente atlanto-axial e síndrome de Sandifer (por refluxo gastroesofágico patológico). Dentre os casos de TMC, cerca de 9% possuem associação com displasia congênita de quadril, e por isso, recomenda-se que as crianças com TMC realizem rotineiramente ultrassonografia de quadril com 1 mês de vida para avaliar possíveis deslocamentos. Gabarito letra E.

100953.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

Comentário: O enunciado nos traz um quadro de icterícia neonatal, queixa muito frequente nesta faixa etária. Para distinção das causas benignas (ex. icterícia fisiológica e icterícia da amamentação forma precoce) das causas patológicas (ex. doença hemolítica perinatal por incompatibilidade ABO Rh, infecção neonatal, TORCHS) de icterícia, são importantes informações como TEMPO de aparecimento da icterícia, NÍVEL de icterícia (zonas de Kramer) e ESTADO GERAL do neonato. Na icterícia fisiológica temos o aparecimento da alteração de cor entre o 2-3º dia de vida, sem ultrapassar a zona II de Kramer, níveis de bilirrubina sérica não ultrapassando 5-7 mg dl, neonato em bom estado geral e boa alimentação, com tendência à melhora espontânea dentro dos 7 dias de vida. E parece ser exatamente este o caso clínico descrito no enunciado. Além disso, a mãe e o bebê apresentam uma situação de risco ABO, isto é, mãe O e neonato A. Entretanto, se houvesse hemólise e icterícia por incompatibilidade ABO, a mesma surgiria nas primeiras 24 horas de vida, e não com 44h. Portanto, parece que estamos, de fato, frente a uma icterícia fisiológica. A conduta é dosar bilirrubinas e frações para confirmar esta hipótese e dar alta com acompanhamento. Gabarito letra C.

101009.

Comentário: A recomendação de abordagem pediátrica neonatal na sala de parto é a de que se estamos diante de um parto de BAIXO RISCO (ausência de doenças sistêmicas ou gestacionais maternas, ausência de consumo de álcool drogas, distúrbios placentários ou de cordão, crescimento intrauterino adequado, ausência de anormalidades anatômicas fetais, feto a termo, com peso estimado normal), SEM INTERCORRÊNCIAS NOSOLÓGICAS periparto (ex líquido meconial, sinais de sofrimento fetal agudo, trabalho de parto prolongado) e com neonato VIGOROSO ao nascer, poder-se-á proceder aos primeiros cuidados (aspiração, secagem, avaliação) do neonato no colo materno, que proporciona vínculo afetivo e fonte de calor. Gabarito B.

106374.

Comentário: O enunciado nos traz a descrição típica da Toxoplasmose Congênita na sua forma neurológica, que se caracteriza por hidrocefalia, microcefalia, alterações do líquor, coriorretinite e

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

calcificações intracranianas, que são tipicamente difusas. A forma generalizada, que ocorre em fases mais tardias, consiste em hepatoesplenomegalia, linfadenomegalia, trombocitopenia, anemia, icterícia, coriorretinite, dentre outras manifestações. Gabarito letra C.

106380.

Comentário: O enunciado nos traz um recém-nato a termo, em aleitamento materno exclusivo, e com uma situação de ausência de incompatibilidade ABO, pois sendo o neonato O ele não possui em suas membranas eritrocitárias nenhum antígeno de grupo A ou B que possa levar à hemólise por anticorpos maternos. Ele apresenta uma bilirrubina total de 10 mg dl, que no quarto dia de vida, para este bebê de baixo risco, não é indicativa de fototerapia. Desta forma, podemos dar alta para o recém-nato e orientar quanto ao aleitamento exclusivo até os 6 meses de vida e quanto ao banho de sol diário nos horários adequados. Provavelmente, ele possui uma icterícia fisiológica, que dificilmente excede 12mg dl. Gabarito letra A.

111658.

Comentário: O teste do olhinho consiste na pesquisa do reflexo vermelho (teste de Bruckner), sendo uma forma de rastreamento para anormalidades oculares, desde a córnea até o segmento posterior, permitindo ainda a detecção das opacidades dos meios transparentes do globo ocular. Dentre as condições que podem ser rastreadas, incluem-se catarata congênita , retinopatia da prematuridade, retinoblastoma , glaucoma congênito, descolamento de retina, hemorragia vítrea. É feito com um oftalmoscópio que deve ser segurado pelo examinador a um braço de distância dos olhos do bebê. A resposta normal é o achado de um reflexo vermelho brilhante quando a luz incide sobre a pupila. A presença de pontos pretos, assimetria ou reflexo branco (leucocoria) indicam a necessidade de uma avaliação por oftalmologista. Resposta E.

77337.

Comentário: Neste caso, o RN é a termo com história de parto cesáreo por rotura prematura de membranas. A taquipneia transitória do recém-nascido, geralmente ocorre em RNs a termo ou próximo do termo. Clinicamente há um desconforto respiratório leve ou moderado, autolimitado, com evolução benigna decorrente de um distúrbio na reabsorção do líquido pulmonar após o

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

nascimento. A frequência respiratória pode ser bastante elevada e pode haver outras manifestações como cianose, gemência, retrações. Essas crianças recebem oxigenioterapia, mas dificilmente necessitarão de uma FiO2 maior que 40%. Apresentação clínica compatível com a que foi descrita no enunciado. As outras opções se tornam menos prováveis uma vez que o medicamento recomendado na letra A é proscrito nesta faixa etária. Não há na história dados para pneumonia congênita uma vez que não há relato de fatores maternos de risco (atenção que no enunciado não está escrito que o tempo de bolsa rota foi maior que 18 horas) nem sinais de infecção com comprometimento sistêmico no RN. Não há história de asfixia nem de piora do desconforto com queda da saturação após a manipulação, condição conhecida como labilidade característica da hipertensão pulmonar persistente neonatal. E em relação a cardiopatia congênita, não há informações no enunciado sobre o sistema circulatório como alterações de pulsos, PA e ou sopro cardíaco e ou não resposta clínica após oferta de O2.

59375.

Comentário: A doença de Hirschsprung é uma anomalia congênita que tem como característica intrínseca a ausência dos neurônios intramurais dos plexos nervosos parassimpáticos (Meissner e Auerbach), afetando o intestino grosso, em geral, nos seus segmentos mais distais, como o reto e o cólon sigmoide (opção A correta). O segmento agangliônico é limitado ao retossigmoide em 75% dos pacientes em cerca de 10% todo o cólon é desprovido de células ganglionares. Os principais sinais e sintomas da doença são a distensão abdominal que ocorre logo após o nascimento, com presença de vômitos e retardo de mais de 48 horas na passagem do mecônio, sem que haja um fator mecânico obstrutivo reconhecido de imediato. A doença compromete quatro vezes mais os meninos que as meninas e é considerada como devido à falha de migração craniocaudal da crista neural do vago, tratando-se, pois, de uma neurocristopatia, hoje considerada associada à deleção do braço longo do cromossomo 10. Noventa por cento dos recém-nascidos que não eliminam mecônio nas primeiras 24 horas, após o nascimento, certamente têm doença de Hirschsprung, sem diferença entre RN a termo e prematuros ou pós-termos (opção D incorreta, respondendo a nossa questão). O abdome distende e sobrevêm vômitos biliosos, mais frequentes quanto mais se insiste

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

com a alimentação, por via oral. Eventualmente, percebe-se à inspeção o peristaltismo intestinal e, quando a distensão abdominal se acentua, o quadro clínico de obstrução é acompanhado de desconforto respiratório que pode se expressar por certo grau de cianose. O exame rotineiro deve incluir o toque digital do reto que, em geral, provoca a saída explosiva de conteúdo intestinal com alívio imediato, porém passageiro da distensão, com tônus anal normal (opção B correta). A abordagem inicial, feito o diagnóstico, tem como propósito manter esses pacientes o mais saudáveis possível para o tratamento cirúrgico definitivo, que consistirá, em última análise, da retirada do segmento desnervado do trânsito intestinal. As recomendações mais clássicas impõem o tratamento estagiado, com colostomia prévia, no cólon transverso ou no sigmoide, logicamente no segmento inervado, e o tratamento definitivo no 10º ou 11º mês de vida, embora bons resultados têm sido obtidos com o tratamento definitivo realizado antes do 3º mês de vida (opção C correta). Resposta letra D.

59393.

Comentário: Trata-se de um caso de impetigo bolhoso em um RN, uma infecção estafilocócica causada pelo S. aureus coagulase positivo. Os recém-nascidos podem ter infecções estafilocócicas cutâneas, geralmente nas suas 6 primeiras semanas de vida. O sintoma mais frequente é a presença de grandes bolhas cheias de um líquido claro ou pus localizadas na axila, na virilha, e nas pregas do pescoço (opção A incorreta). O diagnóstico, geralmente é clínico, mas culturas do conteúdo da vesícula podem fornecer o agente etiológico (opção B correta). O prognóstico é excelente na enorme maioria dos casos, mas via de regra é utilizada a antibioticoterapia (como a cefalexina) para conter a progressão da infecção, a não ser que haja a formação de abscessos (também incomuns - que demandariam antibiótico parenteral), já que a bacteremia e consequente infecção à distância não são esperados a partir dessas lesões (opção C incorreta). Não há alterações específicas ao hemograma, especialmente nos primeiros dias de vida. A análise histopatológica das lesões pode revelar presença de neutrófilos, e não eosinófilos (opção D incorreta). Resposta letra B.

59107.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

Comentário: Diante de um RN menor que 34 semanas de idade gestacional que apresenta um distúrbio respiratório, a primeira hipótese, independentemente da história gestacional ou de qualquer outro fator de risco para outras entidades patológicas (como pneumonia sepse neonatal), será a doença da membrana hialina. É um distúrbio vinculado estreitamente à prematuridade, pela deficiência de surfactante pulmonar inerente à idade gestacional que descrevemos. Como não temos doença da membrana hialina nas opções, vamos atrás de seu sinônimo síndrome do desconforto respiratório (do recém-nascido) , que encontramos na opção B.

59110.

Comentário: As medidas pediátricas para prevenção da transmissão vertical do HIV no período neonatal são 1. Banho em água corrente logo após as medidas iniciais de atendimento ao RN na sala de parto a fim de retirar secreções e sangue materno 2. Iniciar solução oral de AZT ainda na sala de parto (ou no máximo até 2 horas após o nascimento) 3. Realizar hemograma completo para acompanhamento de possíveis efeitos adversos do uso do AZT 4. Alojamento conjunto com a mãe a fim de aumentar o vínculo mãe-bebê 5. Contraindicar o aleitamento materno. O bebê verticalmente exposto deverá receber fórmula infantil de partida nos primeiros 6 a 12 meses de vida. 6. Receber alta com consulta pediátrica agendada antes de completar 1 mês de vida.

59415.

Comentário: O índice Apgar é um escore de avaliação da vitalidade neonatal precoce, desenvolvido para avaliar os neonatos que necessitam de reanimação e para avaliar sobrevida. É muito importante lembrar que o cálculo desse índice não deve adiar o início das manobras de reanimação, que devem ser iniciadas precocemente, e o cálculo deve ser feito após a estabilização do paciente, retrospectivamente. São cinco os parâmetros clínicos para a confecção do índice respiração, frequencia cardíaca, cor, resposta a estímulos e tônus, e cada um deles recebe uma pontuação variando entre 0, 1 e 2 - mínima total de 0, máxima de 10. Deve-se calcular o Apgar no 1º e 5º minutos de vida e, se menor ou igual a 6, o escore deve continuar a ser calculado com intervalos de 5 minutos até que se obtenha nota maior ou igual a 7. No RN em questão, temos - No primeiro minuto Bradicardia 1 Flácido 0 Sem movimentos respiratórios 0 Azul, pálido 0 Reagindo

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

pouco 1 Total 2 - No quinto minuto FC 100 bpm 2 Choro forte 2 (respiração) 2 (resposta a estímulos) Movimento ativo 2 (pelo tônus) Cianose de extremidades 1 Total 9. Resposta correta letra A.

59081.

Comentário: Analisando cada correlação, temos que a coxsackiose pode levar à miocardite viral (quando falamos do tipo B, especificamente). A doença do miocárdio, que pode levar a uma grave insuficiência cardíaca, é incomum mesmo naqueles que têm contato direto com o vírus e, mais raramente ainda, pode haver a transmissão transplacentária desse agente, causando a mesma afecção no feto. Continuando, a mãe portadora de LES, se for portadora do anticorpo anti-Ro, tem um risco aumentado de transmitir pela via transplacentária essa proteína, a qual pode causar lesão no nodo AV do feto, ocasionando, por conseguinte, um bloqueio AV total. Sobre a mãe portadora de rubéola, caso passe a infecção para o feto, pode ocorrer cardiopatia congênita, dentre as quais a mais importante é o PCA (seguida pela estenose de ramo artéria pulmonar). Para finalizar, a mãe portadora de diabete melito promove um hiperinsulinismo fetal. Esse hormônio, em níveis elevados, acarreta uma hipertrofia de toda a musculatura do bebê, incluindo as fibras miocárdicas. Resposta, portanto, letra C.

59084.

Comentário: Temos aqui uma queixa bastante comum na primeira consulta de um recém-nascido, que deve ser muito valorizada uma vez que é responsável por grande parte dos casos de desmame precoce a dor ao amamentar. No caso em questão, notamos a presença de uma fissura na aréola justificando o desconforto sentido pela mãe. É muito importante que o pediatra saiba conduzir casos como este a presença de fissura em mamilo ou aréola deve sempre alertar para a possibilidade de pega e posição incorretas durante a mamada, e a conduta é observá-la e corrigir possíveis erros. Translactação com fórmula infantil na mama direita não é a conduta apropriada para o caso, já que há produção de leite adequada. Suspender totalmente a amamentação na mama direita , além de ser uma conduta que vocês praticamente nunca adotarão nas questões de prova, pode tornar o problema ainda maior devido ao consequente ingurgitamento mamário. Manter

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

o mamilo bem seco com protetores de algodão pode auxiliar quando o problema é apenas pela umidade causada pelo excesso de leite. Aqui parece que estamos diante de uma pega incorreta, e a melhor conduta não é a decrita aqui. A metoclopramida tem como efeito o aumento da produção de leite. Caso não seja realizada a correção da pega posição, a dificuldade na amamentação se perpetuará, potencializando as lesões, evoluindo para ingurgitamento mamário e até mesmo mastite. Assim, Ordenhar a mama direita pré-sucção e acertar a pega é a opção correta, deixando a mama mais macia, menos túrgida, tornando mais fácil para o bebê pegar adequadamente. São características da pega correta O bebê abre bem a boca Abocanha quase toda a aréola Mantém boca bem aberta e acoplada à mama Lábios evertidos (boca de peixe) Queixo do bebê encosta na mama Fica mais aréola visível acima da boca do bebê do que abaixo O bebê suga, respira e engole de forma natural e coordenada. Logo a r esposta correta é a letra C.

366980.

Comentário: Temos um RN prematuro com surgimento súbito de desconforto respiratório, cianose e dessaturação. Qual a suspeita clínica mais provável Vamos às alternativas Letra A correta. O surgimento súbito dos sintomas sugere um quadro de pneumotórax hipertensivo, que cursa com deterioração clínica abrupta, caracterizada por desconforto respiratório, cianose e colapso cardiovascular. A prematuridade é um dos principais fatores de risco para a ocorrência de pneumotórax no período neonatal, associada ao antecedente de síndrome do desconforto respiratório agudo. Letra B incorreta. A asma pode surgir nos primeiros anos de vida, mas não é uma doença do período neonatal. Letra C incorreta. As principais causas de cianose no RN são as doenças pulmonares, as cardiopatias congênitas e a hipertensão pulmonar persistente. Contudo, enquanto o RN com doença pulmonar geralmente apresenta desconforto respiratório importante, o RN com cardiopatia congênita classicamente tem história perinatal benigna e evolui, com o passar das horas e o fechamento do canal arterial, com cianose na presença de choro ou mamadas. Pode não haver desconforto respiratório concomitante no início do quadro, havendo uma piora progressiva à medida que o fluxo pulmonar diminui. Letra D incorreta. Um RN prematuro internado por bastante tempo em UTI até pode cursar com infecção pelo VSR e evoluir com bronquiolite, mas

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

o quadro da bronquiolite caracteriza-se por sintomas gripais iniciais, seguido de piora do padrão respiratório após alguns dias da infecção. O surgimento súbito dos sintomas fala contra a hipótese de bronquiolite nesse caso. Resposta letra A .

363932.

Comentário: A icterícia é um dos sinais mais frequentes no período neonatal e apresenta-se como a coloração amarelada da pele, esclera e membranas mucosas, indicando aumento da bilirrubina sérica com acúmulo de bilirrubina nos tecidos. A icterícia aparece em cerca de 60% dos recém-nascidos (RN) termos e 80% dos RN pré- -termos na primeira semana de vida. Diante disso, vamos analisar as afirmativas em relação às características indicativas de icterícia grave. Letra A correta. Letargia e recusa alimentar, ou sucção débil, podem estar presentes na fase aguda da encefalopatia bilirrubínica, que é grave e indica necessidade de atenção médica imediata. Letra C incorreta. O choro é a única forma do RN comunicar-se e não está associado à icterícia grave. Letra C incorreta. Na avaliação da icterícia, a pressão suave da pele pode revelar a presença da mesma - o que não é um sinal de icterícia grave. Letra D correta. Diante de todo RN cuja icterícia persista além dos 14 dias de vida, impõe-se a dosagem das bilirrubinas e a observação da coloração das fezes e urina - a colestase neonatal passa a ser uma hipótese que precisa ser descartada. Nós do Medgrupo entendemos que as letras A e D são corretas. Entretanto, a banca liberou a letra A como gabarito oficial.

363931.

Comentário: Vamos avaliar as alternativas em relação ao contato pele a pele do recém-nascido com sua mãe logo após o parto. Letra A incorreta. O procedimento reduz o risco de hipotermia no bebê, auxiliando assim na regulação dos níveis de glicemia. Letra B incorreta. O contato pele a pele favorece o aleitamento materno ainda na primeira hora de vida. A sucção do seio pelo bebê irá estimular a liberação de ocitocina, a qual tem papel importante no tônus uterino. Letra C correta. Todos os recém-nascidos que estão em boas condições, devem permanecer junto com a mãe imediatamente após o nascimento. Letra D incorreta. Como vimos, o contato pele a pele traz uma melhor regulação da temperatura neonatal. Resposta letra C.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

331989.

Comentário: Vamos avaliar cada alternativa. A incorreta. Todas as vacinas do PNI devem ser oferecidas às crianças expostas ao HIV que não tenham comprovadamente imunodeficiência, até os 18 meses de idade ou até a definição do diagnóstico de infecção pelo HIV. B incorreta. Para todas as crianças expostas ao HIV no momento do parto, a primeira coleta de CV-HIV deve ser realizada imediatamente após o nascimento e não na segunda semana de vida. C incorreta. Recomenda-se que todas as crianças expostas ao HIV recebam profilaxia com sulfametoxazol-trimetoprima a partir de quatro semanas de vida, até que tenham duas cargas virais indetectáveis. Essa profilaxia é mantida somente para as crianças infectadas, até um ano de idade, independentemente da contagem de LT-CD4 . D correta. De acordo com os estudos, as crianças não infectadas pelo HIV (mas expostas) tendem a apresentar mais infecções bacterianas e quadros mais graves que as não expostas. E incorreta. O recomendado é realizar o anti-HIV a partir dos 18 meses de idade, pois os anticorpos maternos podem persistir no bebê até os 18 meses, podendo ser fator confundidor até este período. Resposta letra D.

330090.

Comentário: Questão difícil e com conceitos importantes. A infecção congênita por herpes simples por via transplacentária é rara, sendo mais comum no parto durante a passagem pelo canal do parto ou no pós-parto. A sífilis materna (nas fases primária ou secundária) sem tratamento tem taxa de transmissão de 70 a 100%. A transmissão do espiroqueta pode ser durante a gestação, acessando à circulação fetal pela placenta ou pode ser transmitido durante o parto, pelo contato do bebê com lesões ricas em treponema no canal do parto. A citomegalovirose e a rubéola podem também ser transmitidas via transplacentária, sendo que o risco de transmissão fetal do vírus da rubéola é maior no 1º e no 3º trimestre, mas o risco de anomalias fetais graves nesta doença é maior quando a mãe adquire a infecção nas primeiras 8 semanas da gravidez. Resposta letra A.

331990.

Comentário: A transmissão vertical da toxoplasmose ocorre quando a mulher imunocompetente tem a infecção aguda durante a gestação (letra A correta). Caso a mulher seja IgM e IgG negativos,

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

significa que ela é uma gestante suscetível e pode sim adquirir a doença durante a gestação (letra E incorreta). Por isso, esta gestante deve evitar ingerir carne crua, vegetais mal lavados, evitar o contato com fezes de gatos e terra contaminada. Gestantes com infecção aguda apresentam IgM positivo e IgG positivo com baixa avidez e devem ser tratadas de imediato (letra C correta). Anticorpos com alta avidez somente são produzidos após 12 semanas. Na infecção aguda materna, a prevenção da infecção congênita é feita com espiramicina (letra B correta). Na presença de infecção fetal, o tratamento é feito com sulfadiazina, pirimetamina e ácido folínico (exceto no primeiro trimestre, cujo esquema não pode ser instituído). Se a soroconversão ocorre durante a gravidez, deve-se fazer a pesquisa de DNA de toxoplasma no líquido amniótico (letra D correta). Resposta Letra E.

346440.

Comentário: A doença da membrana hialina (síndrome do desconforto respiratório) é a principal causa de desconforto respiratório em recém nascidos prematuros extremos - já podemos começar eliminando a alternativa C, já que prematuridade é o principal fator de risco para a doença. Ela ocorre por imaturidade pulmonar, que leva ao colapso alveolar induzido pela deficiência de surfactante. Outros fatores de risco associados a doença são diabetes materno, sexo masculino, parto cesárea, especialmente se realizado na ausência de trabalho de parto, asfixia e etnia branca. A doença hipertensiva específica da gestação, apesar de relacionada a diversas consequências para o recém nascido, não leva a risco aumento de desenvolvimento de DMH. Resposta letra D.

346441.

Comentário: A icterícia fisiológica trata se de quadro comum, benigno e autolimitado, que em geral, inicia-se após 24 horas de vida. Em circunstâncias normais, o nível de bilirrubina total em um recém-nascido (RN) saudável nos primeiros dias de vida aumenta em uma velocidade inferior a 5 mg dl nas 24 horas. A icterícia no RN se torna perceptível quando a bilirrubina atinge níveis superiores a 5-7 mg dl, portanto, uma icterícia fisiológica se tornará aparente no segundo ou terceiro dia de vida. O pico nos níveis de bilirrubina é alcançado entre o segundo e quarto dia (isso pode variar a depender da referência consultada, sendo relatado até o sétimo dia de vida) e cai

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

para níveis inferiores a 2 mg dl entre o quinto e o sétimo dia de vida, sem que outros sinais e sintomas estejam acompanhados, como perda de peso, letargia, anemia, etc. Na presença dessas manifestações, há forte suspeita de tratar-se de uma icterícia patológica. Resposta letra B.

346444.

Comentário: A presença de disfagia e sialorreia abundante, são sintomas comuns em pacientes com doenças neurológicas. Essas manifestações podem favorecer episódios repetidos de infecções do trato respiratório inferior e devem ser tratadas. Existem diversas formas de controle da sialorreia descritas na literatura, como terapia medicamentosa, aplicação de toxina botulínica, radioterapia e procedimentos cirúrgicos. Contudo, algumas dessas abordagens podem não ser viáveis em alguns casos e o ideal é que se opte, sempre que possível, por formas de tratamento menos invasivas. Na prática médica, o colírio de atropina, utilizado por via oral, é indicado de forma off-label no tratamento de vários pacientes. Entretanto, as evidências disponíveis até o momento não nos permitem afirmar que o uso da atropina por via sublingual é eficaz no tratamento da sialorreia. Na maioria dos casos, o benefício da atropina na redução da saliva é temporário ou os efeitos adversos (boca excessivamente seca, constipação e retenção urinária) inviabilizam a continuidade do uso. É importante ressaltar ainda que a utilização do colírio oftalmológico por via sublingual pode aumentar as chances de erros de medicação, como a administração por via incorreta e erros de dose. Tendo em vista a escassez de tratamentos para a sialorreia, é importante considerar que alguns pacientes podem se beneficiar com o uso desse medicamento nessas condições , no entanto, é necessário que a relação entre potenciais riscos e benefícios dessa alternativa terapêutica seja avaliada individualmente, de maneira rigorosa e contínua. Resposta letra C.

342639.

Comentário: A síndrome da rubéola congênita é uma doença grave decorrente da infecção aguda durante a gestação. As principais manifestações clínicas são catarata, cardiopatia congênita (PCA ou estenose pulmonar), perda auditiva, retardo de crescimento intrauterino. O hipotireoidismo congênito se caracteriza pela perda parcial ou total da função tireoidiana. Os principais sintomas

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

são deficiência intelectual e manifestações neurológicas incluindo ataxia, incoordenação, estrabismo, movimentos coreiformes e perda auditiva. A maioria das crianças com hipotireoidismo congênito nasce sem manifestações clínicas aparentes e os sintomas, geralmente inespecíficos, podem surgir semanas ou meses após o nascimento. A toxoplasmose congênita se manifesta por calcificações intracranianas difusas hidrocefalia coriorretinite liquor com inexplicável pleocitose ou proteína elevada hepatoesplenomegalia. A sífilis congênita pode cursar com diferentes sinais e sintomas, divididos em precoces e tardios. No entanto, as características mais marcantes da doença são rash maculopapular ou bolhoso acometendo palmas das mãos e plantas dos pés rinite persistente osteocondrite e periostite pseudoparalisia de Parrot. Resposta letra A.

321586.

Comentário: Para um bebê maior de 34 semanas com boa vitalidade está indicado o clampeamento tardio do cordão, conduta que aumenta a concentração de hemoglobina nas primeira 24h e a concentração de ferritina nos primeiros 3 a 6 meses de vida. O documento mais atualizado da SBP, publicado em maio de 2022, orienta que o clampeamento seja realizado após no mínimo 60 segundos. Embora não estipule o limite máximo para esse clampeamento, sabe-se que tempos muito prolongados para o clampeamento aumentam o risco de policitemia e icterícia por esse motivo, a diretriz anterior limitava o período para até 3 minutos. Embora a diretriz atual não determine esse período máximo, o período mínimo está muito claro, sendo que das alternativas apresentadas a única que se adequada à diretriz é a que determina o clampeamento entre 1 e 3 minutos de vida do RN.

334816.

Comentário: A atresia biliar resulta da obliteração dos ductos biliares extra-hepáticos, o que pode ocorrer em qualquer ponto da árvore biliar. O exame padrão ouro para o diagnóstico é a colangiografia intra-operatória com biópsia. Os achados histológicos clássicos são vias portais aumentadas com fibrose e proliferação de ductos biliares. Também pode-se observar tampões biliares nos ductos biliares. O exame intraoperatório revela a ausência de um ducto biliar extra-hepático patente. Resposta letra C.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

321591.

Comentário: A dica para acertar a questão está na referência do enunciado a ação anti-inflamatória . Os macrolídeos são antibióticos comumente utilizados em quadros de doenças pulmonares crônicas, como a fibrose cística e a bronquiolite obliterante. Esse uso se dá devido à soma de sua atividade antimicrobiana com suas propriedades anti-inflamatórias, sendo capaz de reduzir a liberação de citocinas inflamatórias e a degranulação leucocitária, além de apresentar ação na imunidade adaptativa. Os outros antibióticos citados na questão não têm essa atividade anti-inflamatória bem comprovada em seu espectro de ação.

334819.

Comentário: A síndrome do desconforto respiratório ou doença da membrana hialina ocorre devido a falta de surfactante no interior dos alvéolos, aumentando a tensão superficial e levando à instabilidade e colapso dos mesmos. A diminuição da complacência pulmonar faz com o que o trabalho respiratório aumente, pois torna-se necessário que seja gerada uma maior pressão intratorácica negativa para manter o volume pulmonar. Esse aumento no trabalho respiratório se manifesta clinicamente por retrações da musculatura respiratória e também pelos gemidos ou gemência, que nada mais são do que uma tentativa de prevenir o colapso alveolar. Resposta letra C.

321593.

Comentário: A triagem auditiva neonatal universal, ou teste da orelhinha, é mandatória para todos os recém-nascidos brasileiros. Para crianças sem fatores de risco, o teste realizado é o EOA emissão otoacústicas evocadas. Esse teste avalia apenas a função coclear, de maneira que pode não detectar neuropatias auditivas. Em crianças com indicadores de risco para deficiência auditiva, recomenda-se então a realização do potencial evocado auditivo de tronco encefálico (PEATE-A), exame que avalia a atividade eletrofisiológica do sistema auditivo desde o nervo coclear até o mesencéfalo, sendo que a Sociedade Brasileira de Pediatria reforça a indicação em especial para crianças que permaneceram na UTI neonatal por mais de 5 dias. A saber, outros indicadores para risco de deficiência auditiva incluem os congênitos ou perinatais - história familiar de surdez na

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

infância, hiperbilirrubinemia com exsanguineotransfusão, uso de aminoglicosídeos por mais de 5 dias, asfixia ou encefalopatia hipoxico-isquêmica, uso de oxigenação extracorpórea, infecções intrauterinas (TORCH ou Zika), malformações craniofaciais, síndromes genéticas que cursam com surdez - e os tardios - infecções pós-natais que cursam com surdez, trauma craniano, quimioterapia, alteração de fala ou linguagem, atraso ou regressão do desenvolvimento ou suspeita familiar de surdez.

334823.

Comentário: Acerca do teste do pezinho, vamos avaliar as alternativas. Letra A incorreta. O teste o pezinho é um teste de triagem que deve ser valorizado, mesmo na ausência de manifestações clínicas. Se houver alteração em seu resultado, este paciente deve passar por avaliação mais completa. Letra B correta. Estas são as seis doenças que estão contempladas no teste do pezinho no território nacional no ano que a questão foi realizada. No entanto, há diversas leis que já foram aprovadas para a ampliação do teste, aumentando a sua cobertura. Letra C incorreta. A coleta do teste está indicada entre o terceiro e o quinto dias de vida. Letra D incorreta. A prematuridade e hemotransfusões são fatores que influenciam no resultado do teste e indicam necessidade de recoleta. Resposta letra B.

339823.

Comentário: Guarde sempre o seguinte conceito em recém-nascidos (RN), a icterícia que se inicia antes de 24 horas de vida deve ser considerada patológica e o recém-nascido deve ser investigado. Dentre as principais causas de icterícia no período neonatal, destacam-se as causas hemolíticas, como a incompatibilidade ABO e Rh. Na incompatibilidade Rh, o RN será Rh-positivo e a mãe será Rh-negativo. A mãe, geralmente, terá sido sensibilizada em uma gestação prévia e a gravidade da doença fetal aumenta em gestações subsequentes. A incompatibilidade ABO é caracterizada pela tipagem A ou B em RN de mãe O, seja Rh positivo ou negativo. Como esta é a primeira gestação desta mulher, o diagnóstico de incompatibilidade ABO torna-se mais provável. Resposta letra B.

339826.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

Comentário: Questão desatualizada segundo o atual documento da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP). Para os recém-nascidos com 34 ou mais semanas, preconiza-se atualmente o clampeamento tardio do cordão, aguardando-se, no mínimo , 60 segundos. No antigo documento da SBP, a recomendação era de realizar o clampeamento entre 1 e 3 minutos de vida do RN, mas isto mudou e deve seguir o que está descrito acima. Sendo assim, a questão não apresenta resposta correta e deveria ter sido anulada.

300814.

Comentário: Vamos avaliar as alternativas acerca da anemia da prematuridade. Letra A incorreta. Os níveis de hemoglobina em um prematuro chegam a valores mais baixos do que nos bebês a termo. Letra B correta. O mecanismo que leva à anemia fisiológica é o mesmo em bebês a termo ou prematuros. Com o início da respiração pulmonar e aumento da oferta de oxigênio para os órgãos e tecidos, há um feedback negativo na produção de eritropoiese e de eritropoietina, que, associado a uma menor meia vida das hemácias fetais, faz com que os níveis de hemoglobina circulantes sejam menores. No bebê prematuro esse processo se dá de forma mais intensa nas primeiras quatro à doze semanas de vida. Letra C incorreta. O menor nadir em prematuros se deve a eritropoietina mais baixa. Letra D incorreta. A anemia da prematuridade é mais intensa quanto menor a idade gestacional e afeta mais comumente as crianças com idade gestacional menor que 32 semanas. Resposta letra B.

315790.

Comentário: A respeito do tratamento da retinopatia da prematuridade, vamos analisar cada uma das alternativas Letra A correta. O tratamento padrão da retinopatia da prematuridade (ROP) é a ablação da retina avascular com laser ou crioterapia. No entanto, esta terapia pode deixar sequelas estruturais e visuais permanentes e não ser efetiva em casos de ROP posterior e agressiva. A terapia antiangiogênica é opção nos casos de falha do tratamento padrão. Letra B incorreta. Não pode-se definir cura após regressão completa com o tratamento com a injeção de antiangiogênico, pois ainda não estudos a longo prazo que determinem tal segurança. Letra C incorreta. Como explicado na alternativa A, o tratamento padrão da ROP é a ablação da retina avascular com laser

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

ou crioterapia. Letra D incorreta. Apesar de promissor, o uso de terapia com antiangiogênicos no tratamento da ROP ainda precisa de evidências sólidas sobre a segurança do seu uso em prematuros e os possíveis efeitos adversos locais e sistêmicos. Resposta letra A.

300823.

Comentário: Vamos analisar cada uma das alternativas sobre o manejo de recém-nascidos prematuros. Letra A correta. A manutenção de um ambiente com adequadas temperatura e umidade permite que a temperatura corporal do bebê fique estável, prevenindo a hipotermia (muito comum em prematuros) e o consequente consumo aumentado de oxigênio e energia. Letra B incorreta. A perda de calor para o ambiente leva à hipotermia. Letra C incorreta. Para evitar a hipotermia, o bebê deve ser de fato manipulado o menos possível, devendo-se evitar, portanto, transportes. No entanto, se houver a necessidade do mesmo, está indicada a incubadora de dupla parede que é a mais eficaz em não deixar que o calor se dissipe para o ambiente. Está indicado também o uso de uma fonte de calor irradiante. Letra D incorreta. A cabeça do recém-nascido corresponde a uma grande área da superfície corporal, sendo um dos locais responsáveis por maior perda de calor. Por isso, o uso de gorro é imprescindível em prematuros, principalmente os de baixo peso. Resposta letra A.

314122.

Comentário: Bebê com icterícia zona III de Kramer (lembre até a raiz da coxa, sendo sugestivo de valores de bilirrubina de 8 a 16mg dl) com 30 horas de vida. A mãe tem tipagem sanguínea A , mas não sabemos o tipo sanguíneo do bebê. É possível que se trate de icterícia patológica por doença hemolítica, e é mandatório obter a tipagem sanguínea desse bebê. Ainda, precisamos dosar os níveis de bilirrubina, fator Rh e Coombs direto do bebê, além de hematócrito com reticulócitos para avaliar o grau de hemólise. Enquanto aguardamos os exames, a fototerapia já deve ser iniciada devido ao grau da icterícia (letra A incorreta). A exsanguíneotransfusão é indicada somente em níveis de bilirrubina muito altos, situação em que o risco de encefalopatia bilirrubínica suplanta os riscos inerentes ao procedimento, e não deve ser indicada sem resultado de exames (letra B incorreta). A imunoglobulina endovenosa pode ser considerada somente nos casos de doença

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

hemolítica refratária à fototerapia inicial, com níveis de bilirrubina próximos aos níveis de exsanguíneotransfusão (letra C incorreta). Resposta letra D .

302861.

Comentário: A idade ideal para coleta da primeira amostra de sangue para o rastreamento com hormônio estimulante da tireoide (TSH) é do 3º ao 5º dia de vida, quando já ocorreu a diminuição do pico pós-natal de elevação fisiológica do TSH. A dosagem de TSH nas primeiras 24 horas de vida pode acarretar um aumento de falsos positivos para hipotireoidismo congênito. Resposta letra B.

300827.

Comentário: Um quadro de microcefalia acompanhado de icterícia persistente, convulsões e atraso do desenvolvimento sugere uma infecção congênita. Dentre estas infecções destaca-se o citomegalovírus que é responsável por um quadro de microcefalia, calcificações periventriculares, trombocitopenia, hepatoesplenomegalia, petéquias, coriorretinite e surdez neurossensorial progressiva. A síndrome de Down pode causar todas as alterações descritas no enunciado, mas apresenta outras características mais marcantes como a base nasal em sela, macroglossia relativa, baixa implantação de orelhas, prega simiesca, entre outros. O hipotireoidismo congênito e o craniofaringioma são causas de aumento de perímetro cefálico, seja por retardo no fechamento de fontanelas, seja por hidrocefalia. Resposta letra D.

313217.

Comentário: Estamos diante de um RN com mais de 34 semanas, que nasceu com boa vitalidade (bom tônus, com choro e respiração). A banca tenta nos confundir ao relatar líquido amniótico meconial, mas estamos cansados de saber que a simples presença de líquido meconial não altera nossa conduta inicial. Neste caso apresentado, podemos aguardar entre 1 e 3 minutos para realizar o clampeamento do cordão umbilical (alternativa B incorreta) e manter este RN em contato pele a pele com a mãe (alternativas C e D incorretas). O papel do pediatra neste caso é de avaliar continuamente a vitalidade deste bebê e estimular o aleitamento materno ainda na primeira hora de vida. Resposta letra A.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

313218.

Comentário: O clampeamento tardio do cordão umbilical apresenta benefícios tanto para o bebê a termo quanto para o prematuro. Dentre eles estão a menor frequência de hemorragia intracraniana, enterocolite necrosante e necessidade de transfusões sanguíneas no RN pré-termo 34 semanas, visto que o aumento do volume sanguíneo circulante estabiliza mais rapidamente a pressão arterial. Já nos RN a termo, há indícios de melhores índices hematológicos entre três e seis meses de idade, apesar de aumentar o risco de hiperbilirrubinemia indireta na primeira semana de vida.

Resposta letra B

315805.

Comentário: Estamos diante de neonato prematuro e de baixo peso, do sexo masculino, internado em unidade de terapia intensiva desde o nascimento. O paciente se apresenta em nutrição enteral e parenteral. No momento, apresenta letargia, episódios de apneia, distensão abdominal leucocitose, plaquetopenia e aumento de provas inflamatórias. Na radiografia, evidenciamos sinais claros de pneumatose intestinal. Precisamos lembrar da enterocolite necrosante como provável diagnóstico. A enterocolite consiste em uma necrose em graus variados da mucosa intestinal. Os principais fatores de risco para essa doença são prematuridade e asfixia neonatal, em um neonato de baixo peso. O quadro clínico engloba vômitos, sangramento gastrointestinal e distensão abdominal importante. Na radiografia, pode-se evidenciar pneumatose intestinal, ar no sistema porta, sinal da alça móvel e pneumoperitôneo (em casos de perfuração). O tratamento inicial consiste em jejum, sondagem nasogástrica, hidratação e suporte, além de antibioticoterapia. A cirurgia fica reservada para os casos refratários e de perfuração. Em relação às demais afirmativas, o íleo meconial é caracterizado por não ter evacuação de mecônio nas primeiras 12 a 24 horas. Os RNs apresentam sinais de obstrução intestinal, incluindo vômito que pode ser bilioso e distensão abdominal. O volvo do sigmóide é uma entidade rara na faixa etária pediátrica e cursa, usualmente, com distensão de abdome, dor e constipação. E a intussepção é caracterizada por cólicas abdominais súbitas e importantes que recorrem a cada 15 a 20 minutos, frequentemente acompanhadas de vômitos. Entre os episódios de dor, a criança parecer estar relativamente bem. A

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

seguir, a isquemia intestinal evolui, a dor se torna constante, a criança se torna letárgica e a hemorragia da mucosa faz surgir fezes sanguinolentas ao exame retal. Resposta letra C.

315806.

Comentário: Estamos diante de neonato prematuro e de baixo peso, do sexo masculino, internado em unidade de terapia intensiva desde o nascimento. O paciente se apresenta em nutrição enteral e parenteral. No momento, apresenta letargia, episódios de apneia, distensão abdominal leucocitose, plaquetopenia e aumento de provas inflamatórias. Na radiografia, evidenciamos sinais claros de pneumatose intestinal. Precisamos lembrar da enterocolite necrosante como provável diagnóstico. A enterocolite consiste em uma necrose em graus variados da mucosa intestinal. Os principais fatores de risco para essa doença são prematuridade e asfixia neonatal, em um neonato de baixo peso. O quadro clínico engloba vômitos, sangramento gastrointestinal e distensão abdominal importante. Na radiografia, pode-se evidenciar pneumatose intestinal, ar no sistema porta, sinal da alça móvel e pneumoperitôneo (em casos de perfuração). O tratamento inicial consiste em jejum, sondagem nasogástrica, hidratação e suporte, além de antibioticoterapia. A cirurgia fica reservada para os casos refratários e de perfuração. No caso em questão, observamos pneumatose intestinal e ausência de sinais de pneumoperitôneo, o que indica a possibilidade de tentativa de tratamento conservador, de início. Resposta letra B.

308275.

Comentário: A frase que foi utilizada como gabarito foi copiada e colada na íntegra do Harrison de Medicina Interna. O estudo da epigenética diz respeito a alterações na proteínas de histona e cromatina, bem como metilação do DNA que acabam por influenciar a expressão genética. Isso porque todas as células de uma mesma pessoa possuem uma sequência idêntica de DNA, mas os múltiplos fenótipos que uma célula pode manifestar é resultado da regulação epigenética, o que pode ter relação com uma série de doenças (inclusive neoplásicas). Repare, portanto, que a modificação epigenética é herdada, envolve o DNA mas não envolve modificações na sua sequência em si - a inativação do segundo cromossomo X em mulheres é um bom exemplo de uma modificação epigenética capaz de impedir a expressão gênica em um cromossomo inativado.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

Resposta letra A.

316370.

Comentário: Questão muito importante sobre testes de triagem neonatal. O teste do pezinho deve ser realizado entre o 3º e 5º dia de vida do bebê. As doenças triadas por este teste são fenilcetonúria, hipotireoidismo congênito, doença falciforme e outras hemoglobinopatias, fibrose cística, hiperplasia adrenal congênita, deficiência de biotinidase e toxoplasmose congênita (esta doença passou a integrar a triagem do Ministério da Saúde em 2020). O teste do reflexo vermelho é importante no rastreio de catarata congênita, de retinopatia da prematuridade, de retinoblastoma, de glaucoma congênito, de descolamento de retina e de hemorragia vítrea. Ele deve ser realizado na primeira consulta do recém-nascido e repetido aos 4, 6 e 12 meses e na consulta dos 2 anos de idade. Resposta letra B.

308288.

Comentário: O RN em questão é um bebê nascido a termo e classificado como alto risco para exposição ao HIV, já que sua mãe não fez uso de TARV durante a gestação. Segundo Ministério a Saúde, crianças de alto risco com idade gestacional superior a 37 semanas devem receber Zidovudina, Raltegravir, e Lamivudina por 28 dias. A Nevirapina é indicada para bebês de alto risco, nascidos entre 34 e 37 semanas. Já os recém-nascidos de baixo risco, de qualquer idade gestacional, recebem apenas AZT. Resposta letra D.

308289.

Comentário: Questão clássica de prova. Toda a icterícia de início antes de 24 horas deve ser considerada patológica e, por isso, investigada. O enunciado já nos adianta que existe uma incompatibilidade entre o sistema ABO materno e neonatal, ou seja, mãe O (auto-anticorpos anti-A e anti-B naturais) e neonato A (possui o antígeno A na superfície de suas hemácias, que podem ser agredidas ou marcadas para lise pelos auto-anticorpos anti-A maternos). Sem dúvidas essa é a nossa principal hipótese diagnóstica. Para seguimento da criança, devemos solicitar alguns exames para dar rumo a investigação e a escolha do tratamento mais adequado. Os exames recomendados são hemograma completo, contagem de reticulócitos e dosagem de bilirrubina total

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

e frações. Como temos uma bilirrubina 9,5 com 18 horas de vida, a fototerapia também está indicada. Resposta letra C.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina